Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar

MANAJEMEN KEPERAWATAN

Silvana Evi Linda • Heldawati • Sarwoko Gryttha Tondang
Lia Dwi Jayanti • Puji Rahayu • Aemilianus Mau

Editor: Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.



BUKU AJAR
MANAJEMEN KEPERAWATAN

Penulis:
Silvana Evi Linda, S.Kp., M.Kep., Ph.D.
Ns., Heldawati, S.Kep., M.Kep.
Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.
Grytthа Tondang, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Lia Dwi Jayanti, S.Kep., M.Kep.
Puji Rahayu, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:
Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar Manajemen Keperawatan

Penulis:
Silvana Evi Linda, S.Kp., M.Kep., Ph.D.
Ns., Heldawati, S.Kep., M.Kep.
Sarwoko, S.Ag., S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.
Gryttha Tondang, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Lia Dwi Jayanti, S.Kep., M.Kep.
Puji Rahayu, S.Kep., Ns., M.Kep.
Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Prof. Dr. Hj. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-71-8

Cetakan Pertama: Juli, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar *Manajemen Keperawatan* ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran yang dirancang untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, prinsip, dan penerapan manajemen keperawatan secara komprehensif. Materi yang disajikan mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan dalam pengelolaan pelayanan keperawatan di berbagai tatanan layanan kesehatan. Selain itu, buku ini juga mengacu pada perkembangan praktik keperawatan modern yang menuntut perawat memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan, komunikasi, kolaborasi, serta pengambilan keputusan yang efektif.

Buku ajar ini disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar manajemen keperawatan, organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan, kepemimpinan keperawatan dan manajemen perubahan, hingga manajemen sumber daya manusia keperawatan. Selanjutnya, pembahasan dilengkapi dengan materi mengenai perencanaan dan penjadwalan tenaga keperawatan, manajemen asuhan keperawatan dan delegasi, serta komunikasi efektif, kolaborasi interprofesional, dan manajemen konflik. Untuk mendukung proses pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi, setiap bab dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran, latihan, portofolio, rubrik penilaian, DOPS, OSCE, rangkuman materi, serta red flags dan eskalasi yang relevan dengan praktik keperawatan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan di masa mendatang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas buku ini. Penulis berharap buku ajar ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, perawat klinis, dan seluruh tenaga kesehatan sebagai referensi dalam mempelajari dan mengembangkan kompetensi manajemen keperawatan, sehingga mampu mendukung terwujudnya pelayanan keperawatan yang profesional, bermutu, aman, dan berpusat pada pasien.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 KONSEP DASAR MANAJEMEN KEPERAWATAN DAN PERAN PERAWAT **1**
A. Konsep Dasar Manajemen Keperawatan 5
B. Fungsi Manajemen dalam Keperawatan 7
C. Peran Perawat dalam Manajemen Keperawatan 18
D. Tanggung Jawab Perawat 21
E. Akuntabilitas Perawat 23
F. Penutup 24
G. Aktivitas 1 — Knows How 26
H. Aktivitas 2 — Shows How 27
I. Form Penilaian Osce Keperawatan 40
J. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan 41
K. Portofolio 46
L. Rangkuman Materi 51
M. Daftar Pustaka 52
N. Glosarium 53

BAB 2 ORGANISASI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN SISTEM LAYANAN KESEHATAN **57**
A. Konsep Dasar Organisasi Pelayanan Keperawatan 61
B. Prinsip-Prinsip Pengorganisasian dalam Keperawatan 78
C. Model dan Struktur Organisasi Keperawatan 91
D. Sistem Layanan Kesehatan di Indonesia 99
E. Alur Layanan Keperawatan dan Kesinambungan Pelayanan 104
F. Alur asuhan keperawatan selama perawatan 107
G. Governance Keperawatan dan Tata Kelola Organisasi 114
H. Standar Akreditasi Layanan Keperawatan 124
I. Koordinasi Lintas Profesi dan Kolaborasi Interprofesional 133
J. Aktivitas 1 — Knows How 142
K. Aktivitas 2 — Shows How 143
L. Form Penilaian Osce Keperawatan 154
M. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan 156

N. DOPS (Does) 161
O. Portofolio 164
P. Latihan Soal 171
Q. Red Flag dan Eskalasi 179
R. Rangkuman Materi 186
S. Referensi 187
T. Glosarium 194

BAB 3 KEPEMIMPINAN KEPERAWATAN DAN MANAJEMEN PERUBAHAN ..203
A. Memilih pendekatan kepemimpinan sesuai situasi kerja dan kebutuhan tim 204
B. Menyusun langkah manajemen perubahan yang terukur (tujuan, pemangku kepentingan indikator capaian) 209
C. Teori dan Model Manajemen Perubahan 212
D. Agen Pembaru 217
E. Aktivitas 1 — Knows How 218
F. Form Penilaian Osce Keperawatan 225
G. RUBRIK PENILAIAN 225
H. DOPS (Does) 229
I. Portofolio 231
J. Contoh Soal 236
K. Tabel Red Flags & Eskalasi 236
L. Daftar Pustaka 238

BAB 4 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KEPERAWATAN 241
A. Pengertian Manajemen SDM Keperawatan 242
B. Fungsi Manajemen SDM Keperawatan 242
C. Peran Strategis SDM Keperawatan 244
D. Prinsip Manajemen SDM Keperawatan 245
E. Kebutuhan/Perhitungan Tenaga Keperawatan 246
F. Metode Perhitungan Kebutuhan Tenaga Keperawatan: Metode Douglas 247
G. Prinsip Dasar WISN: Dari Beban Kerja ke Kebutuhan Nyata 255
H. Task Shifting: Strategi Adaptif dalam Krisis Tenaga Keperawatan 258
I. Seleksi Tenaga Keperawatan 262
J. Orientasi Kerja bagi Perawat Muda 265
K. Pengembangan Kemampuan Keperawatan 267
L. Dampak Penerapan Sistem Jenjang Karier Perawat 268

M. Penilaian Prestasi Kerja 269
N. Tujuan Pemberian Kompensasi 271
O. Indikator Kompensasi 271
P. Faktor yang Mempengaruhi Kompensasi 272
Q. Aktivitas 1 — Knows How 273
R. Aktivitas 2 — Shows How 274
S. Rubrik Penilaian 283
T. DOPS (Does) 287
U. Tabel Red Flags & Eskalasi 295
V. Rangkuman Materi 298
W. Daftar Pustaka 299

BAB 5 PERENCANAAN DAN PENJADWALAN TENAGA KEPERAWATAN 301
A. Merencanakan Kebutuhan Tenaga 303
B. Pembagian Tenaga Keperawatan dan Penyusunan Jadwal 310
C. Aktivitas 1 — Knows How 311
D. Aktivitas 2 — Shows How 311
E. Rubrik Penilaian 320
F. DOPS (Does) 324
G. Portofolio 327
H. Rangkuman Materi 335
I. Tabel Red Flags & Eskalasi 336
J. Daftar Pustaka 339

BAB 6 MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN DAN DELEGASI 341
A. Konsep Manajemen Asuhan Keperawatan 344
B. Konsep Delegasi Keperawatan 346
C. Rubrik Penilaian 367
D. Rangkuman Materi 368
E. Daftar Pustaka 370

BAB 7 KOMUNIKASI EFEKTIF, KOLABORASI, DAN MANAJEMEN KONFLIK .. 371
A. Teori Dasar Komunikasi Efektif dalam Keperawatan 372
B. Unsur-unsur Komunikasi 373
C. Prinsip Komunikasi Efektif 373
D. Bentuk Komunikasi dalam Keperawatan 374
E. Teknik Komunikasi Efektif 374
F. Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Efektif 376

G. Dampak Komunikasi Efektif 376
H. Penerapan dalam Praktik Keperawatan 376
I. Teori Dasar Kolaborasi dalam Keperawatan 377
J. Teori Dasar Manajemen Konflik dalam Keperawatan 379
K. Sumber dan Jenis Konflik dalam Keperawatan 381
L. Aktivitas 1: Know How 381
M. Aktivitas 2: Shows How 382
N. Rubrik Penilaian 386
O. Portofolio 391
P. Tabel Red Flags & Eskalasi 396
Q. Rangkuman Materi 398
R. Daftar Pustaka 398

PROFIL PENULIS 401

BAB 1

KONSEP DASAR MANAJEMEN KEPERAWATAN DAN PERAN PERAWAT

Capaian Pembelajaran Lulusan

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep dasar manajemen keperawatan, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pengelolaan pelayanan.	CPMK-1; CPMK-2

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi manajemen, peran perawat manajer, serta etika–legal dalam pelayanan.
CPMK-2	Menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan (tata kelola, standar, kebijakan) untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Konsep Dasar Manajemen Keperawatan dan Peran Perawat	1.1 Menjelaskan fungsi manajemen (perencanaan–pengorganisasian–pengarahan–pengendalian) dalam konteks pelayanan keperawatan.	1.2 Mengidentifikasi peran, tanggung jawab, dan akuntabilitas perawat dalam pengambilan keputusan manajerial.	CPMK-1	CPMK-2; CPMK-7

Asesmen (berbasis CPMK)

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (CBT/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar konsep fungsi manajemen dan akurasi penerapan peran–akuntabilitas pada skenario.	10	Nilai ujian; lembar jawaban
CPMK-2	Tugas analisis organisasi & standar (paper ringkas)	Ketepatan pemetaan struktur/alur layanan dan ketepatan identifikasi gap terhadap standar (skor rubrik).	15	Dokumen analisis; matriks gap

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Ketepatan konsep fungsi manajemen (% benar)	<60% benar; miskonsepsi dominan	60–74% benar; miskonsepsi masih ada	75–89% benar; kesalahan minor	≥90% benar; konsisten
1.2 Ketepatan penerapan peran–akuntabilitas pada skenario	Keliru/tidak relevan	Relevan sebagian; alasan lemah	Tepat; alasan logis	Tepat; alasan kuat dan komprehensif

Rubrik CPMK-2

Indikator	**Skor 1 (Kurang)**	**Skor 2 (Cukup)**	**Skor 3 (Baik)**	**Skor 4 (Sangat Baik)**
2.1 Ketepatan pemetaan struktur & alur layanan	Tidak akurat; komponen inti hilang	Cukup akurat; masih ada kekeliruan bermakna	Akurat; kekeliruan minor	Sangat akurat; komprehensif dan jelas

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.2 Ketepatan gap analysis & prioritas perbaikan	Gap tidak sesuai standar; prioritas acak	Gap sebagian tepat; prioritas kurang konsisten	Gap tepat; prioritas jelas	Gap sangat tepat; prioritas sangat logis & berbasis risiko

Pendahuluan

Pelayanan keperawatan merupakan pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang berkontribusi langsung terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien. Dalam praktik modern, keperawatan tidak hanya berfokus pada tindakan klinis, tetapi juga mencakup kemampuan manajerial seperti pengambilan keputusan, koordinasi tim, dan pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, pemahaman tentang manajemen keperawatan menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap perawat. Perkembangan sistem pelayanan kesehatan yang semakin dinamis, ditandai dengan kemajuan teknologi medis, meningkatnya kompleksitas penyakit, serta perubahan kebutuhan masyarakat, menuntut tenaga keperawatan untuk memiliki kompetensi yang lebih luas. Perawat tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana tindakan medis, tetapi juga sebagai pengelola pelayanan yang mampu merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan secara sistematis. Dalam konteks ini, manajemen keperawatan menjadi suatu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap perawat.

Menurut Marquis dan Huston (2017), manajemen keperawatan merupakan proses penggunaan sumber daya keperawatan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Definisi ini menegaskan bahwa manajemen keperawatan tidak hanya berorientasi pada proses, tetapi juga pada hasil yang diharapkan, yaitu pelayanan yang berkualitas dan berfokus pada keselamatan pasien.

Selain itu, tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya mengharapkan kesembuhan, tetapi juga pelayanan yang manusiawi, aman, dan bermutu. Hal ini mendorong organisasi pelayanan kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam pelayanan keperawatan. Dalam kondisi ini, perawat dituntut untuk mampu mengelola pelayanan secara profesional dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, serta keselamatan pasien.

Di Indonesia, praktik keperawatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang menegaskan bahwa perawat memiliki

tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang aman, bermutu, serta sesuai dengan standar profesi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keperawatan tidak hanya memiliki dimensi praktis, tetapi juga dimensi hukum dan etika yang harus dipahami oleh setiap perawat.

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar manajemen keperawatan menjadi landasan penting dalam praktik profesional keperawatan, khususnya dalam meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Manajemen Keperawatan

Manajemen keperawatan merupakan proses sistematis dalam mengelola sumber daya keperawatan secara optimal untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Proses ini mencakup fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang saling berkaitan.

Gillies (1994) mendefinisikan manajemen keperawatan sebagai proses pengambilan keputusan yang mencakup seluruh fungsi manajemen dalam rangka memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keperawatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis karena melibatkan analisis, perencanaan, serta evaluasi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Konsep manajemen keperawatan berakar dari teori manajemen klasik yang dikembangkan oleh Henry Fayol, yang menyatakan bahwa fungsi manajemen terdiri dari *planning*, *organizing*, *directing*, dan *controlling* (Fayol, 1949). Teori ini menjadi landasan awal dalam memahami bagaimana suatu organisasi dikelola secara sistematis dan terstruktur. Dalam konteks keperawatan, konsep ini kemudian mengalami adaptasi dengan mempertimbangkan karakteristik pelayanan kesehatan yang berorientasi pada manusia (*human-oriented service*). Pelayanan keperawatan tidak hanya berfokus pada efisiensi organisasi, tetapi juga pada aspek kemanusiaan, empati, serta hubungan interpersonal antara perawat dan pasien.

Dalam praktiknya, manajemen keperawatan tidak dapat dipisahkan dari proses asuhan keperawatan yang melibatkan pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kedua proses ini memiliki kesamaan dalam hal pendekatan sistematis dan berorientasi pada tujuan. Namun demikian, manajemen keperawatan memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berfokus pada individu pasien, tetapi juga pada pengelolaan unit pelayanan, tenaga keperawatan, serta sumber daya lainnya. Dengan demikian, manajemen keperawatan dapat dipandang sebagai jembatan antara praktik klinis dan pengelolaan organisasi pelayanan kesehatan.

Dalam perspektif modern, manajemen keperawatan juga dipengaruhi oleh teori sistem yang memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi. Pendekatan ini memungkinkan perawat memahami hubungan antar komponen serta mengelola perubahan secara lebih efektif dalam sistem pelayanan kesehatan. Huber (2018) menyatakan bahwa pendekatan sistem dalam manajemen keperawatan memungkinkan organisasi

untuk memahami hubungan antar komponen serta mengelola perubahan secara efektif. Dalam konteks ini, pelayanan keperawatan dipandang sebagai suatu sistem terbuka (*open system*) yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, seperti kebijakan kesehatan, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Pendekatan sistem dalam manajemen keperawatan menekankan pentingnya integrasi antara berbagai elemen dalam organisasi, termasuk tenaga kesehatan, pasien, fasilitas, serta kebijakan. Setiap perubahan yang terjadi pada satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya. Oleh karena itu, perawat sebagai manajer harus mampu melihat pelayanan keperawatan secara holistik dan memahami dinamika yang terjadi dalam sistem tersebut. Kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam sistem pelayanan kesehatan, seperti perkembangan teknologi medis, perubahan pola penyakit, serta tuntutan mutu pelayanan yang semakin tinggi.

Selain teori sistem, konsep manajemen keperawatan modern juga dipengaruhi oleh pendekatan berbasis bukti (*evidence-based management*), yang menekankan pentingnya penggunaan data dan bukti ilmiah dalam pengambilan keputusan. Dalam keperawatan, pendekatan ini dikenal sebagai *evidence-based practice*, di mana setiap tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang valid dan terkini. Dengan demikian, manajemen keperawatan tidak hanya bergantung pada pengalaman atau intuisi, tetapi juga pada data dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Di sisi lain, manajemen keperawatan juga harus mempertimbangkan aspek etika dan legal dalam praktik keperawatan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat harus sesuai dengan standar praktik, kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek etika dalam keperawatan mencakup prinsip menghormati otonomi pasien, berbuat baik (beneficence), tidak merugikan (non-maleficence), serta keadilan (justice). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis dan manajerial.

Sementara itu, aspek legal berkaitan dengan kewajiban perawat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam praktik keperawatan. Di Indonesia, praktik keperawatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang menegaskan bahwa perawat harus memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, serta standar prosedur operasional. Kepatuhan terhadap aspek legal ini sangat penting untuk melindungi pasien serta tenaga keperawatan dari risiko hukum.

Lebih lanjut, manajemen keperawatan juga berkaitan erat dengan konsep mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan keperawatan tidak hanya diukur dari hasil akhir (*outcome*), tetapi juga dari proses dan struktur pelayanan. Donabedian

(1988) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan kesehatan dapat dinilai berdasarkan tiga komponen utama, yaitu struktur, proses, dan outcome. Struktur mencakup sumber daya yang tersedia, proses mencakup pelaksanaan pelayanan, dan outcome mencakup hasil yang dicapai. Ketiga komponen ini menjadi dasar dalam mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, manajemen keperawatan juga menghadapi tantangan baru yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen rumah sakit, rekam medis elektronik, serta telehealth menjadi bagian integral dalam pelayanan kesehatan modern. Perawat sebagai bagian dari sistem ini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Namun demikian, penerapan manajemen keperawatan dalam praktik tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, serta kompleksitas kondisi pasien. Selain itu, perubahan kebijakan dan tuntutan mutu pelayanan juga memerlukan penyesuaian dalam sistem manajemen. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi, kreativitas, serta komitmen yang tinggi dalam menjalankan perannya.

Dengan demikian, konsep dasar manajemen keperawatan merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang berkualitas. Manajemen keperawatan tidak hanya mencakup penerapan fungsi manajemen, tetapi juga melibatkan berbagai pendekatan teoritis, seperti teori sistem dan *evidence-based practice*, serta mempertimbangkan aspek etika dan legal. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep ini akan membantu perawat dalam mengelola pelayanan keperawatan secara efektif, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjamin keselamatan pasien dalam sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis.

B. Fungsi Manajemen dalam Keperawatan

Fungsi manajemen terdiri dari empat komponen utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keempat fungsi ini membentuk suatu siklus yang saling berkaitan dan berkelanjutan. Dalam keperawatan, fungsi manajemen tidak hanya berperan sebagai kerangka administratif, tetapi juga sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Secara konseptual, fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan dalam teori manajemen klasik oleh Henry Fayol yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola fungsi-fungsi tersebut secara sistematis dan terintegrasi. Dalam praktik keperawatan, konsep ini

diadaptasi dengan mempertimbangkan karakteristik pelayanan kesehatan yang bersifat kompleks, dinamis, dan berorientasi pada manusia. Oleh karena itu, penerapan fungsi manajemen dalam keperawatan tidak hanya menekankan pada efisiensi organisasi, tetapi juga pada kualitas asuhan keperawatan dan kepuasan pasien.

Perencanaan (*planning*) merupakan fungsi awal dalam manajemen yang berperan dalam menentukan arah dan tujuan pelayanan keperawatan. Melalui perencanaan, perawat dapat mengidentifikasi kebutuhan pasien, menetapkan prioritas pelayanan, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan yang baik akan memberikan kejelasan arah, mengurangi ketidakpastian, serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dalam keperawatan, perencanaan tidak hanya dilakukan pada tingkat organisasi, tetapi juga pada tingkat individu melalui proses asuhan keperawatan yang sistematis.

Fungsi berikutnya adalah pengorganisasian (*organizing*), yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola sumber daya agar dapat digunakan secara optimal. Dalam keperawatan, pengorganisasian mencakup pembagian tugas, penetapan struktur organisasi, serta pengaturan hubungan kerja antar tenaga kesehatan. Pengorganisasian yang efektif akan menciptakan sistem kerja yang terkoordinasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta mengurangi risiko kesalahan. Selain itu, pengorganisasian juga memungkinkan adanya kejelasan peran dan tanggung jawab, sehingga setiap perawat dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya.

Selanjutnya, pengarahan (*directing* atau *actuating*) merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada upaya menggerakkan dan memotivasi staf agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam keperawatan, pengarahan mencakup aspek kepemimpinan, komunikasi, motivasi, serta supervisi. Pemimpin keperawatan harus mampu memberikan arahan yang jelas, membangun hubungan kerja yang baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Pengarahan yang efektif akan meningkatkan kinerja staf, memperkuat kerja sama tim, serta mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Fungsi terakhir adalah pengendalian (*controlling*), yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui penetapan standar, pengukuran kinerja, serta tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Dalam keperawatan, pengendalian memiliki peran penting dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Melalui pengendalian yang efektif, organisasi dapat

mengidentifikasi masalah, melakukan perbaikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Keempat fungsi manajemen tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang berkesinambungan. Perencanaan yang baik akan memudahkan proses pengorganisasian, pengorganisasian yang efektif akan mendukung pengarahan, dan pengarahan yang optimal akan mempermudah pengendalian. Sebaliknya, hasil dari proses pengendalian akan menjadi dasar dalam melakukan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, fungsi manajemen dalam keperawatan merupakan suatu proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan dan kondisi pelayanan kesehatan.

Dalam praktik keperawatan, penerapan fungsi manajemen memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan. Perawat yang mampu mengimplementasikan fungsi manajemen secara efektif akan lebih mampu mengelola pelayanan keperawatan, meningkatkan efisiensi kerja, serta menjamin keselamatan pasien. Selain itu, penerapan fungsi manajemen juga dapat meningkatkan kepuasan kerja perawat serta memperkuat profesionalisme dalam praktik keperawatan.

Namun demikian, penerapan fungsi manajemen dalam keperawatan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, serta kompleksitas kondisi pasien. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi, kreativitas, serta komitmen yang tinggi dari perawat untuk dapat mengimplementasikan fungsi manajemen secara optimal. Dukungan dari organisasi dalam bentuk kebijakan yang jelas, pelatihan yang memadai, serta lingkungan kerja yang kondusif juga sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan penerapan fungsi manajemen dalam keperawatan.

Dengan demikian, fungsi manajemen dalam keperawatan merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang berkualitas. Melalui penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian secara efektif dan terintegrasi, diharapkan pelayanan keperawatan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang profesional, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

1. Perencanaan dalam Keperawatan

Perencanaan merupakan fungsi awal dalam manajemen yang menentukan arah dan tujuan organisasi. Robbins dan Coulter (2016) mendefinisikan perencanaan sebagai proses penetapan tujuan serta strategi untuk

mencapainya. Dalam keperawatan, perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan pasien, penentuan prioritas pelayanan, serta penyusunan rencana tindakan yang sistematis. Gillies (1994) menjelaskan bahwa perencanaan dalam keperawatan melibatkan beberapa tahapan, yaitu analisis situasi, penetapan tujuan, pengembangan alternatif tindakan, serta evaluasi efektivitas rencana. Proses ini membutuhkan kemampuan analisis yang kuat serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi organisasi.

Perencanaan yang efektif harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, seperti rasional, fleksibel, dan berorientasi pada tujuan. Selain itu, perencanaan juga harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal organisasi. Pendekatan yang sering digunakan adalah analisis SWOT, yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi (Sullivan, 2018).

Dalam praktik keperawatan, perencanaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Perencanaan yang baik dapat membantu perawat dalam mengelola waktu, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan koordinasi antar tim. Selain itu, perencanaan juga dapat mengurangi risiko kesalahan serta meningkatkan keselamatan pasien.

2. Pengorganisasian dalam Keperawatan

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang bertujuan mengatur dan mengelola sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam keperawatan, pengorganisasian mencakup pembagian tugas, penetapan struktur organisasi, serta pengaturan hubungan kerja antar tenaga kesehatan. Dengan demikian, pengorganisasian menjadi fondasi dalam memastikan bahwa seluruh komponen dalam pelayanan keperawatan dapat bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Secara konseptual, pengorganisasian dapat dipahami sebagai proses mengelompokkan aktivitas, menetapkan hubungan kerja, serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Marquis dan Huston (2017) menyatakan bahwa pengorganisasian melibatkan pembagian kerja, penentuan struktur organisasi, serta penetapan jalur komunikasi yang jelas. Dalam keperawatan, pengorganisasian memiliki dimensi yang lebih kompleks karena melibatkan interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, serta sistem pelayanan kesehatan yang dinamis.

Salah satu aspek utama dalam pengorganisasian adalah penentuan struktur organisasi. Struktur organisasi keperawatan menggambarkan hubungan hierarkis antara berbagai posisi dalam organisasi, termasuk kepala

bidang keperawatan, kepala ruangan, ketua tim, serta perawat pelaksana. Struktur yang jelas akan mempermudah koordinasi, memperjelas alur komunikasi, serta menghindari tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Selain itu, struktur organisasi juga berfungsi sebagai kerangka dalam pengambilan keputusan serta pengendalian kinerja.

Dalam praktik keperawatan, terdapat berbagai model pengorganisasian pelayanan yang dapat diterapkan, salah satunya adalah Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP). Model ini menekankan pada pembagian peran yang jelas antara anggota tim keperawatan serta pemberian tanggung jawab yang sesuai dengan kompetensi masing-masing individu. Dalam MPKP, kepala ruangan berperan sebagai manajer yang mengelola pelayanan secara keseluruhan, sedangkan ketua tim bertanggung jawab dalam koordinasi pelayanan pada kelompok pasien tertentu, dan perawat pelaksana bertugas memberikan asuhan keperawatan secara langsung. Model ini terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan, kepuasan pasien, serta kinerja perawat.

Selain MPKP, terdapat pula model lain seperti metode fungsional, metode tim, metode primer (*primary nursing*), dan metode kasus. Metode fungsional menekankan pada pembagian tugas berdasarkan jenis pekerjaan, sedangkan metode tim menekankan pada kerja sama antar anggota tim dalam memberikan pelayanan kepada sekelompok pasien. Metode primer memberikan tanggung jawab penuh kepada satu perawat untuk mengelola asuhan keperawatan pasien secara menyeluruh, sementara metode kasus berfokus pada pemberian asuhan keperawatan secara individual. Pemilihan model pengorganisasian harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, jumlah tenaga keperawatan, serta kebutuhan pasien.

Pengorganisasian dalam keperawatan juga mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pembagian tugas harus dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, serta beban kerja masing-masing perawat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap perawat dapat bekerja secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, pembagian tugas yang tepat juga dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan.

Penetapan wewenang dan tanggung jawab merupakan bagian penting dalam pengorganisasian. Wewenang berkaitan dengan hak untuk mengambil keputusan dan memberikan perintah, sedangkan tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan. Dalam keperawatan, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dalam pelayanan. Perawat yang

diberikan tanggung jawab harus memiliki wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

Selain itu, pengorganisasian juga berkaitan dengan koordinasi antar anggota tim. Koordinasi merupakan proses penyelarasan aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelayanan keperawatan, koordinasi sangat penting karena melibatkan berbagai profesi kesehatan, seperti dokter, tenaga farmasi, serta tenaga kesehatan lainnya. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat holistik dan terintegrasi.

Komunikasi juga merupakan elemen penting dalam pengorganisasian. Komunikasi yang efektif memungkinkan informasi disampaikan dengan jelas dan tepat waktu, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan. Dalam keperawatan, komunikasi tidak hanya bersifat vertikal (antara atasan dan bawahan), tetapi juga horizontal (antar sesama perawat) dan interprofesional. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk mendukung proses pengorganisasian.

Dalam era modern, pengorganisasian dalam keperawatan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen rumah sakit memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien serta memudahkan koordinasi antar tenaga kesehatan. Dengan adanya teknologi ini, proses pengorganisasian dapat dilakukan secara lebih efektif dan akurat.

Namun demikian, pengorganisasian dalam keperawatan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, serta kompleksitas kondisi pasien dapat menjadi hambatan dalam pengorganisasian. Selain itu, perubahan kebijakan dan tuntutan mutu pelayanan juga memerlukan penyesuaian dalam struktur dan sistem kerja. Oleh karena itu, pengorganisasian harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan.

Pengorganisasian yang efektif juga memerlukan kepemimpinan yang kuat. Pemimpin keperawatan harus mampu mengelola sumber daya, membangun kerja sama tim, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kepemimpinan yang baik akan mendukung proses pengorganisasian serta meningkatkan kinerja staf.

Lebih lanjut, pengorganisasian dalam keperawatan juga harus memperhatikan aspek mutu dan keselamatan pasien. Pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang baik, serta komunikasi yang efektif akan mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan. Oleh karena itu, pengorganisasian merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

Dengan demikian, pengorganisasian dalam keperawatan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional yang mencakup berbagai aspek, mulai dari penentuan struktur organisasi hingga koordinasi antar anggota tim. Pengorganisasian yang efektif akan mendukung pelaksanaan pelayanan keperawatan yang berkualitas, meningkatkan efisiensi kerja, serta menjamin keselamatan pasien. Oleh karena itu, perawat, khususnya yang memiliki peran manajerial, harus memiliki kemampuan dalam melakukan pengorganisasian secara efektif dan profesional.

3. Pengarahan dalam Keperawatan

Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang berfokus pada upaya menggerakkan, memotivasi, dan membimbing tenaga keperawatan agar mampu melaksanakan tugas sesuai dengan rencana. Dalam praktik keperawatan, pengarahan mencakup kepemimpinan, komunikasi, motivasi, serta supervisi. Dalam konteks manajemen keperawatan, pengarahan memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kinerja perawat, kualitas pelayanan, serta keselamatan pasien. Tanpa adanya pengarahan yang efektif, perencanaan dan pengorganisasian yang telah disusun dengan baik tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal.

Secara konseptual, pengarahan dapat dipahami sebagai proses mempengaruhi perilaku individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Terry (1993) menyatakan bahwa pengarahan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota organisasi agar bersedia dan mampu bekerja secara efektif. Dalam keperawatan, pengarahan tidak hanya mencakup pemberian instruksi, tetapi juga melibatkan aspek kepemimpinan, komunikasi, motivasi, serta pembinaan profesional.

Salah satu komponen utama dalam pengarahan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam keperawatan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi tenaga keperawatan agar dapat bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan pelayanan. Perawat yang memiliki peran sebagai kepala ruangan atau ketua tim harus mampu menjalankan fungsi kepemimpinan secara efektif, termasuk dalam memberikan arahan yang jelas, mengambil keputusan yang tepat, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Sullivan (2018) menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam keperawatan dapat meningkatkan kinerja staf, memperkuat kerja sama tim, serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam keperawatan, antara lain gaya otoriter, demokratis, dan

transformasional. Gaya kepemimpinan otoriter cenderung menekankan pada kontrol dan pengambilan keputusan oleh pemimpin, sedangkan gaya demokratis melibatkan partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, gaya kepemimpinan transformasional lebih berfokus pada pemberdayaan, inspirasi, dan pengembangan potensi individu. Dalam konteks pelayanan keperawatan modern, gaya kepemimpinan transformasional dianggap paling efektif karena mampu meningkatkan motivasi dan komitmen staf terhadap organisasi.

Selain kepemimpinan, komunikasi juga merupakan elemen kunci dalam pengarahan. Komunikasi yang efektif memungkinkan informasi disampaikan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan. Dalam keperawatan, komunikasi tidak hanya terjadi antara perawat dengan pasien, tetapi juga antar anggota tim kesehatan. Oleh karena itu, perawat harus memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang baik, termasuk kemampuan mendengarkan secara aktif, menyampaikan informasi dengan jelas, serta memberikan umpan balik yang konstruktif.

Pengarahan juga berkaitan erat dengan motivasi kerja. Motivasi merupakan faktor yang mendorong individu untuk bekerja dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam keperawatan, motivasi kerja sangat penting karena berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien. Pemimpin keperawatan harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi staf, misalnya melalui pemberian penghargaan, pengakuan atas kinerja, serta kesempatan untuk pengembangan profesional. Teori motivasi seperti teori kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Herzberg sering digunakan sebagai dasar dalam memahami dan meningkatkan motivasi kerja dalam organisasi.

Selain itu, pengarahan dalam keperawatan juga mencakup kegiatan supervisi. Supervisi merupakan proses pengawasan dan pembinaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan keperawatan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Melalui supervisi, pemimpin keperawatan dapat memberikan bimbingan, mengidentifikasi masalah, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan. Supervisi yang efektif tidak bersifat mengontrol secara kaku, tetapi lebih menekankan pada pembinaan dan pengembangan kompetensi staf.

Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, pengarahan juga mencakup kegiatan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Perawat harus senantiasa memperbarui pengetahuan dan keterampilannya agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

kesehatan. Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan harus menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan staf. Pengarahan yang baik akan mendorong perawat untuk terus belajar dan mengembangkan diri.

Pengarahan dalam keperawatan juga memiliki peran penting dalam membangun kerja sama tim (*teamwork*). Pelayanan kesehatan merupakan hasil kerja kolaboratif antara berbagai profesi, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik. Pemimpin keperawatan harus mampu membangun hubungan kerja yang harmonis antar anggota tim, serta menciptakan budaya kerja yang saling mendukung. Kerja sama tim yang baik akan meningkatkan efisiensi pelayanan serta mengurangi risiko kesalahan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengarahan dalam keperawatan sering menghadapi berbagai tantangan. Beban kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya, serta perbedaan karakter individu dapat menjadi hambatan dalam proses pengarahan. Selain itu, kurangnya kemampuan kepemimpinan dan komunikasi juga dapat memengaruhi efektivitas pengarahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kompetensi manajerial perawat, khususnya dalam aspek kepemimpinan dan komunikasi.

Dalam era modern, pengarahan dalam keperawatan juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien, serta memudahkan koordinasi antar tenaga kesehatan. Namun demikian, penggunaan teknologi juga memerlukan kemampuan adaptasi serta pemahaman yang baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Lebih lanjut, pengarahan dalam keperawatan harus dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan fungsi manajemen lainnya. Pengarahan tidak hanya dilakukan pada tahap implementasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari proses evaluasi dan perbaikan pelayanan. Dengan demikian, pengarahan dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pengarahan dalam keperawatan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan pelayanan keperawatan. Pengarahan tidak hanya berkaitan dengan pemberian instruksi, tetapi juga mencakup kepemimpinan, komunikasi, motivasi, supervisi, serta pengembangan sumber daya manusia. Melalui pengarahan yang efektif, perawat dapat bekerja secara optimal, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menjamin keselamatan pasien. Oleh karena itu, setiap perawat, khususnya yang memiliki peran manajerial, harus memiliki kemampuan dalam melakukan pengarahan secara efektif dan profesional.

4. Pengendalian dalam Keperawatan

Pengendalian (*controlling*) merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen keperawatan, pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, pengendalian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen keperawatan secara keseluruhan.

Secara konseptual, pengendalian dapat dipahami sebagai proses sistematis yang melibatkan penetapan standar, pengukuran kinerja, perbandingan antara hasil aktual dengan standar, serta pengambilan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Fayol (1949) menyatakan bahwa pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi. Dalam keperawatan, pengendalian memiliki dimensi yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Dalam praktik keperawatan, pengendalian dimulai dengan penetapan standar pelayanan yang jelas dan terukur. Standar ini dapat berupa standar asuhan keperawatan, standar prosedur operasional (SPO), maupun indikator mutu pelayanan. Standar tersebut menjadi acuan bagi perawat dalam melaksanakan tugasnya, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja. Tanpa adanya standar yang jelas, proses pengendalian tidak dapat dilakukan secara efektif karena tidak ada tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja.

Setelah standar ditetapkan, langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti audit keperawatan, observasi langsung, penilaian kinerja staf, serta pengumpulan data indikator mutu. Audit keperawatan merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk menilai kualitas asuhan keperawatan, yang mencakup evaluasi terhadap struktur, proses, dan hasil pelayanan. Melalui audit ini, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelayanan keperawatan.

Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Apabila

ditemukan adanya penyimpangan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap penyebab penyimpangan tersebut. Analisis ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan korektif yang diambil tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi masalah.

Tindakan korektif merupakan tahap akhir dalam proses pengendalian. Tindakan ini dapat berupa perbaikan prosedur, peningkatan kompetensi staf melalui pelatihan, penyesuaian kebijakan, atau perubahan dalam sistem kerja. Dalam beberapa kasus, tindakan korektif juga dapat melibatkan perubahan struktur organisasi atau redistribusi sumber daya. Tujuan utama dari tindakan korektif adalah untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dapat kembali sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam konteks keperawatan, pengendalian juga memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan pasien (*patient safety*). Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan kesehatan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan harus meminimalkan risiko terjadinya kesalahan. Pengendalian yang efektif dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko serta mencegah terjadinya insiden yang dapat merugikan pasien. Oleh karena itu, pengendalian dalam keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek kinerja, tetapi juga pada aspek keselamatan.

Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam pengendalian mutu pelayanan keperawatan adalah model yang dikemukakan oleh Donabedian (1988), yang membagi kualitas pelayanan menjadi tiga komponen utama, yaitu struktur, proses, dan outcome. Struktur mencakup sumber daya yang tersedia, seperti tenaga keperawatan, fasilitas, dan peralatan. Proses mencakup pelaksanaan pelayanan keperawatan, sedangkan outcome mencakup hasil yang dicapai, seperti tingkat kesembuhan pasien, kepuasan pasien, serta tingkat komplikasi. Ketiga komponen ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan.

Selain itu, pengendalian dalam keperawatan juga berkaitan erat dengan penerapan indikator mutu. Indikator mutu merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan keperawatan. Contoh indikator mutu dalam keperawatan antara lain angka kejadian infeksi nosokomial, angka kejadian luka tekan (*pressure ulcer*), tingkat kepatuhan terhadap prosedur, serta tingkat kepuasan pasien. Dengan memantau indikator-indikator ini secara berkala, organisasi dapat mengevaluasi kinerja pelayanan serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Dalam era modern, pengendalian dalam keperawatan juga didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sistem informasi manajemen rumah sakit

memungkinkan pengumpulan dan analisis data secara lebih cepat dan akurat. Data ini dapat digunakan untuk memantau kinerja pelayanan, mengidentifikasi tren, serta mendukung pengambilan keputusan. Dengan demikian, teknologi informasi menjadi alat yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengendalian dalam keperawatan.

Namun demikian, pelaksanaan pengendalian dalam keperawatan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya mutu pelayanan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengendalian. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari seluruh pihak, baik manajemen maupun tenaga keperawatan, untuk menerapkan pengendalian secara konsisten dan berkelanjutan.

Selain itu, budaya organisasi juga memiliki peran penting dalam keberhasilan pengendalian. Organisasi yang memiliki budaya mutu dan keselamatan yang kuat akan mendorong setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. Dalam budaya seperti ini, kesalahan tidak dipandang sebagai kegagalan individu, tetapi sebagai peluang untuk perbaikan sistem.

Lebih lanjut, pengendalian dalam keperawatan juga harus dilakukan secara berkesinambungan melalui siklus perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Pendekatan ini menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus untuk mencapai kualitas pelayanan yang optimal. Dengan menerapkan pendekatan ini, organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan serta meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pengendalian dalam keperawatan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional yang mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan. Pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan mutu pelayanan, menjamin keselamatan pasien, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, perawat harus memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep dan penerapan pengendalian dalam keperawatan agar dapat menjalankan perannya secara efektif

C. Peran Perawat dalam Manajemen Keperawatan

Peran perawat dalam manajemen keperawatan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan keperawatan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Dalam sistem pelayanan kesehatan modern, perawat tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pelaksana tindakan klinis,

tetapi juga sebagai aktor kunci yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan, pengambilan keputusan, serta peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan. Perubahan paradigma ini sejalan dengan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang profesional dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Dalam konteks manajemen keperawatan, perawat memiliki peran yang multidimensional yang mencakup:

- Fungsi Klinis
- Manajerial
- Edukatif
- Koordinatif
- Advokasi

Peran-peran tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang terintegrasi dalam pelayanan keperawatan. Marquis dan Huston (2017) menegaskan bahwa perawat sebagai bagian dari sistem manajemen memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya keperawatan serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu peran utama perawat adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan (*care provider*). Dalam peran ini, perawat bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien melalui proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Peran ini merupakan inti dari praktik keperawatan dan menjadi dasar bagi peran-peran lainnya. Namun demikian, dalam konteks manajemen keperawatan, peran sebagai pemberi asuhan tidak dapat dipisahkan dari kemampuan dalam mengelola pelayanan secara keseluruhan.

Selain sebagai pemberi asuhan, perawat juga berperan sebagai manajer. Dalam peran ini, perawat bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan. Perawat yang memiliki posisi sebagai kepala ruangan atau ketua tim memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sumber daya manusia, mengatur jadwal kerja, serta memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Peran manajerial ini menuntut perawat untuk memiliki kemampuan kepemimpinan, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang efektif.

Peran perawat sebagai pemimpin (*leader*) juga merupakan bagian penting dalam manajemen keperawatan. Kepemimpinan dalam keperawatan tidak hanya berkaitan dengan posisi formal dalam organisasi, tetapi juga mencakup

kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Perawat sebagai pemimpin harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, membangun kerja sama tim yang solid, serta mendorong peningkatan kinerja staf. Sullivan (2018) menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam keperawatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan pasien.

Di samping itu, perawat juga berperan sebagai edukator. Dalam peran ini, perawat bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien, keluarga, serta masyarakat. Pendidikan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan, sehingga dapat mendorong perilaku hidup sehat serta meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, perawat juga memiliki peran dalam pendidikan bagi tenaga keperawatan lainnya, baik melalui kegiatan pelatihan, mentoring, maupun supervisi.

Peran lain yang tidak kalah penting adalah sebagai komunikator. Komunikasi merupakan elemen kunci dalam pelayanan keperawatan, karena melibatkan interaksi antara perawat dengan pasien, keluarga, serta tenaga kesehatan lainnya. Perawat harus mampu menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan empatik, serta mampu mendengarkan dengan baik. Komunikasi yang efektif akan meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan kepuasan pasien.

Perawat juga berperan sebagai koordinator dalam pelayanan kesehatan. Dalam peran ini, perawat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan pelayanan yang melibatkan berbagai profesi kesehatan. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat holistik dan terintegrasi. Perawat harus mampu bekerja sama dengan dokter, tenaga medis lainnya, serta pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal.

Selain itu, perawat juga memiliki peran sebagai advokat bagi pasien. Dalam peran ini, perawat bertindak sebagai pembela kepentingan pasien, khususnya dalam hal hak-hak pasien, keselamatan, serta kualitas pelayanan. Perawat harus memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan yang adil, aman, dan sesuai dengan kebutuhan. Peran advokasi ini sangat penting dalam melindungi pasien dari praktik yang tidak sesuai dengan standar serta dalam memastikan bahwa suara pasien didengar dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks manajemen keperawatan modern, peran perawat juga berkembang menjadi agen perubahan (*change agent*). Perawat dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalah dalam sistem pelayanan, serta mengembangkan

inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Peran ini memerlukan kemampuan analisis, kreativitas, serta keberanian untuk melakukan perubahan. Huber (2018) menyatakan bahwa perawat sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pelayanan serta adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan.

Selain itu, perawat juga berperan sebagai peneliti (*researcher*) dalam upaya pengembangan ilmu keperawatan. Melalui kegiatan penelitian, perawat dapat menghasilkan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) menjadi salah satu pilar penting dalam praktik keperawatan modern, di mana setiap tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang valid.

Peran perawat dalam manajemen keperawatan juga tidak terlepas dari tanggung jawab dalam menjaga mutu dan keselamatan pasien. Perawat harus mampu mengidentifikasi risiko, menerapkan standar keselamatan, serta melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini, perawat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kesalahan medis serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam menjalankan berbagai peran tersebut, perawat sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, serta kompleksitas kondisi pasien. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari organisasi dalam bentuk kebijakan yang jelas, pelatihan yang memadai, serta lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu, perawat juga harus memiliki komitmen untuk terus mengembangkan kompetensinya agar dapat menjalankan perannya secara optimal.

Dengan demikian, peran perawat dalam manajemen keperawatan merupakan peran yang kompleks dan multidimensional yang mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan. Perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai manajer, pemimpin, edukator, komunikator, koordinator, advokat, agen perubahan, dan peneliti. Penguasaan berbagai peran ini menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan serta dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

D. Tanggung Jawab Perawat

Tanggung jawab merupakan salah satu aspek utama dalam praktik keperawatan yang mencerminkan kewajiban perawat dalam melaksanakan tugas dan perannya sesuai dengan standar profesi, kode etik, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelayanan kesehatan, perawat memiliki tanggung jawab

untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, holistik, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Tanggung jawab ini menjadi dasar profesionalisme perawat dalam menjalankan praktik keperawatan.

Tanggung jawab perawat mencakup berbagai aspek pelayanan, mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan, perencanaan tindakan, implementasi, hingga evaluasi hasil asuhan keperawatan. Setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan klinis, serta pertimbangan profesional yang tepat. Perawat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar praktik keperawatan dan prinsip keselamatan pasien.

Selain tanggung jawab profesional, perawat juga memiliki tanggung jawab etika. Dalam menjalankan praktiknya, perawat harus menjunjung tinggi kode etik keperawatan, seperti menghormati hak dan martabat pasien, menjaga kerahasiaan informasi medis, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, serta menghargai nilai dan budaya pasien. Dalam situasi tertentu, perawat dapat menghadapi dilema etika yang membutuhkan kemampuan pengambilan keputusan secara bijaksana dan bertanggung jawab.

Tanggung jawab hukum juga menjadi bagian penting dalam praktik keperawatan. Setiap tindakan keperawatan memiliki konsekuensi hukum sehingga perawat harus memahami regulasi, standar prosedur operasional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menegaskan bahwa perawat wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan standar pelayanan yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka perawat dapat dikenai sanksi hukum maupun disiplin profesi.

Dalam praktik sehari-hari, perawat juga bertanggung jawab untuk melakukan dokumentasi keperawatan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Dokumentasi ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, bukti pelaksanaan asuhan keperawatan, serta bukti hukum apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kemampuan melakukan pencatatan yang sistematis menjadi bagian penting dari tanggung jawab perawat.

Selain memberikan pelayanan langsung kepada pasien, perawat yang memiliki peran manajerial, seperti kepala ruangan atau ketua tim, memiliki tanggung jawab tambahan dalam mengelola sumber daya, mengkoordinasikan pelayanan, serta memastikan seluruh anggota tim bekerja sesuai standar yang ditetapkan. Tanggung jawab ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan keperawatan yang efektif, efisien, dan berkualitas.

Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab perawat sering menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, beban kerja yang tinggi, dan kompleksitas kondisi pasien. Oleh karena itu, diperlukan dukungan organisasi pelayanan kesehatan melalui kebijakan yang jelas, pelatihan yang berkelanjutan, serta lingkungan kerja yang kondusif agar perawat dapat menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.

E. Akuntabilitas Perawat

Akuntabilitas merupakan kewajiban perawat untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Dalam praktik keperawatan, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan hasil tindakan, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan dan alasan yang mendasari tindakan tersebut. Huber (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam keperawatan mencakup tanggung jawab profesional, etika, dan legal yang harus dipenuhi oleh setiap perawat dalam praktiknya.

Akuntabilitas menjadi salah satu indikator penting profesionalisme perawat karena menunjukkan kemampuan perawat dalam bertindak sesuai standar praktik dan prinsip etika profesi. Perawat harus mampu menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan telah didasarkan pada pengetahuan ilmiah, bukti yang valid, serta pertimbangan klinis yang tepat. Dengan demikian, akuntabilitas berperan dalam menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Salah satu bentuk akuntabilitas perawat adalah penerapan evidence-based practice dalam pelayanan keperawatan. Perawat dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya melalui pendidikan berkelanjutan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan tindakan saat ini, tetapi juga dengan upaya pengembangan kompetensi secara terus-menerus.

Akuntabilitas perawat juga berkaitan erat dengan dokumentasi keperawatan. Dokumentasi yang lengkap dan tepat menjadi bukti bahwa perawat telah melaksanakan tindakan sesuai standar yang berlaku. Selain sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, dokumentasi juga memiliki fungsi legal dalam melindungi perawat apabila terjadi tuntutan hukum. Oleh karena itu, pencatatan yang sistematis dan akurat merupakan bagian penting dari akuntabilitas profesional.

Dalam konteks manajemen keperawatan, akuntabilitas tidak hanya bersifat individual tetapi juga kolektif. Perawat yang memiliki peran sebagai manajer

bertanggung jawab terhadap kinerja tim dan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kepala ruangan atau ketua tim harus mampu memastikan bahwa setiap anggota tim melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Selain itu, akuntabilitas juga diwujudkan melalui evaluasi pelayanan keperawatan. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan, mengidentifikasi masalah, serta menentukan upaya perbaikan yang diperlukan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan pasien dan perkembangan sistem pelayanan kesehatan.

Budaya organisasi memiliki peran penting dalam mendukung akuntabilitas perawat. Organisasi yang memiliki budaya keselamatan pasien (safety culture) akan mendorong perawat untuk melaporkan kesalahan, melakukan refleksi terhadap praktik yang dilakukan, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam budaya ini, kesalahan dipandang sebagai peluang untuk memperbaiki sistem, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan individu.

Dengan demikian, akuntabilitas perawat merupakan bentuk pertanggungjawaban profesional terhadap setiap tindakan yang dilakukan dalam praktik keperawatan. Penerapan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi perawat, serta mendukung terciptanya keselamatan pasien secara optimal.

F. Penutup

Manajemen keperawatan merupakan fondasi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan pasien. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern yang semakin kompleks, peran manajemen tidak lagi dipandang sebagai fungsi administratif semata, melainkan sebagai suatu proses strategis yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab ini, manajemen keperawatan mencakup serangkaian fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Keempat fungsi tersebut membentuk suatu siklus manajemen yang berkesinambungan, di mana setiap tahap memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan memberikan arah dan tujuan yang jelas, pengorganisasian memastikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang efektif, pengarahan menggerakkan dan memotivasi sumber daya manusia, serta pengendalian

menjamin bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, penerapan fungsi manajemen keperawatan tidak dapat dipisahkan dari peran perawat sebagai aktor utama dalam pelayanan kesehatan. Perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan keperawatan, tetapi juga sebagai manajer, pemimpin, komunikator, edukator, dan advokat bagi pasien. Peran yang multidimensional ini menuntut perawat untuk memiliki kompetensi yang komprehensif, tidak hanya dalam aspek klinis tetapi juga dalam aspek manajerial dan kepemimpinan. Dengan demikian, penguasaan konsep dasar manajemen keperawatan menjadi suatu keharusan bagi setiap perawat dalam menjalankan praktik profesionalnya.

Selain itu, tanggung jawab dan akuntabilitas perawat dalam pelayanan keperawatan juga menjadi aspek yang sangat penting dalam manajemen keperawatan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, etis, dan legal. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap standar praktik, penerapan kode etik profesi, serta dokumentasi yang akurat dan lengkap. Dalam konteks ini, manajemen keperawatan tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, tetapi juga untuk menjamin perlindungan terhadap pasien serta tenaga keperawatan itu sendiri.

Di sisi lain, tantangan dalam manajemen keperawatan terus berkembang seiring dengan perubahan sistem pelayanan kesehatan. Keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja yang tinggi, tuntutan mutu pelayanan, serta perkembangan teknologi menjadi faktor-faktor yang memengaruhi kompleksitas manajemen keperawatan. Oleh karena itu, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi serta mampu mengembangkan inovasi dalam pengelolaan pelayanan keperawatan. Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) serta penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas manajemen keperawatan.

Lebih lanjut, manajemen keperawatan juga memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen yang efektif, organisasi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan kepuasan pasien. Dalam hal ini, indikator mutu seperti keselamatan pasien, kepuasan pasien, serta outcome pelayanan menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen keperawatan.

Dalam perspektif yang lebih luas, manajemen keperawatan juga berkontribusi terhadap pengembangan profesi keperawatan itu sendiri. Dengan

adanya sistem manajemen yang baik, perawat memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, meningkatkan kinerja, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat organisasi. Hal ini akan meningkatkan profesionalisme perawat serta memperkuat posisi keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa manajemen keperawatan merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar manajemen keperawatan serta kemampuan dalam mengaplikasikannya dalam praktik merupakan kompetensi yang sangat penting bagi setiap perawat. Dengan penerapan manajemen keperawatan yang efektif, diharapkan pelayanan keperawatan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

G. Aktivitas 1 — *Knows How*

Ruang rawat inap penyakit dalam di sebuah rumah sakit memiliki kapasitas 30 tempat tidur dengan tingkat hunian (BOR) 90%. Pada shift pagi, terdapat 1 kepala ruangan dan 5 perawat pelaksana yang bertugas.Pada hari tersebut, terjadi peningkatan jumlah pasien dengan kondisi kompleks, seperti diabetes melitus, hipertensi, dan gagal jantung. Salah satu perawat melaporkan bahwa beban kerja meningkat, sementara pembagian tugas belum merata. Selain itu, terdapat keluhan dari pasien terkait keterlambatan pemberian obat dan kurangnya edukasi kesehatan.

Kepala ruangan melakukan evaluasi dan menemukan masalah:

1. Pembagian tugas belum berdasarkan tingkat ketergantungan pasien
2. Komunikasi antar perawat kurang efektif
3. Tidak semua perawat menjalankan peran edukator dengan optimal
4. Dokumentasi asuhan keperawatan belum lengkap

Diskusi Kelompok Kecil:

1. Apa masalah utama dalam pelayanan keperawatan?
2. Bagaimana dampak peningkatan pasien kompleks terhadap beban kerja?
3. Apa konsekuensi pembagian tugas tidak berbasis ketergantungan pasien?
4. Mengapa keterlambatan obat dan kurang edukasi terjadi?

H. Aktivitas 2 — Shows How

1. Simulasi Analisis Manajemen keperawatan dan peran perawat (Role Play + Presentasi)

Aktivitas ini dirancang untuk melatih mahasiswa mendemonstrasikan kemampuan analisis manajemen keperawatan secara langsung melalui simulasi peran manajerial dan presentasi rekomendasi berbasis bukti. Mahasiswa tidak hanya diminta memahami konsep secara teoritis, tetapi menunjukkan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam pengambilan keputusan manajerial yang nyata dan kontekstual.

2. Deskripsi Kegiatan

Ruang rawat inap penyakit dalam:

- Kapasitas: 30 tempat tidur
- BOR: 90%
- SDM: 1 kepala ruangan + 5 perawat pelaksana (shift pagi)

Permasalahan:

- Beban kerja meningkat (pasien DM, hipertensi, gagal jantung)
- Pembagian tugas tidak merata
- Keterlambatan pemberian obat
- Edukasi pasien kurang optimal
- Komunikasi antar perawat kurang efektif
- Dokumentasi asuhan belum lengkap

3. Pembagian Peran (Role Play)

Setiap kelompok (5–6 mahasiswa):

a. Kepala Ruangan

1) Memimpin rapat
2) Mengambil keputusan
3) Menyusun strategi perbaikan

b. Perawat Senior / Ketua Tim

1) Menjelaskan kondisi pembagian tugas
2) Mengusulkan perbaikan sistem kerja

c. Perawat Pelaksana 1

1) Menyampaikan beban kerja tinggi
2) Mengeluhkan ketidakseimbangan tugas

d. Perawat Pelaksana 2

1) Menyampaikan masalah komunikasi dan keterlambatan obat

e. Perawat Pelaksana 3 / Edukator

1) Menjelaskan kendala dalam edukasi pasien

f. Observer / Tim Mutu

1) Mengidentifikasi masalah dokumentasi dan patient safety

4. Alur Simulasi

Tahap 1: Analisis Kelompok (20–30 menit)
Mahasiswa:

- Mengidentifikasi masalah utama
- Mengelompokkan masalah berdasarkan fungsi manajemen
- Menentukan prioritas masalah

Tahap 2: Role Play (Simulasi Rapat Ruangan) (20 menit)
Alur rapat:

1. Kepala ruangan membuka rapat
2. Perawat menyampaikan masalah masing-masing
3. Diskusi tim
4. Kepala ruangan merumuskan solusi

Contoh Dialog Singkat (Panduan)

- Perawat: "Pembagian pasien belum mempertimbangkan tingkat ketergantungan…"
- Ketua tim: "Perlu sistem pembagian berbasis acuity pasien…"
- Observer: "Dokumentasi belum lengkap, berisiko terhadap keselamatan pasien…"
- Kepala ruangan: "Kita akan evaluasi pembagian tugas dan memperbaiki komunikasi tim…"

Tahap 3: Presentasi (15–20 menit)
Kelompok mempresentasikan:

- Identifikasi masalah
- Analisis fungsi manajemen
- Solusi yang diusulkan

5. Fokus Analisis Mahasiswa

Mahasiswa harus mampu mengaitkan dengan:

a. Planning (Perencanaan)

- Tidak ada perencanaan beban kerja berbasis tingkat ketergantungan pasien

b. Organizing (Pengorganisasian)

- Pembagian tugas tidak merata
- Struktur kerja tim kurang jelas

c. Directing (Pengarahan)

- Kurangnya komunikasi dan supervisi
- Peran edukator belum optimal

d. Controlling (Pengendalian)

- Tidak ada monitoring dokumentasi
- Keterlambatan pemberian obat

6. Rekomendasi Solusi yang Diharapkan

Mahasiswa diharapkan menghasilkan solusi seperti:

a. Pembagian pasien berdasarkan tingkat ketergantungan (*acuity level*)
b. Penerapan metode tim (team nursing)
c. Peningkatan komunikasi (briefing sebelum shift)
d. Penjadwalan edukasi pasien
e. Audit dokumentasi keperawatan
f. Supervisi aktif oleh kepala ruangan

7. Output Kegiatan

a. Analisis masalah berbasis manajemen
b. Solusi sistematis dan aplikatif
c. Simulasi komunikasi profesional
d. Presentasi kelompok

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	**Metode**
Knows	Latihan soal pilihan ganda dan definisi konsep organisasi keperawatan
Knows How	*Self-check* + analisis mini-*case* tertulis secara individual
Shows How	Simulasi peran manajerial + presentasi rekomendasi kelompok

Critical item

a. Mampu mengidentifikasi minimal 80% masalah utama
b. Gap analysis logis dan sesuai standar
c. Rekomendasi aplikatif dan realistis
d. Komunikasi jelas, profesional, dan sistematis

8. Rubrik Penilaian (Skala 1–4)

Aspek	1	2	3	4
Identifikasi Masalah	Tidak tepat	Kurang lengkap	Cukup	Sangat komprehensif
Analisis Manajemen	Tidak sesuai	Sebagian	Tepat	Sangat mendalam
Solusi	Tidak relevan	Kurang efektif	Efektif	Sangat aplikatif
Role Play	Tidak aktif	Kurang	Aktif	Sangat profesional
Presentasi	Tidak jelas	Kurang	Jelas	Sangat sistematis

Tujuan Pembelajaran

- Melatih keterampilan komunikasi manajerial
- Mengembangkan kepemimpinan dalam keperawatan
- Meningkatkan kemampuan kerja tim

Catatan Penting:

Nilai tinggi pada aspek lain tidak dapat menutupi kegagalan pada *critical items*. Mahasiswa yang tidak mampu mengidentifikasi *red flags* keselamatan pasien dan melakukan eskalasi yang tepat dinyatakan **belum lulus** pada station ini meskipun nilai aspek lainnya tinggi, karena kompetensi tersebut merupakan fondasi keselamatan yang tidak dapat dikompromikan dalam praktik manajerial keperawatan.

9. Template Soal OSCE Manajemen Keperawatan

No	Komponen	Isi
1	Nomor station	…… (Dikosongkan)
2	Judul station	Analisis Manajement Keperawatan pada Ruang Rawat Inap
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta dalam menganalisis masalah manajemen keperawatan berdasarkan fungsi manajemen, merumuskan solusi berbasis standar, serta mendemonstrasikan komunikasi manajerial secara profesional.

5	Kompetensi	1. Analisis masalah pada ruang keperawatan dan tata kelola keperawatan 2. Pengambilan keputusan manajerial berbasis bukti 3. Komunikasi profesional dan eskalasi masalah 4. Kolaborasi interprofesional 5. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Organisasi dan manajemen keperawatan 2. Keselamatan pasien 3. Koordinasi dan kolaborasi layanan 4. Kesinambungan pelayanan
7	Instruksi untuk peserta ujian	**SKENARIO KLINIK:** Anda adalah kepala ruangan di ruang rawat inap penyakit dalam dengan kapasitas 30 tempat tidur dan BOR 90%. Pada shift pagi terdapat 5 perawat pelaksana. Terjadi peningkatan pasien dengan kondisi kompleks (diabetes melitus, hipertensi, gagal jantung). Dalam satu minggu terakhir ditemukan beberapa masalah: - Pembagian tugas tidak merata dan tidak berdasarkan tingkat ketergantungan pasien - Keterlambatan pemberian obat - Komunikasi antar perawat kurang efektif - Edukasi pasien belum optimal - Dokumentasi asuhan keperawatan belum lengkap Anda diminta oleh kepala bidang keperawatan untuk menyampaikan analisis dan rencana perbaikan. **TUGAS:** 1. Lakukan analisis masalah berdasarkan fungsi manajemen (planning, organizing, directing, controlling). 2. Identifikasi minimal tiga risiko keselamatan pasien (*patient safety risks*). 3. Tuliskan rekomendasi perbaikan terkait pembagian tugas, komunikasi, edukasi, dan dokumentasi.

		4. Demonstrasikan komunikasi manajerial kepada penguji secara profesional.
8	Instruksi untuk penguji	Skenario klinik disama dengan skenario peserta ujian 1. Menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi masalah manajemen: - Pembagian tugas tidak berbasis acuity pasien - Beban kerja tidak seimbang - Lemahnya komunikasi tim - Dokumentasi tidak lengkap 2. Menilai identifikasi risiko keselamatan pasien: - Keterlambatan obat - Dokumentasi tidak lengkap - Edukasi pasien tidak optimal 3. Menilai kualitas solusi: - Pembagian pasien berbasis tingkat ketergantungan - Briefing tim sebelum shift - Peningkatan komunikasi (SBAR) - Audit dokumentasi 4. Menilai komunikasi peserta: sistematis, jelas, profesional 5. Mengajukan 1 pertanyaan klarifikasi di akhir 6. Tidak menginterupsi selama presentasi 7. perilaku profesional peserta selama seluruh durasi station.
9	Instruksi untuk klien standar	1. Penguji berperan sebagai kepala bidang keperawatan 2. Bersikap netral dan profesional 3. Memberikan pertanyaan: "Dari semua masalah, mana yang paling prioritas dan mengapa?" 4. Menilai kemampuan peserta dalam menentukan prioritas berbasis risiko

10	*Setting* station	Ruang simulasi manajerial - Meja peserta dan penguji - Lembar jawaban - Whiteboard (opsional)
11	Peralatan yang dibutuhkan	**1.** dibutuhkan 1. Lembar soal 2. Lembar jawaban 3. Alat tulis 4. Checklist penilaian 5. Timer 6. Whiteboard (opsional) Peran laboran: menyiapkan alat dan mengatur waktu
12	Penulis	…… ……
13	Referensi	Huber, D. L. (2022). *Leadership and nursing care management* (7th ed.). Elsevier. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI. Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application* (10th ed.). Wolters Kluwer. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit. Sullivan, E. J. (2022). *Effective leadership and management in nursing* (9th ed.). Pearson. Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (1st ed.). DPP PPNI.

10. SOP Analisis Manajemen Keperawatan dan Peran Perawat Dalam Pelayanan

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan (Ya)	Dilakukan (Tidak)	Kompeten (Ya)	Kompeten (Tidak)
A. Tahap Pra Interaksi					
1	Mengecek standar (SOP, SAK, SNARS)	☐	☐	☐	☐
2	Menyiapkan instrumen (observasi, gap analysis, rekomendasi)	☐	☐	☐	☐
3	Mengidentifikasi aspek (SDM, alur kerja, dokumentasi, patient safety)	☐	☐	☐	☐
B. Tahap Orientasi					
4	Memperkenalkan diri kepada kepala ruangan	☐	☐	☐	☐
5	Menjelaskan tujuan kegiatan	☐	☐	☐	☐
6	Membangun komunikasi profesional	☐	☐	☐	☐
C. Tahap Kerja					
7	Melakukan observasi pelayanan keperawatan	☐	☐	☐	☐
8	Wawancara dengan perawat	☐	☐	☐	☐

9	Mengkaji dokumentasi asuhan keperawatan	☐	☐	☐	☐
10	Mengidentifikasi fungsi manajemen	☐	☐	☐	☐
11	Mengidentifikasi masalah dan red flags	☐	☐	☐	☐
12	Melakukan gap analysis	☐	☐	☐	☐
13	Menyusun rekomendasi	☐	☐	☐	☐
14	Melakukan analisis fungsi manajemen (planning–controlling)	☐	☐	☐	☐
15	Melakukan gap analysis	☐	☐	☐	☐
D. Tahap Terminasi					
16	Menyampaikan hasil kepada kepala ruangan	☐	☐	☐	☐
17	Melakukan komunikasi SBAR	☐	☐	☐	☐
18	Menutup interaksi secara profesional	☐	☐	☐	☐
E. Tahap Dokumentasi					
19	Menyusun laporan	☐	☐	☐	☐
20	Membuat tabel gap analysis	☐	☐	☐	☐

21	Menuliskan rekomendasi	☐	☐	☐	☐
F. Penampilan Profesional					
22	Berpakaian rapi	☐	☐	☐	☐
23	Bersikap sopan	☐	☐	☐	☐
24	Komunikasi efektif	☐	☐	☐	☐
25	Menjaga etika dan kerahasiaan	☐	☐	☐	☐

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan (Ya)	Dilakukan (Tidak)	Kompeten (Ya)	Kompeten (Tidak)
A. Tahap Pra Interaksi					
1	Menelaah standar yang berlaku (SOP, SAK, SNARS) sebagai dasar analisis pelayanan keperawatan	☐	☐	☐	☐
2	Mempersiapkan instrumen penilaian meliputi lembar observasi, gap analysis, dan format rekomendasi	☐	☐	☐	☐
3	Mengidentifikasi komponen yang akan dianalisis, mencakup sumber daya manusia, alur kerja, dokumentasi, dan aspek keselamatan pasien	☐	☐	☐	☐
B. Tahap Orientasi					

4	Melakukan perkenalan diri secara profesional kepada kepala ruangan atau penanggung jawab unit	☐	☐	☐	☐
5	Menyampaikan tujuan dan ruang lingkup kegiatan secara jelas dan sistematis	☐	☐	☐	☐
6	Membangun komunikasi terapeutik dan profesional dengan tenaga kesehatan di unit	☐	☐	☐	☐
C. Tahap Kerja					
7	Melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan pelayanan keperawatan di unit	☐	☐	☐	☐
8	Melaksanakan wawancara dengan perawat untuk memperoleh data pendukung terkait pelayanan	☐	☐	☐	☐
9	Melakukan telaah terhadap dokumentasi asuhan keperawatan secara sistematis	☐	☐	☐	☐
10	Mengidentifikasi penerapan fungsi manajemen keperawatan dalam praktik pelayanan	☐	☐	☐	☐

11	Mengidentifikasi permasalahan manajerial serta potensi risiko (red flags) dalam pelayanan	☐	☐	☐	☐
12	Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi aktual dengan standar yang berlaku	☐	☐	☐	☐
13	Merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis secara logis dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐
14	Menganalisis penerapan fungsi manajemen (perencanaan hingga pengendalian) dalam pelayanan keperawatan	☐	☐	☐	☐
15	Melakukan penguatan analisis kesenjangan untuk memastikan ketepatan identifikasi	☐	☐	☐	☐
D. Tahap Terminasi					
16	Menyampaikan hasil analisis kepada kepala ruangan atau pihak terkait secara profesional	☐	☐	☐	☐
17	Melakukan komunikasi menggunakan	☐	☐	☐	☐

	pendekatan SBAR secara sistematis dan terstruktur				
18	Mengakhiri kegiatan interaksi secara profesional dan etis	☐	☐	☐	☐
E. Tahap Dokumentasi					
21	Menyusun laporan hasil analisis secara sistematis dan komprehensif	☐	☐	☐	☐
20	Menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel gap analysis yang terstruktur	☐	☐	☐	☐
21	Mendokumentasikan rekomendasi perbaikan secara tertulis dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐
F. Penampilan Profesional					
22	Menunjukkan penampilan yang rapi dan sesuai standar profesional	☐	☐	☐	☐
23	Menunjukkan sikap sopan, santun, dan menghargai lingkungan kerja	☐	☐	☐	☐
24	Menunjukkan kemampuan komunikasi yang efektif dalam interaksi profesiona	☐	☐	☐	☐
25	Menjaga etika profesi serta kerahasiaan	☐	☐	☐	☐

	informasi pasien dan institusi				

I. Form Penilaian Osce Keperawatan

STATION: ANALISIS ORGANISASI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN TATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN

1. Form Penilaian (sesuaikan dgn critical)

No	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1	Identifikasi Masalah Utama	Mampu mengidentifikasi minimal 80% masalah utama secara tepat berdasarkan skenario					3	
2	Gap analysis logis dan sesuai standar	Melakukan gap analysis yang logis, sistematis, dan sesuai standar					3	
3	Rekomendasi aplikatif dan realistis	Menyusun rekomendasi yang aplikatif, realistis, dan berbasis masalah					2	
4	Komunikasi jelas, profesional, dan sistematis	Menyampaikan hasil analisis dengan komunikasi jelas, profesional, dan sistematis					2	
	Jumlah						**10**	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat atau tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

J. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan

STATION: ANALISIS ORGANISASI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN TATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN

1. Rubrik

Kompetensi	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1. Analisis Organisasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi masalah utama yang terdapat dalam skenario secara komprehensif dan relevan. Peserta diharapkan mampu mengenali minimal 80% permasalahan kunci yang berdampak terhadap mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta efektivitas organisasi, dengan tetap berfokus pada prioritas masalah yang paling signifikan.					3	
2. Gap analysis logis dan sesuai standar Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi aktual dengan standar yang seharusnya. Analisis yang dilakukan harus logis, sistematis, dan mengacu pada prinsip serta standar pelayanan keperawatan, sehingga mampu menggambarkan secara jelas letak permasalahan dan penyebab terjadinya ketidaksesuaian.					3	
3. Rekomendasi aplikatif dan realistis Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Rekomendasi yang diberikan harus bersifat aplikatif, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam konteks pelayanan keperawatan, serta					2	

	berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien.					
4.	**Komunikasi jelas, profesional, dan sistematis** Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi secara efektif. Komunikasi yang dilakukan harus jelas, sistematis, dan profesional, serta mampu menunjukkan alur berpikir yang terstruktur sehingga mudah dipahami oleh pihak manajerial maupun tim kesehatan lainnya.				2	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

no	Kompetensi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3
1	**Identifikasi Masalah Utama**	Tidak mampu mengidentifikasi masalah utama, atau masalah yang disampaikan tidak relevan dengan skenario.berlaku	Mengidentifikasi sebagian kecil masalah (<50%), dengan ketepatan rendah dan tanpa penjelasan yang memadai.	Mengidentifikasi sebagian besar masalah (50–79%) dengan cukup tepat, namun belum lengkap atau kurang mendalam dalam menjelaskan dampaknya.	Mengidentifikasi ≥80% masalah utama secara tepat, lengkap, dan mampu menjelaskan dampaknya terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien secara logis dan berbasis bukti.
2	**Gap analysis logis dan sesuai standar**	Tidak melakukan gap analysis, atau analisis tidak sesuai dengan standar yang berlaku.	Melakukan gap analysis secara sangat terbatas, tidak logis, dan tidak sistematis.	Melakukan gap analysis yang cukup logis dan sesuai sebagian standar, namun belum sistematis atau kurang lengkap.	Melakukan gap analysis secara logis, sistematis, dan sesuai standar, serta mampu menjelaskan kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi ideal secara jelas.
3	**Rekomendasi aplikatif dan realistis**	Tidak memberikan rekomendasi,	Memberikan rekomendasi yang kurang tepat, tidak	Memberikan rekomendasi yang cukup	Memberikan rekomendasi yang aplikatif,

		atau rekomendasi tidak relevan dengan permasalahan.	realistis, dan sulit diimplementasikan.	sesuai, namun kurang aplikatif atau belum sepenuhnya realistis.	realistis, sesuai dengan masalah, serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan dan keselamatan pasien.
4	**Komunikasi jelas, profesional, dan sistematis**	Tidak mampu menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi.	Komunikasi tidak jelas, tidak sistematis, dan kurang menunjukkan sikap profesional.	Komunikasi cukup jelas dan dapat dipahami, namun belum sistematis atau kurang profesional.	Menyampaikan hasil analisis dan rekomendasi secara jelas, sistematis, dan profesional, dengan alur yang mudah dipahami serta argumentasi yang logis.

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan atau seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian.

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota),.....

.....

Penguji :.....

5. Rubrik Penilaian OSCE Keperawatan

Aspek	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
Analisis	Tidak tepat	Kurang tepat	Tepat	Sangat tepat
Fungsi manajemen keperawatan	Tidak terlihat	Kurang	Baik	Sangat baik

6. DOPS (*Does*)

DOPS di Lahan Praktik

a. Observasi langsung pada pelaksanaan analisis organisasi keperawatan, komunikasi manajerial, dan koordinasi layanan di fasilitas kesehatan nyata
b. *Checklist* + umpan balik singkat
c. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Contoh Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) Pada Manajemen Keperawatan dan Peran Perawat dalam Pelayanan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Organisasi Pelayanan Keperawatan
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa manajerial mahasiswa dalam situasi nyata di lahan praktik, berfokus pada	Mahasiswa diamati saat menganalisis organisasi keperawatan di ruang rawat inap, mengidentifikasi kesenjangan antara praktik

	kemampuan analisis organisasi, identifikasi masalah tata kelola, serta komunikasi profesional berbasis bukti.	dan standar, serta menyampaikan hasil kepada kepala ruangan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan konsep manajemen keperawatan dengan praktik nyata, termasuk analisis situasi, pengambilan keputusan, komunikasi, dan keselamatan pasien.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah handover, menyusun rekomendasi, dan menyampaikannya secara sistematis kepada pembimbing.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi nyata di unit pelayanan yang memiliki permasalahan manajerial.	Masalah koordinasi tim, handover tidak standar, atau discharge planning tidak optimal.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan observasi, pengumpulan data, analisis gap, penyusunan rekomendasi, dan presentasi hasil.	Mengamati alur pelayanan, mengidentifikasi red flags, lalu memaparkan hasil secara profesional.
Aspek yang dinilai	Meliputi kemampuan analisis organisasi, identifikasi risiko, kualitas rekomendasi, komunikasi, dan kolaborasi.	Mahasiswa mampu mengenali masalah dan memberikan solusi berbasis bukti.
Umpan balik	Diberikan secara langsung, spesifik, dan konstruktif setelah observasi.	Pembimbing memberikan saran peningkatan dalam prioritas masalah dan komunikasi.
Keputusan penilaian	Menentukan apakah mahasiswa kompeten, perlu supervisi, atau remedial.	Mahasiswa dinilai kompeten jika mampu melakukan analisis dan komunikasi dengan baik.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level praktik nyata.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan manajerial secara langsung di lapangan.

`

K. Portofolio

Bukti yang Dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat organisasi keperawatan
3. *Feedback* CI/dosen pembimbing

Tabel Portofolio pada manajemen keperawatan dan peran perawat dalam Pelayanan Keperawatan

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Organisasi Pelayanan Keperawatan**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan.	Berisi hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik dari pembimbing.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses pembelajaran, capaian kompetensi, serta perkembangan kemampuan mahasiswa selama praktik.	Menunjukkan peningkatan kemampuan analisis dan komunikasi manajerial dari waktu ke waktu.
OSCE dan DOPS	Bagian penting sebagai bukti kompetensi laboratorium dan praktik nyata.	OSCE untuk simulasi, DOPS untuk praktik langsung.
Catatan kasus singkat	Ringkasan masalah organisasi dan solusi yang diberikan.	Masalah handover dan rekomendasinya.
Umpan balik dosen / *feedback dosen*	Umpan balik dari *Clinical Instructor (CI)* atau dosen merupakan bentuk evaluasi pembinaan yang menggambarkan kekuatan serta aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam kompetensi manajerial mahasiswa..	*Clinical Instructor* (CI) menilai bahwa mahasiswa telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengidentifikasi permasalahan handover serta menyusun rekomendasi yang realistis. Namun, mahasiswa masih perlu meningkatkan kemampuan dalam menentukan prioritas rekomendasi berdasarkan tingkat risiko, serta

		memperkuat argumentasi berbasis bukti ketika menyampaikan hasil kepada pimpinan.
Karakteristik penilaian	Bersifat berkelanjutan dan menekankan pada konsistensi performa mahasiswa dalam berbagai situasi praktik.	Dinilai dari beberapa pengalaman praktik di unit yang berbeda.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio berfungsi sebagai indikator untuk menilai keberlanjutan dan stabilitas performa manajerial mahasiswa dalam berbagai situasi praktik serta pada rentang waktu yang berbeda. Melalui portofolio, dapat dievaluasi sejauh mana mahasiswa mampu mempertahankan kualitas kinerja secara konsisten dalam konteks nyata pelayanan keperawatan.	Berdasarkan integrasi hasil *OSCE, DOPS,* dokumentasi kasus, refleksi diri, serta umpan balik dari pembimbing, menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan yang berkesinambungan dalam melakukan analisis kesenjangan organisasi (*gap analysis*), mengidentifikasi potensi risiko yang berkaitan dengan keselamatan pasien (*red flags*), serta menyusun rekomendasi yang berbasis bukti. Kualitas performa tersebut tampak terjaga secara konsisten dari satu penugasan ke penugasan berikutnya.
Makna dalam OBE	Menunjukkan bahwa kompetensi mahasiswa tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis dan konsisten.	Mahasiswa mampu menerapkan konsep secara nyata dan berulang.

Tabel *Case Report* pada Organisasi Pelayanan Keperawatan dan Sistem Layanan Kesehatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Organisasi Pelayanan Keperawatan
Hakikat *case report*	Case report merupakan laporan sistematis mengenai satu masalah manajerial nyata yang dianalisis mahasiswa selama praktik klinik.	Kasus koordinasi tim yang tidak efektif dalam pelayanan keperawatan.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis sistematis, menyusun laporan ilmiah, serta mengintegrasikan teori dengan praktik.	Mahasiswa menjelaskan akar masalah, dampak, dan solusi yang diberikan.
Isi laporan	Meliputi deskripsi kondisi, analisis masalah, rekomendasi, implementasi, dan evaluasi hasil.	Masalah handover dan rekomendasi penggunaan metode SBAR.
Fokus penilaian	Penilaian diarahkan pada ketajaman mahasiswa dalam menganalisis situasi, ketepatan dalam mengidentifikasi kesenjangan yang relevan, serta konsistensi logika dalam merumuskan rekomendasi. Selain itu, aspek yang dinilai mencakup kemampuan dalam menetapkan prioritas berdasarkan tingkat risiko serta kecakapan dalam melakukan evaluasi tindak lanjut secara objektif dan sistematis.	Dalam proses penilaian, pembimbing mengevaluasi sejauh mana mahasiswa mampu mengintegrasikan temuan empiris di lapangan dengan prinsip-prinsip organisasi keperawatan yang berlaku. Mahasiswa juga dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menentukan alternatif solusi yang paling tepat dan aplikatif, serta dalam menilai dampak implementasi rekomendasi yang telah disampaikan kepada pimpinan unit secara kritis dan berbasis bukti.

Nilai edukatif	Ketepatan analisis, relevansi rekomendasi, serta kemampuan evaluasi hasil tindak lanjut.	Mahasiswa mampu menentukan prioritas masalah berbasis risiko.
Makna dalam OBE	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori manajemen keperawatan ke dalam praktik nyata secara sistematis dan berbasis bukti.	Laporan disusun secara ilmiah dan kontekstual sesuai kondisi lapangan.

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab 2: Organisasi Pelayanan Keperawatan dan Sistem Layanan Kesehatan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / *Skill Lab* : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang se suai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian manajemen keperawatan secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan fungsi manajemen keperawatan (planning, organizing, directing, controlling)	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi peran perawat sebagai manajer dalam pelayanan keperawatan	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menjelaskan hubungan manajemen keperawatan dengan mutu pelayanan	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan pelayanan keperawatan di suatu unit	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa melakukan pengorganisasian sederhana dalam tim keperawatan	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan keperawatan	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah manajerial (red flags) dalam pelayanan keperawatan	☐	☐	_____

9	Saya sudah bisa melakukan analisis sederhana terhadap sistem pelayanan keperawatan di unit	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan keperawatan secara logis	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan pentingnya keselamatan pasien dalam manajemen keperawatan	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menentukan prioritas masalah berdasarkan risiko dalam pelayanan keperawatan	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa berkomunikasi secara profesional dalam konteks manajerial keperawatan	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi sederhana terkait analisis pelayanan keperawatan	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, tanggung jawab, dan kolaboratif dalam pelayanan keperawatan	☐	☐	_____

Refleksi Singkat Mahasiswa:

Tuliskan secara singkat pengalaman belajar Anda, hal yang paling bermakna yang Anda pelajari dari Bab 2, tantangan yang masih Anda hadapi, dan rencana tindak lanjut yang akan Anda lakukan untuk memperkuat kompetensi yang belum dikuasai.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Tanda Tangan Mahasiswa

(_____)

L. Rangkuman Materi

Manajemen keperawatan merupakan suatu proses sistematis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan. Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang berkelanjutan dalam upaya mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu. Dalam praktiknya, manajemen keperawatan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, pengambilan keputusan klinis, serta pengendalian mutu pelayanan secara menyeluruh.

Perawat memiliki peran strategis sebagai manajer dalam sistem pelayanan kesehatan, baik pada tingkat individu, tim, maupun organisasi. Dalam perannya sebagai manajer, perawat bertanggung jawab untuk merencanakan kebutuhan pelayanan, mengorganisasikan sumber daya, mengarahkan pelaksanaan asuhan keperawatan, serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Peran ini menuntut perawat untuk memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek klinis, tetapi juga dalam kepemimpinan, komunikasi, serta pengambilan keputusan yang berbasis bukti (*evidence-based*).

Selain itu, tanggung jawab perawat sebagai manajer juga mencakup upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Dalam konteks ini, perawat harus mampu mengidentifikasi risiko, menerapkan standar pelayanan, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Keselamatan pasien menjadi prioritas utama dalam manajemen keperawatan, sehingga setiap proses pelayanan harus dirancang untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan.

Penerapan fungsi manajemen yang efektif akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pelayanan keperawatan. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dapat ditingkatkan melalui perencanaan yang matang dan pengorganisasian yang tepat. Kualitas pelayanan dapat ditingkatkan melalui pengarahan yang efektif serta pengendalian yang berkesinambungan. Selain itu, kepuasan pasien juga dapat meningkat apabila pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan dan harapan pasien secara optimal.

Dengan demikian, manajemen keperawatan merupakan elemen kunci dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang profesional. Perawat sebagai manajer memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa pelayanan keperawatan berjalan secara efektif, efisien, dan aman. Oleh karena itu, penguasaan konsep dan penerapan fungsi manajemen dalam keperawatan

menjadi kompetensi yang sangat penting bagi setiap perawat dalam menghadapi tuntutan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks.

M. Daftar Pustaka

Aiken, L. H., Sloane, D. M., Ball, J., Bruyneel, L., Rafferty, A. M., & Griffiths, P. (2014). Patient satisfaction with hospital care and nurses in England: An observational study. *BMJ Open*, 4(1), e004189. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2013-004189

American Nurses Association. (2015). *Code of ethics for nurses with interpretive statements*. ANA Publishing.

Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed? *Journal of the American Medical Association*, 260(12), 1743–1748. https://doi.org/10.1001/jama.1988.03410120089033

Fayol, H. (1949). *General and industrial management* (C. Storrs, Trans.). Pitman Publishing.

Gillies, D. A. (1994). *Nursing management: A systems approach* (3rd ed.). W.B. Saunders Company.

Huber, D. L. (2018). *Leadership and nursing care management* (6th ed.). Elsevier.

Institute of Medicine. (2011). *The future of nursing: Leading change, advancing health*. National Academies Press.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Standar pelayanan keperawatan di rumah sakit*. Kemenkes RI.

Lake, E. T., Sanders, J., Duan, R., Riman, K. A., Schoenauer, K. M., & Chen, Y. (2019). A meta-analysis of the associations between the nurse work environment in hospitals and 4 sets of outcomes. *Medical Care*, 57(5), 353–361. https://doi.org/10.1097/MLR.0000000000001109

Lasater, K. B., Aiken, L. H., Sloane, D. M., French, R., Martin, B., Reneau, K., Alexander, M., & McHugh, M. D. (2021). Chronic hospital nurse understaffing meets COVID-19: An observational study. *BMJ Quality & Safety*, 30(8), 639–647. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2020-011512

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2017). *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application* (9th ed.). Wolters Kluwer.

Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2019). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (4th ed.). Wolters Kluwer.

Nursalam. (2020). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional*. Salemba Medika.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Management* (13th ed.). Pearson Education.

Rosen, M. A., DiazGranados, D., Dietz, A. S., Benishek, L. E., Thompson, D., Pronovost, P. J., & Weaver, S. J. (2018). Teamwork in healthcare: Key discoveries enabling safer, high-quality care. *American Psychologist*, 73(4), 433–450. https://doi.org/10.1037/amp0000298

Shirey, M. R. (2017). Authentic leadership, organizational culture, and healthy work environments. *Critical Care Nursing Quarterly*, 40(3), 256–266. https://doi.org/10.1097/CNQ.0000000000000160

Simamora, R. H. (2021). *Manajemen keperawatan dalam praktik klinis*. EGC.

Sullivan, E. J. (2018). *Effective leadership and management in nursing* (10th ed.). Pearson.

Terry, G. R. (1993). *Principles of management*. Richard D. Irwin, Inc.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

West, M., Eckert, R., Steward, K., & Pasmore, B. (2014). *Developing collective leadership for healthcare*. The King's Fund.

World Health Organization. (2020). *State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership*. WHO Press.

World Health Organization. (2021). *Global strategic directions for nursing and midwifery 2021–2025*. WHO Press.

N. Glosarium

Akuntabilitas

Kewajiban perawat untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil secara profesional, etis, dan hukum.

Asuhan Keperawatan

Serangkaian proses sistematis yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dalam pelayanan kepada pasien.

Audit Keperawatan

Proses evaluasi sistematis terhadap kualitas asuhan keperawatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Efektivitas

Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Efisiensi

Kemampuan dalam menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

Evidence-Based Practice (EBP)

Pendekatan praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, serta nilai dan preferensi pasien.

Fungsi Manajemen

Serangkaian kegiatan dalam manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Kepemimpinan Keperawatan

Kemampuan perawat dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau tim untuk mencapai tujuan pelayanan keperawatan.

Keselamatan Pasien (Patient Safety)

Upaya sistematis untuk mencegah kesalahan dan meminimalkan risiko cedera pada pasien selama proses pelayanan kesehatan.

Kode Etik Keperawatan

Pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku perawat dalam menjalankan praktik keperawatan.

Komunikasi Terapeutik

Proses interaksi antara perawat dan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien.

Manajemen Keperawatan

Proses pengelolaan pelayanan keperawatan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

Model Praktik Keperawatan Profesional (MPKP)

Sistem pengorganisasian pelayanan keperawatan yang menekankan pembagian peran dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi perawat.

Mutu Pelayanan

Tingkat kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan standar yang telah ditetapkan serta kemampuan memenuhi kebutuhan pasien.

Organisasi Keperawatan

Struktur dan sistem yang mengatur hubungan kerja serta pembagian tugas dalam pelayanan keperawatan.

Pengarahan (Directing)

Fungsi manajemen yang berfokus pada pemberian instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada staf untuk mencapai tujuan organisasi.

Pengendalian (Controlling)

Proses evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan standar.

Pengorganisasian (Organizing)

Proses pengaturan sumber daya dan pembagian tugas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Perawat Manajer

Perawat yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola pelayanan keperawatan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.

Perencanaan (Planning)

Proses penetapan tujuan dan strategi untuk mencapainya dalam pelayanan keperawatan.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Panduan tertulis yang berisi langkah-langkah kerja yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu tindakan.

Sistem Pelayanan Kesehatan

Keseluruhan komponen yang saling berinteraksi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Supervisi Keperawatan

Proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan keperawatan sesuai standar.

BAB 2

ORGANISASI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN SISTEM LAYANAN KESEHATAN

Capaian Pembelajaran Lulusan

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Mampu menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan untuk mendukung tata kelola dan kesinambungan layanan.	CPMK-2; CPMK-7

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-2	Menganalisis organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan (tata kelola, standar, kebijakan) untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial.
CPMK-7	Menggunakan dokumentasi, informatika, audit data, dan pelaporan untuk evaluasi kinerja serta menyusun proyek mini peningkatan mutu berbasis data.

Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 2. Organisasi Pelayanan Keperawatan dan Sistem Layanan Kesehatan	2.1 Menganalisis struktur organisasi dan alur layanan keperawatan untuk memastikan kesinambungan pelayanan.	2.2 Mengkaitkan kebijakan/standar layanan kesehatan dengan perencanaan dan pengendalian pelayanan keperawatan.	CPMK-2	CPMK-1; CPMK-7
Bab 12. Manajemen Dokumentasi,	12.1 Menetapkan standar dokumentasi	12.2 Memanfaatkan data/informatika untuk pelaporan	CPMK-7	CPMK-2; CPMK-6

Informatika, dan Rekam Medis	keperawatan yang lengkap, tepat waktu, dan dapat diaudit.	kinerja dan pengambilan keputusan manajerial.

Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Tugas analisis organisasi & standar (paper ringkas)	Ketepatan pemetaan struktur/alur layanan dan ketepatan identifikasi gap terhadap standar (skor rubrik).	15	Dokumen analisis; matriks gap
CPMK-7	Proyek mini peningkatan mutu + portofolio laporan	Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil) dan kualitas rekomendasi perbaikan terukur.	15	Laporan proyek; portofolio data; refleksi

Rubrik CPMK

Rubrik CPMK-2

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Ketepatan pemetaan struktur & alur layanan	Tidak akurat; komponen inti hilang	Cukup akurat; masih ada kekeliruan bermakna	Akurat; kekeliruan minor	Sangat akurat; komprehensif dan jelas
2.2 Ketepatan gap analysis & prioritas perbaikan	Gap tidak sesuai standar; prioritas acak	Gap sebagian tepat; prioritas kurang konsisten	Gap tepat; prioritas jelas	Gap sangat tepat; prioritas sangat logis & berbasis risiko

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kelengkapan laporan berbasis data (baseline–target–hasil)	Data tidak lengkap; tidak dapat dievaluasi	Data cukup; hubungan baseline–hasil kurang jelas	Data lengkap; evaluasi jelas	Data sangat lengkap; evaluasi kuat dan transparan
7.2 Kualitas proyek mini peningkatan mutu (rencana–uji–evaluasi)	Tidak sistematis; tanpa evaluasi hasil	Sistematis sebagian; evaluasi terbatas	Sistematis; evaluasi hasil memadai	Sangat sistematis; evaluasi kuat; rekomendasi implementatif & berkelanjutan

Uraian Materi

Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem layanan kesehatan yang tidak dapat dipisahkan dari struktur organisasi tempat ia beroperasi. Dalam konteks modern, keperawatan tidak lagi sekadar menjalankan tugas klinis di sisi tempat tidur pasien, tetapi telah berkembang menjadi suatu profesi yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Organisasi pelayanan keperawatan yang baik mencerminkan bagaimana sumber daya manusia, material, dan informasi dikelola secara sistematis untuk mencapai tujuan pelayanan yang berkualitas, aman, dan berkesinambungan. Pemahaman mendalam tentang struktur organisasi keperawatan menjadi fondasi penting bagi setiap perawat, khususnya mereka yang mengemban tanggung jawab manajerial, agar mampu mengambil keputusan yang tepat dan akuntabel dalam setiap situasi layanan.

Sistem layanan kesehatan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak diberlakukannya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan reformasi sistem rujukan berjenjang. Fasilitas layanan kesehatan kini dituntut untuk beroperasi dalam kerangka regulasi yang ketat, standar akreditasi yang terukur, serta mekanisme kendali mutu dan kendali biaya yang transparan. Dalam konteks inilah organisasi pelayanan keperawatan harus mampu menempatkan dirinya secara strategis, tidak hanya sebagai pelaksana asuhan, tetapi juga sebagai motor penggerak mutu layanan di setiap lini. Perawat manajer dituntut memahami peta kebijakan kesehatan nasional, regulasi Kementerian Kesehatan, standar *Joint Commission International* (JCI) maupun Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), serta bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tata kelola operasional harian di unit keperawatan.

Struktur organisasi dalam pelayanan keperawatan bukan sekadar bagan hierarki yang terpampang di dinding kantor. Ia adalah cerminan dari bagaimana wewenang, tanggung jawab, komunikasi, dan koordinasi mengalir di antara individu dan tim dalam mencapai tujuan bersama. Berbagai model organisasi, mulai dari struktur fungsional, *divisional*, *matriks*, hingga model tim keperawatan profesional, masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan yang harus dipahami secara kontekstual. Pemilihan model organisasi yang tepat akan berdampak langsung pada efisiensi alur kerja, kepuasan tenaga keperawatan, keselamatan pasien, serta keberhasilan institusi dalam memenuhi indikator mutu layanan. Oleh karena itu, analisis organisasi keperawatan harus dilakukan secara kritis, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan yang berkelanjutan.

Bab ini hadir untuk membekali mahasiswa keperawatan dengan pemahaman komprehensif mengenai organisasi pelayanan keperawatan dan posisinya dalam sistem layanan kesehatan yang lebih luas. Melalui pembahasan yang mencakup konsep *governance* keperawatan, struktur dan alur layanan, kebijakan dan standar pelayanan, hingga mekanisme koordinasi lintas-profesi, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kondisi nyata di lapangan dan mengusulkan perbaikan berbasis bukti. Kemampuan ini tidak hanya relevan bagi mereka yang bercita-cita menjadi pemimpin keperawatan di masa depan, tetapi juga bagi setiap perawat pelaksana yang ingin memahami posisi dan kontribusinya dalam sistem yang lebih besar demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.

A. Konsep Dasar Organisasi Pelayanan Keperawatan

1. Pengertian organisasi dan pelayanan keperawatan

Organisasi pada dasarnya merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas sekumpulan individu yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. Dalam konteks pelayanan kesehatan, organisasi tidak sekadar dipahami sebagai struktur hierarki formal yang menggambarkan siapa melapor kepada siapa, melainkan juga mencakup keseluruhan sistem nilai, budaya kerja, mekanisme komunikasi, dan pola interaksi antarindividu yang membentuk cara suatu institusi berfungsi. Organisasi keperawatan di rumah sakit era digital tidak lagi dapat dimaknai secara sempit sebagai susunan jabatan struktural, melainkan harus dipahami sebagai ekosistem layanan yang dinamis, responsif terhadap perubahan, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pemahaman yang komprehensif tentang hakikat organisasi ini menjadi titik awal yang tidak dapat diabaikan oleh setiap perawat yang ingin memahami perannya secara utuh dalam sistem layanan kesehatan yang semakin kompleks (Kusuma et al., 2024).

Pelayanan keperawatan, sebagai inti dari aktivitas organisasi keperawatan, dapat didefinisikan sebagai seluruh upaya profesional yang diberikan oleh perawat kepada individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, yang mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Definisi ini menegaskan bahwa keperawatan bukan sekadar tindakan teknis di sisi tempat tidur pasien, melainkan suatu bentuk layanan profesional yang bersifat holistik, mencakup dimensi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual dari setiap individu yang dilayani. Sistem layanan kesehatan primer berbasis komunitas yang efektif sangat bergantung pada kemampuan organisasi keperawatan dalam memberikan pelayanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, pelayanan

keperawatan bukan hanya produk dari interaksi antara perawat dan pasien, tetapi juga merupakan hasil dari bagaimana organisasi keperawatan dirancang, dikelola, dan dikembangkan secara sistematis (Putri et al., 2022).

Hubungan antara organisasi dan pelayanan keperawatan bersifat resiprokal dan saling memengaruhi secara mendalam. Organisasi yang tertata dengan baik akan menghasilkan pelayanan keperawatan yang terstruktur, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara pelayanan keperawatan yang berkualitas tinggi pada gilirannya akan memperkuat legitimasi dan kapasitas organisasi itu sendiri. Dalam kerangka ini, setiap elemen organisasi, mulai dari desain struktur, sistem rekrutmen dan pengembangan tenaga, mekanisme supervisi, hingga budaya organisasi, memiliki dampak langsung terhadap kualitas asuhan yang diterima pasien. Kepemimpinan yang efektif dalam organisasi keperawatan terbukti berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja perawat, yang pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Oleh karena itu, membangun organisasi keperawatan yang kuat dan adaptif merupakan investasi strategis yang tidak dapat ditunda-tunda (Novita et al., 2022).

Dalam literatur manajemen keperawatan, terdapat berbagai perspektif teoritis yang digunakan untuk memahami organisasi pelayanan keperawatan. Perspektif *classical management* memandang organisasi sebagai mesin yang dapat dirancang secara rasional untuk mencapai efisiensi maksimal melalui spesialisasi dan standardisasi. Sementara itu, perspektif *human relations* menekankan bahwa produktivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan antarmanusia, motivasi, dan kepuasan kerja para anggotanya. Perspektif *systems theory* memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungannya, menyerap *input*, memproses, dan menghasilkan *output* berupa layanan kesehatan. Perawat spesialis klinis, sebagai salah satu elemen organisasi keperawatan, memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kapasitas sistem layanan kesehatan primer melalui peran konsultasi, pendidikan, dan praktik langsung. Keragaman perspektif ini memperkaya pemahaman kita tentang betapa kompleks dan multilapis hakikat organisasi pelayanan keperawatan sesungguhnya (Bostelman et al., 2023).

Secara operasional, organisasi pelayanan keperawatan di Indonesia diwujudkan dalam berbagai bentuk kelembagaan, mulai dari instalasi keperawatan di rumah sakit, unit pelayanan keperawatan di *Puskesmas*, hingga lembaga keperawatan komunitas dan *home care*. Setiap bentuk kelembagaan ini memiliki karakteristik, kompleksitas, dan tantangan manajemen yang

berbeda-beda, namun semuanya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu memberikan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan berpusat pada pasien. Pentingnya sinkronisasi sistem dokumentasi elektronik dalam organisasi keperawatan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemampuan evaluasi kinerja layanan secara real-time. Transformasi digital yang sedang berlangsung secara masif di berbagai fasilitas kesehatan Indonesia menuntut organisasi keperawatan untuk terus beradaptasi dan memperbarui model operasionalnya agar tetap relevan dan kompetitif dalam ekosistem layanan kesehatan yang terus berubah (Hartono et al., 2025).

Memahami pengertian organisasi dan pelayanan keperawatan secara mendalam bukan merupakan kegiatan akademis semata, melainkan suatu kebutuhan praktis yang mendasar bagi setiap profesional keperawatan. Seorang perawat yang memahami organisasinya dengan baik akan mampu menavigasi kompleksitas sistem, berkolaborasi lebih efektif dengan profesi lain, mengidentifikasi peluang perbaikan, serta berkontribusi secara aktif dalam pengembangan institusi tempatnya bekerja. Kesetaraan gender dan inklusivitas dalam *workforce* kesehatan, termasuk keperawatan, merupakan dimensi penting dari tata kelola organisasi yang sehat dan berkeadilan. Dengan landasan pemahaman yang kuat tentang apa itu organisasi dan apa itu pelayanan keperawatan, mahasiswa diharapkan mampu membangun perspektif manajerial yang komprehensif, humanis, dan berorientasi pada perbaikan mutu yang berkelanjutan sebagai bekal memasuki dunia profesional keperawatan yang semakin dinamis dan penuh tantangan (So & Zhao, 2024).

2. Tujuan dan fungsi organisasi keperawatan

Organisasi keperawatan tidak terbentuk secara kebetulan, melainkan dibangun secara terencana dan bertujuan untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Dalam perjalanan sejarah keperawatan sebagai profesi, organisasi keperawatan telah bertransformasi dari sekadar kelompok tenaga pembantu medis menjadi suatu sistem pelayanan profesional yang terstruktur, terstandar, dan memiliki arah yang jelas. Memahami tujuan dan fungsi organisasi keperawatan merupakan langkah fundamental bagi setiap perawat agar mampu berkontribusi secara optimal, tidak hanya sebagai pelaksana asuhan di garis terdepan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang lebih besar yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat (Bostelman et al., 2023). Tanpa pemahaman yang mendalam tentang mengapa organisasi keperawatan ada dan apa yang seharusnya ia lakukan, seorang perawat hanya akan bekerja secara mekanis

tanpa mampu memaknai kontribusinya dalam gambaran besar sistem layanan kesehatan yang ia geluti setiap harinya.

a. Tujuan Organisasi Keperawatan

1) Memberikan Asuhan Keperawatan yang Aman, Bermutu, dan Berpusat pada Pasien

Tujuan utama dan paling mendasar dari setiap organisasi keperawatan adalah memastikan bahwa setiap pasien menerima asuhan yang aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan kebutuhannya secara individual. Tujuan ini bukan sekadar pernyataan normatif yang tertulis dalam dokumen visi dan misi sebuah institusi, melainkan merupakan komitmen operasional yang harus tercermin dalam setiap kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diambil oleh seluruh anggota organisasi keperawatan setiap harinya. Keamanan pasien mencakup perlindungan dari risiko kesalahan medis, infeksi nosokomial, jatuh, dan berbagai insiden yang dapat membahayakan jiwa, sementara mutu pelayanan mencakup ketepatan diagnosis keperawatan, efektivitas intervensi, serta relevansi rencana asuhan dengan kebutuhan nyata pasien. Aspek yang tidak kalah penting adalah prinsip *patient-centered care*, yaitu menempatkan pasien sebagai subjek aktif dalam proses perawatan, bukan sekadar objek yang menerima tindakan, sehingga nilai-nilai, preferensi, dan kebutuhan unik setiap individu dihormati dan diintegrasikan ke dalam setiap keputusan klinis yang diambil oleh tim keperawatan (Merino et al., 2023).

Pencapaian tujuan ini membutuhkan sinergi yang erat antara sumber daya manusia yang kompeten, sistem tata kelola yang kuat, teknologi yang mendukung, dan budaya organisasi yang menempatkan keselamatan pasien sebagai nilai tertinggi yang tidak dapat dikompromikan dalam situasi apapun. Ketika budaya keselamatan telah mengakar kuat dalam organisasi keperawatan, maka setiap perawat akan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan potensi risiko, mempertanyakan prosedur yang meragukan, dan aktif berkontribusi dalam upaya pencegahan insiden tanpa rasa takut akan sanksi atau penilaian negatif dari atasan. Dengan demikian, tujuan pertama ini bukan hanya tentang hasil klinis yang terukur, tetapi juga tentang membangun ekosistem organisasi yang mendukung praktik keperawatan yang etis, bertanggung jawab, dan konsisten berorientasi pada kepentingan terbaik pasien.

2) Menjamin Kesinambungan Pelayanan Keperawatan

Organisasi keperawatan bertujuan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan bersifat berkesinambungan, tidak terputus oleh pergantian

shift, rotasi tenaga, perpindahan antar unit layanan, maupun transisi dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lainnya. Kesinambungan pelayanan menjadi fondasi penting dalam mencegah terjadinya kesalahan yang diakibatkan oleh putusnya informasi dan koordinasi antar tenaga keperawatan, terutama pada momen-momen kritis seperti *handover* antar *shift*, pemindahan pasien dari *Intensive Care Unit* (ICU) ke ruang rawat biasa, atau saat proses pemulangan pasien ke rumah. Fragmentasi layanan yang terjadi akibat lemahnya sistem kesinambungan tidak hanya berdampak pada menurunnya kepuasan pasien, tetapi juga dapat berujung pada komplikasi klinis yang seharusnya dapat dicegah apabila informasi dan koordinasi berjalan dengan baik dan terstruktur sejak awal (Ferraz et al., 2024).

Untuk mewujudkan kesinambungan layanan, organisasi keperawatan perlu membangun sistem *handover* yang terstandar, mekanisme dokumentasi yang komprehensif dan mudah diakses, serta budaya komunikasi yang terbuka dan akurat antar anggota tim. Selain itu, kesinambungan layanan juga mencakup dimensi longitudinal, yaitu memastikan bahwa pasien yang telah selesai menjalani perawatan di fasilitas kesehatan mendapatkan dukungan yang memadai untuk melanjutkan proses pemulihan di rumah atau di komunitas, termasuk melalui program *discharge planning* yang komprehensif dan pelayanan *home care* yang terorganisasi dengan baik. Dengan menjadikan kesinambungan sebagai tujuan organisasi, maka setiap elemen sistem keperawatan, dari dokumentasi, komunikasi, koordinasi, hingga edukasi pasien dan keluarga, akan dirancang secara terintegrasi dan saling menguatkan satu sama lain.

3) Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi Tenaga Keperawatan

Organisasi keperawatan juga bertujuan untuk secara aktif mengembangkan kompetensi, profesionalisme, dan kapasitas seluruh tenaga keperawatan yang berada di bawah naungannya, karena sumber daya manusia adalah aset terpenting dan paling menentukan dalam kualitas sebuah organisasi layanan. Tujuan ini diwujudkan melalui beragam program yang terstruktur, mulai dari orientasi bagi tenaga baru, pelatihan klinis berkelanjutan, program sertifikasi kompetensi, supervisi klinis yang konstruktif, mentoring dan *coaching* oleh perawat senior, hingga penciptaan lingkungan kerja yang kondusif bagi pertumbuhan profesional setiap individu. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia keperawatan pada hakikatnya adalah investasi dalam kualitas layanan itu

sendiri, karena kompetensi perawat yang tinggi akan secara langsung berkorelasi dengan hasil klinis yang lebih baik, tingkat kepuasan pasien yang lebih tinggi, dan angka insiden keselamatan yang lebih rendah. Profesionalisme dalam keperawatan tidak hanya mencakup kompetensi teknis dalam melakukan prosedur klinis, tetapi juga mencakup dimensi etika, komunikasi terapeutik, kemampuan berpikir kritis, kecakapan pengambilan keputusan berbasis bukti, serta kemampuan berkolaborasi secara efektif dalam tim multidisiplin. Organisasi keperawatan yang berhasil dalam membangun profesionalisme anggotanya adalah organisasi yang mampu menciptakan iklim belajar yang aman, di mana kesalahan dipandang sebagai peluang pembelajaran bukan sebagai dasar hukuman, dan di mana setiap perawat merasa dihargai kontribusinya serta didukung dalam upaya pengembangannya. Dengan demikian, tujuan peningkatan profesionalisme ini erat kaitannya dengan kualitas kepemimpinan dalam organisasi, karena pemimpin keperawatan yang visioner dan empatif akan menjadi penggerak utama terwujudnya budaya profesionalisme yang tumbuh dari dalam, bukan dipaksakan dari luar (Abdulrahman Alqarni et al., 2025).

4) Mendukung Pencapaian Tujuan Institusi dan Sistem Kesehatan Nasional

Organisasi keperawatan tidak berdiri sendiri dalam ruang hampa, melainkan merupakan subsistem dari institusi layanan kesehatan yang lebih besar, dan pada gilirannya merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang memiliki visi, misi, dan target yang jelas. Oleh karena itu, salah satu tujuan penting organisasi keperawatan adalah menyelaraskan visi, misi, program kerja, dan indikator kinerjanya dengan tujuan institusi induk serta kebijakan kesehatan nasional yang berlaku, termasuk target-target yang ditetapkan dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* (RPJMN) di bidang kesehatan. Ketika organisasi keperawatan mampu menunjukkan kontribusi nyatanya terhadap pencapaian indikator institusi, seperti penurunan *Length of Stay* (LOS), peningkatan skor kepuasan pasien, penurunan angka *Hospital Acquired Infection* (HAI), dan keberhasilan akreditasi, maka posisi strategis keperawatan dalam ekosistem layanan kesehatan akan semakin diakui dan diperkuat.

Keselarasan antara tujuan organisasi keperawatan dengan kebijakan kesehatan nasional juga bermakna bahwa setiap perawat, dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, sesungguhnya sedang berkontribusi pada upaya yang jauh lebih besar dari sekadar merawat satu pasien di satu

ruangan. Ia adalah bagian dari gerakan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, dan berkeadilan. Kesadaran ini penting untuk ditanamkan dalam budaya organisasi keperawatan, karena akan memberikan makna yang lebih dalam bagi setiap perawat dalam menjalankan profesinya, sekaligus mendorong mereka untuk terus meningkatkan standar kerja agar kontribusi yang diberikan benar-benar bermakna bagi sistem kesehatan yang lebih luas.

5) Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Sehat, Adil, dan Inklusif

Organisasi keperawatan bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan kerja yang sehat secara fisik maupun psikologis, adil dalam distribusi beban kerja dan penghargaan, serta inklusif bagi seluruh tenaga keperawatan tanpa memandang latar belakang gender, etnis, agama, maupun status sosial. Lingkungan kerja yang positif terbukti secara ilmiah berkontribusi pada penurunan angka *burnout*, peningkatan retensi tenaga perawat, penurunan angka absensi, dan pada akhirnya peningkatan kualitas asuhan yang diberikan kepada pasien. Sebaliknya, lingkungan kerja yang toksik, penuh tekanan berlebihan, tidak adil, dan tidak inklusif akan menguras energi fisik dan mental perawat, menurunkan motivasi kerja, dan menciptakan iklim organisasi yang tidak kondusif bagi pertumbuhan profesional maupun kualitas layanan.

Mewujudkan lingkungan kerja yang sehat bukan hanya tanggung jawab manajemen puncak, melainkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota organisasi keperawatan, dari kepala bidang keperawatan hingga perawat pelaksana di tingkat *bedside*. Setiap individu berkontribusi dalam membentuk budaya organisasi melalui cara mereka berkomunikasi, menyelesaikan konflik, memberikan dukungan kepada rekan kerja, dan menyikapi perbedaan. Dengan menjadikan terciptanya lingkungan kerja yang sehat, adil, dan inklusif sebagai tujuan eksplisit organisasi, maka keperawatan tidak hanya memberikan pelayanan yang bermartabat kepada pasien, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tenaga yang menjalankan pelayanan tersebut diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan keadilan sebagai wujud nyata nilai-nilai humanisme yang selalu dijunjung tinggi oleh profesi keperawatan.

b. Fungsi Organisasi Keperawatan

1) Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Fungsi perencanaan merupakan fondasi dari seluruh aktivitas organisasi keperawatan, mencakup penetapan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, penyusunan strategi pencapaian, alokasi sumber daya secara proporsional, dan penentuan standar kinerja yang akan dijadikan acuan evaluasi. Tanpa perencanaan yang matang dan sistematis, organisasi keperawatan akan berjalan secara reaktif, hanya merespons masalah yang sudah terjadi tanpa mampu mengantisipasinya, sehingga rentan terhadap inefisiensi, pemborosan sumber daya, dan penurunan mutu layanan yang berkelanjutan. Perencanaan dalam organisasi keperawatan tidak hanya mencakup perencanaan operasional harian seperti penjadwalan tenaga, pengadaan logistik, dan penugasan klinis, tetapi juga perencanaan strategis yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas layanan, pengadaan teknologi baru, dan adaptasi terhadap perubahan kebijakan yang terus dinamis (Hezab Alshammari et al., 2024).

Kualitas perencanaan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat, kemampuan analitis pemimpin, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya. Perencanaan yang dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan perawat pelaksana, kepala ruangan, manajer keperawatan, dan bahkan representasi pasien, akan menghasilkan rencana yang lebih realistis, lebih mudah diimplementasikan, dan lebih mendapatkan dukungan dari seluruh anggota organisasi. Sebaliknya, perencanaan yang dilakukan secara *top-down* tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan seringkali gagal dalam implementasinya karena tidak mencerminkan kebutuhan dan kapasitas riil dari mereka yang harus menjalankannya sehari-hari.

2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Fungsi pengorganisasian mencakup penetapan struktur organisasi yang tepat, pembagian tugas dan wewenang yang jelas, pengelompokan aktivitas ke dalam unit-unit kerja yang logis dan fungsional, serta pembangunan mekanisme koordinasi yang efektif antar bagian dalam sistem pelayanan. Melalui fungsi ini, organisasi keperawatan memastikan bahwa setiap perawat mengetahui dengan jelas peran dan tanggung jawabnya, kepada siapa ia melapor, siapa yang berada di bawah supervisinya, dan bagaimana ia harus berkoordinasi dengan rekan-rekan

di unit lain untuk memastikan kelancaran alur layanan. Pengorganisasian yang baik akan menciptakan kejelasan peran yang mengurangi ambiguitas, konflik, dan tumpang tindih tugas yang sering menjadi sumber inefisiensi dan frustrasi dalam organisasi layanan kesehatan yang kompleks. Dalam merancang struktur organisasi, pemimpin keperawatan perlu mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual, termasuk ukuran dan kompleksitas fasilitas layanan, karakteristik populasi pasien yang dilayani, ketersediaan dan kompetensi tenaga yang dimiliki, serta tuntutan regulasi dan standar akreditasi yang berlaku. Tidak ada satu model organisasi yang universal dan cocok untuk semua konteks, sehingga fleksibilitas dan kemampuan adaptasi dalam mendesain struktur organisasi menjadi kompetensi penting bagi pemimpin keperawatan. Fungsi pengorganisasian yang dijalankan dengan baik akan menghasilkan sinergi antarbagian yang kuat, di mana setiap unit bekerja sebagai bagian yang saling melengkapi dalam satu sistem yang kohesif, bukan sebagai entitas yang terpisah dan berjalan sendiri-sendiri (Wasik et al., 2024).

3) Fungsi Pengarahan (*Directing*)

Fungsi pengarahan berkaitan dengan kemampuan pimpinan organisasi keperawatan untuk memotivasi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh anggota tim menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bersama. Fungsi ini mencakup pemilihan dan penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan karakteristik tim, kualitas komunikasi antara pemimpin dan anggota, mekanisme pemberian umpan balik yang konstruktif, serta kemampuan mengelola konflik yang tidak dapat dihindari dalam dinamika kerja tim yang beragam. Pengarahan yang efektif bukan berarti kontrol yang ketat dan mikro-manajerial, melainkan pemberdayaan yang membuat setiap perawat merasa memiliki otonomi yang cukup untuk mengambil keputusan klinis yang tepat, sambil tetap merasa didukung dan diarahkan oleh pemimpinnya. Pemimpin keperawatan yang efektif dalam menjalankan fungsi pengarahan adalah mereka yang mampu membaca situasi dengan cermat dan menyesuaikan pendekatannya secara fleksibel, tegas saat dibutuhkan, namun empatik dan suportif dalam keseharian. Mereka juga adalah pemimpin yang mampu menginspirasi melalui keteladanan, menjaga konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta membangun kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan kerja yang produktif dan bermakna. Ketika fungsi pengarahan berjalan

optimal, setiap perawat dalam organisasi tidak hanya bekerja karena kewajiban, tetapi karena memiliki motivasi intrinsik yang kuat, merasa dihargai kontribusinya, dan percaya bahwa pemimpinnya benar-benar peduli pada keberhasilan mereka sebagai individu maupun sebagai tim (Schober, 2025).

4) Fungsi Pengendalian (*Controlling*)

Fungsi pengendalian mencakup pemantauan kinerja secara sistematis, evaluasi capaian terhadap standar dan target yang telah ditetapkan, identifikasi penyimpangan dan akar penyebabnya, serta penerapan tindakan korektif yang diperlukan untuk mengembalikan organisasi pada jalurnya. Dalam konteks keperawatan, fungsi ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme yang saling melengkapi, seperti audit keperawatan, supervisi klinis terstruktur, pemantauan indikator mutu secara berkala, sistem pelaporan dan pembelajaran insiden, serta evaluasi kepuasan pasien dan tenaga perawat secara periodik. Fungsi pengendalian yang efektif bukan dimaksudkan sebagai alat pengawasan yang mengancam atau menciptakan iklim ketakutan, melainkan sebagai sistem umpan balik yang konstruktif untuk mendorong refleksi diri dan perbaikan berkelanjutan di setiap level organisasi.

Pengendalian yang efektif juga memerlukan keberanian organisasi untuk menghadapi data yang tidak menyenangkan, mengakui kekurangan, dan mengambil langkah perbaikan yang mungkin tidak populer namun diperlukan demi kebaikan jangka panjang sistem layanan. Budaya *blame-free* atau bebas dari budaya menyalahkan individu merupakan prasyarat penting agar fungsi pengendalian dapat berjalan secara optimal, karena hanya dalam iklim yang aman psikologis itulah perawat akan bersedia melaporkan insiden, mengungkap masalah, dan berkontribusi secara jujur dalam proses evaluasi yang pada akhirnya akan menghasilkan perbaikan nyata bagi sistem dan bagi pasien (Merino et al., 2023).

5) Fungsi Koordinasi (*Coordinating*)

Fungsi koordinasi berperan memastikan bahwa seluruh unit, tim, dan individu dalam organisasi keperawatan bekerja secara selaras, saling mendukung, dan tidak saling tumpang tindih dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Koordinasi dalam organisasi keperawatan tidak hanya terjadi secara internal antar perawat dalam satu unit, tetapi juga secara lintas unit antar bangsal, secara lintas profesi dengan dokter, fisioterapis, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya, serta secara lintas

institusi dalam sistem rujukan yang berjenjang. Tanpa koordinasi yang efektif, pelayanan keperawatan akan menjadi terfragmentasi, di mana setiap bagian bekerja dengan baik secara parsial namun gagal menghasilkan pengalaman layanan yang mulus dan berkesinambungan bagi pasien yang membutuhkan layanan dari berbagai sumber secara bersamaan.

Mekanisme koordinasi yang efektif dalam organisasi keperawatan meliputi pertemuan tim yang terjadwal dan terstruktur, sistem komunikasi yang jelas dan standar, penetapan penanggungjawab koordinasi yang tegas, serta teknologi informasi yang mendukung berbagi data secara *real-time* antar pihak yang terlibat. Pemimpin keperawatan memiliki peran sentral dalam memfasilitasi koordinasi ini, tidak hanya dengan menyediakan mekanisme formalnya, tetapi juga dengan membangun hubungan kerja yang saling percaya dan menghormati antar individu dan antar profesi, karena pada akhirnya koordinasi yang paling efektif tumbuh dari hubungan profesional yang sehat dan rasa tanggung jawab bersama terhadap keselamatan dan kesejahteraan pasien (Ferraz et al., 2024).

6) Fungsi Pengembangan (*Developing*)

Fungsi pengembangan mencakup upaya sistematis dan berkesinambungan dari organisasi keperawatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem dan proses kerja, mengadopsi inovasi yang relevan, serta membangun budaya belajar yang menjadikan perbaikan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas organisasi. Fungsi ini diwujudkan melalui berbagai program yang saling melengkapi, mulai dari *in-service training*, pengiriman perawat ke seminar dan konferensi, fasilitasi penelitian keperawatan berbasis praktik, program *preceptorship* bagi perawat baru, hingga penciptaan *communities of practice* yang memungkinkan berbagi pengetahuan dan pengalaman antar perawat secara informal namun berdampak nyata.

Organisasi keperawatan yang menempatkan pengembangan sebagai fungsi inti, bukan sekadar program sampingan yang dijalankan saat ada anggaran lebih, akan memiliki daya adaptasi yang jauh lebih tinggi terhadap perubahan yang datang dari luar, baik berupa perubahan regulasi, perkembangan teknologi, maupun pergeseran pola penyakit dan kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, fungsi pengembangan adalah investasi paling strategis yang dapat dilakukan oleh organisasi keperawatan, karena perawat yang terus berkembang,

termotivasi, dan merasa dihargai akan menjadi aset tak ternilai yang membawa organisasi melampaui sekadar memenuhi standar minimum menuju keunggulan layanan yang sesu

3. Karakteristik organisasi pelayanan kesehatan

Organisasi pelayanan kesehatan memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dari organisasi bisnis atau industri pada umumnya, sehingga pendekatan manajemen yang diterapkan pun tidak dapat sepenuhnya mengadopsi model manajemen korporat tanpa modifikasi yang substansial dan kontekstual. Keunikan karakteristik ini muncul dari hakikat layanan kesehatan itu sendiri, yang bersentuhan langsung dengan nyawa manusia, melibatkan dimensi etika yang kompleks, menuntut keahlian yang sangat terspesialisasi, serta beroperasi dalam lingkungan yang sarat dengan ketidakpastian klinis dan tekanan regulasi yang terus berkembang. Marquis dan Huston (2021) dalam *Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application* menegaskan bahwa memahami karakteristik unik organisasi layanan kesehatan merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemimpin keperawatan yang ingin mengelola timnya secara efektif, karena strategi yang berhasil di industri lain belum tentu relevan dan aman diterapkan dalam konteks layanan yang menyangkut keselamatan jiwa manusia. Dengan memahami karakteristik ini secara mendalam, perawat manajer akan lebih mampu merancang sistem kerja yang realistis, responsif, dan bertanggung jawab terhadap tuntutan lingkungan layanan kesehatan yang terus berubah.

a. Berorientasi pada Keselamatan dan Kesejahteraan Manusia

Karakteristik paling mendasar yang membedakan organisasi pelayanan kesehatan dari organisasi lainnya adalah bahwa seluruh aktivitasnya berorientasi langsung pada keselamatan jiwa dan kesejahteraan manusia, sehingga setiap keputusan manajerial, klinis, maupun operasional harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan pasien sebagai prioritas utama yang tidak dapat dinegosiasikan. Berbeda dengan organisasi bisnis yang dapat mentoleransi tingkat kesalahan tertentu sebagai bagian dari proses pembelajaran, organisasi layanan kesehatan beroperasi dalam lingkungan di mana satu kesalahan kecil pun dapat berakibat fatal bagi pasien yang sedang dalam kondisi rentan. Huber (2022) dalam *Leadership and Nursing Care Management* menjelaskan bahwa budaya keselamatan dalam organisasi layanan kesehatan harus dibangun secara sistematis melalui kebijakan yang jelas, pelatihan yang konsisten, dan kepemimpinan yang memberikan teladan nyata dalam memprioritaskan

keselamatan di atas segalanya. Orientasi pada keselamatan ini menjadikan standar operasional, protokol klinis, dan sistem pelaporan insiden bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen vital yang menentukan apakah organisasi mampu memenuhi tanggung jawab moralnya kepada setiap pasien yang mempercayakan kesehatannya kepada sistem layanan tersebut.

b. Layanan Bersifat *Intangible* dan Tidak Dapat Distandarisasi Sepenuhnya

Produk utama organisasi pelayanan kesehatan adalah jasa atau layanan yang bersifat *intangible*, artinya tidak dapat dilihat, diraba, atau diuji kualitasnya sebelum diterima oleh pasien, sehingga penilaian mutu layanan sangat bergantung pada persepsi subjektif pasien dan keluarganya serta pada indikator klinis yang terukur secara ilmiah. Lebih dari itu, meskipun berbagai prosedur dan protokol klinis telah distandarisasi sedetail mungkin, respons setiap pasien terhadap intervensi yang sama dapat sangat bervariasi karena perbedaan kondisi fisik, psikologis, genetik, dan sosial budaya yang unik pada setiap individu. Sullivan (2022) dalam *Effective Leadership and Management in Nursing* menekankan bahwa sifat *intangible* dan variabilitas inheren dalam layanan kesehatan ini menuntut organisasi untuk membangun sistem jaminan mutu yang fleksibel namun konsisten, yang mampu mengakomodasi keberagaman kebutuhan pasien tanpa mengorbankan standar keamanan yang telah ditetapkan. Pemahaman tentang karakteristik ini penting agar manajer keperawatan tidak terjebak dalam pendekatan *one-size-fits-all* dalam mengelola layanan, melainkan mampu mendorong tim untuk berpikir adaptif dan berpusat pada kebutuhan unik setiap pasien yang dilayaninya.

c. Melibatkan Tenaga Profesional dengan Otonomi Klinis yang Tinggi

Organisasi pelayanan kesehatan adalah salah satu jenis organisasi yang paling padat dengan tenaga profesional yang memiliki otonomi klinis tinggi, seperti dokter, perawat, apoteker, dan berbagai tenaga kesehatan lainnya yang masing-masing memiliki kompetensi spesifik, kode etik profesi, dan kewenangan klinis yang diatur oleh regulasi tersendiri. Keberadaan berbagai profesi dengan otonomi yang tinggi dalam satu organisasi menciptakan dinamika manajemen yang kompleks, karena pemimpin tidak dapat sekadar memberikan perintah hierarkis tanpa mempertimbangkan batas kewenangan profesi, etika, dan standar praktik masing-masing. Marquis dan Huston (2021) menegaskan bahwa manajer keperawatan harus mampu mengelola tenaga profesional dengan pendekatan yang menghormati otonomi klinis mereka, sambil tetap memastikan akuntabilitas

dan keselarasan dengan tujuan organisasi, sebuah keseimbangan yang memerlukan keterampilan kepemimpinan yang matang dan pemahaman mendalam tentang dinamika antarprofesi. Karakteristik ini juga menuntut organisasi untuk membangun sistem tata kelola klinis yang jelas, termasuk mekanisme *credentialing*, penetapan *clinical privilege*, dan evaluasi kompetensi berkala yang transparan dan berkeadilan bagi semua tenaga profesional yang bekerja di dalamnya.

d. Beroperasi dalam Lingkungan yang Sangat Terregulasi

Organisasi pelayanan kesehatan beroperasi dalam salah satu lingkungan regulasi yang paling ketat dan kompleks di antara semua jenis organisasi, dengan berbagai peraturan perundang-undangan, standar akreditasi, pedoman klinis, dan kebijakan pemerintah yang terus diperbarui dan harus dipatuhi secara konsisten tanpa pengecualian. Di Indonesia, regulasi yang mengatur organisasi keperawatan mencakup Undang-Undang Keperawatan, peraturan *Kementerian Kesehatan*, standar akreditasi KARS, ketentuan *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial* (BPJS), hingga regulasi profesi yang dikeluarkan oleh *Persatuan Perawat Nasional Indonesia* (PPNI) (2022). Huber (2022) menjelaskan bahwa dalam lingkungan yang sangat terregulasi ini, manajer keperawatan harus memiliki kompetensi untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengimplementasikan regulasi yang relevan ke dalam kebijakan operasional unit kerjanya, sekaligus mampu mengadvokasi perubahan regulasi yang diperlukan melalui jalur yang tepat apabila regulasi yang ada dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan layanan. Kemampuan navigasi regulasi ini bukan sekadar kompetensi administratif, melainkan juga merupakan bentuk tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan selalu berada dalam koridor hukum yang melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan institusi secara bersamaan.

e. Membutuhkan Kolaborasi *Multiprofesi* dan *Multidisiplin*

Kompleksitas masalah kesehatan manusia tidak dapat ditangani oleh satu profesi tunggal, sehingga organisasi pelayanan kesehatan secara inheren membutuhkan kolaborasi yang erat antara berbagai profesi dan disiplin ilmu yang masing-masing berkontribusi dengan perspektif dan keahlian uniknya dalam proses diagnosis, pengobatan, dan pemulihan pasien. Kolaborasi *multiprofesi* dalam organisasi layanan kesehatan mencakup tidak hanya kerja sama antar profesi klinis seperti dokter, perawat, dan apoteker, tetapi juga melibatkan tenaga non-klinis seperti administrator, teknisi, pekerja sosial, dan tenaga gizi yang semuanya memiliki peran dalam

menciptakan pengalaman layanan yang holistik dan berkualitas bagi pasien. Sullivan (2022) menekankan bahwa organisasi kesehatan yang berhasil membangun budaya kolaborasi *multiprofesi* yang kuat terbukti memiliki tingkat keselamatan pasien yang lebih tinggi, efisiensi layanan yang lebih baik, dan tingkat kepuasan tenaga kesehatan yang lebih optimal dibandingkan organisasi yang masih beroperasi dalam silo-silo profesi yang terpisah. Oleh karena itu, membangun infrastruktur kolaborasi, baik melalui desain fisik ruang kerja, sistem komunikasi, maupun program *interprofessional education* yang terstruktur, merupakan investasi strategis yang tidak dapat diabaikan oleh setiap organisasi pelayanan kesehatan yang serius dalam mewujudkan layanan bermutu tinggi.

f. Berorientasi pada Nilai (*Value-Based*) Bukan Sekadar Volume

Paradigma organisasi pelayanan kesehatan modern telah bergeser secara fundamental dari orientasi berbasis volume, di mana keberhasilan diukur dari jumlah pasien yang dilayani atau prosedur yang dilakukan, menuju orientasi berbasis nilai (*value-based care*), di mana keberhasilan diukur dari kualitas hasil klinis yang dicapai relatif terhadap biaya yang digunakan dan pengalaman pasien selama menjalani layanan. Pergeseran paradigma ini memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap cara organisasi keperawatan merancang sistem layanannya, menetapkan indikator kinerja, mengalokasikan sumber daya, dan mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan kepada pasien. Marquis dan Huston (2021) menjelaskan bahwa dalam era *value-based care*, manajer keperawatan dituntut untuk tidak hanya memahami indikator klinis, tetapi juga memiliki literasi finansial yang cukup untuk menganalisis hubungan antara kualitas layanan yang diberikan dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga mampu membuat argumen berbasis data dalam setiap pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Karakteristik ini menuntut transformasi mentalitas seluruh anggota organisasi, dari sekadar menyelesaikan tugas harian menjadi selalu bertanya apakah layanan yang diberikan benar-benar memberikan nilai tambah yang bermakna bagi kehidupan pasien yang dipercayakan kepada mereka.

g. Beroperasi Secara Kontinu Tanpa Henti (*Continuous Operation*)

Salah satu karakteristik operasional yang paling membedakan organisasi pelayanan kesehatan dari hampir semua jenis organisasi lainnya adalah tuntutan untuk beroperasi tanpa henti selama dua puluh empat jam sehari, tujuh hari seminggu, tiga ratus enam puluh lima hari setahun, karena kebutuhan kesehatan manusia tidak mengenal hari libur, jam kerja, maupun

kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Karakteristik ini menciptakan tantangan manajerial yang unik, mulai dari kompleksitas penjadwalan tenaga yang harus memastikan cakupan layanan yang adekuat di setiap *shift*, pengelolaan kelelahan tenaga yang merupakan risiko nyata terhadap keselamatan pasien, hingga pemeliharaan konsistensi standar layanan antara *shift* pagi, sore, dan malam yang seringkali memiliki karakteristik beban kerja yang berbeda secara signifikan. Huber (2022) mengingatkan bahwa manajer keperawatan harus secara proaktif mengelola risiko yang timbul dari operasi kontinu ini, termasuk dengan merancang sistem rotasi yang manusiawi, memastikan kecukupan jumlah tenaga di setiap *shift*, dan membangun mekanisme *handover* yang robust untuk menjamin kesinambungan informasi klinis antara tim yang berganti. Kesadaran akan karakteristik operasi kontinu ini juga penting untuk ditanamkan kepada seluruh tenaga keperawatan, agar setiap perawat memahami bahwa tanggung jawab profesionalnya tidak berakhir pada saat jam kerjanya selesai, melainkan berlanjut hingga informasi dan tanggung jawab klinis telah diserahterimakan secara sempurna kepada tim yang akan melanjutkan layanan.

4. Hubungan organisasi keperawatan dengan mutu layanan

Hubungan antara organisasi keperawatan dan mutu layanan bersifat sangat erat, langsung, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena kualitas asuhan yang diterima pasien pada dasarnya merupakan cerminan langsung dari seberapa baik organisasi keperawatan dirancang, dikelola, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Mutu layanan keperawatan bukan sekadar produk dari kemampuan teknis individu perawat di sisi tempat tidur pasien, melainkan merupakan hasil kumulatif dari keseluruhan sistem organisasi yang melingkupinya, mencakup desain struktur yang mendukung alur kerja yang efisien, kepemimpinan yang menginspirasi komitmen terhadap standar, budaya organisasi yang menjunjung tinggi akuntabilitas, serta sistem evaluasi yang memberikan umpan balik konstruktif secara berkelanjutan. Marquis dan Huston (2021) menegaskan bahwa organisasi keperawatan yang kuat dan sehat secara struktural maupun kultural adalah prasyarat utama bagi terwujudnya mutu layanan yang konsisten dan berkelanjutan, karena bahkan perawat yang paling kompeten sekalipun akan kesulitan memberikan pelayanan berkualitas tinggi apabila sistem organisasi di sekitarnya tidak mendukung dan tidak memfasilitasi praktik terbaiknya. Dengan demikian, investasi dalam penguatan organisasi keperawatan sejatinya adalah investasi langsung dalam peningkatan mutu

layanan yang akan dirasakan manfaatnya oleh setiap pasien yang memasuki pintu fasilitas kesehatan tersebut.

Secara teoritis, hubungan antara organisasi keperawatan dan mutu layanan dapat dipahami melalui kerangka *Donabedian* yang membagi dimensi mutu layanan kesehatan ke dalam tiga komponen yang saling terkait, yaitu struktur, proses, dan hasil (*structure, process, outcome*). Komponen struktur mencakup semua elemen organisasi yang membentuk kapasitas layanan, termasuk jumlah dan kompetensi tenaga perawat, ketersediaan fasilitas dan peralatan, desain sistem manajemen, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi. Komponen proses mencakup keseluruhan rangkaian tindakan dan interaksi yang terjadi selama pemberian asuhan, mulai dari pengkajian, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, yang kualitasnya sangat dipengaruhi oleh seberapa baik organisasi mendukung pelaksanaannya melalui pelatihan, supervisi, dan sistem kendali mutu yang memadai. Huber (2022) menjelaskan bahwa komponen hasil atau *outcome* merupakan muara dari seluruh upaya struktur dan proses, yang tercermin dalam berbagai indikator klinis seperti angka kejadian *phlebitis*, *decubitus*, jatuh, infeksi *nosokomial*, lama rawat inap, serta tingkat kepuasan pasien yang pada akhirnya menjadi ukuran paling nyata dari seberapa baik organisasi keperawatan menjalankan fungsinya dalam menjamin mutu layanan kepada setiap pasien yang dipercayakan kepada sistem tersebut.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa mekanisme konkret melalui mana organisasi keperawatan secara langsung memengaruhi mutu layanan yang diberikan kepada pasien. Pertama, rasio tenaga perawat terhadap pasien (*nurse-to-patient ratio*) yang merupakan keputusan organisasi fundamental terbukti secara ilmiah memiliki hubungan yang signifikan dengan berbagai indikator mutu dan keselamatan pasien, di mana beban kerja yang berlebihan akan menurunkan kemampuan perawat untuk memberikan perhatian yang optimal kepada setiap pasien. Kedua, sistem orientasi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi yang dirancang oleh organisasi secara langsung menentukan tingkat kesiapan perawat dalam menghadapi kompleksitas klinis yang semakin meningkat, sehingga organisasi yang berinvestasi secara serius dalam pengembangan sumber daya manusianya akan memiliki tenaga yang lebih mampu memberikan asuhan berkualitas tinggi secara konsisten. Ketiga, kepemimpinan keperawatan yang efektif, yang merupakan produk dari bagaimana organisasi mengidentifikasi, mengembangkan, dan mendukung pemimpinnya, terbukti menjadi salah satu determinan terkuat dari mutu layanan, karena pemimpin yang baik akan menciptakan iklim kerja yang

mendorong praktik berbasis bukti, komunikasi yang terbuka, dan komitmen kolektif terhadap standar mutu yang telah ditetapkan. Sullivan (2022) menambahkan bahwa sistem evaluasi kinerja yang adil, transparan, dan berorientasi pada pengembangan, bukan sekadar hukuman, merupakan mekanisme organisasi yang sangat berpengaruh dalam mendorong perawat untuk terus meningkatkan kualitas praktiknya demi memberikan layanan terbaik bagi setiap pasien yang dilayaninya.

Memahami hubungan yang mendalam antara organisasi keperawatan dan mutu layanan membawa implikasi yang sangat penting bagi setiap perawat, terlepas dari posisi dan level jabatannya dalam hierarki organisasi. Bagi perawat pelaksana, pemahaman ini berarti bahwa setiap kontribusi yang diberikan dalam mematuhi standar, melaporkan insiden, memberikan saran perbaikan, dan menjalin kolaborasi yang baik dengan rekan kerja sesungguhnya adalah kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan yang dirasakan langsung oleh pasien. Bagi perawat manajer, pemahaman ini berarti bahwa setiap keputusan organisasi, mulai dari penentuan jumlah tenaga, pemilihan model asuhan, penyusunan jadwal pelatihan, hingga penetapan mekanisme evaluasi, memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas asuhan yang akan diterima oleh pasien di bawah tanggung jawabnya. Dalam era akuntabilitas publik yang semakin tinggi, di mana data mutu layanan semakin mudah diakses dan dibandingkan oleh masyarakat, organisasi keperawatan tidak lagi memiliki kemewahan untuk memisahkan urusan manajemen organisasi dari urusan mutu klinis, karena keduanya adalah dua sisi dari satu koin yang sama, yaitu komitmen profesi keperawatan untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi setiap manusia yang mempercayakan kesehatan dan hidupnya kepada sistem layanan yang dibangun dan dikelola bersama (Marquis & Huston, 2021) .

B. Prinsip-Prinsip Pengorganisasian dalam Keperawatan

1. Prinsip hierarki dan *chain of command*

Dalam setiap organisasi pelayanan kesehatan, hierarki dan *chain of command* bukan sekadar simbol kekuasaan atau formalitas struktural yang terpampang dalam bagan organisasi, melainkan merupakan sistem yang secara fungsional mengatur bagaimana wewenang mengalir, bagaimana keputusan dibuat, dan bagaimana tanggung jawab diemban oleh setiap individu dalam organisasi tersebut. Prinsip hierarki dalam organisasi keperawatan merujuk pada penataan posisi jabatan secara vertikal dari tingkatan tertinggi hingga terendah, yang mencerminkan distribusi otoritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas secara berjenjang dalam sistem pelayanan.

Sementara itu, *chain of command* atau rantai komando merujuk pada jalur formal yang menghubungkan setiap posisi dalam hierarki tersebut, yang menentukan kepada siapa seseorang melapor, dari siapa seseorang menerima arahan, dan melalui jalur mana komunikasi resmi organisasi seharusnya mengalir. Pemahaman yang kuat tentang kedua prinsip ini merupakan fondasi penting bagi setiap perawat, karena tanpa kejelasan hierarki dan rantai komando, organisasi keperawatan akan rentan terhadap konflik wewenang, kebingungan peran, duplikasi kerja, dan pada akhirnya penurunan kualitas layanan yang langsung berdampak pada keselamatan pasien yang menjadi tanggung jawab moral seluruh anggota organisasi (Marquis & Huston, 2021).

a. Kesatuan Komando (*Unity of Command*)

   Prinsip kesatuan komando menetapkan bahwa setiap anggota organisasi keperawatan seharusnya hanya menerima perintah, arahan, dan pertanggungjawaban dari satu atasan langsung yang jelas, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam menerima instruksi yang mungkin saling bertentangan dari berbagai sumber otoritas yang berbeda secara bersamaan. Ketika seorang perawat pelaksana menerima arahan dari lebih dari satu sumber otoritas tanpa kejelasan hierarki yang tegas, maka risiko konflik peran, stres kerja, dan kesalahan klinis akibat kebingungan prioritas akan meningkat secara signifikan. Dalam konteks keperawatan, prinsip ini diimplementasikan melalui penetapan struktur yang jelas, di mana perawat pelaksana melapor kepada ketua tim, ketua tim melapor kepada kepala ruangan, kepala ruangan melapor kepada kepala bidang keperawatan, dan seterusnya hingga pucuk pimpinan organisasi. Prinsip kesatuan komando ini tidak berarti menutup jalur komunikasi informal atau konsultasi lintas bagian, melainkan memastikan bahwa dalam hal pemberian tugas, evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan yang bersifat mengikat, setiap perawat memiliki satu atasan yang jelas yang bertanggung jawab atas pengarahannya dan kepada siapa ia wajib melaporkan hasil pekerjaannya secara resmi dan terstruktur.

b. Skalar atau Gradasi Wewenang (*Scalar Principle*)

   Prinsip skalar menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi keperawatan tersusun secara bertingkat dari posisi paling tinggi hingga posisi paling rendah dalam hierarki, membentuk sebuah rantai yang tidak terputus dari pimpinan puncak hingga perawat pelaksana di tingkat terbawah. Setiap level dalam hierarki memiliki tingkat wewenang dan tanggung jawab yang proporsional dengan posisinya, di mana semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki, semakin luas cakupan wewenang dan

tanggung jawab yang diembannya terhadap sistem layanan secara keseluruhan. Dalam praktik keperawatan, prinsip ini terwujud dalam pembagian yang jelas antara wewenang kepala bidang keperawatan yang mencakup seluruh unit keperawatan di institusi, wewenang kepala ruangan yang mencakup satu unit atau bangsal tertentu, wewenang ketua tim yang mencakup sekelompok pasien tertentu dalam satu *shift*, hingga wewenang perawat pelaksana yang berfokus pada asuhan langsung kepada pasien yang menjadi tanggung jawabnya. Pemahaman tentang prinsip skalar ini penting agar setiap perawat tidak mengambil keputusan yang melampaui batas wewenangnya, namun juga tidak menghindari tanggung jawab yang seharusnya ada dalam lingkup posisinya, sehingga akuntabilitas di setiap level hierarki dapat terjaga dengan baik dan konsisten (Yoder-Wise & Sportsman, 2023).

c. Pendelegasian Wewenang (*Delegation of Authority*)

Pendelegasian wewenang merupakan mekanisme penting dalam hierarki organisasi keperawatan yang memungkinkan pimpinan untuk menyerahkan sebagian wewenangnya kepada bawahan yang dipercaya, sehingga pimpinan dapat memfokuskan energinya pada tugas-tugas strategis yang lebih membutuhkan perhatian dan keahliannya di level kepemimpinan. Pendelegasian yang efektif bukan berarti melepaskan tanggung jawab, melainkan justru merupakan ekspresi kepercayaan dan pengembangan kompetensi bawahan sambil tetap mempertahankan akuntabilitas akhir di tangan pimpinan yang mendelegasikan. Dalam konteks keperawatan, pendelegasian dapat terjadi secara vertikal, misalnya kepala ruangan mendelegasikan tugas pengawasan kepada ketua tim, maupun secara horizontal dalam bentuk koordinasi tugas antar perawat dalam level yang setara. Agar pendelegasian berjalan dengan baik dan aman, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi secara konsisten, yaitu kejelasan tugas yang didelegasikan, kesesuaian antara beban tugas dengan kompetensi penerima delegasi, ketersediaan sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas, serta mekanisme supervisi dan pelaporan yang memungkinkan pimpinan memantau perkembangan tanpa harus mengambil alih secara berlebihan. Kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat pendelegasian ini tidak hanya akan mengurangi efektivitas organisasi, tetapi juga dapat menciptakan risiko keselamatan pasien apabila tugas klinis yang kritikal diserahkan kepada individu yang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menanganinya.

d. Rentang Kendali (*Span of Control*)

Rentang kendali merujuk pada jumlah bawahan yang secara efektif dapat diawasi, diarahkan, dan dibimbing oleh seorang pimpinan dalam hierarki organisasi keperawatan, dan merupakan salah satu variabel struktural yang paling berpengaruh terhadap efektivitas manajemen dan kualitas supervisi klinis yang dapat diberikan. Rentang kendali yang terlalu lebar, di mana seorang kepala ruangan misalnya harus mengawasi puluhan perawat sekaligus, akan mengakibatkan supervisi yang dangkal, komunikasi yang tidak efektif, dan hilangnya sentuhan personal yang penting dalam membimbing perawat untuk terus berkembang secara profesional. Sebaliknya, rentang kendali yang terlalu sempit akan mengakibatkan pemborosan sumber daya manajerial, birokrasi yang berlebihan, serta terhambatnya otonomi dan inisiatif anggota tim karena terlalu banyak lapisan pengawasan yang harus dilalui dalam setiap proses pengambilan keputusan. Besaran rentang kendali yang optimal dalam organisasi keperawatan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, termasuk kompleksitas kasus pasien yang dirawat, tingkat kompetensi dan pengalaman tenaga keperawatan, ketersediaan sistem pendukung seperti teknologi informasi, serta karakteristik fisik dan geografis unit layanan yang bersangkutan. Oleh karena itu, penetapan rentang kendali yang tepat harus dilakukan berdasarkan analisis kontekstual yang cermat, bukan sekadar mengikuti formula standar yang tidak memperhitungkan keunikan dan kompleksitas situasi layanan di setiap unit keperawatan.

e. Jalur Formal dan Informal dalam *Chain of Command*

Dalam organisasi keperawatan, *chain of command* tidak hanya beroperasi melalui jalur formal yang tercantum dalam bagan organisasi, tetapi juga melalui jalur informal yang terbentuk secara organik dari hubungan kerja, kepercayaan, dan pengaruh interpersonal yang berkembang di antara anggota tim dalam keseharian operasional layanan. Jalur formal *chain of command* menetapkan siapa berhak memberi perintah kepada siapa, melalui jalur mana keputusan resmi harus disampaikan, dan bagaimana eskalasi masalah seharusnya dilakukan ketika persoalan tidak dapat diselesaikan di level yang lebih rendah. Sementara itu, jalur informal seringkali berperan penting dalam mempercepat aliran informasi, membangun konsensus, dan memfasilitasi penyelesaian masalah operasional sehari-hari yang tidak selalu memerlukan melalui prosedur formal yang membutuhkan waktu lebih panjang. Meskipun jalur informal ini penting dan tidak dapat dihindari dalam dinamika organisasi yang hidup,

pemimpin keperawatan perlu memastikan bahwa jalur informal tidak sampai menggerus atau membypass jalur formal yang ada, karena melemahnya *chain of command* formal dapat menciptakan ambiguitas wewenang, konflik kepentingan, dan pada akhirnya mengancam efektivitas koordinasi layanan yang bergantung pada kejelasan struktur dan akuntabilitas yang tegas di setiap level hierarki organisasi.

f. Eskalasi dan Pelaporan dalam Hierarki

Salah satu fungsi paling kritis dari hierarki dan *chain of command* dalam organisasi keperawatan adalah menyediakan jalur yang jelas dan dapat diandalkan untuk melakukan eskalasi masalah, melaporkan insiden, dan mencari dukungan pengambilan keputusan ketika seorang perawat menghadapi situasi klinis atau manajerial yang melampaui kapasitas atau wewenangnya di level saat ini. Eskalasi yang tepat waktu dan melalui jalur yang benar merupakan salah satu penentu utama keselamatan pasien, karena banyak insiden klinis yang serius sebenarnya dapat dicegah apabila perawat pelaksana yang pertama kali mengenali tanda-tanda perburukan kondisi pasien mampu dan berani melaporkan temuannya kepada pimpinan yang memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan tanpa penundaan. Hambatan terhadap eskalasi, seperti budaya organisasi yang tidak aman secara psikologis, hierarki yang terlalu kaku dan mengintimidasi, atau ketidakjelasan tentang kapan dan bagaimana harus melakukan eskalasi, merupakan risiko sistemik yang harus diatasi secara proaktif oleh pimpinan keperawatan melalui kebijakan yang jelas, pelatihan yang memadai, dan keteladanan yang konsisten dalam menyambut setiap laporan dengan sikap yang terbuka, apresiatif, dan konstruktif agar seluruh anggota tim merasa aman dan bahkan terdorong untuk selalu melaporkan setiap persoalan yang mereka temui demi kebaikan bersama (Baretto et al., 2025).

2. Prinsip *span of control* dan rentang kendali

Span of control atau rentang kendali merupakan salah satu prinsip pengorganisasian yang mengacu pada jumlah bawahan yang dapat diawasi dan dibimbing secara efektif oleh seorang pimpinan dalam suatu organisasi. Dalam konteks keperawatan, prinsip ini sangat relevan karena menyangkut kemampuan kepala ruangan atau manajer keperawatan dalam memberikan supervisi yang berkualitas kepada seluruh anggota tim yang berada di bawah tanggung jawabnya. Penetapan rentang kendali yang tepat bukan sekadar persoalan administratif, melainkan keputusan strategis yang berdampak

langsung terhadap efektivitas supervisi, kualitas asuhan, dan keselamatan pasien secara keseluruhan (Haimi, 2026).

a. Rentang Kendali Lebar vs. Sempit

Rentang kendali lebar berarti satu pimpinan membawahi banyak bawahan sekaligus, sehingga struktur organisasi menjadi lebih datar dan efisien secara biaya, namun berisiko menghasilkan supervisi yang dangkal karena perhatian pimpinan terbagi terlalu luas. Sebaliknya, rentang kendali sempit berarti satu pimpinan hanya membawahi sedikit bawahan, sehingga supervisi dapat dilakukan lebih intensif dan personal, namun struktur organisasi menjadi lebih berlapis dan cenderung birokratis. Dalam organisasi keperawatan, keduanya memiliki konsekuensi klinis yang nyata, sehingga pilihan antara keduanya harus didasarkan pada analisis konteks layanan yang cermat dan bukan semata-mata pertimbangan efisiensi anggaran.

b. Faktor yang Memengaruhi Rentang Kendali

Tidak ada angka baku yang berlaku universal untuk rentang kendali dalam keperawatan, karena besarannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor situasional. Kompleksitas kasus pasien yang dirawat menjadi faktor utama, di mana unit dengan tingkat keparahan pasien yang tinggi seperti ICU membutuhkan rentang kendali yang lebih sempit dibandingkan unit rawat inap umum. Selain itu, tingkat kompetensi dan pengalaman tenaga perawat juga sangat menentukan, karena perawat yang berpengalaman membutuhkan supervisi yang lebih sedikit dibandingkan perawat baru. Faktor lain yang turut berpengaruh mencakup ketersediaan teknologi pendukung, desain fisik unit layanan, serta kejelasan standar prosedur operasional yang berlaku di unit tersebut.

c. Implikasi terhadap Kualitas Supervisi

Rentang kendali yang tidak proporsional dengan beban kerja nyata akan secara langsung melemahkan kualitas supervisi klinis yang dapat diberikan oleh pimpinan keperawatan. Ketika seorang kepala ruangan harus mengawasi terlalu banyak perawat sekaligus, kemampuannya untuk mendeteksi masalah klinis secara dini, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membimbing perawat yang membutuhkan dukungan akan menurun secara signifikan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kinerja individu perawat, tetapi juga pada keselamatan pasien secara keseluruhan, karena supervisi yang lemah meningkatkan risiko terlewatnya tanda-tanda perburukan kondisi pasien yang seharusnya dapat dideteksi lebih awal.

d. Rentang Kendali dalam Praktik Keperawatan Indonesia

Dalam konteks fasilitas layanan kesehatan di Indonesia, rentang kendali dalam keperawatan seringkali belum ditetapkan secara eksplisit berdasarkan analisis beban kerja yang terstandar, melainkan lebih banyak ditentukan oleh ketersediaan tenaga dan struktur yang sudah ada. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajer keperawatan yang harus berupaya memberikan supervisi yang optimal di tengah keterbatasan jumlah tenaga dan kompleksitas beban kerja yang terus meningkat. Oleh karena itu, advokasi untuk penetapan rentang kendali yang berbasis bukti dan berorientasi pada keselamatan pasien merupakan salah satu tugas penting yang harus diemban oleh pemimpin keperawatan di setiap level organisasi (Cherry & Jacob, 2022).

3. Prinsip pembagian kerja dan spesialisasi

Prinsip pembagian kerja dan spesialisasi merupakan salah satu fondasi penting dalam pengorganisasian pelayanan keperawatan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas asuhan melalui penetapan peran dan tugas yang jelas bagi setiap anggota tim. Pembagian kerja pada dasarnya adalah proses membagi keseluruhan pekerjaan organisasi menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan spesifik, yang kemudian didistribusikan kepada individu atau kelompok berdasarkan kompetensi, kewenangan, dan kapasitas yang dimiliki. Dalam organisasi keperawatan yang semakin kompleks, prinsip ini menjadi semakin relevan karena tuntutan layanan yang terus berkembang tidak lagi dapat dipenuhi secara optimal oleh satu individu yang bekerja secara serba bisa tanpa fokus dan kedalaman keahlian yang memadai (Whitehead et al., 2023).

a. Pengertian Pembagian Kerja dalam Keperawatan

Pembagian kerja dalam keperawatan merujuk pada pendistribusian tugas dan tanggung jawab asuhan secara terstruktur kepada anggota tim berdasarkan kompetensi, jenjang pendidikan, dan kewenangan klinis yang dimiliki masing-masing individu. Dalam praktiknya, pembagian kerja ini tercermin dalam penetapan tugas perawat pelaksana, ketua tim, kepala ruangan, dan perawat spesialis yang masing-masing memiliki lingkup tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi. Pembagian kerja yang tepat akan mencegah terjadinya penumpukan beban pada satu individu, mengurangi risiko kesalahan akibat kelelahan, serta memastikan bahwa setiap tugas dikerjakan oleh orang yang paling kompeten dan berwenang untuk mengerjakannya demi keselamatan dan kenyamanan pasien (Whitehead et al., 2023).

b. Spesialisasi dalam Praktik Keperawatan

Spesialisasi dalam keperawatan merujuk pada pengembangan keahlian mendalam di bidang atau area layanan tertentu, seperti keperawatan kritis, keperawatan onkologi, keperawatan perioperatif, keperawatan jiwa, dan berbagai bidang spesialisasi lainnya yang membutuhkan kompetensi di atas standar keperawatan umum. Spesialisasi lahir sebagai respons terhadap semakin kompleksnya kebutuhan klinis pasien yang tidak lagi dapat ditangani secara optimal hanya dengan kompetensi keperawatan dasar. Perawat spesialis memiliki kedalaman pengetahuan, keterampilan teknis, dan kemampuan pengambilan keputusan klinis yang lebih tinggi di bidangnya, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu layanan, khususnya dalam penanganan kasus-kasus kompleks yang membutuhkan pendekatan klinis yang presisi dan berbasis bukti terkini.

c. Manfaat Pembagian Kerja dan Spesialisasi

Penerapan prinsip pembagian kerja dan spesialisasi yang baik dalam organisasi keperawatan memberikan sejumlah manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh pasien, perawat, maupun institusi secara keseluruhan. Bagi pasien, pembagian kerja yang terstruktur memastikan bahwa asuhan yang diterima diberikan oleh tenaga yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan standar yang konsisten. Bagi perawat, spesialisasi membuka ruang pengembangan karier yang lebih terarah, meningkatkan kepuasan kerja, dan memperkuat identitas profesional yang pada gilirannya berkontribusi pada retensi tenaga yang lebih baik. Bagi institusi, efisiensi yang dihasilkan dari pembagian kerja yang optimal akan mengurangi pemborosan sumber daya, memperpendek *length of stay*, dan meningkatkan produktivitas layanan secara keseluruhan.

d. Risiko dan Tantangan Spesialisasi Berlebihan

Meskipun spesialisasi membawa banyak manfaat, penerapannya yang berlebihan atau tidak terkelola dengan baik juga dapat menimbulkan sejumlah risiko dalam organisasi keperawatan. Fragmentasi layanan merupakan risiko utama, di mana pasien yang memiliki kebutuhan kompleks dan *multidimensi* justru menerima asuhan yang terpecah-pecah karena setiap spesialis hanya berfokus pada bidangnya tanpa memandang pasien secara holistik. Selain itu, spesialisasi yang berlebihan dapat menciptakan silo-silo profesional yang menghambat kolaborasi dan komunikasi lintas bidang, sehingga koordinasi layanan menjadi lebih sulit dan rentan terhadap kesalahan akibat putusnya informasi antar tim. Oleh

karena itu, spesialisasi dalam keperawatan harus selalu diimbangi dengan pendekatan holistik dan mekanisme koordinasi yang kuat agar manfaatnya dapat diraih secara optimal tanpa mengorbankan kesinambungan dan keutuhan asuhan yang diberikan kepada pasien.

e. Implementasi Pembagian Kerja Berbasis Kompetensi

Pembagian kerja yang efektif dalam keperawatan harus didasarkan pada kompetensi yang terverifikasi, bukan sekadar senioritas, ketersediaan, atau kebiasaan yang telah berlangsung lama tanpa evaluasi yang memadai. Sistem *skill mix* yang mengombinasikan perawat dengan berbagai tingkat kompetensi dalam satu tim secara proporsional merupakan pendekatan yang terbukti efektif dalam mengoptimalkan kualitas layanan sekaligus efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Pemimpin keperawatan bertanggung jawab untuk secara berkala mengevaluasi kesesuaian antara kompetensi tenaga yang dimiliki dengan tuntutan layanan yang ada, serta mengambil langkah proaktif dalam mengisi kesenjangan melalui program pelatihan, rekrutmen, atau redistribusi tenaga yang berbasis data dan berorientasi pada kebutuhan riil pasien (Finkelman & Kenner, 2023).

4. Prinsip koordinasi dan kesatuan komando

Koordinasi dan kesatuan komando merupakan dua prinsip pengorganisasian yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam membangun organisasi keperawatan yang efektif dan responsif terhadap tuntutan layanan. Koordinasi memastikan bahwa seluruh bagian organisasi bergerak secara selaras menuju tujuan bersama, sementara kesatuan komando memastikan bahwa setiap individu memiliki kejelasan tentang dari mana arahan diterima dan kepada siapa tanggung jawab dilaporkan. Dalam lingkungan pelayanan kesehatan yang dinamis dan penuh tekanan, kedua prinsip ini menjadi penentu utama apakah sebuah organisasi keperawatan mampu memberikan layanan yang terkoordinasi, aman, dan konsisten kepada setiap pasien yang dipercayakan kepada sistemnya (Kim et al., 2024).

a. Pengertian Koordinasi dalam Organisasi Keperawatan

Koordinasi dalam organisasi keperawatan adalah proses mengintegrasikan seluruh aktivitas, sumber daya, dan upaya berbagai unit serta individu secara terencana agar tujuan pelayanan dapat dicapai secara efisien dan efektif tanpa terjadi tumpang tindih, konflik, maupun kekosongan layanan yang membahayakan pasien. Koordinasi tidak terjadi secara otomatis meskipun struktur organisasi telah dirancang dengan baik,

melainkan membutuhkan upaya aktif dari seluruh anggota tim untuk berkomunikasi secara terbuka, berbagi informasi yang relevan, dan menyelaraskan langkah-langkah tindakan mereka dengan langkah-langkah rekan kerja di unit lain. Tanpa koordinasi yang efektif, bahkan organisasi dengan tenaga yang kompeten dan fasilitas yang lengkap sekalipun akan kesulitan memberikan layanan yang berkesinambungan dan bermutu tinggi kepada pasien yang kebutuhannya seringkali melintasi batas-batas unit dan profesi dalam sistem layanan kesehatan.

b. Bentuk-Bentuk Koordinasi dalam Keperawatan

Koordinasi dalam organisasi keperawatan dapat berlangsung dalam berbagai bentuk yang masing-masing memiliki fungsi dan konteks penerapannya sendiri. Koordinasi vertikal terjadi antara level hierarki yang berbeda, misalnya antara kepala bidang keperawatan dengan kepala ruangan, atau antara kepala ruangan dengan ketua tim, untuk memastikan bahwa kebijakan dari level atas diterjemahkan secara tepat ke dalam praktik operasional di level bawah. Koordinasi horizontal terjadi antara unit atau individu yang berada pada level hierarki yang setara, seperti koordinasi antar kepala ruangan dari bangsal yang berbeda, atau antar perawat dalam satu *shift* yang menangani kelompok pasien yang berbeda namun berada dalam satu unit yang sama. Koordinasi diagonal terjadi lintas level dan lintas unit sekaligus, misalnya ketika perawat pelaksana berkoordinasi langsung dengan apoteker atau fisioterapis dalam penanganan kebutuhan pasien tertentu tanpa harus melalui seluruh jalur hierarki formal yang ada.

c. Mekanisme Koordinasi yang Efektif

Agar koordinasi dapat berjalan secara efektif dalam organisasi keperawatan, dibutuhkan mekanisme yang terstruktur dan disepakati bersama oleh seluruh anggota tim. Pertemuan *briefing* dan *debriefing* harian merupakan salah satu mekanisme koordinasi paling sederhana namun efektif, karena memberikan ruang bagi seluruh anggota tim untuk menyamakan pemahaman tentang prioritas layanan, kondisi pasien, dan pembagian tugas di setiap *shift*. Proses *handover* yang terstandar menggunakan metode seperti *Situation, Background, Assessment, Recommendation* (SBAR) merupakan mekanisme koordinasi klinis yang krusial untuk memastikan kesinambungan informasi antar *shift* tanpa kehilangan data penting yang memengaruhi keselamatan pasien. Selain itu, sistem dokumentasi yang terintegrasi, rapat koordinasi lintas unit secara berkala, dan pemanfaatan teknologi komunikasi yang tepat juga

merupakan pilar-pilar mekanisme koordinasi yang efektif dalam organisasi keperawatan modern.

d. Kesatuan Komando sebagai Fondasi Koordinasi

Kesatuan komando (*unity of command*) adalah prinsip yang menetapkan bahwa setiap anggota organisasi keperawatan seharusnya hanya bertanggung jawab kepada satu atasan langsung yang jelas dalam setiap waktu, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam menerima arahan yang saling bertentangan dari berbagai sumber otoritas yang berbeda secara bersamaan. Prinsip ini menjadi fondasi yang memungkinkan koordinasi berjalan dengan lancar, karena kejelasan tentang siapa yang berwenang memberi arahan akan menghilangkan ambiguitas yang seringkali menjadi sumber konflik dan inefisiensi dalam organisasi. Ketika prinsip kesatuan komando diterapkan secara konsisten, setiap perawat dapat bekerja dengan keyakinan penuh tentang prioritas tugasnya, mengetahui kepada siapa ia harus melapor ketika menghadapi masalah, dan memahami jalur eskalasi yang harus ditempuh ketika situasi membutuhkan pengambilan keputusan di level yang lebih tinggi.

e. Tantangan Koordinasi dan Kesatuan Komando di Lapangan

Dalam praktik nyata, penerapan prinsip koordinasi dan kesatuan komando dalam organisasi keperawatan seringkali menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kompleksitas layanan kesehatan yang melibatkan banyak profesi dengan hierarki dan otoritas masing-masing seringkali menciptakan situasi di mana seorang perawat harus merespons arahan dari dokter, manajer keperawatan, dan kebijakan institusi secara bersamaan, yang potensial menimbulkan konflik prioritas yang membingungkan. Selain itu, dinamika tim yang beragam, pergantian *shift* yang terus menerus, dan tekanan beban kerja yang tinggi seringkali membuat mekanisme koordinasi formal terpinggirkan oleh kebutuhan penanganan situasi darurat yang mendesak. Pemimpin keperawatan perlu secara proaktif mengidentifikasi celah-celah koordinasi ini dan membangun sistem yang cukup fleksibel untuk mengakomodasi dinamika layanan, namun tetap cukup terstruktur untuk memastikan akuntabilitas dan keselamatan pasien tidak pernah dikorbankan atas nama kecepatan atau kepraktisan semata (Jabakhanji et al., 2024).

5. Prinsip akuntabilitas dan pendelegasian wewenang

Akuntabilitas dan pendelegasian wewenang merupakan dua prinsip yang berjalan beriringan dan saling bergantung dalam sistem organisasi

keperawatan yang sehat dan fungsional. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu dalam organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan hasil kerjanya kepada pihak yang berwenang, baik kepada atasan langsung, institusi, profesi, maupun kepada pasien dan masyarakat yang dilayaninya. Pendelegasian wewenang di sisi lain adalah proses formal di mana seorang pimpinan menyerahkan sebagian tugas dan wewenangnya kepada bawahan yang dipercaya, dengan tetap mempertahankan akuntabilitas akhir atas hasil dari tugas yang didelegasikan tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang kedua prinsip ini sangat penting bagi setiap perawat karena dalam praktik keperawatan sehari-hari, keputusan tentang apa yang dapat dan tidak dapat didelegasikan, serta bagaimana mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang diambil, merupakan inti dari praktik profesional yang aman, etis, dan berkualitas tinggi (Farghaly et al., 2022).

Akuntabilitas dalam keperawatan tidak bersifat tunggal, melainkan berdimensi jamak yang mencakup akuntabilitas klinis, akuntabilitas profesional, akuntabilitas etis, dan akuntabilitas hukum yang masing-masing memiliki lingkup dan konsekuensinya sendiri. Akuntabilitas klinis berarti bahwa setiap perawat bertanggung jawab atas ketepatan pengkajian, keakuratan diagnosis keperawatan, relevansi intervensi yang dipilih, serta efektivitas evaluasi asuhan yang diberikan kepada setiap pasien di bawah tanggung jawabnya. Akuntabilitas profesional berarti bahwa setiap perawat bertanggung jawab untuk senantiasa memperbarui kompetensinya, mematuhi standar praktik yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan menjaga integritas serta martabat profesi keperawatan dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Akuntabilitas etis menuntut setiap perawat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambilnya mencerminkan nilai-nilai keperawatan yang mendasar, termasuk penghormatan terhadap otonomi pasien, keadilan dalam pemberian layanan, dan komitmen untuk tidak merugikan pihak manapun. Sementara akuntabilitas hukum mengingatkan setiap perawat bahwa tindakan klinisnya berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa kelalaian profesional dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius bagi dirinya maupun institusi tempatnya bekerja (Horton et al., 2024).

Pendelegasian wewenang yang efektif dan aman dalam keperawatan mensyaratkan terpenuhinya sejumlah prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan dalam kondisi apapun, termasuk dalam situasi darurat sekalipun. Pertama, kejelasan tugas yang didelegasikan harus dipastikan secara eksplisit, termasuk

batasan wewenang, standar pelaksanaan yang diharapkan, dan hasil yang ingin dicapai, sehingga penerima delegasi memiliki pemahaman yang utuh tentang apa yang harus dilakukannya. Kedua, kesesuaian antara kompleksitas tugas yang didelegasikan dengan kompetensi dan kewenangan klinis penerima delegasi harus dievaluasi secara cermat, karena mendelegasikan tugas klinis yang kritikal kepada individu yang belum memiliki kompetensi yang memadai merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip keselamatan pasien. Ketiga, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan harus dipastikan sebelum pendelegasian dilakukan, agar penerima delegasi tidak berada dalam posisi bertanggung jawab atas tugas yang tidak mungkin diselesaikan dengan baik karena keterbatasan fasilitas atau dukungan yang ada. Keempat, mekanisme supervisi dan pelaporan yang jelas harus ditetapkan sejak awal, sehingga pimpinan yang mendelegasikan dapat memantau perkembangan tanpa harus mengambil alih secara berlebihan, dan penerima delegasi mengetahui kapan dan bagaimana ia harus melaporkan perkembangan atau eskalasi masalah yang ditemuinya (Ahmad Shulah, 2024).

Hubungan antara akuntabilitas dan pendelegasian dalam konteks keperawatan mengandung paradoks yang penting untuk dipahami secara mendalam, yaitu bahwa meskipun wewenang dapat didelegasikan kepada bawahan, akuntabilitas akhir tetap melekat pada pimpinan yang mendelegasikan dan tidak dapat dipindahtangankan sepenuhnya kepada penerima delegasi. Artinya, seorang kepala ruangan yang mendelegasikan tugas pemantauan kondisi pasien kepada ketua tim tetap bertanggung jawab atas keselamatan pasien tersebut apabila ternyata supervisi yang diberikannya tidak memadai atau penerima delegasi tidak memiliki kompetensi yang seharusnya dimiliki untuk menjalankan tugas tersebut. Paradoks ini menuntut pemimpin keperawatan untuk tidak memandang pendelegasian sebagai cara untuk melepaskan tanggung jawab, melainkan sebagai investasi dalam pengembangan kompetensi bawahan yang harus dikelola secara aktif melalui supervisi yang konsisten, umpan balik yang konstruktif, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, budaya akuntabilitas yang kuat dalam organisasi keperawatan bukan dibangun melalui sistem hukuman yang membuat perawat takut untuk bertindak, melainkan melalui kepemimpinan yang menjadi teladan dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan secara jujur dan terbuka, sehingga akuntabilitas menjadi nilai yang dihayati dari dalam diri setiap perawat dan bukan sekadar kewajiban eksternal yang dipenuhi karena terpaksa (Weber et al., 2022).

C. Model dan Struktur Organisasi Keperawatan

1. Struktur organisasi fungsional, *divisional,* matriks

Struktur organisasi merupakan kerangka formal yang menggambarkan bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab didistribusikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan dalam suatu organisasi pelayanan kesehatan. Dalam konteks keperawatan, pemilihan model struktur organisasi bukan sekadar keputusan administratif semata, melainkan keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap efektivitas koordinasi layanan, kecepatan pengambilan keputusan, kualitas komunikasi antar unit, dan pada akhirnya terhadap mutu asuhan yang diterima oleh pasien. Terdapat tiga model struktur organisasi yang paling umum ditemukan dalam institusi layanan kesehatan, yaitu struktur fungsional, *divisional*, dan matriks, yang masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan yang perlu dipahami secara mendalam oleh setiap pemimpin keperawatan sebelum memutuskan model mana yang paling sesuai dengan konteks dan kebutuhan organisasinya (Splane et al., 2025).

Struktur organisasi fungsional adalah model yang mengelompokkan seluruh tenaga dan aktivitas berdasarkan kesamaan fungsi atau keahlian profesional, sehingga semua perawat berada dalam satu departemen keperawatan yang dipimpin oleh kepala bidang keperawatan, semua tenaga medis berada dalam departemen medis, semua tenaga farmasi berada dalam departemen farmasi, dan seterusnya secara konsisten mengikuti garis fungsi yang sama. Model ini merupakan yang paling klasik dan paling banyak ditemukan di rumah sakit Indonesia, terutama pada institusi dengan skala menengah hingga besar yang membutuhkan spesialisasi fungsi yang jelas dan terstandar di setiap bidang layanan. Kelebihan utama struktur fungsional terletak pada efisiensi yang tinggi dalam pengembangan keahlian, karena tenaga dengan fungsi yang sama akan belajar bersama, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan standar praktik yang konsisten dalam lingkup fungsinya. Selain itu, jalur karier dalam struktur fungsional relatif jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan perencanaan pengembangan sumber daya manusia dan sistem evaluasi kinerja yang terstandar di seluruh unit keperawatan (Hidayat et al., 2024).

Namun demikian, struktur fungsional juga memiliki keterbatasan yang cukup signifikan dalam konteks layanan kesehatan yang semakin menuntut kolaborasi *lintas-profesi* yang erat dan responsif. Silo fungsional yang terbentuk akibat pengelompokan berdasarkan fungsi seringkali menciptakan hambatan koordinasi horizontal, di mana setiap departemen cenderung berfokus pada

kepentingan dan prioritasnya sendiri tanpa memandang kebutuhan integrasi layanan yang dibutuhkan pasien secara menyeluruh. Komunikasi antar departemen dalam struktur fungsional seringkali harus melalui jalur hierarki yang panjang, sehingga memperlambat respons terhadap kebutuhan klinis pasien yang bersifat mendesak dan membutuhkan koordinasi lintas fungsi secara cepat dan langsung. Dalam situasi di mana pasien membutuhkan layanan dari berbagai profesi secara simultan dan terkoordinasi, keterbatasan struktur fungsional ini dapat menjadi hambatan nyata yang berpotensi menurunkan kualitas dan kesinambungan asuhan yang diberikan.

Struktur organisasi *divisional* mengelompokkan seluruh sumber daya dan fungsi yang diperlukan untuk melayani segmen tertentu, seperti jenis penyakit, kelompok usia pasien, atau area geografis layanan, ke dalam satu divisi yang relatif otonom dan memiliki kapasitas untuk beroperasi secara mandiri dalam memenuhi kebutuhan segmen yang dilayaninya. Dalam konteks rumah sakit, model *divisional* dapat terwujud dalam bentuk divisi layanan anak yang mencakup bangsal pediatri, poliklinik anak, dan tim keperawatan anak dalam satu unit terintegrasi, atau divisi layanan jantung yang menggabungkan unit *coronary care*, rehabilitasi kardiak, dan poliklinik kardiologi dalam satu kesatuan manajerial. Kelebihan utama struktur *divisional* adalah kemampuannya untuk menciptakan layanan yang lebih terfokus dan responsif terhadap kebutuhan spesifik segmen yang dilayani, karena seluruh sumber daya dan pengambilan keputusan terkonsentrasi dalam satu divisi yang memahami secara mendalam karakteristik populasi pasiennya. Koordinasi internal dalam setiap divisi juga cenderung lebih mudah dan cepat karena seluruh fungsi yang relevan berada dalam satu atap manajerial yang sama, mengurangi kebutuhan untuk bernegosiasi lintas departemen dalam penanganan kasus sehari-hari (Purnama et al., 2022).

Keterbatasan struktur *divisional* terletak pada potensi duplikasi sumber daya yang tidak efisien, karena setiap divisi cenderung membangun kapasitasnya sendiri meskipun beberapa fungsi seperti laboratorium, radiologi, atau farmasi sebenarnya dapat digunakan bersama secara lebih efisien dalam skema yang terpusat. Selain itu, standarisasi praktik keperawatan di seluruh divisi menjadi lebih menantang karena setiap divisi memiliki otonominya sendiri dalam menetapkan prosedur dan protokol, sehingga konsistensi mutu layanan antar divisi perlu diawasi secara aktif oleh pimpinan puncak keperawatan. Dalam konteks Indonesia, model *divisional* mulai banyak diadopsi oleh rumah sakit besar, terutama yang memiliki layanan *unggulan* (*center of excellence*) di bidang tertentu seperti kanker, jantung, atau transplantasi, yang membutuhkan

integrasi sumber daya dan koordinasi tim yang sangat erat dan spesifik di luar kapasitas struktur fungsional konvensional (Marquis & Huston, 2021).

Struktur organisasi matriks merupakan model yang menggabungkan elemen struktur fungsional dan *divisional* secara bersamaan, sehingga setiap individu dalam organisasi memiliki dua jalur pelaporan sekaligus, yaitu kepada pimpinan fungsional yang bertanggung jawab atas standar dan pengembangan profesi, serta kepada pimpinan proyek atau program yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan layanan tertentu. Dalam keperawatan, struktur matriks dapat terwujud ketika seorang perawat spesialis onkologi secara bersamaan melapor kepada kepala bidang keperawatan dalam hal standar praktik dan pengembangan kompetensi, sekaligus melapor kepada manajer program kanker dalam hal pelaksanaan program layanan dan pencapaian target klinis yang telah ditetapkan. Kelebihan utama struktur matriks adalah fleksibilitasnya yang tinggi dalam mengalokasikan sumber daya manusia secara lintas fungsi, kemampuannya mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar bidang keahlian, serta kapasitasnya untuk merespons perubahan kebutuhan layanan dengan lebih adaptif dibandingkan struktur fungsional maupun *divisional* yang lebih kaku. Namun demikian, struktur matriks juga mengandung risiko yang tidak kecil, terutama potensi konflik peran dan ambiguitas wewenang yang timbul dari dualitas jalur pelaporan yang dimiliki setiap individu, sehingga keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kematangan budaya organisasi, kejelasan sistem komunikasi, dan kualitas kepemimpinan yang mampu mengelola kompleksitas dinamika interpersonal yang inheren dalam model organisasi ini (Sullivan, 2022).

2. Model tim keperawatan (*team nursing*)

Model tim keperawatan atau *team nursing* merupakan salah satu model pemberian asuhan keperawatan yang paling luas diterapkan di berbagai fasilitas layanan kesehatan, baik di Indonesia maupun di tingkat global, karena kemampuannya dalam mengoptimalkan sumber daya manusia yang beragam tingkat kompetensinya untuk bekerja secara kolaboratif dalam memberikan asuhan yang komprehensif kepada sekelompok pasien. Model ini pertama kali dikembangkan pada dekade 1950-an sebagai respons terhadap kekurangan tenaga perawat profesional pasca Perang Dunia II, yang mendorong institusi layanan kesehatan untuk merancang sistem kerja yang memungkinkan perawat dengan berbagai latar belakang pendidikan dan kompetensi bekerja bersama secara terstruktur di bawah koordinasi seorang ketua tim yang berpengalaman. Dalam model ini, sebuah tim yang terdiri dari perawat profesional, perawat

vokasional, dan tenaga pembantu keperawatan bekerja bersama di bawah kepemimpinan ketua tim untuk memberikan asuhan kepada sekelompok pasien tertentu selama satu *shift* atau dalam periode perawatan yang lebih panjang sesuai kebutuhan layanan (Cole et al., 2023).

Karakteristik utama model tim keperawatan terletak pada pembagian tugas yang proporsional berdasarkan tingkat kompetensi masing-masing anggota tim, di mana ketua tim yang merupakan perawat profesional bertanggung jawab atas koordinasi asuhan, penetapan rencana keperawatan, pengambilan keputusan klinis yang kompleks, serta supervisi terhadap seluruh anggota tim dalam pelaksanaan tugasnya. Anggota tim dengan kompetensi yang lebih rendah, seperti perawat vokasional atau tenaga pembantu keperawatan, diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan lingkup kewenangan dan kemampuannya, seperti pengukuran tanda-tanda vital, pemenuhan kebutuhan dasar, dan prosedur keperawatan rutin yang tidak membutuhkan tingkat keahlian klinis yang tinggi. Komunikasi dalam model tim keperawatan sangat ditekankan, terutama melalui *conference* tim yang dilakukan secara rutin sebelum, selama, dan setelah *shift* untuk memastikan seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama tentang kondisi pasien, prioritas asuhan, dan perkembangan yang terjadi selama periode perawatan berlangsung (Setiawan et al., 2025).

Kelebihan model tim keperawatan yang paling nyata adalah kemampuannya dalam mengoptimalkan penggunaan tenaga dengan berbagai tingkat kompetensi secara efisien, sehingga perawat profesional dapat memfokuskan energi dan keahliannya pada aspek asuhan yang paling membutuhkan kompetensi tinggi, sementara tugas-tugas yang lebih rutin didelegasikan kepada anggota tim dengan tingkat kewenangan yang sesuai. Model ini juga memberikan kesempatan pembelajaran yang berharga bagi anggota tim yang lebih junior, karena mereka bekerja dalam bimbingan langsung ketua tim yang berpengalaman dan dapat mengamati serta belajar dari proses pengambilan keputusan klinis yang berlangsung dalam dinamika tim sehari-hari. Dari perspektif institusi, model tim keperawatan menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam manajemen tenaga, karena memungkinkan penyesuaian komposisi tim berdasarkan fluktuasi beban kerja dan ketersediaan tenaga tanpa harus mengorbankan kualitas asuhan secara keseluruhan (Sari et al., 2023).

Namun demikian, model tim keperawatan juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dikelola dengan cermat oleh pimpinan keperawatan. Fragmentasi asuhan merupakan risiko yang paling sering muncul, terutama

ketika tugas-tugas telah terdistribusi kepada berbagai anggota tim namun koordinasi dan komunikasinya tidak berjalan dengan optimal, sehingga pasien menerima layanan dari banyak orang yang masing-masing hanya memiliki gambaran parsial tentang kebutuhan dan kondisinya secara menyeluruh. Kualitas model tim keperawatan sangat bergantung pada kompetensi kepemimpinan ketua tim, karena seorang ketua tim yang lemah dalam koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan klinis akan menghasilkan tim yang tidak terkoordinasi, konflik peran yang tidak terselesaikan, dan pada akhirnya menurunnya kualitas asuhan yang diterima pasien. Beban ketua tim yang seringkali sangat berat, harus menyeimbangkan tugas klinis langsung dengan tanggung jawab koordinasi dan supervisi seluruh anggota tim secara bersamaan, juga menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan dukungan organisasi yang memadai.

Keberhasilan implementasi model tim keperawatan di suatu institusi sangat ditentukan oleh seberapa serius organisasi keperawatan berinvestasi dalam mempersiapkan ketua tim yang kompeten, membangun sistem komunikasi yang efektif, dan menciptakan budaya kerja tim yang saling mendukung dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pelatihan kepemimpinan bagi calon ketua tim, penetapan mekanisme *conference* yang terstruktur, serta sistem evaluasi kinerja tim yang berbasis indikator klinis merupakan komponen infrastruktur yang tidak boleh diabaikan apabila model ini ingin memberikan hasil yang optimal. Dalam konteks Indonesia, model tim keperawatan tetap menjadi pilihan yang relevan dan realistis mengingat heterogenitas latar belakang pendidikan tenaga keperawatan yang masih cukup tinggi, sehingga model yang mampu mengintegrasikan berbagai tingkat kompetensi dalam satu sistem kerja yang terkoordinasi ini menawarkan solusi praktis yang dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi sumber daya yang tersedia di berbagai jenis fasilitas layanan kesehatan.

3. Model *primary nursing*

Model *primary nursing* merupakan model pemberian asuhan keperawatan yang menempatkan satu perawat profesional sebagai penanggung jawab utama dan menyeluruh atas asuhan seorang pasien sejak masuk hingga keluar dari fasilitas layanan, sehingga menciptakan hubungan terapeutik yang berkelanjutan, personal, dan akuntabel antara perawat dan pasien yang dilayaninya. Model ini dikembangkan oleh Marie Manthey pada akhir dekade 1960-an sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap model tim dan model fungsional yang dinilai terlalu terfragmentasi dan kurang mampu

membangun hubungan yang bermakna antara perawat dan pasien. Dalam model *primary nursing*, perawat primer bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian komprehensif, menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun rencana asuhan, mengimplementasikan intervensi, mengevaluasi perkembangan, dan mengomunikasikan kondisi pasien kepada seluruh anggota tim kesehatan yang terlibat, bahkan ketika ia tidak sedang bertugas dan asuhan dilanjutkan oleh perawat asosiasi yang bertugas menggantikannya (Ittup, 2025).

Kelebihan utama model *primary nursing* terletak pada tingginya akuntabilitas dan kontinuitas asuhan yang dihasilkannya, karena satu perawat yang memiliki pemahaman paling mendalam tentang kondisi, kebutuhan, dan preferensi pasiennya menjadi titik pusat koordinasi seluruh proses asuhan selama periode perawatan berlangsung. Pasien dan keluarga mendapatkan manfaat yang signifikan dari model ini karena mereka memiliki satu kontak utama yang dapat diandalkan, sehingga mengurangi kecemasan akibat harus berinteraksi dengan banyak perawat berbeda yang masing-masing memiliki pemahaman yang tidak merata tentang kondisi dan kebutuhan spesifik mereka. Kepuasan kerja perawat juga terbukti lebih tinggi dalam model *primary nursing* karena setiap perawat memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan klinis, membangun hubungan terapeutik yang bermakna dengan pasiennya, dan dapat melihat secara langsung dampak dari asuhan yang diberikannya terhadap perkembangan kondisi pasien dari waktu ke waktu (Abdullah et al., 2023).

Model *primary nursing* menuntut persyaratan sumber daya yang cukup tinggi, terutama dalam hal ketersediaan perawat profesional yang kompeten dan berpengalaman dalam jumlah yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab penuh sebagai perawat primer bagi setiap pasien yang dirawat. Beban kerja perawat primer yang mencakup seluruh aspek asuhan dari pengkajian hingga evaluasi, ditambah dengan tanggung jawab koordinasi dengan tim kesehatan lain dan komunikasi dengan keluarga, dapat menjadi sangat berat apabila tidak didukung oleh rasio tenaga yang memadai dan sistem pendukung organisasi yang kuat. Di Indonesia, implementasi model *primary nursing* secara penuh masih menghadapi tantangan yang tidak kecil, terutama karena keterbatasan jumlah perawat profesional di banyak fasilitas kesehatan, heterogenitas latar belakang pendidikan tenaga keperawatan, serta beban kerja yang sudah tinggi di sebagian besar unit rawat inap, sehingga adaptasi model ini perlu dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi riil sumber daya yang tersedia (Shahu et al., 2024).

Keberhasilan model *primary nursing* sangat bergantung pada komitmen organisasi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perawat primer menjalankan perannya secara optimal, termasuk melalui penetapan rasio tenaga yang realistis, pemberian otonomi klinis yang cukup dalam pengambilan keputusan asuhan, serta dukungan sistem dokumentasi yang memudahkan perawat asosiasi untuk memahami dan melanjutkan rencana asuhan yang telah ditetapkan oleh perawat primer. Budaya organisasi yang menghargai akuntabilitas individual, mendukung pengembangan hubungan terapeutik yang bermakna, dan mengakui kontribusi nyata setiap perawat dalam hasil klinis pasiennya merupakan prasyarat kultural yang tidak kalah pentingnya dari prasyarat struktural dan sumber daya yang telah disebutkan sebelumnya.

4. Model *case management*

Model *case management* dalam keperawatan merupakan pendekatan pemberian asuhan yang berfokus pada koordinasi komprehensif seluruh layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh seorang pasien, khususnya pasien dengan kondisi kompleks, kronis, atau yang membutuhkan layanan dari berbagai profesi dan institusi secara berkesinambungan, dengan tujuan mengoptimalkan hasil klinis, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan memastikan kesinambungan layanan dari satu setting perawatan ke setting lainnya. Berbeda dengan model tim maupun *primary nursing* yang lebih berfokus pada pemberian asuhan langsung dalam satu unit atau institusi, model *case management* memiliki perspektif yang lebih luas dan longitudinal, mencakup keseluruhan perjalanan pasien melalui sistem layanan kesehatan dari penerimaan hingga pemulangan dan bahkan hingga ke layanan *follow-up* pasca rawat di komunitas. Perawat *case manager* bertindak sebagai koordinator, advokat, fasilitator, dan pemantau yang memastikan bahwa setiap komponen layanan yang dibutuhkan pasien tersedia, terkoordinasi dengan baik, dan diberikan pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan klinis yang terus berkembang (Marquis & Huston, 2021).

Peran perawat *case manager* mencakup beberapa fungsi kritis yang membedakannya dari peran perawat dalam model asuhan lainnya. Fungsi pengkajian komprehensif dilakukan tidak hanya terhadap kondisi klinis pasien, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dukungan keluarga, dan sumber daya komunitas yang tersedia, karena semua faktor ini secara signifikan memengaruhi kemampuan pasien untuk mencapai hasil klinis yang optimal dan menjalani pemulihan yang berkesinambungan setelah meninggalkan fasilitas rawat inap. Fungsi perencanaan mencakup penyusunan rencana asuhan yang

terintegrasi lintas profesi dan lintas *setting*, termasuk koordinasi dengan layanan sosial, rehabilitasi, *home care*, dan komunitas yang akan melanjutkan dukungan kepada pasien setelah pemulangan. Fungsi pemantauan dan evaluasi dilakukan secara aktif dan berkelanjutan untuk mendeteksi perubahan kondisi pasien yang membutuhkan penyesuaian rencana asuhan, serta untuk memastikan bahwa target klinis dan efisiensi sumber daya yang telah ditetapkan dalam *clinical pathway* dapat dicapai sesuai rencana (Huber, 2022).

Kelebihan model *case management* paling dirasakan dalam penanganan pasien dengan kondisi kronis kompleks, *multi-morbiditas*, atau kebutuhan sosial yang tinggi, di mana koordinasi layanan yang buruk seringkali menjadi penyebab utama rawat inap berulang, komplikasi yang dapat dicegah, dan pemborosan sumber daya kesehatan yang signifikan. Dengan adanya perawat *case manager* yang berfungsi sebagai titik koordinasi tunggal bagi seluruh kebutuhan pasien, fragmentasi layanan dapat diminimalkan secara signifikan, komunikasi antar profesi menjadi lebih terstruktur, dan pasien serta keluarga mendapatkan dukungan yang lebih konsisten dan komprehensif dalam menavigasi sistem layanan kesehatan yang seringkali terasa kompleks dan membingungkan. Dari perspektif institusi, model *case management* terbukti berkontribusi pada penurunan *length of stay*, pengurangan readmisi yang tidak terencana, dan optimalisasi penggunaan sumber daya yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan finansial institusi layanan kesehatan.

Implementasi model *case management* di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, dengan penerapan yang lebih banyak ditemukan di rumah sakit besar dan rumah sakit rujukan nasional yang menangani kasus-kasus kompleks dengan tingkat kebutuhan koordinasi yang tinggi. Tantangan utama dalam implementasinya mencakup kebutuhan akan perawat *case manager* yang memiliki kompetensi klinis yang luas, kemampuan koordinasi lintas profesi yang kuat, serta pemahaman mendalam tentang sistem pembiayaan kesehatan dan sumber daya komunitas yang tersedia. Dukungan kebijakan institusi yang memberikan kewenangan yang memadai kepada perawat *case manager*, sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pemantauan kondisi pasien secara komprehensif, serta kolaborasi yang erat dengan seluruh profesi kesehatan dan layanan komunitas merupakan prasyarat infrastruktur yang harus dipenuhi agar model *case management* dapat berfungsi secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas dan efisiensi layanan keperawatan di Indonesia (Sullivan, 2022).

D. Sistem Layanan Kesehatan di Indonesia

1. Pengertian dan komponen sistem layanan kesehatan

Sistem layanan kesehatan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan tatanan yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berinteraksi dan bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, merata, dan berkeadilan. Dalam pengertian yang lebih operasional, sistem layanan kesehatan mencakup seluruh organisasi, institusi, sumber daya, dan aktivitas yang tujuan utamanya adalah mempromosikan, memulihkan, dan memelihara kesehatan individu maupun masyarakat melalui berbagai bentuk intervensi yang berbasis bukti dan berorientasi pada kebutuhan nyata populasi yang dilayani. Di Indonesia, sistem layanan kesehatan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan berbagai regulasi kesehatan sebelumnya, dan dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan yang mengatur aspek-aspek teknis penyelenggaraan layanan secara lebih spesifik. Pemahaman tentang sistem layanan kesehatan secara menyeluruh menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan oleh setiap perawat, karena hanya dengan memahami sistem secara utuh seorang perawat akan mampu menempatkan perannya secara tepat dan berkontribusi secara optimal dalam kerangka yang lebih besar dari sekadar unit kerja tempatnya bertugas sehari-hari (Kemenkes, 2023).

Komponen sistem layanan kesehatan di Indonesia dapat dipahami melalui enam elemen utama yang saling bergantung dan saling memengaruhi satu sama lain dalam membentuk kapasitas sistem secara keseluruhan. Pertama, komponen sumber daya manusia kesehatan mencakup seluruh tenaga kesehatan yang terlatih dan berwenang untuk memberikan layanan, termasuk dokter, perawat, bidan, apoteker, dan berbagai profesi kesehatan lainnya yang masing-masing memiliki kontribusi spesifik dalam sistem. Kedua, komponen fasilitas dan infrastruktur mencakup seluruh fisik tempat layanan diberikan, mulai dari Puskesmas, klinik pratama, rumah sakit tipe D hingga tipe A, serta fasilitas penunjang seperti laboratorium, bank darah, dan instalasi farmasi yang mendukung keberlangsungan layanan klinis. Ketiga, komponen pembiayaan kesehatan mencakup seluruh mekanisme penggalangan, pengalokasian, dan penggunaan dana untuk membiayai layanan kesehatan, termasuk anggaran pemerintah pusat dan daerah, iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan pembiayaan *out-of-pocket* masyarakat. Keempat, komponen sistem informasi kesehatan mencakup seluruh mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data kesehatan untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan

evaluasi program layanan. Kelima, komponen obat dan teknologi kesehatan mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan penggunaan yang rasional dari obat-obatan, alat kesehatan, dan teknologi medis yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas. Keenam, komponen tata kelola dan kepemimpinan kesehatan mencakup keseluruhan kebijakan, regulasi, dan mekanisme akuntabilitas yang memandu penyelenggaraan sistem layanan kesehatan secara keseluruhan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan nilai yang telah ditetapkan bersama (Trisnantoro, 2020).

2. Sejarah dan perkembangan sistem kesehatan nasional

Sejarah sistem kesehatan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks perjuangan bangsa dalam membangun fondasi layanan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat sejak masa kemerdekaan. Pada era awal kemerdekaan, sistem kesehatan Indonesia masih sangat terbatas, dengan infrastruktur layanan yang terkonsentrasi di kota-kota besar dan hampir tidak menjangkau wilayah pedesaan yang justru dihuni oleh mayoritas penduduk. Konferensi Kesehatan di Bandung pada tahun 1951 menjadi tonggak penting dalam sejarah sistem kesehatan nasional, karena dalam konferensi inilah konsep Bandung Plan dirumuskan, yang menekankan pendekatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat melalui pengembangan pusat kesehatan masyarakat sebagai ujung tombak layanan primer yang dapat menjangkau seluruh lapisan penduduk di tingkat kecamatan dan desa. Gagasan ini kemudian menjadi cikal bakal sistem Puskesmas yang secara formal mulai dikembangkan pada dekade 1960-an dan diresmikan sebagai model layanan primer nasional pada era Orde Baru, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pertama di Asia yang mengembangkan model layanan primer berbasis masyarakat secara terstruktur dan sistematis (Mukti & Moertjahjo, 2020).

Pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, pembangunan kesehatan mengalami ekspansi yang signifikan melalui program Pelita yang secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Puskesmas di seluruh kecamatan, pengembangan rumah sakit kabupaten dan provinsi, serta program-program kesehatan masyarakat yang berfokus pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, penanggulangan penyakit menular, dan peningkatan gizi masyarakat. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) pertama kali dirumuskan secara formal pada tahun 1982 sebagai kerangka acuan pembangunan kesehatan nasional yang mengintegrasikan seluruh upaya kesehatan dalam satu sistem yang terkoordinasi. Era reformasi yang dimulai pada akhir dekade 1990-an membawa perubahan mendasar dalam tata kelola sistem kesehatan melalui

desentralisasi, yang mengalihkan sebagian besar kewenangan pengelolaan layanan kesehatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi ini membawa peluang bagi penyesuaian program kesehatan dengan kebutuhan lokal, namun sekaligus menciptakan tantangan baru dalam hal pemerataan kapasitas layanan antar daerah yang memiliki kemampuan fiskal dan kapasitas sumber daya manusia yang sangat beragam (Nadjib et al., 2021).

Perkembangan paling transformatif dalam sejarah sistem kesehatan Indonesia terjadi pada tahun 2004 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang meletakkan landasan hukum bagi pembangunan sistem jaminan kesehatan universal yang kemudian diwujudkan melalui peluncuran program JKN pada tanggal 1 Januari 2014 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Transformasi ini merupakan lompatan besar dalam sejarah kesehatan Indonesia karena pertama kalinya dalam sejarah bangsa, setiap warga negara secara bertahap mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif tanpa harus khawatir tentang kemampuan finansialnya dalam menanggung biaya pengobatan. Sistem Kesehatan Nasional terus mengalami pembaruan, dengan SKN terbaru yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 dan diperbarui kembali seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang membawa perubahan mendasar dalam kerangka penyelenggaraan layanan kesehatan, termasuk dalam hal pengaturan tenaga kesehatan, standar fasilitas, dan mekanisme pengawasan mutu layanan di seluruh jenjang sistem (Wibowo et al., 2022).

3. Kebijakan JKN dan dampaknya terhadap layanan keperawatan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang resmi beroperasi sejak 1 Januari 2014 merupakan program jaminan sosial terbesar di dunia berdasarkan jumlah peserta, dan telah membawa dampak yang sangat luas dan mendalam terhadap seluruh aspek penyelenggaraan layanan kesehatan di Indonesia, termasuk terhadap organisasi dan praktik keperawatan di semua jenjang fasilitas layanan. JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan prinsip gotong royong, di mana iuran dari peserta yang sehat digunakan untuk membiayai layanan bagi peserta yang sakit, dengan tujuan akhir mewujudkan akses layanan kesehatan yang universal dan berkeadilan bagi seluruh penduduk Indonesia tanpa

terkecuali. Sistem pembayaran dalam JKN menggunakan mekanisme *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) untuk layanan rawat inap di rumah sakit, yang menetapkan tarif tetap berdasarkan kelompok diagnosis tanpa memandang lamanya perawatan atau jumlah tindakan yang diberikan, sehingga menciptakan insentif kuat bagi fasilitas layanan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi *length of stay* pasien sebagai strategi utama pengendalian biaya (Wibowo et al., 2022).

Dampak JKN terhadap layanan keperawatan bersifat multidimensi dan dirasakan di berbagai aspek praktik profesional. Dari sisi beban kerja, implementasi JKN telah menyebabkan peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah kunjungan pasien di seluruh jenjang fasilitas layanan, karena jutaan penduduk yang sebelumnya tidak mampu mengakses layanan kesehatan kini mendapatkan jaminan pembiayaan yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan secara lebih aktif. Peningkatan volume pasien yang tidak selalu diimbangi dengan penambahan tenaga keperawatan yang proporsional telah menimbulkan tantangan serius dalam hal rasio perawat terhadap pasien di banyak fasilitas layanan, yang pada gilirannya berpotensi memengaruhi kualitas asuhan dan keselamatan pasien. Dari sisi dokumentasi, sistem INA-CBG menuntut akurasi dan kelengkapan dokumentasi klinis yang jauh lebih tinggi dibandingkan era sebelum JKN, karena ketepatan *coding* diagnosis yang sangat bergantung pada kualitas dokumentasi keperawatan dan medis secara langsung memengaruhi besaran klaim yang dapat diajukan oleh fasilitas layanan kepada BPJS Kesehatan (Trisnantoro, 2020).

Dari perspektif pengembangan profesi, JKN secara tidak langsung mendorong peningkatan profesionalisme keperawatan melalui tuntutan akreditasi yang menjadi syarat bagi fasilitas layanan untuk dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Standar akreditasi KARS yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dan Puskesmas mencakup berbagai elemen yang berkaitan langsung dengan praktik keperawatan, termasuk standar kompetensi tenaga, kelengkapan dokumentasi, penerapan *patient safety*, dan implementasi standar prosedur operasional yang terukur. Kebijakan JKN juga mendorong penguatan layanan primer sebagai gerbang pertama sistem rujukan, yang berarti peran perawat di Puskesmas dan klinik pratama semakin strategis dalam melakukan deteksi dini, manajemen penyakit kronis, dan edukasi kesehatan sebagai upaya mencegah terjadinya komplikasi yang membutuhkan layanan spesialistik yang lebih mahal. Dengan demikian, JKN telah menjadi pendorong transformasi yang signifikan bagi profesi keperawatan Indonesia, menuntut peningkatan

kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalisme yang lebih tinggi dari seluruh tenaga keperawatan di semua jenjang layanan.

4. Peran pemerintah pusat dan daerah dalam sistem kesehatan

Sistem kesehatan Indonesia menganut prinsip desentralisasi dalam pengelolaannya, sehingga kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan layanan kesehatan dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan kerangka regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembagian peran ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan kesehatan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia yang sangat beragam dari sisi geografi, demografi, budaya, dan kapasitas sumber dayanya. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab utama dalam penetapan kebijakan nasional, regulasi, dan standar yang berlaku di seluruh Indonesia, termasuk standar kompetensi tenaga kesehatan, standar pelayanan minimal, pedoman klinis, dan kerangka sistem jaminan mutu layanan yang mengikat seluruh fasilitas kesehatan di tingkat nasional. Selain itu, pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas layanan kesehatan rujukan nasional seperti rumah sakit tipe A dan rumah sakit khusus nasional yang memberikan layanan spesialistik dan subspesialistik yang tidak dapat disediakan di tingkat daerah (Kemenkes, 2023).

Pemerintah provinsi memiliki peran sebagai fasilitator, koordinator, dan pengawas pembangunan kesehatan di tingkat wilayah, dengan tanggung jawab utama yang mencakup pengelolaan rumah sakit provinsi sebagai fasilitas rujukan tingkat kedua, koordinasi program kesehatan lintas kabupaten atau kota, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan di seluruh kabupaten atau kota dalam wilayah yurisdiksinya. Dinas Kesehatan Provinsi berperan dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program-program yang relevan dengan konteks dan kebutuhan spesifik wilayah, termasuk dalam hal perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, pengembangan sistem informasi kesehatan daerah, dan pengelolaan program-program kesehatan prioritas yang membutuhkan koordinasi lintas batas administratif kabupaten atau kota. Pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota memegang tanggung jawab operasional yang paling langsung dalam penyelenggaraan layanan kesehatan kepada masyarakat, mencakup pengelolaan Puskesmas dan jaringannya, rumah sakit umum daerah, serta program kesehatan masyarakat yang menyasar langsung kebutuhan kesehatan

penduduk di tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa (Mukti & Moertjahjo, 2020).

Dalam konteks keperawatan, implikasi pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah sangat nyata dan langsung dirasakan oleh tenaga keperawatan di lapangan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan menetapkan standar kompetensi perawat, kurikulum pendidikan keperawatan, regulasi praktik, dan standar kewenangan klinis yang berlaku secara nasional, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas perekrutan, penempatan, pengembangan, dan pemenuhan kesejahteraan tenaga keperawatan di fasilitas layanan yang berada di bawah pengelolaannya. Ketimpangan kapasitas fiskal dan manajerial antar daerah seringkali menciptakan disparitas yang signifikan dalam hal ketersediaan, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga keperawatan antara daerah maju dan daerah tertinggal, yang pada akhirnya berujung pada ketidakmerataan kualitas layanan keperawatan yang diterima oleh masyarakat di berbagai pelosok Indonesia. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui sistem insentif yang mendorong penempatan tenaga keperawatan di daerah terpencil dan program pengembangan kapasitas yang merata, merupakan agenda strategis yang harus terus diperjuangkan demi terwujudnya sistem keperawatan Indonesia yang berkeadilan dan merata bagi seluruh rakyat tanpa memandang tempat tinggalnya (Mukti & Moertjahjo, 2020).

E. Alur Layanan Keperawatan dan Kesinambungan Pelayanan

Alur layanan keperawatan merupakan rangkaian proses yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan yang dimulai sejak seorang pasien pertama kali memasuki fasilitas pelayanan kesehatan hingga pasien kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat dengan kondisi kesehatan yang seoptimal mungkin sesuai dengan kapasitas pemulihannya. Proses ini mencerminkan keterpaduan berbagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan dalam mendukung keberhasilan terapi serta pemulihan pasien. Keberadaan alur layanan yang jelas memungkinkan setiap tahap pelayanan dapat dijalankan secara terarah, mulai dari tahap penerimaan pasien, pengkajian awal, pelaksanaan asuhan keperawatan, pemantauan kondisi pasien, hingga proses pemulangan. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak hanya bersifat reaktif terhadap kondisi pasien, tetapi juga terencana secara sistematis sehingga tujuan perawatan dapat tercapai secara optimal (Wibowo et al., 2022).

Kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan alur layanan keperawatan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan. Alur yang tersusun dengan baik akan memudahkan tenaga kesehatan dalam memahami tanggung jawab masing-masing serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dalam kerangka kerja yang terorganisasi. Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, kesinambungan layanan atau *continuity of care* menjadi salah satu prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap proses pelayanan keperawatan. Hal ini karena pasien sering kali menerima pelayanan dari berbagai tenaga kesehatan dengan latar belakang profesi yang berbeda. Tanpa adanya sistem alur layanan yang jelas, risiko terjadinya miskomunikasi, keterlambatan tindakan, maupun ketidaksesuaian pelayanan dapat meningkat (Ge et al., 2025).

Setiap tahapan dalam alur layanan keperawatan mengandung berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi keselamatan pasien. Tahap penerimaan pasien atau *admission* misalnya, menjadi titik awal untuk mengidentifikasi kondisi klinis pasien secara menyeluruh melalui proses pengkajian. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan asuhan keperawatan, tenaga keperawatan harus memastikan bahwa seluruh intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien serta standar praktik yang berlaku. Proses pergantian shift atau *handover* juga menjadi salah satu tahap yang sangat krusial karena melibatkan transfer informasi mengenai kondisi pasien dari satu perawat kepada perawat lainnya. Ketepatan penyampaian informasi pada tahap ini sangat menentukan keberlanjutan tindakan keperawatan yang akan diberikan kepada pasien (Lidauer et al., 2025).

Selain itu, proses pemulangan pasien atau *discharge planning* serta pemantauan pasca perawatan juga merupakan bagian penting dari alur layanan keperawatan yang tidak dapat diabaikan. Perawat memiliki peran dalam memastikan bahwa pasien dan keluarga memahami rencana perawatan lanjutan yang harus dilakukan di rumah maupun di komunitas. Dengan adanya perencanaan pemulangan yang baik, risiko terjadinya komplikasi, kekambuhan penyakit, maupun perawatan ulang dapat diminimalkan. Oleh karena itu, organisasi pelayanan keperawatan perlu mengembangkan sistem kerja, standar prosedur, serta budaya kerja yang mendukung keselamatan pasien atau *patient safety* sebagai prinsip utama dalam setiap tahap pelayanan kesehatan. Melalui pengelolaan alur layanan yang terstruktur dan terintegrasi, pelayanan keperawatan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Sari et al., 2023).

1. Alur penerimaan pasien *(admission)*

Proses penerimaan pasien atau *admission* merupakan titik pertama dan salah satu titik paling kritis dalam keseluruhan alur layanan keperawatan, karena kualitas pengkajian dan orientasi yang dilakukan pada tahap ini akan menjadi fondasi bagi seluruh proses asuhan yang mengikutinya. Kesan pertama yang diterima pasien dan keluarga pada saat *admission* juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan, kecemasan, dan kooperatifitas mereka selama menjalani perawatan, sehingga kemampuan perawat dalam memberikan sambutan yang hangat, informatif, dan profesional pada tahap ini merupakan kompetensi interpersonal yang tidak boleh diremehkan (Baniak et al., 2025).

Menurut Sullivan, (2022) alur penerimaan pasien dalam organisasi keperawatan umumnya mencakup beberapa tahapan yang harus dilaksanakan secara sistematis dan terstandar sebagai berikut.

a. Triase dan Seleksi Prioritas

Pada fasilitas *Instalasi Gawat Darurat* (IGD), proses triase merupakan langkah pertama yang menentukan tingkat kegawatan pasien dan prioritas penanganannya berdasarkan kondisi klinis yang ditemukan saat pertama kali tiba. Sistem triase yang digunakan di Indonesia umumnya mengacu pada sistem empat atau lima kategori yang mengklasifikasikan pasien mulai dari yang membutuhkan penanganan segera (*immediate*) hingga yang dapat menunggu (*delayed*) atau tidak memerlukan intervensi medis darurat. Ketepatan triase yang dilakukan oleh perawat sangat menentukan keselamatan pasien, karena kesalahan dalam menilai kegawatan dapat berakibat fatal, sehingga kompetensi triase merupakan salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap perawat yang bertugas di unit gawat darurat (Sullivan, 2022).

b. Registrasi dan Verifikasi Administratif

Setelah triase, pasien menjalani proses registrasi yang mencakup pendataan identitas, verifikasi kepesertaan jaminan kesehatan, penandatanganan persetujuan umum (*general consent*), dan pemberian informasi awal tentang hak dan kewajiban pasien selama menjalani perawatan. Dalam era JKN, verifikasi kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi bagian integral dari proses *admission* yang harus dilakukan secara akurat untuk menghindari permasalahan administratif di kemudian hari. Perawat perlu memastikan bahwa seluruh proses administratif ini dilakukan dengan tetap mengutamakan kondisi klinis pasien, sehingga tidak ada penundaan penanganan yang terjadi semata-mata karena persoalan administratif yang belum terselesaikan.

c. Pengkajian Keperawatan Awal

Pengkajian keperawatan awal yang komprehensif merupakan inti dari proses *admission* keperawatan, mencakup pengkajian fisik head-to-toe, riwayat kesehatan, riwayat alergi, status nutrisi, risiko jatuh, status fungsional, kondisi psikologis, latar belakang sosial budaya, serta kebutuhan edukasi pasien dan keluarga. Hasil pengkajian ini menjadi dasar bagi penetapan diagnosis keperawatan, penyusunan rencana asuhan yang individualisasi, serta identifikasi risiko-risiko klinis yang memerlukan perhatian khusus sejak dini selama periode perawatan berlangsung. Ketepatan, kelengkapan, dan kedalaman pengkajian awal ini secara langsung menentukan kualitas seluruh rencana asuhan yang akan dilaksanakan, sehingga perawat harus mengalokasikan waktu dan perhatian yang memadai untuk melaksanakannya meskipun dalam kondisi beban kerja yang tinggi sekalipun.

d. Orientasi Pasien dan Keluarga

Orientasi pasien dan keluarga terhadap lingkungan, fasilitas, peraturan, dan prosedur unit perawatan merupakan bagian dari proses *admission* yang seringkali dianggap sekunder namun sesungguhnya memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keselamatan pasien dan kualitas pengalaman perawatan secara keseluruhan. Orientasi yang baik mencakup pengenalan terhadap denah ruangan dan fasilitas, penjelasan tentang prosedur memanggil perawat, informasi tentang jadwal dokter dan visite, penjelasan tentang diet yang diperbolehkan, serta edukasi tentang pencegahan jatuh dan keselamatan umum selama berada di fasilitas layanan. Ketika pasien dan keluarga memiliki pemahaman yang baik tentang lingkungan dan prosedur layanan sejak hari pertama, mereka akan menjadi mitra yang lebih aktif dan kooperatif dalam proses perawatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas asuhan dan kepuasan mereka terhadap layanan yang diterima (Sullivan, 2022).

F. Alur asuhan keperawatan selama perawatan

Alur asuhan keperawatan selama periode perawatan merupakan inti dari seluruh proses layanan keperawatan, di mana seluruh kompetensi profesional perawat dikerahkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasien, mengatasi masalah kesehatan yang ada, mencegah komplikasi, dan mengoptimalkan proses pemulihan menuju kondisi yang memungkinkan pasien untuk kembali berfungsi secara mandiri. Proses ini tidak bersifat linear dan kaku, melainkan bersifat siklus yang dinamis dan terus beradaptasi dengan

perkembangan kondisi pasien yang dapat berubah dari waktu ke waktu secara tidak terduga (Sitorus et al., 2023).

1. Penetapan Diagnosis dan Rencana Asuhan

Berdasarkan hasil pengkajian awal, perawat menetapkan diagnosis keperawatan yang mencerminkan respons aktual maupun potensial pasien terhadap masalah kesehatannya, yang kemudian menjadi dasar penyusunan rencana asuhan yang terindividualisasi dan terukur. Rencana asuhan yang baik harus mencakup tujuan yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound* (SMART), intervensi keperawatan yang berbasis bukti, serta indikator evaluasi yang jelas untuk menilai perkembangan pasien secara objektif. Dalam era *clinical pathway*, rencana asuhan keperawatan perlu diintegrasikan dengan *pathway* multidisiplin yang telah ditetapkan untuk setiap kelompok diagnosis, sehingga seluruh anggota tim kesehatan bergerak dalam kerangka yang terkoordinasi menuju tujuan klinis yang sama (Oostra et al., 2023).

2. Implementasi Intervensi Keperawatan

Implementasi mencakup seluruh tindakan keperawatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan asuhan yang telah ditetapkan, mulai dari tindakan mandiri keperawatan seperti mobilisasi, perawatan luka, manajemen nyeri non-farmakologi, dan edukasi pasien, hingga tindakan kolaboratif yang dilaksanakan bersama dengan profesi kesehatan lain sesuai instruksi medis yang berlaku. Setiap implementasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keselamatan pasien, termasuk prinsip benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute, benar waktu, dan benar dokumentasi, yang merupakan standar minimal yang tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apapun. Pendokumentasian setiap tindakan yang dilakukan secara akurat dan tepat waktu merupakan bagian integral dari implementasi yang tidak kalah pentingnya dari tindakan itu sendiri, karena dokumentasi yang baik memungkinkan kesinambungan informasi, akuntabilitas profesional, dan dasar evaluasi yang valid (Nordaunet et al., 2023).

3. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Pemantauan kondisi pasien secara berkala dan sistematis merupakan fungsi keperawatan yang paling fundamental dan tidak dapat didelegasikan sepenuhnya kepada tenaga non-profesional, karena kemampuan mendeteksi perubahan kondisi klinis secara dini dan mengambil tindakan yang tepat merupakan inti dari kompetensi keperawatan profesional. Sistem *Early Warning*

Score (EWS) yang kini banyak diterapkan di rumah sakit Indonesia merupakan alat bantu standar yang memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami perburukan kondisi sebelum krisis yang sebenarnya terjadi, sehingga intervensi dini dapat dilakukan untuk mencegah konsekuensi yang lebih serius. Evaluasi terhadap pencapaian tujuan asuhan harus dilakukan secara periodik dan didokumentasikan dengan jelas, karena hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan tentang apakah rencana asuhan perlu dipertahankan, dimodifikasi, atau diganti sesuai dengan perkembangan kondisi pasien.

4. Kolaborasi Multidisiplin

Asuhan pasien selama periode perawatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal oleh keperawatan saja, melainkan membutuhkan kolaborasi yang erat dengan seluruh profesi kesehatan yang terlibat dalam penanganan pasien melalui mekanisme yang terstruktur dan terkoordinasi. *Ward round* multidisiplin, *case conference* untuk pasien dengan kondisi kompleks, dan mekanisme konsultasi yang berjalan lancar antar profesi merupakan infrastruktur kolaborasi yang harus dibangun dan dipelihara secara aktif oleh organisasi keperawatan bersama seluruh pemangku kepentingan layanan. Perawat memiliki peran yang sangat strategis dalam forum multidisiplin ini karena sebagai profesi yang paling lama dan paling intensif berinteraksi dengan pasien, perawat seringkali memiliki informasi klinis dan kontekstual yang paling komprehensif tentang kondisi, perkembangan, dan kebutuhan pasien yang tidak selalu dapat ditangkap oleh profesi lain dalam interaksi yang lebih singkat dan terbatas (Sitorus et al., 2023).

5. Proses *handover* dan serah terima antar shift

Handover atau serah terima antar *shift* merupakan salah satu momen paling kritis dalam alur layanan keperawatan karena pada titik inilah tanggung jawab klinis atas keselamatan pasien berpindah dari satu tim ke tim berikutnya, dan kegagalan dalam transfer informasi yang akurat dan lengkap pada momen ini merupakan salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien yang dapat dicegah. Riset internasional konsisten menunjukkan bahwa sebagian besar kesalahan klinis yang terjadi di fasilitas rawat inap dapat ditelusuri akar penyebabnya hingga ke momen *handover* yang tidak berjalan dengan baik, sehingga standarisasi proses ini merupakan investasi paling efektif dalam pencegahan insiden keselamatan pasien (Hartono et al., 2024).

a. Metode SBAR dalam *Handover*

Metode *Situation, Background, Assessment, Recommendation* (SBAR) merupakan kerangka komunikasi terstruktur yang paling banyak direkomendasikan dan digunakan dalam proses *handover* keperawatan karena kemampuannya untuk memastikan bahwa informasi kritis disampaikan secara sistematis, ringkas, dan mudah dipahami oleh penerima. Komponen *Situation* mencakup identifikasi pasien dan masalah klinis utama yang sedang dihadapi saat ini, komponen *Background* mencakup konteks klinis yang relevan termasuk diagnosis, riwayat, dan terapi yang sedang berjalan, komponen *Assessment* mencakup penilaian perawat tentang kondisi pasien saat ini dan kecenderungannya, serta komponen *Recommendation* mencakup tindakan yang perlu dilanjutkan, dipantau, atau diantisipasi oleh tim berikutnya selama periode *shift* mereka. Penggunaan SBAR yang konsisten dan terstandar di seluruh unit keperawatan merupakan salah satu indikator kualitas komunikasi klinis yang dievaluasi dalam proses akreditasi fasilitas layanan kesehatan.

b. *Bedside Handover*

Bedside handover atau serah terima di sisi tempat tidur pasien merupakan model *handover* yang semakin banyak diadopsi karena memungkinkan pasien dan keluarga untuk terlibat aktif dalam proses transfer informasi, sehingga meningkatkan akurasi data klinis, memperkuat keterlibatan pasien dalam proses perawatannya sendiri, dan memberikan kesempatan bagi tim yang datang untuk melakukan verifikasi langsung terhadap kondisi pasien. Model ini juga memungkinkan perawat yang akan bertugas untuk langsung mengamati kondisi fisik pasien, memeriksa alat-alat medis yang terpasang, dan mengonfirmasi informasi yang disampaikan oleh perawat sebelumnya dengan kondisi nyata yang ada, sehingga mengurangi risiko kesalahan yang dapat timbul dari transfer informasi yang hanya bersifat verbal tanpa verifikasi langsung.

c. Dokumentasi *Handover*

Dokumentasi yang akurat dan lengkap merupakan komplemen yang tidak terpisahkan dari proses *handover* verbal, karena dokumentasi tertulis menyediakan rekam jejak yang dapat dirujuk kembali apabila terjadi ketidakjelasan atau perselisihan tentang informasi yang telah disampaikan. *Lembar serah terima* yang terstandar, catatan keperawatan yang diperbarui sebelum *handover*, dan sistem *checklist* yang memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan merupakan komponen dokumentasi *handover* yang harus tersedia dan digunakan secara konsisten di setiap unit

keperawatan. Dalam era digitalisasi layanan kesehatan, sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi memungkinkan dokumentasi *handover* yang lebih efisien, akurat, dan dapat diakses oleh seluruh anggota tim yang membutuhkannya tanpa terbatas oleh waktu dan lokasi fisik (Hartono et al., 2024).

6. Alur pemulangan pasien *(discharge planning)*

Discharge planning atau perencanaan pemulangan pasien bukan merupakan kegiatan yang dilakukan sesaat sebelum pasien pulang, melainkan proses yang seharusnya dimulai sejak hari pertama pasien masuk dan direncanakan secara sistematis sepanjang periode perawatan untuk memastikan bahwa pasien pulang dalam kondisi yang siap dan memiliki dukungan yang memadai untuk melanjutkan pemulihan di rumah. Kegagalan dalam *discharge planning* yang komprehensif merupakan salah satu penyebab utama readmisi yang tidak terencana, komplikasi pasca rawat, dan ketidakpuasan pasien terhadap layanan yang diterima, sehingga investasi dalam proses ini memiliki dampak klinis dan finansial yang sangat signifikan bagi pasien, keluarga, maupun institusi layanan (Kurniawati et al., 2023).

a. Pengkajian Kebutuhan *Discharge*

Pengkajian kebutuhan *discharge* mencakup identifikasi komprehensif terhadap kondisi klinis yang akan dibawa pulang pasien, tingkat kemampuan fungsional yang telah dicapai, kebutuhan perawatan lanjutan yang masih diperlukan, kapasitas dan kesiapan keluarga sebagai *caregiver*, kondisi lingkungan rumah yang akan ditempati, ketersediaan sumber daya finansial untuk mendukung keberlangsungan pengobatan, serta akses terhadap fasilitas layanan kesehatan tingkat lanjutan yang mungkin masih diperlukan. Pengkajian yang komprehensif ini akan menghasilkan gambaran yang akurat tentang kesenjangan antara kondisi pasien saat ini dengan kondisi yang dibutuhkan untuk dapat menjalani pemulihan secara aman dan optimal di lingkungan rumah, sehingga intervensi yang tepat sasaran dapat dirancang untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

b. Edukasi Pasien dan Keluarga

Edukasi pasien dan keluarga merupakan komponen terpenting dari *discharge planning* yang menentukan apakah pasien dan keluarganya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang cukup untuk mengelola kondisi kesehatannya secara mandiri setelah meninggalkan fasilitas layanan. Materi edukasi yang komprehensif mencakup penjelasan

tentang diagnosis dan perjalanan penyakit dalam bahasa yang dapat dipahami, instruksi penggunaan obat termasuk dosis, jadwal, dan efek samping yang perlu diwaspadai, demonstrasi keterampilan perawatan mandiri yang diperlukan seperti perawatan luka atau penggunaan alat bantu, tanda-tanda bahaya yang harus segera mendapatkan penanganan medis, serta informasi tentang jadwal kontrol dan fasilitas layanan yang dapat dihubungi apabila timbul permasalahan kesehatan pasca rawat. Efektivitas edukasi harus diverifikasi melalui metode *teach-back*, di mana pasien dan keluarga diminta untuk mendemonstrasikan kembali pemahaman dan keterampilan yang telah diajarkan, sehingga perawat dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar dipahami dan dapat diaplikasikan secara mandiri.

c. Koordinasi Layanan Lanjutan

Koordinasi layanan lanjutan mencakup pengaturan rujukan ke fasilitas atau layanan kesehatan yang akan melanjutkan perawatan pasien setelah pemulangan, termasuk koordinasi dengan *Puskesmas* terdekat untuk pemantauan kondisi kronis, pengaturan layanan *home care* apabila diperlukan, penjadwalan kontrol poliklinik, serta koordinasi dengan layanan rehabilitasi atau layanan sosial yang dibutuhkan pasien untuk mendukung pemulihan fungsionalnya. Komunikasi yang akurat dan tepat waktu antara fasilitas yang merujuk dengan fasilitas yang menerima rujukan merupakan kunci keberhasilan koordinasi ini, karena tanpa transfer informasi klinis yang komprehensif, fasilitas penerima tidak akan memiliki konteks yang cukup untuk melanjutkan perawatan secara berkesinambungan (Kurniawati et al., 2023).

7. Kesinambungan layanan pasca rawat *(continuity of care)*

Continuity of care atau kesinambungan layanan pasca rawat merupakan dimensi kualitas layanan yang mengukur sejauh mana pasien menerima layanan yang terkoordinasi, konsisten, dan tidak terputus selama transisi dari satu *setting* perawatan ke *setting* lainnya, termasuk transisi dari rumah sakit ke komunitas yang merupakan momen paling rentan dalam perjalanan kesehatan seorang pasien. Kesinambungan layanan bukan hanya tentang kontinuitas informasi klinis, melainkan juga mencakup kontinuitas hubungan terapeutik, kontinuitas nilai dan preferensi pasien yang dihormati secara konsisten, serta kontinuitas dukungan yang diberikan kepada pasien dan keluarganya sepanjang perjalanan pemulihannya (Hartono et al., 2024).

a. Kesinambungan Informasi

Kesinambungan informasi mensyaratkan bahwa seluruh data klinis yang relevan tentang kondisi, riwayat, terapi, dan rencana perawatan pasien tersedia secara akurat dan dapat diakses oleh seluruh pemberi layanan yang akan melanjutkan perawatan, tanpa tergantung pada ingatan pasien atau anggota keluarganya yang seringkali tidak lengkap dan tidak akurat. *Surat rujukan* yang komprehensif, *resume medis* yang akurat, *resume keperawatan* yang mencakup status fungsional dan kebutuhan perawatan lanjutan, serta sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi antar fasilitas merupakan instrumen utama yang mendukung kesinambungan informasi dalam sistem layanan kesehatan. Dalam konteks Indonesia, pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi antar fasilitas masih menjadi agenda yang terus diupayakan, sehingga perawat harus memastikan bahwa dokumentasi yang menyertai pasien saat transisi layanan dibuat dengan kualitas tertinggi sebagai jembatan informasi yang dapat diandalkan.

b. Kesinambungan Manajemen

Kesinambungan manajemen mengacu pada konsistensi dalam pendekatan terapeutik dan rencana perawatan yang dipertahankan secara berkesinambungan antar pemberi layanan yang berbeda, sehingga pasien tidak mengalami kebingungan akibat perbedaan instruksi, perubahan terapi yang tidak dijelaskan, atau inkonsistensi dalam standar perawatan yang diterimanya dari berbagai penyedia layanan yang berbeda. Program manajemen penyakit kronis yang terkoordinasi antara rumah sakit dan *Puskesmas*, penggunaan panduan klinis yang terstandar secara nasional, serta mekanisme komunikasi yang efektif antar penyedia layanan merupakan pilar utama yang mendukung kesinambungan manajemen dalam sistem layanan yang berjenjang.

c. Kesinambungan Relasional

Kesinambungan relasional merujuk pada keberlanjutan hubungan terapeutik antara pasien dengan pemberi layanan kesehatannya, yang merupakan dimensi kesinambungan yang paling sering diabaikan dalam desain sistem layanan namun memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kepercayaan pasien, kepatuhan terhadap rencana perawatan, dan hasil klinis jangka panjang yang ingin dicapai. Pasien yang memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan perawat atau tenaga kesehatan yang mengenalnya secara personal cenderung lebih terbuka dalam mengkomunikasikan keluhannya, lebih patuh dalam mengikuti rencana perawatan, dan lebih mampu mengelola kondisi kronisnya secara mandiri

dibandingkan pasien yang setiap kali berhadapan dengan pemberi layanan yang berbeda dan harus memulai dari awal dalam membangun kepercayaan dan pemahaman bersama tentang kondisi dan kebutuhannya.

d. Peran Perawat dalam Memastikan *Continuity of Care*

Perawat memiliki peran yang sangat sentral dan tidak tergantikan dalam memastikan kesinambungan layanan pasca rawat, mengingat posisinya sebagai profesi yang paling dekat, paling lama, dan paling intensif berinteraksi dengan pasien sepanjang periode perawatan. Perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa *discharge planning* yang telah disusun benar-benar ditindaklanjuti, bahwa pasien dan keluarga memiliki pemahaman dan kapasitas yang cukup untuk mengelola kondisi kesehatannya di rumah, bahwa koordinasi dengan fasilitas penerima rujukan telah dilakukan dengan baik, serta bahwa ada mekanisme pemantauan yang memungkinkan deteksi dini apabila terjadi perburukan kondisi setelah pasien meninggalkan fasilitas rawat inap. Dengan menjalankan peran ini secara konsisten dan kompeten, perawat tidak hanya memberikan layanan yang berakhir pada saat pasien pulang, tetapi menjadi jembatan yang memastikan bahwa perjalanan pemulihan setiap pasien berlangsung secara aman, terdukung, dan berkesinambungan jauh melampaui batas fisik fasilitas layanan tempatnya bekerja (Hartono et al., 2024).

G. *Governance* Keperawatan dan Tata Kelola Organisasi

1. Pengertian *governance* dalam konteks keperawatan

Governance dalam konteks keperawatan merupakan konsep yang jauh lebih luas dan mendalam dari sekadar pengelolaan administratif atau pengawasan hierarkis yang bersifat mekanis dan reaktif. Secara substansial, *governance* keperawatan merujuk pada keseluruhan sistem nilai, kebijakan, struktur, proses, dan mekanisme akuntabilitas yang secara bersama-sama membentuk cara sebuah organisasi keperawatan membuat keputusan, mendistribusikan wewenang, mengelola sumber daya, dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada seluruh pemangku kepentingan yang relevan. Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, *governance* keperawatan mencakup dimensi formal seperti struktur organisasi, regulasi, dan prosedur tertulis, sekaligus dimensi informal seperti budaya organisasi, nilai-nilai profesi, dan norma perilaku yang membentuk cara anggota organisasi berinteraksi dan mengambil keputusan dalam keseharian operasional layanan. Tanpa *governance* yang kuat dan terarah, organisasi keperawatan akan rentan terhadap inkonsistensi dalam standar layanan, ketidakjelasan

akuntabilitas, lemahnya perlindungan terhadap pasien dan tenaga keperawatan, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi dan institusi yang menaunginya (Oliveira et al., 2022).

Konsep *governance* dalam keperawatan berkembang secara signifikan sejak akhir dekade 1990-an, didorong oleh serangkaian insiden keselamatan pasien yang mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem layanan kesehatan di berbagai negara dan memaksa profesi serta institusi untuk merefleksikan secara mendalam tentang bagaimana kewenangan klinis dijalankan, bagaimana standar praktik dipantau, dan bagaimana akuntabilitas terhadap hasil layanan dijamin secara sistematis. Di Inggris, konsep *clinical governance* pertama kali diperkenalkan secara formal melalui dokumen kebijakan *A First Class Service* pada tahun 1998 sebagai respons terhadap berbagai skandal layanan kesehatan, dan dengan cepat menyebar ke berbagai negara termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru sebagai kerangka tata kelola kualitas layanan yang komprehensif. Dalam konteks Indonesia, konseptualisasi *governance* keperawatan mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan implementasi JKN dan tuntutan akreditasi yang semakin ketat, yang secara bersama-sama mendorong institusi layanan kesehatan untuk membangun sistem tata kelola yang lebih terstruktur, transparan, dan berorientasi pada hasil yang terukur sebagai syarat untuk dapat beroperasi dalam ekosistem layanan yang semakin kompetitif dan akuntabel (Adikoesoemo et al., 2024).

Governance keperawatan yang efektif mencakup tiga dimensi utama yang saling memperkuat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam membentuk sistem tata kelola yang benar-benar fungsional. Dimensi pertama adalah *governance* struktural, yang mencakup kejelasan hierarki, pembagian wewenang, mekanisme pengambilan keputusan, dan sistem pelaporan yang memastikan bahwa setiap individu dan unit dalam organisasi memiliki kejelasan tentang peran, tanggung jawab, dan jalur akuntabilitasnya. Dimensi kedua adalah *governance* klinis, yang berfokus pada mekanisme yang memastikan bahwa praktik keperawatan dilaksanakan sesuai dengan standar tertinggi yang berbasis bukti, termasuk sistem *credentialing*, audit klinis, manajemen risiko, dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Dimensi ketiga adalah *governance* profesional, yang mencakup penegakan standar etika, pemeliharaan integritas profesi, perlindungan terhadap *whistle-blower*, dan pembangunan budaya profesionalisme yang menjadikan kepentingan pasien sebagai kompas utama setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh setiap anggota profesi keperawatan (Desmet et al., 2023).

Memahami *governance* keperawatan secara mendalam memiliki implikasi praktis yang sangat nyata bagi setiap perawat, tidak terbatas pada mereka yang menduduki posisi manajerial atau kepemimpinan formal dalam organisasi. Setiap perawat pelaksana sesungguhnya adalah aktor *governance* yang aktif, karena setiap keputusan klinis yang diambilnya, setiap standar prosedur yang dipatuhi atau dilanggarnya, setiap insiden yang dilaporkan atau disembunyikannya, dan setiap interaksi profesional yang dijalinnya dengan rekan kerja dan profesi lain merupakan kontribusi nyata terhadap kualitas *governance* organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, *governance* yang kuat tidak dapat dibangun dari atas ke bawah semata melalui kebijakan dan regulasi yang dipaksakan, melainkan harus tumbuh dari dalam melalui internalisasi nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, dan komitmen terhadap keselamatan pasien yang tertanam dalam diri setiap individu yang menjadi anggota komunitas profesi keperawatan (Nelson et al., 2022).

2. Komponen *clinical governance* keperawatan

Clinical governance merupakan kerangka yang digunakan oleh organisasi layanan kesehatan untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas layanan klinis dan menjamin standar pelayanan yang tinggi melalui pengintegrasian berbagai mekanisme penjaminan mutu dalam satu sistem yang kohesif dan terkoordinasi. Dalam konteks keperawatan, *clinical governance* bukan sekadar program mutu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh organisasi untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan pemberian asuhan berkualitas tinggi secara konsisten kepada setiap pasien yang dilayani.

Menurut Talebong & Wijayanti, (2024) Komponen-komponen *clinical governance* keperawatan yang perlu dipahami secara mendalam adalah sebagai berikut.

a. Manajemen Risiko Klinis

Manajemen risiko klinis merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko-risiko yang berpotensi merugikan pasien, tenaga keperawatan, maupun institusi dalam penyelenggaraan layanan klinis sehari-hari. Dalam organisasi keperawatan, manajemen risiko klinis diwujudkan melalui sistem pelaporan insiden yang *blame-free*, analisis akar masalah (*root cause analysis*) yang dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap insiden yang terjadi, dan implementasi tindakan perbaikan yang sistematis untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Budaya keselamatan yang

kuat, di mana setiap perawat merasa aman dan bahkan terdorong untuk melaporkan setiap potensi risiko tanpa rasa takut akan hukuman, merupakan prasyarat kultural yang harus dibangun sebagai fondasi dari seluruh sistem manajemen risiko klinis yang efektif.

b. Audit Klinis

Audit klinis merupakan proses penilaian sistematis terhadap praktik klinis aktual yang dibandingkan dengan standar atau kriteria terbaik yang telah ditetapkan, dengan tujuan mengidentifikasi kesenjangan, memahami penyebabnya, dan mengimplementasikan perbaikan yang terukur untuk menutup kesenjangan tersebut dalam siklus yang berkesinambungan. Dalam keperawatan, audit klinis dapat mencakup audit dokumentasi keperawatan, audit kepatuhan terhadap *bundle* pencegahan infeksi, audit penerapan protokol manajemen nyeri, audit kelengkapan pengkajian risiko jatuh, dan berbagai audit lainnya yang berfokus pada aspek-aspek praktik yang secara langsung memengaruhi keselamatan dan kualitas pengalaman pasien. Hasil audit harus dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh tim keperawatan dan digunakan sebagai dasar perencanaan perbaikan yang konkret, bukan sekadar dokumen yang tersimpan dalam arsip tanpa tindak lanjut yang bermakna.

c. Pengembangan Profesional Berkelanjutan

Pengembangan profesional berkelanjutan atau *Continuing Professional Development* (CPD) merupakan komponen *clinical governance* yang memastikan bahwa seluruh tenaga keperawatan mempertahankan dan terus meningkatkan kompetensinya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan layanan yang terus berubah. Sistem CPD yang efektif dalam organisasi keperawatan mencakup identifikasi kebutuhan pengembangan yang sistematis melalui evaluasi kinerja, program pelatihan dan pendidikan yang terencana dan relevan, mekanisme verifikasi pencapaian kompetensi yang terstandar, serta portofolio pengembangan profesional yang didokumentasikan secara individual untuk setiap perawat. Investasi dalam CPD bukan hanya kewajiban etis profesi, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas bagi organisasi karena tenaga keperawatan yang kompeten dan terus berkembang terbukti menghasilkan layanan yang lebih aman, lebih efisien, dan lebih memuaskan bagi pasien.

d. Praktik Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*)

Praktik berbasis bukti atau *Evidence-Based Practice* (EBP) merupakan komponen *clinical governance* yang menuntut seluruh intervensi dan keputusan klinis dalam keperawatan dilandasi oleh bukti ilmiah terbaik yang

tersedia, diintegrasikan dengan keahlian klinis perawat dan preferensi pasien dalam konteks sumber daya yang ada. Implementasi EBP dalam organisasi keperawatan membutuhkan infrastruktur yang mendukung, termasuk akses terhadap literatur ilmiah terkini, kapasitas perawat dalam menginterpretasikan dan mengaplikasikan hasil penelitian, mekanisme *journal club* dan diskusi ilmiah yang teratur, serta kepemimpinan yang secara aktif mendorong dan memberi ruang bagi pembaruan praktik berdasarkan temuan penelitian terbaru. Kesenjangan antara bukti ilmiah dan praktik klinis aktual merupakan salah satu masalah paling persisten dalam layanan keperawatan yang harus diatasi melalui strategi implementasi yang terencana dan dukungan organisasi yang konsisten.

e. Keterlibatan Pasien dan Keluarga

Keterlibatan pasien dan keluarga sebagai komponen *clinical governance* mencerminkan pengakuan bahwa pasien bukan hanya objek layanan, melainkan mitra aktif yang memiliki perspektif unik dan berharga tentang kualitas layanan yang mereka terima, sehingga masukan mereka merupakan sumber informasi yang tidak tergantikan dalam upaya perbaikan mutu yang berkelanjutan. Mekanisme keterlibatan pasien dalam *clinical governance* keperawatan mencakup survei kepuasan pasien yang dirancang dengan baik dan hasilnya ditindaklanjuti secara nyata, forum konsultasi pasien, sistem penanganan keluhan yang responsif dan transparan, serta keterlibatan representasi pasien dalam komite mutu dan keselamatan institusi. Organisasi keperawatan yang sungguh-sungguh mengintegrasikan perspektif pasien dalam sistem *governance*-nya akan menghasilkan layanan yang tidak hanya memenuhi standar klinis yang ditetapkan oleh profesi, tetapi juga benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan nyata dari mereka yang paling berkepentingan terhadap kualitas layanan tersebut (Talebong & Wijayanti, 2024).

3. Peran komite keperawatan dalam tata kelola

Komite keperawatan merupakan salah satu struktur tata kelola yang paling strategis dalam organisasi keperawatan di fasilitas layanan kesehatan, berfungsi sebagai representasi profesional keperawatan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik keperawatan di institusi tersebut diselenggarakan sesuai dengan standar profesi, nilai etika, dan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit, komite keperawatan memiliki kedudukan yang independen dari struktur manajemen keperawatan, sehingga

dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan profesional secara objektif dan tidak terpengaruh oleh kepentingan administratif semata. Peran-peran utama komite keperawatan dalam tata kelola organisasi keperawatan adalah sebagai berikut (Murphy & Carter-Templeton, 2023).

a. Kredensial Tenaga Keperawatan

Kredensial merupakan proses verifikasi dan penilaian kompetensi tenaga keperawatan untuk memastikan bahwa setiap perawat yang diberikan kewenangan klinis di institusi benar-benar memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan kewenangan tersebut secara aman dan efektif. Subkomite kredensial dalam komite keperawatan bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap pendidikan, pelatihan, pengalaman, sertifikasi, dan rekam jejak klinis setiap perawat yang mengajukan kewenangan klinis, serta menerbitkan rekomendasi tentang jenis dan batasan kewenangan klinis yang dapat diberikan kepada setiap individu. Proses kredensial yang dilaksanakan dengan ketat dan konsisten merupakan salah satu mekanisme perlindungan pasien yang paling fundamental, karena memastikan bahwa tidak ada perawat yang menjalankan tindakan klinis yang melampaui batas kompetensi yang telah diverifikasi secara resmi oleh institusi.

b. Penetapan dan Evaluasi Standar Praktik

Komite keperawatan bertanggung jawab untuk merumuskan, mengembangkan, dan secara berkala mengevaluasi standar praktik keperawatan yang berlaku di institusi, memastikan bahwa standar-standar tersebut selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, regulasi yang berlaku, dan kebutuhan spesifik populasi pasien yang dilayani. Standar praktik yang dihasilkan oleh komite keperawatan mencakup standar asuhan keperawatan untuk berbagai kondisi klinis yang umum ditemui, standar prosedur operasional untuk berbagai tindakan keperawatan, serta standar dokumentasi yang memastikan akurasi dan kelengkapan rekam medis keperawatan. Evaluasi berkala terhadap implementasi standar-standar ini, yang dapat dilakukan melalui mekanisme audit klinis dan pemantauan indikator mutu, merupakan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan oleh komite agar standar yang ada benar-benar hidup dalam praktik dan bukan hanya dokumen tertulis yang tidak berdampak pada kualitas asuhan nyata.

c. Pembinaan Etika dan Disiplin Profesi

Subkomite etika dan disiplin dalam komite keperawatan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh tenaga keperawatan di institusi menjalankan praktiknya sesuai dengan kode etik profesi dan norma perilaku profesional yang berlaku, serta menangani kasus-kasus pelanggaran etika

atau disiplin yang dilaporkan dengan cara yang adil, transparan, dan konstruktif. Pembinaan etika bukan semata-mata tentang penegakan hukum dan pemberian sanksi, melainkan lebih fundamental tentang pembangunan budaya profesionalisme yang menempatkan integritas, kejujuran, dan kepentingan pasien sebagai nilai-nilai yang dihayati secara mendalam oleh setiap anggota komunitas profesi. Komite keperawatan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan penyelesaian dilema etis yang seringkali dihadapi perawat dalam praktik klinis sehari-hari, termasuk melalui konsultasi etika, forum diskusi kasus, dan pembinaan individual yang bersifat mendukung dan mengembangkan, bukan menghakimi.

d. Advokasi Pengembangan Profesi

Komite keperawatan juga memiliki peran penting sebagai advokat pengembangan profesi keperawatan di tingkat institusi, memperjuangkan kebijakan dan sumber daya yang mendukung peningkatan kompetensi, kesejahteraan, dan otonomi profesional tenaga keperawatan dalam sistem yang seringkali masih didominasi oleh perspektif medis dan administratif. Advokasi ini mencakup perjuangan untuk rasio tenaga yang memadai, program pengembangan profesional yang didanai secara memadai, pengakuan atas kontribusi klinis perawat dalam sistem layanan, serta perlindungan terhadap perawat yang melaporkan insiden atau pelanggaran standar dalam kerangka budaya keselamatan yang sehat. Komite keperawatan yang efektif dalam menjalankan peran advokasinya akan menjadi suara yang diperhitungkan dalam forum-forum pengambilan keputusan institusi, memperkuat posisi strategis keperawatan sebagai profesi yang memberikan kontribusi yang setara dan tidak tergantikan dalam sistem layanan kesehatan (Almeida et al., 2023).

4. Mekanisme akuntabilitas dan transparansi organisasi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua nilai tata kelola yang saling melengkapi dan merupakan fondasi dari kepercayaan publik terhadap organisasi keperawatan dan sistem layanan kesehatan secara keseluruhan. Akuntabilitas berarti bahwa setiap individu dan unit dalam organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan, dan hasil kerjanya, sementara transparansi berarti bahwa informasi tentang kinerja, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam organisasi keperawatan, penerapan kedua nilai ini secara konsisten merupakan prasyarat

bagi terciptanya budaya perbaikan berkelanjutan yang sesungguhnya, karena hanya dalam iklim yang akuntabel dan transparan, masalah dapat diidentifikasi secara jujur dan solusi dapat dirancang secara efektif (Ferreira et al., 2024).

Menurut Villarreal-Granda et al., (2024) mekanisme-mekanisme utama yang mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi keperawatan adalah sebagai berikut.

a. Sistem Pelaporan Kinerja

Sistem pelaporan kinerja yang terstruktur dan komprehensif merupakan tulang punggung akuntabilitas dalam organisasi keperawatan, menyediakan data objektif tentang pencapaian indikator mutu, keselamatan pasien, dan efisiensi layanan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan di setiap level organisasi. Indikator kinerja keperawatan yang dilaporkan secara rutin mencakup angka *phlebitis*, angka decubitus, angka jatuh, angka infeksi *nosokomial*, tingkat kepuasan pasien, kepatuhan *hand hygiene*, dan berbagai indikator klinis lainnya yang mencerminkan kualitas asuhan yang diberikan. Laporan kinerja ini harus dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh anggota tim keperawatan, bukan hanya kepada jajaran manajerial, sehingga setiap perawat memiliki gambaran yang jelas tentang posisi kinerja unitnya dan dapat berkontribusi secara aktif dalam upaya perbaikan yang diperlukan.

b. Evaluasi Kinerja Individual

Evaluasi kinerja individual merupakan mekanisme akuntabilitas yang memastikan bahwa setiap perawat secara periodik mendapatkan penilaian yang objektif, konstruktif, dan berbasis bukti tentang kualitas praktik klinis, perilaku profesional, dan kontribusinya terhadap tujuan tim dan organisasi. Sistem evaluasi yang efektif harus mencakup komponen *self-assessment*, penilaian oleh atasan, dan idealnya juga komponen *peer review* yang memberikan perspektif dari rekan sejawat yang berinteraksi langsung dalam praktik klinis sehari-hari. Hasil evaluasi kinerja harus digunakan secara konstruktif sebagai dasar perencanaan pengembangan individual, bukan semata-mata sebagai instrumen hukuman atau reward administratif yang tidak terhubung dengan peningkatan kualitas praktik yang sesungguhnya dibutuhkan.

c. Transparansi dalam Pengambilan Keputusan

Transparansi dalam pengambilan keputusan berarti bahwa proses, pertimbangan, dan dasar dari setiap keputusan organisasi yang memengaruhi tenaga keperawatan dan kualitas layanan dikomunikasikan secara terbuka dan dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan

yang terdampak. Ketika keputusan tentang kebijakan, prosedur, alokasi sumber daya, atau perubahan sistem dibuat secara tertutup tanpa penjelasan yang memadai, kepercayaan anggota tim terhadap pimpinan akan terkikis dan resistensi terhadap perubahan akan meningkat secara signifikan. Pimpinan keperawatan yang menjalankan transparansi dalam pengambilan keputusan, dengan menjelaskan rasional di balik setiap kebijakan, membuka ruang bagi masukan dan pertanyaan, serta mengakui keterbatasan dan ketidakpastian secara jujur, akan membangun iklim kepercayaan yang merupakan modal sosial paling berharga bagi efektivitas organisasi dalam jangka panjang.

d. Mekanisme Penanganan Keluhan dan Pengaduan

Mekanisme penanganan keluhan yang efektif, aksesibel, dan responsif merupakan komponen transparansi yang melindungi hak pasien sekaligus menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi organisasi tentang aspek-aspek layanan yang membutuhkan perbaikan. Setiap keluhan yang masuk harus ditangani dengan serius, diinvestigasi secara objektif, dan direspons secara tepat waktu kepada pelapor, dengan umpan balik yang jelas tentang tindakan yang telah diambil sebagai respons terhadap keluhan tersebut. Analisis pola keluhan secara berkala dapat memberikan gambaran yang sangat informatif tentang masalah sistemik dalam organisasi yang mungkin tidak terdeteksi melalui mekanisme pemantauan internal biasa, sehingga menjadikan sistem penanganan keluhan bukan hanya sebagai mekanisme pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan organisasi yang genuinely berharga (da Macêdo et al., 2022).

5. *Shared governance* sebagai model partisipasi perawat

Shared governance merupakan model tata kelola keperawatan yang secara fundamental mengubah cara pengambilan keputusan dalam organisasi dengan memberikan otonomi, akuntabilitas, dan kewenangan yang bermakna kepada perawat pelaksana dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan standar praktik, lingkungan kerja, kompetensi, dan kualitas layanan yang mereka berikan setiap harinya. Model ini didasarkan pada keyakinan filosofis bahwa mereka yang paling dekat dengan praktik klinis, yaitu perawat di garis terdepan, memiliki pengetahuan, perspektif, dan komitmen yang tidak ternilai untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan organisasi, dan bahwa pelibatan yang bermakna dari mereka bukan sekadar kebaikan hati manajemen, melainkan merupakan keharusan profesional dan strategis untuk menghasilkan

sistem layanan yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan pasien. Tim Porter-O'Grady, yang dikenal sebagai salah satu arsitek intelektual utama *shared governance* dalam keperawatan, menegaskan bahwa *shared governance* bukan tentang demokrasi tanpa struktur, melainkan tentang menciptakan akuntabilitas yang terdistribusi secara tepat kepada mereka yang paling memiliki kompetensi dan informasi untuk menjalankannya (Lai et al., 2022).

Implementasi *shared governance* dalam organisasi keperawatan diwujudkan melalui berbagai struktur formal yang memungkinkan partisipasi perawat dalam pengambilan keputusan secara terstruktur dan akuntabel. Struktur yang paling umum mencakup dewan atau komite praktik yang terdiri dari perawat pelaksana yang dipilih oleh rekan sejawatnya untuk merumuskan dan mengevaluasi standar praktik klinis, komite kualitas yang bertanggung jawab atas pemantauan indikator mutu dan perencanaan perbaikan berbasis data, komite pendidikan yang merancang program pengembangan kompetensi berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi dari praktik nyata, serta dewan keperawatan unit yang memberikan forum bagi setiap unit untuk membahas isu-isu spesifik yang relevan dengan konteks layanan mereka. Kunci keberhasilan struktur-struktur ini bukan terletak pada kesempurnaan desainnya, melainkan pada seberapa nyata kewenangan yang diberikan kepada mereka, seberapa konsisten pimpinan menghormati keputusan yang dihasilkan, dan seberapa jelas mekanisme pertanggungjawaban yang dituntut dari setiap anggota yang berpartisipasi dalam forum-forum tersebut (Murphy & Carter-Templeton, 2023).

Bukti empiris yang terakumulasi selama beberapa dekade implementasi *shared governance* di berbagai negara secara konsisten menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap berbagai dimensi hasil, baik bagi perawat, pasien, maupun institusi secara keseluruhan. Bagi perawat, *shared governance* terbukti meningkatkan kepuasan kerja, otonomi profesional, rasa kepemilikan terhadap standar dan lingkungan kerja, serta komitmen terhadap organisasi yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan *turnover* tenaga yang merupakan salah satu masalah paling mahal yang dihadapi oleh organisasi keperawatan di seluruh dunia. Bagi pasien, *shared governance* berkontribusi pada peningkatan mutu layanan karena keputusan tentang standar praktik dibuat oleh mereka yang paling memahami nuansa dan kompleksitas klinis sehari-hari, menghasilkan standar yang lebih relevan, lebih realistis, dan lebih mungkin untuk diimplementasikan secara konsisten dibandingkan standar yang ditetapkan oleh manajemen tanpa keterlibatan perawat pelaksana. Bagi institusi, pengurangan *turnover* tenaga, peningkatan produktivitas, dan perbaikan

indikator mutu yang dihasilkan oleh *shared governance* memberikan manfaat finansial yang nyata yang jauh melampaui biaya investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur model ini (Fu & Lee, 2024).

Meskipun demikian, implementasi *shared governance* yang sejati bukanlah proses yang mudah atau cepat, melainkan membutuhkan transformasi budaya yang mendalam dan komitmen jangka panjang dari seluruh level kepemimpinan organisasi. Resistensi dari manajer menengah yang merasa terancam oleh redistribusi kewenangan, ketidaksiapan sebagian perawat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, serta inkonsistensi antara retorika *shared governance* dan praktik manajemen yang masih bersifat otoriter merupakan hambatan nyata yang sering ditemui dalam proses implementasi. Keberhasilan *shared governance* membutuhkan pemimpin keperawatan yang memiliki keberanian untuk melepaskan kontrol yang tidak perlu, kerendahan hati untuk mengakui bahwa tidak semua kebijakan yang baik harus berasal dari atas, dan komitmen yang konsisten untuk menghormati keputusan yang dihasilkan oleh forum-forum partisipasi yang telah dibangun, bahkan ketika keputusan tersebut tidak selalu sesuai dengan preferensi pribadi mereka sebagai pimpinan. Dalam konteks Indonesia, pengembangan *shared governance* memiliki relevansi yang sangat besar sebagai strategi untuk memperkuat profesionalisme keperawatan, meningkatkan retensi tenaga, dan mendorong inovasi berbasis praktik yang akan membawa profesi keperawatan Indonesia menuju standar internasional yang menjadi cita-cita bersama seluruh anggota komunitas profesi (Murphy & Carter-Templeton, 2023).

H. Standar Akreditasi Layanan Keperawatan

1. Konsep dan tujuan akreditasi fasilitas kesehatan

Akreditasi fasilitas kesehatan merupakan proses penilaian eksternal yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif oleh lembaga independen yang berwenang untuk menilai sejauh mana sebuah fasilitas layanan kesehatan memenuhi standar yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kualitas, keamanan, dan efektivitas penyelenggaraan layanan. Berbeda dengan proses perizinan yang bersifat administratif dan merupakan prasyarat minimal untuk beroperasi, akreditasi merupakan pengakuan formal bahwa sebuah institusi telah memenuhi standar yang melampaui persyaratan minimal dan secara aktif berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanannya secara berkelanjutan. Proses akreditasi mencakup penilaian menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan layanan, mulai dari tata kelola institusi,

manajemen sumber daya manusia, standar klinis, keselamatan pasien, manajemen lingkungan, hingga sistem informasi dan dokumentasi yang mendukung keberlangsungan layanan yang aman dan berkualitas. Dalam konteks Indonesia, akreditasi fasilitas kesehatan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan berbagai regulasi turunannya yang mewajibkan seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk menjalani proses akreditasi sebagai syarat operasional dan syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan (Amrullah et al., 2025).

Tujuan akreditasi fasilitas kesehatan bersifat multidimensi dan memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem layanan kesehatan. Bagi pasien dan masyarakat, akreditasi memberikan jaminan bahwa fasilitas yang mereka pilih telah memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah diverifikasi secara independen, sehingga mengurangi asimetri informasi yang seringkali membuat pasien kesulitan menilai kualitas layanan yang akan mereka terima. Bagi institusi layanan, proses akreditasi memberikan kerangka yang terstruktur untuk melakukan evaluasi internal yang menyeluruh, mengidentifikasi kesenjangan antara praktik aktual dan standar ideal, serta menyusun rencana perbaikan yang sistematis dan terukur yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh proses layanan. Bagi tenaga kesehatan termasuk perawat, akreditasi mendorong pengembangan kompetensi, kepatuhan terhadap standar praktik, dan budaya perbaikan berkelanjutan yang merupakan ciri khas profesionalisme tingkat tinggi. Bagi pemerintah dan pembayar layanan, akreditasi memberikan mekanisme kendali mutu yang efisien untuk memastikan bahwa dana publik yang digunakan untuk membiayai layanan kesehatan benar-benar menghasilkan layanan yang berkualitas dan aman bagi seluruh peserta jaminan kesehatan (Kemenkes, 2023).

Siklus akreditasi yang berlangsung secara periodik, umumnya setiap tiga hingga lima tahun tergantung pada jenis dan level akreditasi yang diraih, dirancang untuk mendorong institusi agar tidak memandang akreditasi sebagai tujuan akhir yang dicapai sekali dan kemudian diabaikan, melainkan sebagai bagian dari budaya perbaikan berkelanjutan yang menjadi identitas permanen organisasi. Persiapan akreditasi yang hanya dilakukan secara intensif menjelang jadwal penilaian tanpa didukung oleh sistem pemeliharaan standar yang konsisten sepanjang waktu merupakan pendekatan yang tidak hanya tidak efektif dalam jangka panjang, tetapi juga berbahaya karena menciptakan ilusi kepatuhan yang tidak mencerminkan kondisi layanan yang sesungguhnya

dialami pasien sehari-hari. Institusi yang benar-benar menginternalisasi semangat akreditasi akan membangun sistem di mana standar akreditasi menjadi standar operasional sehari-hari yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota organisasi tanpa perlu tekanan atau pengawasan khusus, karena setiap individu memahami dan meyakini bahwa standar tersebut ada untuk melindungi pasien dan mendukung praktik profesional mereka (Trisnantoro, 2020).

2. Standar akreditasi KARS dan elemen penilaian keperawatan

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) merupakan lembaga independen yang diberi kewenangan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan akreditasi rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia, dengan standar yang dikembangkan secara kontekstual berdasarkan kondisi sistem kesehatan nasional namun tetap selaras dengan standar internasional yang berlaku. Standar KARS yang saat ini berlaku mengalami berbagai penyempurnaan signifikan dari generasi ke generasi, dengan standar terbaru yang dikenal sebagai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 yang menggantikan standar berbasis *Joint Commission International* (JCI) yang sebelumnya diadopsi secara langsung, mencerminkan upaya untuk menciptakan standar yang lebih relevan dengan konteks layanan kesehatan Indonesia tanpa mengorbankan substansi kualitas dan keamanan yang menjadi esensi dari proses akreditasi. Standar KARS mencakup berbagai kelompok standar yang secara komprehensif menjangkau seluruh dimensi penyelenggaraan layanan rumah sakit, dan di dalamnya terdapat berbagai elemen yang secara langsung berkaitan dengan praktik dan manajemen keperawatan sebagai profesi yang memberikan layanan paling intensif dan berkelanjutan kepada pasien (Primasa & Kosasih, 2024).

Kelompok standar yang paling relevan dengan keperawatan dalam sistem akreditasi KARS mencakup standar *Pelayanan Pasien* (PP) yang mengatur tentang proses pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan klinis termasuk asuhan keperawatan, dengan elemen penilaian yang mencakup kelengkapan dan ketepatan pengkajian awal, konsistensi pembaruan rencana asuhan, dokumentasi implementasi yang akurat, serta proses evaluasi yang terstruktur dan didokumentasikan dengan baik. Standar *Asesmen Pasien* (AP) menetapkan persyaratan tentang kompetensi assessor, kerangka waktu penyelesaian asesmen, dan kedalaman asesmen yang harus dilakukan oleh perawat pada berbagai kondisi klinis, termasuk asesmen nyeri, asesmen risiko jatuh, asesmen status nutrisi, dan asesmen kebutuhan khusus yang memerlukan

pendekatan yang terindividualisasi. Standar *Kompetensi dan Kewenangan Staf* (KKS) yang berkaitan langsung dengan manajemen sumber daya manusia keperawatan menetapkan persyaratan tentang proses rekrutmen, orientasi, pelatihan, kredensial, dan evaluasi kinerja tenaga keperawatan yang harus dipenuhi oleh institusi sebagai jaminan bahwa tenaga yang memberikan layanan benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawab klinis yang diembannya (Haryadi, 2022).

Elemen penilaian keperawatan dalam standar *Manajemen Komunikasi dan Edukasi* (MKE) mencakup persyaratan tentang kualitas edukasi yang diberikan kepada pasien dan keluarga, termasuk asesmen kebutuhan edukasi, penggunaan metode edukasi yang sesuai dengan karakteristik pelajar, verifikasi pemahaman melalui *teach-back*, dan dokumentasi proses edukasi yang komprehensif dalam rekam medis. Standar *Pencegahan dan Pengendalian Infeksi* (PPI) memuat elemen-elemen yang secara langsung dinilai dalam praktik keperawatan sehari-hari, termasuk kepatuhan *hand hygiene*, implementasi *bundle* pencegahan *Health Care Associated Infections* (HAIs), penggunaan *Alat Pelindung Diri* (APD) yang sesuai, dan pengelolaan lingkungan yang aman. Standar *Sasaran Keselamatan Pasien* (SKP) yang mencakup enam sasaran keselamatan pasien internasional merupakan kelompok standar yang paling intensif dinilai dalam survei akreditasi karena berkaitan langsung dengan risiko yang paling sering menjadi penyebab insiden klinis yang dapat dicegah, dan perawat sebagai profesi yang paling intensif berinteraksi dengan pasien memiliki peran terdepan dalam implementasi keenam sasaran tersebut secara konsisten (Sitorus et al., 2023).

Proses survei akreditasi KARS melibatkan tim surveyor yang terdiri dari berbagai profesi termasuk surveyor keperawatan yang secara khusus menilai dimensi-dimensi layanan dan manajemen keperawatan, menggunakan metode penilaian yang mencakup telaah dokumen, observasi langsung praktik di lapangan, wawancara dengan tenaga keperawatan di berbagai level, dan wawancara dengan pasien serta keluarga tentang pengalaman mereka dalam menerima asuhan. Metode *tracer* yang digunakan oleh surveyor KARS memungkinkan penilaian yang lebih realistis tentang bagaimana standar diimplementasikan dalam praktik nyata dengan mengikuti perjalanan asuhan seorang pasien secara longitudinal melalui berbagai unit dan layanan yang ditanganinya, sehingga surveyor dapat menilai tidak hanya keberadaan kebijakan dan prosedur tertulis, tetapi juga konsistensi implementasinya dalam kondisi layanan yang sesungguhnya. Hasil survei akreditasi KARS memberikan penilaian yang dikategorikan dalam beberapa tingkat, mulai dari akreditasi

paripurna sebagai pencapaian tertinggi hingga kategori yang lebih rendah yang mencerminkan perlunya perbaikan dalam berbagai aspek standar yang belum terpenuhi secara optimal (Adikoesoemo et al., 2024).

3. Standar *Joint Commission International* (JCI)

Joint Commission International (JCI) merupakan lembaga akreditasi internasional yang berbasis di Amerika Serikat dan dikenal sebagai salah satu standar akreditasi kesehatan paling bergengsi di dunia, yang standarnya diadopsi atau dijadikan referensi oleh lebih dari sembilan puluh negara dalam pengembangan sistem akreditasi kesehatan nasional mereka. Standar JCI dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan pasien dan kualitas layanan yang bersifat universal dan *evidence-based*, mencakup dua kelompok besar standar yaitu standar yang berpusat pada pasien (*patient-centered standards*) dan standar yang berpusat pada organisasi (*organization-centered standards*). Kelompok standar yang berpusat pada pasien mencakup akses dan kontinuitas layanan, hak pasien dan keluarga, asesmen pasien, asuhan pasien, anestesi dan bedah, manajemen obat, serta edukasi pasien dan keluarga, yang kesemuanya memiliki elemen penilaian yang berkaitan erat dengan praktik keperawatan profesional. Dalam konteks keperawatan, standar JCI yang paling relevan adalah standar tentang kompetensi dan kewenangan staf yang menetapkan persyaratan ketat tentang proses kredensial, evaluasi kinerja, dan pengembangan profesional berkelanjutan yang harus dipenuhi oleh institusi sebagai jaminan bahwa setiap perawat yang memberikan layanan memiliki kompetensi yang terverifikasi dan sesuai dengan tanggung jawab klinis yang diembannya (Purnama et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, beberapa rumah sakit besar dan rumah sakit internasional telah memperoleh atau sedang dalam proses memperoleh akreditasi JCI sebagai pengakuan internasional atas kualitas layanan mereka, terutama untuk mendukung pengembangan layanan wisata medis dan untuk menarik pasien internasional yang membutuhkan jaminan kualitas yang diakui secara global. Meskipun akreditasi JCI tidak diwajibkan secara regulasi di Indonesia, standar JCI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan standar keperawatan nasional karena banyak elemen standar KARS yang mengadopsi atau mengadaptasi prinsip-prinsip yang terkandung dalam standar JCI. Bagi keperawatan Indonesia, pemahaman tentang standar JCI penting tidak hanya bagi perawat yang bekerja di institusi terakreditasi JCI, tetapi juga sebagai referensi tentang praktik keperawatan berkelas dunia yang dapat menjadi inspirasi dan tolok ukur dalam upaya peningkatan standar profesi

secara nasional, mendorong profesi keperawatan Indonesia untuk terus bergerak menuju standar internasional yang menjadi cita-cita bersama seluruh komunitas profesi (Setiawan et al., 2025).

4. Persiapan akreditasi dari perspektif manajemen keperawatan

Persiapan akreditasi dari perspektif manajemen keperawatan merupakan proses yang jauh lebih kompleks dan strategis dari sekadar pengumpulan dokumen dan pelatihan kilat yang dilakukan sesaat sebelum jadwal survei tiba. Manajer keperawatan memiliki tanggung jawab sentral dalam memimpin, mengkoordinasikan, dan memastikan kesiapan seluruh dimensi layanan keperawatan untuk dinilai oleh surveyor, sekaligus memanfaatkan momentum akreditasi sebagai katalis untuk transformasi organisasi yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Pendekatan yang paling efektif adalah menjadikan persiapan akreditasi sebagai bagian integral dari manajemen operasional harian yang berjalan sepanjang tahun, bukan sebagai proyek khusus yang hanya diaktifkan ketika jadwal survei sudah semakin dekat. Berikut adalah komponen-komponen utama persiapan akreditasi dari perspektif manajemen keperawatan (Hartati et al., 2024).

a. *Gap Analysis* Komprehensif

Langkah pertama dan paling fundamental dalam persiapan akreditasi adalah melakukan *gap analysis* yang komprehensif dan jujur terhadap kondisi aktual layanan keperawatan dibandingkan dengan seluruh standar yang akan dinilai dalam proses survei. *Gap analysis* yang efektif tidak hanya menilai keberadaan dokumen kebijakan dan prosedur, tetapi juga menilai sejauh mana standar-standar tersebut benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam praktik klinis sehari-hari oleh seluruh tenaga keperawatan di semua unit dan semua *shift*. Hasil *gap analysis* harus didokumentasikan secara sistematis dalam matriks yang mencantumkan setiap elemen standar, kondisi aktual yang ditemukan, kesenjangan yang teridentifikasi, prioritas perbaikan berdasarkan tingkat risiko, penanggungjawab perbaikan, dan *timeline* penyelesaian yang realistis.

b. Pengembangan dan Pembaruan Kebijakan serta Prosedur

Berdasarkan hasil *gap analysis*, manajer keperawatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, prosedur, dan panduan klinis yang diperlukan oleh standar akreditasi tersedia, mutakhir, berbasis bukti, dan mencerminkan praktik yang benar-benar mampu dilaksanakan oleh tenaga yang ada. Kebijakan dan prosedur yang baik untuk keperluan akreditasi bukan berarti dokumen yang tebal dan rumit, melainkan dokumen

yang jelas, ringkas, mudah dipahami oleh perawat pelaksana, dan benar-benar mencerminkan cara terbaik untuk melaksanakan suatu prosedur berdasarkan bukti ilmiah terkini. Proses pengembangan kebijakan harus melibatkan perawat pelaksana sebagai pihak yang paling memahami tantangan dan realitas lapangan, sehingga menghasilkan dokumen yang memiliki relevansi tinggi dan tingkat penerimaan yang baik dari seluruh anggota tim.

c. Pelatihan dan Sosialisasi Standar

Keberadaan kebijakan dan prosedur yang baik tidak akan berdampak pada kualitas layanan apabila tidak diikuti oleh pelatihan yang memastikan seluruh tenaga keperawatan memahami, mampu menerapkan, dan meyakini pentingnya standar-standar tersebut dalam melindungi keselamatan pasien dan mendukung praktik profesional mereka. Program pelatihan persiapan akreditasi harus dirancang secara sistematis berdasarkan kebutuhan nyata yang teridentifikasi dalam *gap analysis*, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan interaktif termasuk simulasi, *role play*, dan studi kasus yang relevan dengan konteks layanan sehari-hari. Verifikasi pemahaman dan kemampuan penerapan standar harus dilakukan melalui evaluasi yang objektif, bukan hanya melalui presensi kehadiran pelatihan, untuk memastikan bahwa investasi pelatihan benar-benar menghasilkan perubahan perilaku yang nyata dan berkelanjutan dalam praktik klinis.

d. Simulasi dan *Mock Survey*

Mock survey atau simulasi survei merupakan strategi persiapan yang sangat efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin terlewat dalam *gap analysis* berbasis dokumen, sekaligus membiasakan seluruh tenaga keperawatan dengan proses dan atmosfer survei akreditasi sehingga mereka dapat merespons pertanyaan dan observasi surveyor dengan tenang, percaya diri, dan berbasis fakta. *Mock survey* sebaiknya dilakukan oleh tim yang tidak terlibat langsung dalam unit yang disurvei, menggunakan metode dan instrumen yang semirip mungkin dengan proses survei yang sesungguhnya, termasuk observasi langsung praktik, telaah dokumen, wawancara dengan perawat dan pasien, serta penelusuran *tracer* pasien. Temuan *mock survey* harus ditindaklanjuti secara serius dengan rencana perbaikan yang konkret dan *timeline* yang jelas, menjadikan *mock survey* bukan sekadar latihan formalitas tetapi sebagai instrumen perbaikan yang genuinely bermakna.

e. Pemeliharaan Budaya Keselamatan

Persiapan akreditasi yang paling fundamental dan berkelanjutan adalah pembangunan budaya keselamatan yang kuat di mana setiap perawat secara intrinsik termotivasi untuk menjalankan standar terbaik bukan karena takut dinilai surveyor, melainkan karena memiliki komitmen yang tulus terhadap keselamatan pasien dan profesionalisme keperawatan. Budaya keselamatan yang kuat ditandai oleh keterbukaan dalam melaporkan insiden dan *near miss*, keberanian untuk mempertanyakan praktik yang tidak aman tanpa rasa takut akan sanksi, komitmen kolektif terhadap pembelajaran dari setiap kesalahan, dan kepemimpinan yang secara konsisten menjadi teladan dalam menerapkan standar keselamatan dalam setiap tindakan dan keputusannya. Institusi yang berhasil membangun budaya keselamatan yang kuat akan menghadapi survei akreditasi dengan lebih siap dan lebih percaya diri, karena standar yang dinilai oleh surveyor sesungguhnya adalah standar yang sudah menjadi cara kerja sehari-hari mereka (Hartati et al., 2024).

5. Peran perawat manajer dalam mempertahankan standar akreditasi

Mempertahankan standar akreditasi pasca survei merupakan tantangan yang secara umum diakui lebih sulit dari sekadar mencapai akreditasi itu sendiri, karena membutuhkan komitmen yang konsisten, sistem pemantauan yang efektif, dan kepemimpinan yang mampu menjaga motivasi tim dalam menerapkan standar secara berkelanjutan jauh setelah euforia keberhasilan akreditasi berlalu. Perawat manajer memegang peran yang paling kritis dalam mempertahankan standar ini karena posisinya sebagai penghubung antara kebijakan institusi di level atas dengan praktik klinis di garis terdepan, memiliki visibilitas langsung terhadap konsistensi implementasi standar dalam keseharian operasional unit yang dipimpinnya. Berikut adalah peran-peran utama perawat manajer dalam mempertahankan standar akreditasi secara berkelanjutan (Layli, 2022).

a. Pemantauan Indikator Mutu Secara Berkala

Perawat manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh indikator mutu keperawatan yang menjadi bagian dari persyaratan akreditasi dipantau secara konsisten, akurat, dan tepat waktu, serta bahwa data yang dikumpulkan dianalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perbaikan yang nyata. Pemantauan indikator tidak boleh hanya menjadi kegiatan pengumpulan data administratif yang dilakukan untuk keperluan pelaporan semata, melainkan harus menjadi alat manajemen aktif yang memungkinkan deteksi dini terhadap tren negatif sebelum berkembang

menjadi masalah yang signifikan. Perawat manajer harus mengomunikasikan data indikator secara transparan kepada seluruh anggota tim, menggunakan data tersebut dalam diskusi tim untuk mendorong refleksi kolektif, dan merayakan pencapaian yang baik sebagai bentuk pengakuan terhadap upaya tim yang telah berkontribusi pada hasil yang positif.

b. Supervisi Klinis yang Konsisten

Supervisi klinis yang dilakukan secara konsisten dan konstruktif oleh perawat manajer merupakan mekanisme pemeliharaan standar yang paling langsung dan efektif, karena memungkinkan observasi *real-time* terhadap kepatuhan praktik terhadap standar yang ditetapkan dan pemberian umpan balik yang segera dan relevan kepada perawat yang bersangkutan. Supervisi yang efektif bukan tentang mencari kesalahan untuk dihukum, melainkan tentang memberikan dukungan, bimbingan, dan penguatan positif yang mendorong perawat untuk terus meningkatkan kualitas praktiknya. Perawat manajer yang melakukan supervisi secara reguler dan konsisten akan membangun iklim di mana standar dipandang sebagai bagian dari identitas tim, bukan sebagai beban eksternal yang hanya relevan ketika ada surveyor yang mengamati.

c. Pengelolaan Temuan dan Tindak Lanjut

Setiap temuan yang dihasilkan dari audit internal, laporan insiden, atau hasil survei eksternal harus dikelola secara sistematis oleh perawat manajer melalui proses analisis akar masalah yang mendalam, perencanaan tindakan korektif yang spesifik dan terukur, implementasi perubahan yang direncanakan, serta verifikasi efektivitas perubahan tersebut dalam mengatasi akar masalah yang telah diidentifikasi. Perawat manajer harus memastikan bahwa tindak lanjut terhadap temuan tidak berhenti pada level pernyataan niat yang tertulis dalam dokumen rencana perbaikan, melainkan benar-benar dieksekusi secara nyata dan hasilnya dievaluasi secara objektif dalam *timeline* yang telah ditetapkan. Pola temuan yang berulang merupakan sinyal penting bahwa ada masalah sistemik yang lebih dalam yang perlu ditangani, bukan sekadar masalah individual yang dapat diselesaikan dengan memberikan peringatan kepada perawat yang bersangkutan.

d. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan

Perawat manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh anggota timnya memiliki kompetensi yang terus diperbarui sesuai dengan perkembangan standar, teknologi, dan pengetahuan klinis terkini, termasuk memastikan bahwa program orientasi bagi perawat baru mencakup seluruh elemen standar akreditasi yang relevan dengan unit mereka. Identifikasi

kebutuhan pengembangan kompetensi harus dilakukan secara proaktif melalui evaluasi kinerja, analisis insiden, dan pemantauan tren indikator mutu, sehingga program pelatihan yang dirancang benar-benar menjawab kesenjangan kompetensi yang nyata. Perawat manajer juga harus menciptakan iklim belajar yang mendorong perawat untuk secara aktif mencari pengetahuan baru, berbagi pembelajaran dari praktik, dan mengaplikasikan temuan penelitian terbaru dalam perbaikan praktik klinis mereka sehari-hari.

e. Advokasi Sumber Daya yang Memadai

Perawat manajer memiliki tanggung jawab untuk secara aktif mengadvokasi ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam hal jumlah dan kompetensi tenaga, kelengkapan fasilitas dan peralatan, maupun dukungan sistem informasi yang diperlukan untuk menjalankan standar akreditasi secara konsisten. Standar akreditasi tidak dapat dipertahankan dalam kondisi kekurangan tenaga yang kronis, peralatan yang tidak berfungsi, atau sistem informasi yang tidak mendukung dokumentasi yang akurat dan efisien. Advokasi yang efektif membutuhkan data yang kuat dan argumentasi yang berbasis bukti, sehingga perawat manajer harus memiliki kemampuan untuk menghubungkan secara eksplisit antara ketersediaan sumber daya dengan pencapaian indikator mutu dan keselamatan pasien, menjadikan argumen mereka tidak mudah diabaikan oleh pengambil keputusan di level yang lebih tinggi dalam hierarki institusi (Layli, 2022).

I. Koordinasi Lintas Profesi dan Kolaborasi Interprofesional

1. Konsep kolaborasi interprofesional (*Interprofessional Collaboration*/IPC)

Kolaborasi interprofesional atau *Interprofessional Collaboration* (IPC) merupakan proses di mana berbagai profesi kesehatan bekerja bersama secara setara, saling menghormati, dan saling melengkapi dalam memberikan layanan kesehatan yang komprehensif, aman, dan berpusat pada pasien melalui komunikasi yang terbuka, pengambilan keputusan bersama, dan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara seluruh anggota tim. IPC bukan sekadar kerja sama yang bersifat paralel di mana setiap profesi bekerja sendiri-sendiri dalam silo masing-masing kemudian hasilnya digabungkan, melainkan merupakan integrasi yang sesungguhnya di mana perspektif, pengetahuan, dan keahlian berbagai profesi melebur dalam satu proses pengambilan keputusan klinis yang menghasilkan solusi yang jauh lebih komprehensif daripada yang dapat dihasilkan oleh satu profesi manapun secara mandiri. *World Health Organization* (WHO) dalam kerangka *Framework for Action on Interprofessional*

Education and Collaborative Practice menegaskan bahwa IPC yang efektif merupakan salah satu strategi paling kuat yang tersedia bagi sistem kesehatan untuk mengatasi kompleksitas tantangan layanan modern, mengurangi kesalahan klinis, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, dan pada akhirnya menghasilkan luaran kesehatan yang lebih baik bagi populasi yang dilayani (Pasha Al-Ghani, 2025).

Dalam praktik keperawatan Indonesia, IPC memiliki relevansi yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kompleksitas kasus yang ditangani, tuntutan akreditasi yang mewajibkan implementasi layanan multidisiplin yang terstruktur, dan kebijakan JKN yang mendorong efisiensi melalui koordinasi layanan yang lebih baik. Keperawatan, sebagai profesi yang memiliki intensitas interaksi paling tinggi dengan pasien di antara semua profesi kesehatan, berada dalam posisi strategis yang unik dalam ekosistem IPC, yaitu sebagai penghubung utama yang mengintegrasikan informasi dari berbagai profesi, memastikan bahwa perspektif pasien terwakili dalam setiap keputusan klinis, dan menjaga kesinambungan koordinasi di antara anggota tim yang masing-masing memiliki jadwal interaksi yang lebih terbatas dengan pasien. Membangun kapasitas IPC yang kuat dalam organisasi keperawatan Indonesia bukan hanya tentang meningkatkan kualitas layanan klinis semata, tetapi juga tentang memperkuat posisi dan pengakuan profesional keperawatan dalam ekosistem layanan kesehatan yang selama ini masih sering didominasi oleh perspektif medis dalam pengambilan keputusan klinis yang sesungguhnya membutuhkan kontribusi setara dari semua profesi yang terlibat (Sillero & Buil, 2021).

2. Model *Interprofessional Education* (IPE) dan relevansinya

Interprofessional Education (IPE) merupakan pendekatan pendidikan kesehatan yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai profesi kesehatan untuk belajar bersama, belajar dari satu sama lain, dan belajar tentang satu sama lain dalam rangka membangun kompetensi kolaborasi yang akan mereka butuhkan dalam praktik profesional. Landasan filosofis IPE bertumpu pada keyakinan bahwa kolaborasi yang efektif dalam praktik klinis harus dimulai dari pembentukan sikap saling menghormati, pemahaman tentang peran masing-masing profesi, dan keterampilan komunikasi lintas profesi yang dibangun sejak masa pendidikan, jauh sebelum para calon tenaga kesehatan memasuki dunia kerja yang penuh dengan tekanan dan kompleksitas (Whitney et al., 2022). Poin-poin penting dalam model IPE dan relevansinya bagi keperawatan adalah sebagai berikut.

a. Kompetensi Inti IPE

Interprofessional Education Collaborative (IPEC) mengidentifikasi empat kompetensi inti yang harus dikuasai melalui IPE, yaitu nilai dan etika dalam praktik interprofesional, pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masing-masing profesi, komunikasi interprofesional yang efektif, dan kerja tim serta dinamika kelompok yang produktif. Keempat kompetensi ini saling terkait dan harus dikembangkan secara terintegrasi, bukan secara terpisah, karena efektivitas kolaborasi dalam praktik nyata bergantung pada penguasaan keseluruhan kompetensi secara simultan dalam situasi klinis yang kompleks dan dinamis.

b. Model Pembelajaran IPE

IPE dapat diimplementasikan melalui berbagai model pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks institusi pendidikan, mulai dari pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*) yang mempertemukan mahasiswa keperawatan dengan mahasiswa kedokteran, farmasi, dan gizi untuk membahas kasus klinis secara bersama, simulasi klinis interprofesional menggunakan *standardized patient* atau *mannequin* di laboratorium keterampilan, hingga praktik klinik interprofesional di mana mahasiswa dari berbagai profesi bertugas bersama dalam satu unit layanan di bawah supervisi pembimbing yang terlatih dalam fasilitasi IPE. Kunci keberhasilan setiap model adalah terciptanya pengalaman belajar yang autentik, di mana mahasiswa benar-benar harus berkolaborasi dan tidak sekadar bekerja berdampingan tanpa interaksi yang bermakna (Price et al., 2021).

c. Relevansi IPE bagi Pendidikan Keperawatan Indonesia

Dalam konteks pendidikan keperawatan Indonesia, IPE memiliki relevansi yang sangat besar namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang tidak kecil. Banyak institusi pendidikan kesehatan di Indonesia yang program keperawatan, kedokteran, dan farmasi-nya beroperasi secara terpisah dengan kurikulum yang tidak terintegrasi, sehingga lulusan yang dihasilkan seringkali memasuki dunia kerja tanpa pengalaman kolaborasi interprofesional yang memadai. Integrasi IPE dalam kurikulum keperawatan membutuhkan komitmen kelembagaan yang kuat, koordinasi intensif antar program studi, pengembangan kompetensi fasilitator yang terlatih secara khusus, serta penyediaan infrastruktur pembelajaran yang mendukung simulasi kolaborasi klinis yang realistis dan bermakna.

d. Dampak IPE terhadap Praktik Kolaborasi

Bukti penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa paparan IPE yang berkualitas selama masa pendidikan menghasilkan tenaga kesehatan yang lebih siap untuk berkolaborasi, lebih menghormati kontribusi profesi lain, lebih efektif dalam komunikasi lintas profesi, dan lebih mampu mengelola konflik yang tidak terhindarkan dalam dinamika tim multidisiplin. Perawat yang telah memiliki pengalaman IPE yang baik cenderung lebih percaya diri dalam mengekspresikan perspektif keperawatan dalam forum multidisiplin, lebih mampu membangun hubungan profesional yang setara dengan dokter dan profesi lain, serta lebih terampil dalam mengintegrasikan perspektif berbagai profesi menjadi rencana asuhan yang kohesif dan komprehensif bagi setiap pasien yang dilayaninya (Angelen Shirley et al., 2024).

3. Peran keperawatan dalam tim kesehatan multidisiplin

Keperawatan memiliki peran yang sangat strategis dan tidak tergantikan dalam tim kesehatan multidisiplin, sebuah peran yang tumbuh dari karakteristik unik profesi ini sebagai satu-satunya profesi yang memberikan layanan langsung kepada pasien secara terus-menerus selama dua puluh empat jam sehari, tujuh hari seminggu, sehingga memiliki pemahaman yang paling komprehensif dan terkini tentang kondisi, perkembangan, kebutuhan, dan preferensi setiap pasien yang menjadi tanggung jawab timnya. Posisi strategis ini memberikan keperawatan tanggung jawab moral yang besar untuk tidak hanya menjalankan fungsi koordinasi secara pasif, tetapi untuk menjadi penggerak aktif kolaborasi yang memastikan bahwa suara pasien didengar, informasi klinis yang relevan sampai kepada semua pihak yang membutuhkannya, dan rencana layanan multidisiplin diimplementasikan secara terintegrasi tanpa fragmentasi yang merugikan pasien. Peran-peran spesifik keperawatan dalam tim kesehatan multidisiplin adalah sebagai berikut (Al-Twigey & AL-Fayyadh, 2024).

a. Peran sebagai Koordinator Asuhan

Sebagai koordinator asuhan, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh elemen rencana layanan multidisiplin yang telah disepakati diimplementasikan secara terkoordinasi, terjadwal dengan baik, dan tidak saling bertabrakan atau menimbulkan beban yang berlebihan bagi pasien. Koordinasi ini mencakup pengaturan jadwal pemeriksaan dan tindakan dari berbagai profesi, pemantauan apakah seluruh rekomendasi dari konsultan telah ditindaklanjuti, serta identifikasi dan penyelesaian

hambatan yang muncul dalam implementasi rencana layanan yang telah ditetapkan bersama.

b. Peran sebagai Advokat Pasien

Sebagai advokat, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nilai-nilai, preferensi, kebutuhan, dan hak-hak pasien terwakili dan dihormati dalam setiap keputusan yang dibuat oleh tim multidisiplin, terutama dalam situasi di mana pasien tidak mampu mengekspresikan kebutuhannya sendiri secara langsung karena kondisi klinis atau hambatan komunikasi yang dimilikinya. Advokasi perawat bukan berarti menentang profesi lain, melainkan memastikan bahwa perspektif pasien sebagai penerima layanan selalu hadir sebagai pertimbangan yang setara dengan pertimbangan teknis medis dalam setiap proses pengambilan keputusan klinis.

c. Peran sebagai Komunikator Kunci

Perawat berfungsi sebagai komunikator kunci dalam tim multidisiplin karena posisinya sebagai titik kontak utama yang menghubungkan pasien dengan seluruh anggota tim, keluarga dengan institusi, dan anggota tim yang satu dengan yang lainnya. Kualitas komunikasi yang dilakukan perawat, baik dalam menyampaikan informasi klinis kepada dokter, memfasilitasi diskusi multidisiplin, menjelaskan rencana layanan kepada pasien dan keluarga, maupun dalam mendokumentasikan perkembangan klinis yang akurat, secara langsung menentukan efektivitas koordinasi tim dan keselamatan pasien secara keseluruhan.

d. Peran sebagai Pemantau Kondisi Klinis

Dengan kehadiran yang berkelanjutan di sisi pasien, perawat memegang peran yang tidak tergantikan sebagai pemantau kondisi klinis yang paling real-time dan komprehensif di antara semua anggota tim. Kemampuan perawat untuk mendeteksi perubahan kondisi klinis secara dini, menginterpretasikan temuan pemantauan dalam konteks riwayat dan rencana layanan pasien secara keseluruhan, dan mengambil tindakan awal yang tepat sambil segera menginformasikan anggota tim yang relevan merupakan kontribusi klinis yang seringkali menentukan perbedaan antara pencegahan komplikasi serius dan terjadinya krisis klinis yang dapat mengancam jiwa.

e. Peran sebagai Penghubung Lintas *Setting*

Dalam sistem layanan berjenjang yang mewajibkan transisi pasien dari satu *setting* ke *setting* lainnya, perawat berperan sebagai penghubung yang memastikan kesinambungan informasi dan koordinasi layanan selama

proses transisi berlangsung. Peran ini mencakup koordinasi rujukan yang komprehensif, penyusunan *resume* keperawatan yang informatif, komunikasi langsung dengan tenaga keperawatan di fasilitas penerima, serta edukasi pasien dan keluarga tentang layanan lanjutan yang akan diterima, sehingga setiap transisi layanan berlangsung secara mulus dan tidak menimbulkan kebingungan atau kesenjangan layanan yang membahayakan pasien (Doornebosch et al., 2024).

4. Mekanisme koordinasi antar unit dan antar profesi

Mekanisme koordinasi yang efektif merupakan infrastruktur operasional yang memungkinkan kolaborasi interprofesional terwujud bukan sekadar sebagai aspirasi konseptual, melainkan sebagai praktik nyata yang berlangsung secara konsisten dalam dinamika layanan kesehatan sehari-hari yang penuh dengan tekanan waktu, beban kerja, dan kompleksitas klinis yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya. Tanpa mekanisme koordinasi yang terstruktur dan disepakati bersama, bahkan tim yang terdiri dari individu-individu yang berkomitmen tinggi terhadap kolaborasi pun akan kesulitan untuk mewujudkan potensi kolektifnya karena tidak memiliki wadah dan saluran yang memungkinkan pengetahuan, perspektif, dan informasi dari berbagai profesi mengalir secara efisien ke titik-titik pengambilan keputusan yang membutuhkannya pada waktu yang tepat (Thrwi et al., 2024).

Ward round multidisiplin atau visite bersama merupakan salah satu mekanisme koordinasi paling kuat yang tersedia dalam sistem layanan rawat inap, karena mempertemukan seluruh anggota tim dalam satu momen terjadwal untuk secara kolektif meninjau kondisi pasien, mendiskusikan perkembangan klinis, menetapkan prioritas tindakan, dan menyepakati rencana layanan yang terkoordinasi untuk periode berikutnya. Efektivitas *ward round* multidisiplin sangat bergantung pada kualitas persiapan setiap anggota tim sebelum pertemuan, termasuk kesiapan perawat untuk menyampaikan informasi klinis pasien secara komprehensif dan sistematis, budaya diskusi yang setara di mana setiap profesi merasa bebas untuk mengekspresikan perspektifnya tanpa hirarki yang menghambat, serta mekanisme dokumentasi hasil diskusi yang akurat dan dapat diakses oleh seluruh anggota tim. Ketika *ward round* multidisiplin dilaksanakan dengan kualitas tinggi secara konsisten, dampaknya terhadap koordinasi layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan keselamatan pasien terbukti sangat signifikan, menjadikannya investasi waktu yang sangat layak meskipun dalam konteks beban kerja yang sudah padat (Prasitanarapun & Kitreerawutiwong, 2023).

Case conference merupakan mekanisme koordinasi yang lebih intensif dan terfokus yang digunakan untuk membahas kasus-kasus pasien dengan kompleksitas tinggi yang membutuhkan perspektif lintas profesi yang lebih mendalam daripada yang dapat diakomodasi dalam format *ward round* rutin. Dalam *case conference*, seluruh anggota tim yang relevan berkumpul untuk melakukan analisis komprehensif terhadap kondisi pasien, mengidentifikasi permasalahan yang belum terselesaikan, mengeksplorasi alternatif pendekatan terapeutik, dan menyepakati rencana koordinasi yang lebih terperinci dengan pembagian tanggung jawab yang jelas di antara masing-masing profesi. Keberhasilan *case conference* sangat bergantung pada keterampilan fasilitasi yang baik dari pemimpin pertemuan, yang harus mampu memastikan bahwa setiap profesi mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkontribusi, diskusi tetap fokus pada kepentingan terbaik pasien, dan hasil pertemuan terdokumentasi serta ditindaklanjuti secara konsisten oleh seluruh anggota tim (Fang Num, 2025).

Sistem komunikasi terstruktur yang mencakup protokol konsultasi yang jelas, mekanisme eskalasi yang terdefinisi dengan baik, dan platform informasi yang terintegrasi merupakan fondasi infrastruktur koordinasi yang memungkinkan kolaborasi interprofesional berjalan secara efisien bahkan di luar momen-momen pertemuan formal seperti *ward round* dan *case conference*. Protokol konsultasi yang jelas menentukan kapan dan bagaimana perawat harus mengkonsultasikan kondisi pasien kepada dokter atau profesi lain, termasuk standar informasi minimum yang harus disiapkan sebelum konsultasi dan waktu respons yang diharapkan dari pihak yang dikonsultasikan. Platform informasi terintegrasi, idealnya berupa rekam medis elektronik yang dapat diakses oleh seluruh anggota tim secara real-time, memungkinkan setiap profesi untuk mengikuti perkembangan kondisi pasien dan mengetahui tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh profesi lain, sehingga duplikasi tindakan dapat dihindari dan kesenjangan layanan dapat diidentifikasi sebelum berkembang menjadi masalah klinis yang serius bagi pasien (Thrwi et al., 2024).

5. Hambatan dan strategi penguatan kolaborasi di lapangan

Meskipun manfaat kolaborasi interprofesional telah terbukti secara ilmiah dan diakui secara universal, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, berlapis, dan berakar pada faktor-faktor struktural, kultural, maupun interpersonal yang tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan administratif semata. Pemahaman yang jujur dan mendalam tentang hambatan-hambatan ini merupakan prasyarat bagi

pengembangan strategi penguatan kolaborasi yang realistis dan efektif, karena solusi yang tidak mempertimbangkan akar masalah yang sesungguhnya hanya akan menghasilkan perubahan permukaan yang tidak bertahan lama dan tidak memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan. Hambatan utama dan strategi penguatannya adalah sebagai berikut (Suryani et al., 2020).

a. Hambatan Hierarki dan Dominasi Profesional

   Budaya hierarki yang menempatkan profesi medis secara dominan di atas profesi lain dalam pengambilan keputusan klinis merupakan salah satu hambatan paling persisten terhadap kolaborasi interprofesional yang setara di banyak fasilitas layanan kesehatan Indonesia. Hambatan ini seringkali tidak bersifat eksplisit dan disengaja, melainkan tertanam dalam norma-norma interaksi yang telah terbentuk selama puluhan tahun dan direproduksi secara tidak sadar melalui praktik komunikasi sehari-hari yang menempatkan perawat dan profesi lain dalam posisi sub-ordinat. Strategi untuk mengatasi hambatan ini mencakup program *interprofessional education* yang membangun rasa saling menghormati sejak masa pendidikan, kepemimpinan institusional yang secara eksplisit memodelkan kolaborasi setara, serta pembangunan forum-forum multidisiplin yang dirancang untuk memberikan ruang yang setara bagi kontribusi setiap profesi.

b. Hambatan Komunikasi dan Perbedaan Bahasa Profesional

   Setiap profesi kesehatan memiliki terminologi, kerangka konseptual, dan gaya komunikasi yang khas yang terbentuk melalui proses pendidikan dan sosialisasi profesional yang berbeda, sehingga komunikasi lintas profesi seringkali menghadapi hambatan berupa perbedaan bahasa yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, ketidaklengkapan informasi, dan bahkan konflik yang sesungguhnya bersumber dari masalah komunikasi bukan perbedaan penilaian klinis yang substansial. Strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan ini mencakup penggunaan alat komunikasi terstruktur seperti SBAR yang telah terbukti meningkatkan akurasi dan efisiensi komunikasi lintas profesi, pelatihan komunikasi interprofesional yang menjadi bagian reguler dari program pengembangan profesional, serta pembangunan budaya klarifikasi aktif di mana setiap anggota tim merasa nyaman untuk meminta penjelasan ketika informasi yang diterima tidak cukup jelas.

c. Hambatan Beban Kerja dan Keterbatasan Waktu

   Beban kerja yang tinggi dan keterbatasan waktu merupakan hambatan praktis yang seringkali dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan mekanisme koordinasi formal seperti *ward round* multidisiplin atau *case conference*

secara konsisten dan berkualitas. Ketika seluruh anggota tim berada di bawah tekanan beban kerja yang sangat berat, investasi waktu untuk berkoordinasi sering dipandang sebagai kemewahan yang tidak dapat diafforded, padahal justru dalam kondisi beban kerja yang tinggi itulah koordinasi yang baik paling dibutuhkan untuk mencegah kesalahan yang diakibatkan oleh fragmentasi informasi dan duplikasi atau kesenjangan tindakan. Strategi untuk mengatasi hambatan ini mencakup desain ulang proses koordinasi agar lebih efisien tanpa mengorbankan substansi, pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi koordinasi asinkron, serta advokasi untuk rasio tenaga yang memadai sebagai prasyarat struktural bagi kolaborasi yang berkualitas.

d. Hambatan Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung

Budaya organisasi yang tidak menghargai kolaborasi, tidak memberikan pengakuan terhadap kontribusi tim, dan tidak menyediakan infrastruktur yang mendukung praktik interprofesional merupakan hambatan sistemik yang tidak dapat diatasi melalui upaya individual semata. Ketika kolaborasi tidak didukung oleh kebijakan, sistem reward, dan keteladanan kepemimpinan yang konsisten, bahkan individu-individu yang berkomitmen tinggi terhadap kolaborasi pun akan kesulitan mempertahankan praktik tersebut dalam jangka panjang di tengah tekanan norma organisasi yang tidak mendukung. Strategi untuk mengatasi hambatan ini membutuhkan komitmen kepemimpinan puncak yang konsisten dalam memodelkan dan menghargai kolaborasi, integrasi kompetensi kolaborasi dalam sistem evaluasi kinerja seluruh tenaga kesehatan, serta pembangunan infrastruktur fisik dan sistem informasi yang secara aktif memfasilitasi interaksi lintas profesi dalam keseharian operasional layanan.

e. Strategi Penguatan Kolaborasi Berbasis Institusi

Penguatan kolaborasi interprofesional yang berkelanjutan membutuhkan strategi institusional yang komprehensif dan terencana, tidak sekadar inisiatif individual atau program pelatihan yang bersifat episodik tanpa tindak lanjut yang sistematis. Strategi yang terbukti efektif mencakup pembangunan tim interprofesional yang stabil dengan keanggotaan yang relatif konsisten sehingga anggota tim memiliki kesempatan untuk membangun kepercayaan dan pemahaman satu sama lain secara mendalam, penetapan indikator kinerja kolaborasi yang terukur dan dipantau secara berkala, pengembangan program *team building* interprofesional yang dirancang secara khusus untuk membangun kohesi dan kepercayaan antar profesi, serta penciptaan mekanisme umpan balik yang memungkinkan tim

untuk secara berkala merefleksikan efektivitas kolaborasi mereka dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan secara bersama-sama (Price et al., 2021).

J. Aktivitas 1 — *Knows How*

1. Mini-Case Tertulis (Diskusi Kelompok)

Rumah Sakit Umum Daerah "Sejahtera" merupakan rumah sakit tipe C milik pemerintah kabupaten yang melayani sekitar 150 pasien rawat inap per hari. Sejak diberlakukannya kebijakan JKN, jumlah kunjungan pasien meningkat signifikan hingga 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun penambahan jumlah tenaga keperawatan tidak sebanding dengan peningkatan beban kerja tersebut. Saat ini satu kepala ruangan membawahi 35 perawat pelaksana secara langsung tanpa ada lapisan ketua tim di antaranya.

Dalam tiga bulan terakhir, ditemukan beberapa permasalahan yang berulang di unit rawat inap, antara lain proses *handover* antar *shift* yang sering dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi terstruktur, beberapa pasien dipulangkan tanpa *discharge planning* yang memadai, dan terdapat dua insiden jatuh yang tidak dilaporkan secara resmi. Selain itu, koordinasi antara perawat dan tim dokter, apoteker, serta fisioterapis berjalan tidak optimal karena tidak ada jadwal *ward round* multidisiplin yang terstruktur. Komite keperawatan di rumah sakit ini secara formal telah terbentuk namun belum pernah menjalankan fungsi kredensial maupun audit klinis sejak dibentuk dua tahun lalu.

Kepala bidang keperawatan yang baru dilantik satu bulan lalu ingin melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem organisasi keperawatan di rumah sakit tersebut namun belum mengetahui dari mana harus memulai.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi prinsip-prinsip pengorganisasian keperawatan yang dilanggar dalam kasus tersebut dan jelaskan dampaknya terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien.
2. Analisis permasalahan yang terjadi dalam alur layanan keperawatan di rumah sakit tersebut, mulai dari *handover* hingga *discharge planning*, dan kaitkan dengan risiko nyata yang dihadapi pasien.
3. Jelaskan peran komite keperawatan yang seharusnya dijalankan untuk mengatasi permasalahan yang ada, dan langkah-langkah apa yang perlu segera diprioritaskan oleh komite tersebut.

4. Sebagai kepala bidang keperawatan yang baru, susunlah rekomendasi perbaikan organisasi yang mencakup aspek struktur, tata kelola, koordinasi interprofesional, dan kesinambungan layanan berdasarkan konsep yang telah dipelajari.

K. Aktivitas 2 — Shows How

1. Simulasi Analisis Organisasi Keperawatan (*Role Play* + Presentasi)

Aktivitas ini dirancang untuk melatih mahasiswa mendemonstrasikan kemampuan analisis organisasi keperawatan secara langsung melalui simulasi peran manajerial dan presentasi rekomendasi berbasis bukti. Mahasiswa tidak hanya diminta memahami konsep secara teoritis, tetapi menunjukkan bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam pengambilan keputusan manajerial yang nyata dan kontekstual.

Skenario Simulasi

Mahasiswa dibagi dalam kelompok yang masing-masing terdiri dari 4–5 orang. Setiap kelompok mendapatkan peran sebagai **Tim Konsultan Manajemen Keperawatan** yang diminta oleh direktur sebuah rumah sakit tipe C untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi perbaikan organisasi keperawatan.

Rumah sakit tersebut memiliki kondisi sebagai berikut:

a. Model asuhan keperawatan yang digunakan tidak jelas, sebagian unit menggunakan model tim namun sebagian berjalan secara fungsional tanpa koordinasi yang terstruktur
b. Proses *handover* tidak menggunakan metode terstandar sehingga sering terjadi kehilangan informasi klinis antar *shift*
c. Belum ada mekanisme *ward round* multidisiplin yang terjadwal secara rutin
d. *Discharge planning* tidak dimulai sejak hari pertama pasien masuk sehingga pasien sering dipulangkan secara mendadak tanpa persiapan yang memadai
e. Komite keperawatan belum menjalankan fungsi kredensial, audit klinis, dan pembinaan etika secara aktif
f. Perawat pelaksana tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait standar praktik dan kebijakan unit

Tugas Kelompok

Setiap kelompok diminta untuk melakukan hal-hal berikut secara berurutan dalam simulasi.

Tahap 1 — Analisis Situasi Lakukan *gap analysis* terhadap kondisi rumah sakit tersebut dibandingkan dengan standar organisasi keperawatan yang ideal berdasarkan materi Bab 2. Identifikasi minimal lima kesenjangan utama yang paling kritis dan urutkan berdasarkan prioritas risiko terhadap keselamatan pasien.

Tahap 2 — Simulasi Peran Setiap anggota kelompok mengambil salah satu peran berikut dan mendiskusikan perspektif serta rekomendasi dari sudut pandang perannya masing-masing.

a. Kepala Bidang Keperawatan
b. Kepala Ruangan
c. Ketua Komite Keperawatan
d. Perawat Pelaksana Senior
e. *Case Manager*

Tahap 3 — Penyusunan Rekomendasi Berdasarkan diskusi peran, kelompok menyusun rekomendasi perbaikan yang mencakup aspek struktur organisasi, model asuhan yang direkomendasikan, mekanisme *handover* dan koordinasi, penguatan fungsi komite keperawatan, serta strategi implementasi *shared governance*.

Tahap 4 — Presentasi Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis dan rekomendasi di hadapan kelompok lain selama 10–15 menit, diikuti sesi tanya jawab dan umpan balik dari fasilitator.

2. Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows	Latihan soal pilihan ganda dan definisi konsep organisasi keperawatan
Knows How	*Self-check* + analisis mini-*case* tertulis secara individual
Shows How	Simulasi peran manajerial + presentasi rekomendasi kelompok

3. OSCE Ringkas Manajemen Keperawatan

***Critical Items* (WAJIB LULUS)**

a. Kemampuan mengidentifikasi pelanggaran prinsip pengorganisasian dalam skenario yang diberikan
b. Kemampuan melakukan *gap analysis* antara kondisi organisasi aktual dengan standar yang berlaku

c. Kemampuan merumuskan rekomendasi perbaikan yang logis, terstruktur, dan berbasis bukti
d. Kemampuan mendemonstrasikan komunikasi profesional dalam simulasi koordinasi dan eskalasi masalah manajerial
e. Kemampuan mengidentifikasi *red flags* organisasi yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan menentukan tindakan eskalasi yang tepat

4. Cuplikan Rubrik Penilaian

Kriteria	**4**	**3**	**2**	**1**
Ketepatan analisis organisasi	Analisis sangat tepat, komprehensif, dan berbasis bukti	Analisis tepat dengan kesalahan minor	Analisis cukup namun kurang mendalam	Analisis keliru atau tidak relevan
Kemampuan *gap analysis*	Kesenjangan teridentifikasi secara akurat, lengkap, dan diprioritaskan berdasarkan risiko	Kesenjangan teridentifikasi dengan beberapa kekeliruan minor	Kesenjangan sebagian teridentifikasi, prioritas kurang konsisten	Kesenjangan tidak teridentifikasi atau tidak sesuai standar
Kualitas rekomendasi	Rekomendasi sangat logis, terstruktur, realistis, dan dapat diimplementasikan	Rekomendasi logis dengan beberapa aspek yang kurang rinci	Rekomendasi cukup namun kurang realistis atau tidak lengkap	Rekomendasi tidak relevan atau tidak berdasarkan konsep yang dipelajari
Identifikasi *red flags*	Seluruh *red flags* teridentifikasi dengan tepat beserta tindakan eskalasi yang benar	*Red flags* sebagian besar teridentifikasi dengan eskalasi yang cukup tepat	Beberapa *red flags* teridentifikasi namun eskalasi kurang tepat	*Red flags* tidak teridentifikasi atau tindakan eskalasi keliru

Komunikasi dan presentasi	Sangat komunikatif, sistematis, percaya diri, dan mampu menjawab pertanyaan dengan tepat	Komunikatif dan sistematis dengan beberapa kelemahan minor	Cukup komunikatif namun kurang sistematis atau kurang percaya diri	Komunikasi tidak jelas, tidak terstruktur, atau tidak profesional
Kolaborasi dan dinamika tim	Seluruh anggota berkontribusi aktif, peran terdistribusi merata, dan diskusi berjalan produktif	Sebagian besar anggota berkontribusi dengan distribusi peran yang cukup merata	Kontribusi tidak merata, beberapa anggota pasif dalam diskusi	Diskusi tidak berjalan, dominasi satu anggota, atau tidak ada kolaborasi nyata

Catatan Penting:

Nilai tinggi pada aspek lain tidak dapat menutupi kegagalan pada *critical items*. Mahasiswa yang tidak mampu mengidentifikasi *red flags* keselamatan pasien dan melakukan eskalasi yang tepat dinyatakan **belum lulus** pada station ini meskipun nilai aspek lainnya tinggi, karena kompetensi tersebut merupakan fondasi keselamatan yang tidak dapat dikompromikan dalam praktik manajerial keperawatan.

5. Template Soal OSCE Manajemen Keperawatan

No	Komponen	Isi
1	Nomor station	…… (Dikosongkan)
2	Judul station	Analisis Organisasi Pelayanan Keperawatan dan Tata Kelola Layanan Kesehatan
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam menganalisis struktur organisasi keperawatan, mengidentifikasi kesenjangan tata kelola, merumuskan rekomendasi perbaikan berbasis standar, serta mendemonstrasikan

		kemampuan komunikasi manajerial dan eskalasi masalah secara profesional.
5	Kompetensi	6. Analisis organisasi dan tata kelola keperawatan 7. Identifikasi *red flags* manajerial dan keselamatan pasien 8. Pengambilan keputusan manajerial berbasis bukti 9. Komunikasi profesional dan eskalasi masalah 10. Kolaborasi interprofesional 6. Perilaku profesional
6	Kategori	5. Organisasi dan manajemen keperawatan 6. Keselamatan pasien 7. Tata kelola klinis 8. Koordinasi dan kolaborasi layanan 9. Kesinambungan pelayanan
7	Instruksi untuk peserta ujian	**SKENARIO KLINIK:** Anda adalah seorang perawat yang baru dilantik sebagai kepala ruangan di Ruang Mawar, sebuah unit rawat inap penyakit dalam di RSUD tipe C. Setelah satu minggu bertugas, Anda menemukan sejumlah permasalahan di unit tersebut. Satu kepala ruangan sebelumnya membawahi 30 perawat tanpa struktur ketua tim, proses *handover* dilakukan secara lisan tanpa metode terstandar, tiga pasien dalam sebulan terakhir mengalami insiden jatuh namun tidak ada satupun yang dilaporkan secara resmi, *discharge planning* tidak pernah dimulai sejak hari pertama pasien masuk, dan koordinasi dengan dokter serta apoteker berjalan sangat tidak terstruktur. Anda diminta oleh kepala bidang keperawatan untuk menyampaikan analisis situasi dan rencana perbaikan secara langsung. **TUGAS:** 1. Lakukan analisis terhadap permasalahan organisasi keperawatan yang ditemukan di unit tersebut berdasarkan prinsip pengorganisasian yang berlaku. 2. Identifikasi minimal tiga *red flags* keselamatan pasien yang ditemukan dalam skenario dan jelaskan tindakan eskalasi yang harus dilakukan. 3. Tuliskan pada lembar jawab rekomendasi perbaikan yang mencakup struktur organisasi, mekanisme

handover, sistem pelaporan insiden, dan *discharge planning*.

4. Demonstrasikan komunikasi manajerial kepada penguji yang berperan sebagai kepala bidang keperawatan, menyampaikan temuan dan rekomendasi secara profesional dan terstruktur.

8 Instruksi untuk penguji

SKENARIO KLINIK:

Sama dengan skenario pada instruksi peserta ujian.

INSTRUKSI PENGUJI:

1. Menilai ketepatan peserta dalam mengidentifikasi pelanggaran prinsip pengorganisasian, mencakup *span of control* yang terlalu lebar, tidak adanya struktur ketua tim, dan tidak berjalannya prinsip akuntabilitas.
2. Menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi *red flags* keselamatan pasien secara tepat, yaitu insiden jatuh yang tidak dilaporkan, *handover* yang tidak terstandar, dan tidak adanya *discharge planning*, disertai tindakan eskalasi yang benar.
3. Menilai kualitas rekomendasi tertulis peserta, yang seharusnya mencakup pembentukan struktur ketua tim, penerapan metode SBAR dalam *handover*, pengaktifan sistem pelaporan insiden yang *blame-free*, dan inisiasi *discharge planning* sejak hari pertama.
4. Menilai kemampuan komunikasi manajerial peserta dalam menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada kepala bidang keperawatan secara sistematis, percaya diri, berbasis bukti, dan dengan bahasa profesional yang tepat.
5. Penguji berperan sebagai kepala bidang keperawatan yang mendengarkan pemaparan peserta dan dapat memberikan satu pertanyaan klarifikasi di akhir presentasi peserta.
6. Penguji tidak diperbolehkan menginterupsi peserta selama pemaparan berlangsung kecuali waktu telah habis.

		7. Monitor perilaku profesional peserta selama seluruh durasi station.
9	Instruksi untuk klien standar	1. Penguji berperan sebagai kepala bidang keperawatan, bukan sebagai pasien, sehingga tidak ada klien standar dalam station ini. 2. Penguji duduk di meja yang mencerminkan posisi atasan, bersikap netral dan profesional selama peserta memaparkan temuannya. 3. Setelah peserta selesai memaparkan seluruh tugasnya, penguji mengajukan satu pertanyaan klarifikasi, misalnya: *"Dari seluruh rekomendasi yang Anda sampaikan, mana yang paling mendesak untuk diimplementasikan terlebih dahulu dan mengapa?"* 4. Penguji menilai respons peserta terhadap pertanyaan klarifikasi berdasarkan ketepatan argumentasi dan kemampuan penetapan prioritas berbasis risiko.
10	*Setting* station	**Ruang Simulasi Manajerial** - Meja dan kursi kepala ruangan - Meja penguji yang berperan sebagai kepala bidang keperawatan - Lembar jawaban peserta - Laboran **Tata letak ruang:** **5.** Meja peserta dengan lembar jawaban dan alat tulis **6.** Meja penguji menghadap peserta **7.** Pintu masuk **8.** Jam dinding yang terlihat oleh peserta **9.** *Whiteboard* atau papan tulis kecil apabila diperlukan peserta untuk menggambarkan struktur organisasi **10.** Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	**Peralatan:** 1. Lembar jawaban peserta 2. Alat tulis 3. Lembar skenario yang dapat dibaca peserta 4. *Checklist* penilaian untuk penguji 5. Jam atau *timer* 6. *Whiteboard* kecil dan spidol apabila diperlukan

		Peran laboran: Memastikan lembar jawaban baru tersedia untuk setiap peserta, mengumpulkan lembar jawaban setelah station selesai, dan memastikan seluruh perlengkapan station siap sebelum peserta berikutnya masuk.
12	Penulis	....
13	Referensi	Huber, D. L. (2022). *Leadership and nursing care management* (7th ed.). Elsevier. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI. Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application* (10th ed.). Wolters Kluwer. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit. Sullivan, E. J. (2022). *Effective leadership and management in nursing* (9th ed.). Pearson. Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (1st ed.). DPP PPNI.

6. SOP Analisis Organisasi Keperawatan dan Komunikasi Manajerial

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan		Kompeten	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
A	**Tahap Pra Interaksi**				
1	Mengecek data organisasi unit keperawatan yang akan dianalisis, termasuk struktur organisasi, jumlah tenaga, dan laporan kinerja yang tersedia				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Lembar *gap analysis* b. Lembar rekomendasi tertulis c. Alat tulis d. *Checklist red flags* manajerial e. Panduan standar organisasi keperawatan yang berlaku				
3	Melakukan kebersihan tangan sebelum memulai kegiatan				
B	**Tahap Orientasi**				
4	Menyampaikan salam profesional kepada kepala bidang keperawatan atau pimpinan yang menerima laporan				
5	Menyampaikan nama, peran, dan tujuan pertemuan secara jelas dan singkat				
6	Mengkonfirmasi kontrak waktu dan mekanisme penyampaian laporan yang disepakati				
7	Menyampaikan garis besar topik yang akan dipaparkan agar pimpinan memiliki gambaran keseluruhan sebelum pemaparan dimulai				
8	Memberi kesempatan kepada pimpinan untuk menyampaikan pertanyaan atau ekspektasi sebelum pemaparan dimulai				
9	Memulai pemaparan dengan sikap profesional, tenang, dan percaya diri				
10	Menjaga suasana diskusi yang kondusif, saling menghormati, dan berorientasi pada solusi				
C	**Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)**				

11 Memaparkan temuan analisis struktur organisasi keperawatan secara sistematis menggunakan data yang objektif dan relevan
12 Mengidentifikasi dan menjelaskan pelanggaran prinsip *span of control* yang ditemukan beserta dampaknya terhadap efektivitas supervisi
13 Mengidentifikasi dan menjelaskan pelanggaran prinsip kesatuan komando yang ditemukan beserta dampaknya terhadap kejelasan peran dan tanggung jawab
14 Mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan dalam proses *handover* yang tidak terstandar beserta risiko klinis yang ditimbulkannya
15 Mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan dalam pelaksanaan *discharge planning* beserta potensi dampaknya terhadap kesinambungan layanan pasca rawat
16 Mengidentifikasi minimal tiga *red flags* keselamatan pasien yang ditemukan dalam skenario secara tepat dan lengkap
17 Menjelaskan tindakan eskalasi yang tepat untuk setiap *red flag* yang diidentifikasi berdasarkan jalur *chain of command* yang berlaku
18 Melakukan *gap analysis* antara kondisi organisasi aktual dengan standar organisasi keperawatan yang seharusnya diterapkan secara terstruktur
19 Merumuskan rekomendasi perbaikan struktur organisasi yang logis, realistis, dan dapat diimplementasikan berdasarkan kondisi yang ada
20 Merumuskan rekomendasi perbaikan mekanisme *handover* menggunakan metode SBAR yang terstandar dan berbasis bukti

21 Merumuskan rekomendasi pengaktifan sistem pelaporan insiden yang *blame-free* beserta mekanisme *root cause analysis* yang terstruktur

22 Merumuskan rekomendasi perbaikan *discharge planning* yang dimulai sejak hari pertama pasien masuk dan terkoordinasi dengan tim multidisiplin

23 Merumuskan rekomendasi penguatan koordinasi interprofesional melalui *ward round* multidisiplin yang terjadwal dan terstruktur

24 Merumuskan rekomendasi pengaktifan fungsi komite keperawatan dalam kredensial, audit klinis, dan pembinaan etika profesi

25 Memprioritaskan rekomendasi berdasarkan tingkat risiko terhadap keselamatan pasien dengan argumentasi yang jelas dan berbasis bukti

26 Meminta konfirmasi pemahaman pimpinan terhadap temuan dan rekomendasi yang telah disampaikan

27 Menjawab pertanyaan klarifikasi dari pimpinan dengan tepat, sistematis, dan percaya diri

28 Merapikan seluruh dokumen dan lembar kerja yang digunakan selama pemaparan berlangsung

D Tahap Terminasi

29 Menyimpulkan seluruh temuan analisis dan rekomendasi secara ringkas dan sistematis di akhir pemaparan

30 Mengevaluasi respons pimpinan secara subjektif dan objektif terhadap pemaparan yang telah disampaikan

31 Memberikan apresiasi terhadap kesempatan yang diberikan dan komitmen untuk menindaklanjuti arahan pimpinan

32 Membuat kontrak tindak lanjut yang mencakup waktu implementasi rekomendasi

dan mekanisme pelaporan perkembangan yang disepakati

33 Mengakhiri pertemuan dengan sikap profesional, sopan, dan menunjukkan komitmen terhadap perbaikan organisasi

E Tahap Dokumentasi

34 Mencatat hari, tanggal, jam, hasil analisis organisasi, rekomendasi yang telah disampaikan, respons pimpinan, keputusan yang disepakati, serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan

F Penampilan Profesional

35 Aman, sistematis, berbasis bukti, komunikatif, responsif terhadap pertanyaan, menjaga sikap profesional selama seluruh durasi kegiatan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik pasien serta organisasi

L. Form Penilaian Osce Keperawatan

Station: Analisis Organisasi Pelayanan Keperawatan dan Tata Kelola Layanan Kesehatan

1. Form Penilaian

No	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1	Analisis Organisasi Keperawatan	Mengidentifikasi pelanggaran prinsip pengorganisasian (*span of control*, kesatuan komando, akuntabilitas) secara tepat dan lengkap berdasarkan skenario					2	
2	Identifikasi *Red Flags* dan Eskalasi	Mengidentifikasi minimal tiga *red flags* keselamatan pasien dan menentukan tindakan eskalasi yang tepat sesuai jalur *chain of command*					2	

3	*Gap Analysis* dan Rekomendasi Tertulis	Melakukan *gap analysis* yang akurat dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang logis, terstruktur, berbasis bukti, dan diprioritaskan berdasarkan risiko	3
4	Komunikasi Manajerial	Memaparkan temuan dan rekomendasi kepada pimpinan secara sistematis, percaya diri, profesional, dan mampu menjawab pertanyaan klarifikasi dengan tepat	2
5	Perilaku Profesional	Komunikasi profesional, sistematis, berbasis bukti, responsif, menjaga sikap etis, dan berorientasi pada keselamatan pasien serta kepentingan terbaik organisasi	1
	Jumlah		**10**

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat atau tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

M. Rubrik Penilaian Osce Keperawatan

STATION: ANALISIS ORGANISASI PELAYANAN KEPERAWATAN DAN TATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN

1. Rubrik

Kompetensi	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1. Analisis Organisasi Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam mengidentifikasi pelanggaran prinsip pengorganisasian yang terdapat dalam skenario, mencakup *span of control* yang tidak proporsional, tidak adanya struktur ketua tim, lemahnya akuntabilitas, dan tidak berjalannya prinsip koordinasi dalam unit layanan.					2	
2. Identifikasi *Red Flags* dan Eskalasi Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam mengenali *red flags* keselamatan pasien yang terdapat dalam skenario secara tepat dan lengkap, serta menentukan tindakan eskalasi yang sesuai berdasarkan jalur *chain of command* dan prinsip keselamatan pasien yang berlaku.					2	
3. *Gap Analysis* dan Rekomendasi Tertulis Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam melakukan *gap analysis* antara kondisi organisasi aktual dengan standar yang seharusnya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang mencakup struktur organisasi, mekanisme *handover*, sistem pelaporan insiden, *discharge planning*, koordinasi interprofesional, dan penguatan fungsi komite keperawatan.					3	
4. Komunikasi Manajerial Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menyampaikan temuan analisis dan rekomendasi kepada kepala bidang keperawatan secara sistematis, percaya diri, dan profesional, termasuk					2	

kemampuan menjawab pertanyaan klarifikasi dengan argumentasi yang tepat dan berbasis bukti.	
5. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan profesionalisme selama seluruh durasi station, meliputi cara berkomunikasi yang etis dan menghormati, sikap yang tenang dan percaya diri, ketepatan dalam memprioritaskan rekomendasi berbasis risiko, serta konsistensi orientasi pada keselamatan pasien dan kepentingan terbaik organisasi.	1

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

Kompetensi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3
1. Analisis Organisasi Keperawatan	Tidak melakukan analisis organisasi, atau analisis yang disampaikan tidak relevan dengan prinsip pengorganisasian keperawatan yang berlaku	Melakukan analisis sangat terbatas, hanya mengidentifikasi satu permasalahan tanpa penjelasan yang memadai tentang dampaknya terhadap mutu layanan	Mengidentifikasi sebagian besar permasalahan organisasi dengan cukup tepat, namun penjelasan tentang dampak terhadap keselamatan pasien masih kurang mendalam atau kurang lengkap	Mengidentifikasi seluruh pelanggaran prinsip pengorganisasian secara tepat dan lengkap, menjelaskan dampaknya terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien dengan argumentasi yang kuat dan berbasis bukti
2. Identifikasi *Red Flags* dan Eskalasi	Tidak mampu mengidentifikasi *red flags* keselamatan	Mengidentifikasi satu *red flag* dengan kurang tepat,	Mengidentifikasi dua hingga tiga *red flags*	Mengidentifikasi minimal tiga *red flags* secara tepat

	pasien, atau *red flags* yang disebutkan tidak relevan dengan skenario yang diberikan	atau tindakan eskalasi yang diusulkan tidak sesuai dengan jalur *chain of command* yang berlaku	dengan cukup tepat, namun tindakan eskalasi yang diusulkan masih kurang lengkap atau kurang spesifik terhadap situasi yang ada	dan lengkap, disertai tindakan eskalasi yang spesifik, tepat sasaran, dan sesuai jalur *chain of command* yang berlaku
3. *Gap Analysis* dan Rekomendasi Tertulis	Tidak melakukan *gap analysis*, atau rekomendasi yang dirumuskan tidak relevan dengan permasalahan organisasi yang ditemukan dalam skenario	Melakukan *gap analysis* yang sangat terbatas, rekomendasi hanya mencakup satu aspek organisasi dan tidak diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko yang ada	Melakukan *gap analysis* yang cukup baik dan merumuskan rekomendasi yang mencakup sebagian besar aspek organisasi, namun prioritisasi masih kurang tajam atau dasar bukti yang digunakan kurang kuat	Melakukan *gap analysis* yang akurat dan komprehensif, merumuskan rekomendasi yang mencakup seluruh aspek organisasi yang bermasalah, diprioritaskan secara tepat berdasarkan risiko, dan didukung argumentasi berbasis bukti yang kuat

4. Komunikasi Manajerial	Tidak mampu memaparkan temuan dan rekomendasi, atau pemaparan tidak relevan dengan skenario dan tidak dapat dipahami oleh pimpinan	Memaparkan temuan secara tidak sistematis, kurang percaya diri, dan tidak mampu menjawab pertanyaan klarifikasi dengan argumentasi yang memadai	Memaparkan temuan dan rekomendasi dengan cukup sistematis dan cukup percaya diri, namun masih ada kekurangan dalam kejelasan argumentasi atau ketepatan menjawab pertanyaan klarifikasi	Memaparkan temuan dan rekomendasi secara sangat sistematis, percaya diri, dan profesional, disertai kemampuan menjawab pertanyaan klarifikasi dengan argumentasi yang tepat, jelas, dan berbasis bukti
5. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, bersikap tidak etis, tidak menghormati pimpinan, dan tidak berorientasi pada keselamatan pasien selama kegiatan berlangsung	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, namun komunikasi kurang etis, kurang sistematis, atau tidak konsisten berorientasi pada keselamatan pasien dan kepentingan organisasi	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi cukup etis dan sistematis, namun masih ada kekurangan dalam konsistensi sikap atau ketajaman orientasi pada	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten dan menyeluruh, komunikasi etis dan menghormati, sistematis, percaya diri, responsif, dan secara konsisten berorientasi pada keselamatan pasien serta

	keselamatan pasien	kepentingan terbaik organisasi

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan atau seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian.

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

N. DOPS (*Does*)

DOPS di Lahan Praktik

1. Observasi langsung pada pelaksanaan analisis organisasi keperawatan, komunikasi manajerial, dan koordinasi layanan di fasilitas kesehatan nyata
2. *Checklist* + umpan balik singkat
3. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Contoh Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS) pada Organisasi Pelayanan Keperawatan dan Sistem Layanan Kesehatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Organisasi Pelayanan Keperawatan
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa manajerial mahasiswa dalam situasi nyata di lahan praktik, berfokus pada kemampuan menganalisis organisasi, mengidentifikasi masalah tata kelola, dan mengkomunikasikan rekomendasi secara profesional.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa menganalisis kondisi organisasi keperawatan di unit tempat praktik, mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar yang berlaku, dan menyampaikan temuannya kepada pembimbing klinik atau kepala ruangan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pemahaman konseptual tentang organisasi keperawatan dengan kemampuan analisis situasional, identifikasi *red flags*, pengambilan keputusan manajerial, komunikasi profesional, dan perilaku yang berorientasi pada keselamatan pasien dalam konteks nyata.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang prinsip pengorganisasian dan tata kelola, tetapi juga dari kemampuannya mengidentifikasi permasalahan nyata di unit, menyusun rekomendasi yang realistis, dan mengkomunikasikannya kepada pembimbing secara sistematis dan berbasis bukti.

Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi manajerial nyata yang ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan pada tahap profesi.	Mahasiswa ditempatkan di unit rawat inap yang memiliki permasalahan nyata dalam koordinasi tim, pelaksanaan *handover*, atau *discharge planning*, dan diminta untuk menganalisis kondisi tersebut secara langsung selama periode praktik berlangsung.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan observasi dan analisis organisasi secara utuh, dimulai dari pengumpulan data kondisi unit, identifikasi kesenjangan, perumusan rekomendasi, hingga penyampaian temuan kepada pembimbing klinik atau kepala ruangan secara langsung.	Mahasiswa mengobservasi pelaksanaan *handover* antar *shift*, mengamati mekanisme koordinasi antara perawat dan profesi lain, mengidentifikasi apakah *discharge planning* dimulai sejak hari pertama, menilai kesesuaian *span of control* yang ada, lalu menyusun dan memaparkan analisis temuannya secara terstruktur kepada pembimbing.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi kemampuan analisis organisasi, identifikasi *red flags* keselamatan pasien, kualitas *gap analysis*, ketepatan rekomendasi yang dirumuskan, komunikasi manajerial yang profesional, kolaborasi interprofesional, dan konsistensi perilaku profesional selama kegiatan berlangsung.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan *span of control* yang tidak proporsional, mengenali *handover* yang tidak terstandar sebagai *red flag*, memahami pentingnya *discharge planning* sejak hari pertama, serta menyampaikan rekomendasi yang logis dengan argumentasi berbasis bukti.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa manajerial mahasiswa secara langsung	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan temuan di lapangan dengan prinsip-prinsip

	menggunakan format DOPS yang terstruktur, berfokus pada ketajaman analisis, ketepatan identifikasi masalah, dan kualitas komunikasi profesional yang ditunjukkan.	organisasi keperawatan yang telah dipelajari, mampu memprioritaskan rekomendasi berdasarkan tingkat risiko terhadap keselamatan pasien, dan mampu menyampaikan temuannya dengan cara yang konstruktif dan menghormati semua pihak yang terlibat.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi manajerial mahasiswa di lahan praktik secara nyata.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengidentifikasi permasalahan *handover* dan menyusun rekomendasi yang realistis, namun masih perlu meningkatkan kemampuan memprioritaskan rekomendasi berdasarkan risiko dan memperkuat argumentasi berbasis bukti dalam komunikasi manajerial yang dilakukannya.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat performa manajerial mahasiswa dalam praktik klinik nyata berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan.	Mahasiswa dinyatakan **kompeten** apabila mampu melakukan analisis organisasi secara runtut, mengidentifikasi *red flags* dengan tepat, merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti, dan mengkomunikasikannya secara profesional. Mahasiswa dinyatakan **perlu supervisi** apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa aspek analisis atau komunikasi. Mahasiswa dinyatakan **remedial** apabila belum mampu mengidentifikasi permasalahan organisasi secara memadai atau rekomendasi yang dirumuskan

		tidak relevan dengan kondisi nyata yang ditemukan.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level *does* dalam konteks manajerial keperawatan yang nyata dan tidak tersimulasi.	Pada materi organisasi pelayanan keperawatan dan sistem layanan kesehatan, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori tata kelola dan prinsip pengorganisasian, tetapi mampu menerapkan kompetensi manajerial secara langsung, aman, tepat, sistematis, dan profesional di lahan praktik yang sesungguhnya.

O. Portofolio

Bukti yang Dikumpulkan

1. OSCE + DOPS
2. Catatan kasus singkat organisasi keperawatan
3. Refleksi *patient safety* berbasis manajerial
4. *Feedback* CI/dosen pembimbing

Tabel. Portofolio pada Organisasi Pelayanan Keperawatan dan Sistem Layanan Kesehatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Organisasi Pelayanan Keperawatan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada materi organisasi pelayanan keperawatan, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu menganalisis struktur organisasi, mengidentifikasi kesenjangan tata kelola, merumuskan rekomendasi perbaikan, dan mendemonstrasikan komunikasi manajerial yang profesional secara konsisten sepanjang masa praktik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah

	belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik berlangsung.	menganalisis organisasi keperawatan di satu unit, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuan analisis dan komunikasi manajerialnya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti kompetensi terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik secara bersamaan.	OSCE memuat hasil ujian simulasi analisis organisasi dan komunikasi manajerial, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa menganalisis kondisi unit, mengidentifikasi *red flags*, dan menyampaikan rekomendasi kepada kepala ruangan di fasilitas kesehatan nyata.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan situasi organisasi yang ditemukan mahasiswa di lahan praktik, permasalahan yang diidentifikasi, rekomendasi yang dirumuskan, dan hasil tindak lanjut yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan analisis unit rawat inap tempat praktik, mencakup permasalahan *handover* yang tidak terstandar, ketidaksesuaian *span of control*, lemahnya koordinasi interprofesional, rekomendasi yang disampaikan, dan respons kepala ruangan terhadap temuan tersebut.
Refleksi *patient safety*	Refleksi *patient safety* menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien yang bersumber dari kelemahan organisasi, menganalisis dampaknya, dan menyusun langkah pencegahan yang konkret dan berbasis bukti.	Mahasiswa merefleksikan bagaimana *handover* yang tidak terstandar di unit praktiknya berpotensi menyebabkan kehilangan informasi klinis kritis, serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencegah terjadinya insiden akibat kelemahan koordinasi dan tata kelola yang ditemukan.

Feedback CI/dosen	Umpan balik dari *Clinical Instructor* (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan dalam kompetensi manajerial mahasiswa.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengidentifikasi permasalahan *handover* dan menyusun rekomendasi yang realistis, namun masih perlu meningkatkan kemampuan memprioritaskan rekomendasi berdasarkan risiko dan memperkuat argumentasi berbasis bukti saat berkomunikasi dengan pimpinan.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan dengan penekanan utama pada konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu pengalaman analisis organisasi, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan konsistensi dalam menganalisis tata kelola, mengidentifikasi *red flags*, dan mengkomunikasikan rekomendasi secara profesional di berbagai konteks layanan.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa manajerial pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda-beda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan *gap analysis* organisasi, mengidentifikasi *red flags* keselamatan pasien, dan merumuskan rekomendasi yang berbasis bukti dengan kualitas yang terjaga dari satu penugasan ke penugasan berikutnya.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam	Pada materi organisasi pelayanan keperawatan, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep tata kelola dan prinsip pengorganisasian, tetapi secara

	performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi secara sistematis.	konsisten mampu menerapkan kompetensi manajerial tersebut dalam konteks praktik klinik yang nyata dan beragam.

Tabel *Case Report* pada Organisasi Pelayanan Keperawatan dan Sistem Layanan Kesehatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Organisasi Pelayanan Keperawatan
Hakikat *case report*	*Case report* merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu situasi manajerial nyata yang dianalisis mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, *case report* berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan permasalahan organisasi secara ilmiah dan kontekstual.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang permasalahan organisasi keperawatan yang ditemukan di unit praktik, misalnya ketidaksesuaian *span of control*, tidak berjalannya mekanisme *handover* yang terstandar, atau lemahnya koordinasi interprofesional yang berdampak nyata pada kesinambungan layanan pasien.
Tujuan	*Case report* bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data analisis organisasi, identifikasi kesenjangan, perumusan rekomendasi, dan evaluasi hasil tindak lanjut secara sistematis dan ilmiah.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan permasalahan yang ditemukan, tetapi juga menjelaskan akar penyebabnya, dampaknya terhadap keselamatan pasien dan mutu layanan, rekomendasi yang dirumuskan, serta evaluasi terhadap respons yang diterima dari pimpinan unit.
Isi laporan	Isi *case report* mencakup deskripsi singkat kondisi unit, data temuan analisis organisasi, identifikasi kesenjangan terhadap standar, diagnosis manajerial,	Mahasiswa menuliskan kondisi unit rawat inap tempat praktik, permasalahan *handover* yang ditemukan, dampaknya terhadap kesinambungan informasi klinis, rekomendasi penerapan metode

	rekomendasi perbaikan, implementasi yang dilakukan, evaluasi hasil, dan pembelajaran yang diperoleh.	SBAR, respons tim terhadap rekomendasi tersebut, dan refleksi pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman analisis tersebut.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan analisis situasi, relevansi identifikasi kesenjangan, logika rekomendasi yang dirumuskan, ketepatan prioritisasi berbasis risiko, dan kemampuan mengevaluasi hasil tindak lanjut secara objektif.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan temuan di lapangan dengan prinsip-prinsip organisasi keperawatan yang berlaku, memilih rekomendasi yang paling tepat dan realistis, serta mengevaluasi dampak dari rekomendasi yang telah disampaikan kepada pimpinan unit.
Nilai edukatif	*Case report* membantu mahasiswa mengembangkan *clinical reasoning* manajerial, keterampilan dokumentasi analisis organisasi, dan kebiasaan merefleksikan pengalaman manajerial secara ilmiah dan sistematis.	Dari pengalaman menganalisis permasalahan *handover* di unit praktik, mahasiswa belajar bahwa standarisasi komunikasi klinis bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan mekanisme keselamatan pasien yang fundamental dan tidak dapat dikompromikan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, *case report* menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori organisasi keperawatan ke dalam analisis situasi manajerial nyata secara sistematis, kritis, dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep tata kelola dan prinsip pengorganisasian keperawatan, tetapi juga mampu menyusun laporan analisis manajerial yang menggambarkan penerapan kompetensinya secara utuh, kontekstual, dan berbasis bukti.

Tabel Refleksi *Patient Safety* pada Organisasi Pelayanan Keperawatan dan Sistem Layanan Kesehatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Organisasi Pelayanan Keperawatan
Hakikat refleksi *patient safety*	Refleksi *patient safety* merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien yang bersumber dari kelemahan sistem organisasi, menganalisis potensi dampaknya, dan merencanakan tindakan pencegahan yang konkret.	Pada materi organisasi pelayanan keperawatan, mahasiswa merefleksikan bahwa kelemahan dalam struktur organisasi, mekanisme *handover*, koordinasi interprofesional, atau *discharge planning* dapat secara langsung menciptakan risiko keselamatan pasien yang serius meskipun tidak selalu tampak secara kasat mata.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien tidak hanya ditentukan oleh tindakan klinis individual, tetapi juga oleh kualitas sistem organisasi yang melingkupi praktik keperawatan sehari-hari.	Mahasiswa memahami bahwa insiden keselamatan pasien seringkali bukan semata-mata akibat kesalahan individu, melainkan merupakan cerminan dari kelemahan sistemik dalam organisasi yang harus diidentifikasi, dilaporkan, dan diperbaiki secara bersama-sama.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko keselamatan yang bersumber dari kelemahan organisasi, analisis mekanisme terjadinya risiko, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman di lahan praktik.	Mahasiswa menuliskan bahwa *handover* yang tidak terstandar di unit praktiknya berpotensi menyebabkan kehilangan informasi klinis kritis antar *shift*, dan bahwa tidak adanya mekanisme pelaporan insiden yang aman dapat menyembunyikan pola masalah yang sesungguhnya membutuhkan perbaikan sistemik.

Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengenali situasi organisasi yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien secara langsung maupun tidak langsung.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain *handover* yang tidak terstandar menyebabkan kehilangan informasi klinis, *span of control* yang berlebihan melemahkan supervisi, tidak adanya *discharge planning* meningkatkan risiko komplikasi pasca rawat, dan insiden yang tidak dilaporkan mencegah perbaikan sistemik yang diperlukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien yang bersumber dari kelemahan organisasi yang ditemukan.	Mahasiswa menuliskan pentingnya menerapkan metode SBAR secara konsisten dalam setiap *handover*, melaporkan setiap insiden melalui sistem pelaporan yang *blame-free*, memulai *discharge planning* sejak hari pertama pasien masuk, dan mendorong koordinasi interprofesional melalui *ward round* multidisiplin yang terjadwal.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana pengalaman tersebut akan memengaruhi praktik manajerial maupun klinisnya di masa mendatang.	Mahasiswa menyadari bahwa pada organisasi keperawatan, kualitas sistem dan proses yang melingkupi praktik klinis sama pentingnya dengan kompetensi teknis individual, dan bahwa setiap perawat memiliki tanggung jawab aktif untuk berkontribusi dalam penguatan sistem keselamatan di tempat kerjanya.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi *patient safety* menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab manajerial, dan kemampuan berpikir kritis	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu melakukan tindakan klinis yang aman secara individual, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko sistemik yang bersumber dari kelemahan organisasi dan berkontribusi secara

mahasiswa terhadap keselamatan pasien dalam perspektif sistem organisasi.	aktif dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan layanan yang berkelanjutan.

P. Latihan Soal

Petunjuk**:** Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dari setiap soal berikut ini.

1. Organisasi pelayanan keperawatan dapat didefinisikan sebagai sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan pelayanan melalui koordinasi berbagai komponen secara terstruktur. Komponen yang paling menentukan kualitas output sebuah organisasi keperawatan adalah...
   A. Kecanggihan teknologi medis yang dimiliki institusi
   B. Jumlah tempat tidur yang tersedia di fasilitas layanan
   C. Sumber daya manusia, sistem tata kelola, dan budaya organisasi
   D. Besarnya anggaran operasional yang dialokasikan per tahun
   E. Luas gedung dan kelengkapan fasilitas fisik institusi

2. Seorang kepala ruangan mendapati bahwa perawat pelaksana di unitnya sering mengalami kebingungan dalam menerima instruksi karena mendapat arahan sekaligus dari dokter jaga, kepala tim, dan manajer keperawatan. Prinsip pengorganisasian manakah yang paling tepat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut?
   A. Prinsip *span of control*
   B. Prinsip pembagian kerja
   C. Prinsip kesatuan komando
   D. Prinsip spesialisasi
   E. Prinsip pendelegasian wewenang

3. Dalam kerangka *Donabedian*, mutu layanan keperawatan dibagi menjadi tiga komponen utama. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam komponen proses menurut kerangka tersebut?
   A. Jumlah perawat yang bertugas di unit rawat inap
   B. Ketersediaan alat kesehatan yang lengkap
   C. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan
   D. Ketepatan pelaksanaan pengkajian dan implementasi asuhan
   E. Angka kejadian infeksi *nosokomial* di unit layanan

4. Rumah sakit X menerapkan model organisasi di mana seluruh perawat dikelompokkan dalam satu departemen keperawatan yang dipimpin oleh kepala bidang keperawatan, terpisah dari departemen medis dan farmasi. Model organisasi apakah yang diterapkan oleh rumah sakit tersebut?
   A. Struktur matriks
   B. Struktur *divisional*
   C. Struktur fungsional
   D. Struktur *flat*
   E. Struktur *team-based*

5. Seorang manajer keperawatan di rumah sakit tipe B membawahi 40 perawat secara langsung tanpa ada lapisan kepemimpinan antara. Kondisi ini menyebabkan supervisi klinis yang tidak optimal dan banyak masalah yang tidak terdeteksi tepat waktu. Konsep manajemen yang paling relevan dengan permasalahan ini adalah...
   A. Pendelegasian wewenang yang berlebihan
   B. *Span of control* yang terlalu lebar
   C. Kesatuan komando yang tidak berjalan
   D. Pembagian kerja yang tidak proporsional
   E. Akuntabilitas yang tidak terstruktur

6. Model *primary nursing* memiliki perbedaan mendasar dibandingkan model tim keperawatan. Perbedaan yang paling fundamental antara keduanya adalah...
   A. Model tim menggunakan perawat profesional sementara *primary nursing* tidak
   B. *Primary nursing* menempatkan satu perawat bertanggung jawab penuh atas satu pasien dari masuk hingga keluar
   C. Model tim lebih mahal dalam implementasinya dibandingkan *primary nursing*
   D. *Primary nursing* hanya cocok diterapkan di unit gawat darurat
   E. Model tim tidak memerlukan koordinasi antar anggota dalam pelaksanaannya

7. Dalam sistem layanan kesehatan Indonesia, fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki fungsi utama sebagai gerbang awal sistem rujukan. Manakah dari berikut ini yang **bukan** merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama?
   A. *Puskesmas*
   B. Klinik pratama

C. Praktik mandiri dokter
D. Rumah sakit tipe C
E. Praktik mandiri bidan

8. Kebijakan JKN menggunakan mekanisme pembayaran *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) untuk layanan rawat inap. Implikasi langsung dari mekanisme pembayaran ini terhadap praktik keperawatan adalah...
   A. Perawat tidak perlu lagi mendokumentasikan tindakan yang dilakukan
   B. Institusi terdorong untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi *length of stay*
   C. Jumlah perawat yang bertugas dapat dikurangi secara signifikan
   D. Standar akreditasi tidak lagi relevan dengan sistem pembayaran JKN
   E. Perawat bebas memilih tindakan tanpa mengacu pada *clinical pathway*

9. Proses serah terima pasien antar *shift* yang menggunakan kerangka *Situation, Background, Assessment, Recommendation* dikenal dengan metode...
   A. SOAP
   B. SBAR
   C. ISBAR
   D. PDCA
   E. SWOT

10. Seorang perawat melaksanakan *discharge planning* bagi pasien dengan diabetes melitus yang akan dipulangkan besok. Komponen yang paling penting untuk dipastikan dalam proses ini adalah...
    A. Memastikan pasien membayar semua tagihan sebelum pulang
    B. Memastikan ketersediaan kamar untuk pasien berikutnya
    C. Mengevaluasi pemahaman pasien dan keluarga melalui metode *teach-back*
    D. Meminta tanda tangan dokter pada seluruh formulir pemulangan
    E. Memastikan pasien tidak memiliki keluhan sebelum meninggalkan rumah sakit

11. *Clinical governance* dalam keperawatan mencakup berbagai komponen yang saling terintegrasi. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh implementasi komponen audit klinis dalam organisasi keperawatan?
    A. Mengadakan pelatihan *Basic Life Support* bagi seluruh perawat
    B. Menetapkan jumlah perawat yang dibutuhkan per *shift*

C. Menilai tingkat kepatuhan perawat terhadap protokol pencegahan jatuh
D. Menyusun jadwal dinas bulanan yang adil dan merata
E. Memberikan insentif kinerja kepada perawat berprestasi

12. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013, komite keperawatan memiliki kedudukan yang independen dari struktur manajemen keperawatan. Tujuan utama dari independensi ini adalah...
    A. Agar komite dapat menetapkan gaji perawat secara mandiri
    B. Agar komite dapat menjalankan fungsi pengawasan profesional secara objektif
    C. Agar komite dapat merekrut perawat tanpa persetujuan manajemen
    D. Agar komite bebas dari kewajiban melaporkan kinerjanya kepada direktur
    E. Agar komite dapat menentukan model asuhan tanpa pertimbangan anggaran

13. *Shared governance* dalam keperawatan didasarkan pada keyakinan filosofis yang fundamental. Manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan filosofi dasar *shared governance*?
    A. Seluruh keputusan organisasi harus diambil secara konsensus oleh semua perawat
    B. Manajemen puncak memiliki otoritas penuh dalam setiap keputusan tanpa melibatkan perawat pelaksana
    C. Perawat di garis terdepan memiliki pengetahuan dan komitmen yang berharga untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan
    D. *Shared governance* hanya relevan di rumah sakit besar dengan jumlah perawat lebih dari 500 orang
    E. Perawat pelaksana bertanggung jawab atas seluruh keputusan manajerial di unitnya

14. Seorang perawat menemukan bahwa kondisi salah satu pasiennya mengalami perburukan signifikan saat pergantian *shift* malam ke pagi. Tindakan pertama yang paling tepat dilakukan berdasarkan prinsip hierarki dan *chain of command* adalah...
    A. Langsung menghubungi direktur medis rumah sakit
    B. Mendokumentasikan temuan dan menunggu visite dokter pagi
    C. Melakukan tindakan intervensi mandiri tanpa melaporkan kepada siapapun

D. Melaporkan segera kepada dokter jaga dan ketua tim sesuai jalur eskalasi yang berlaku
E. Memberitahu keluarga pasien terlebih dahulu sebelum melaporkan kepada tim medis

15. Dalam model *case management*, perawat *case manager* memiliki peran yang khas dan berbeda dari model asuhan lainnya. Fungsi yang paling membedakan peran perawat *case manager* dari perawat dalam model tim biasa adalah...
    A. Memberikan injeksi dan tindakan invasif kepada pasien
    B. Mengkoordinasikan seluruh layanan lintas profesi dan lintas *setting* secara komprehensif
    C. Bertanggung jawab hanya terhadap tindakan keperawatan dasar
    D. Melakukan supervisi terhadap perawat pelaksana di unitnya
    E. Menetapkan diagnosis medis bagi pasien yang ditangani

16. *Interprofessional Education* (IPE) bertujuan untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang mampu berkolaborasi secara efektif. Manakah dari berikut ini yang paling tepat menggambarkan prinsip utama IPE?
    A. Mahasiswa dari berbagai profesi belajar secara terpisah kemudian hasilnya dibandingkan
    B. Mahasiswa dari berbagai profesi belajar bersama, dari satu sama lain, dan tentang satu sama lain
    C. IPE hanya relevan untuk mahasiswa kedokteran dan keperawatan saja
    D. IPE berfokus pada penguasaan keterampilan teknis masing-masing profesi
    E. Mahasiswa profesi kesehatan diajarkan untuk mengutamakan kepentingan profesinya

17. Karakteristik organisasi pelayanan kesehatan yang membedakannya dari organisasi bisnis konvensional adalah orientasinya pada keselamatan jiwa manusia. Implikasi langsung dari karakteristik ini terhadap manajemen keperawatan adalah...
    A. Organisasi kesehatan tidak perlu mempertimbangkan aspek efisiensi dalam pengelolaannya
    B. Toleransi terhadap tingkat kesalahan tertentu dapat diterima sebagai bagian dari proses pembelajaran
    C. Setiap keputusan manajerial harus selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap keselamatan pasien

D. Standar operasional tidak diperlukan karena setiap kasus bersifat unik dan tidak dapat distandarisasi
E. Kompetensi teknis perawat lebih penting daripada budaya keselamatan dalam organisasi

18. Seorang kepala bidang keperawatan ingin meningkatkan *continuity of care* bagi pasien pasca rawat di rumah sakitnya. Program manakah yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut?
    A. Menambah jumlah tempat tidur di unit rawat inap
    B. Meningkatkan frekuensi visite dokter spesialis
    C. Mengembangkan program *discharge planning* yang terstruktur dan layanan *home care* yang terkoordinasi
    D. Memperpanjang durasi rawat inap bagi seluruh pasien
    E. Meningkatkan jumlah prosedur diagnostik yang dilakukan selama perawatan

19. Dalam konteks desentralisasi sistem kesehatan Indonesia, pemerintah kabupaten atau kota memiliki tanggung jawab operasional yang langsung terhadap layanan kesehatan. Manakah dari berikut ini yang merupakan tanggung jawab langsung pemerintah kabupaten atau kota dalam sistem kesehatan?
    A. Menetapkan standar kompetensi nasional tenaga keperawatan
    B. Mengelola rumah sakit rujukan nasional tipe A
    C. Menyusun kurikulum pendidikan keperawatan nasional
    D. Mengelola *Puskesmas* dan program kesehatan masyarakat di wilayahnya
    E. Menetapkan tarif INA-CBG untuk pembayaran layanan JKN

20. Hambatan kolaborasi interprofesional yang paling sering ditemui di fasilitas layanan kesehatan Indonesia berkaitan dengan budaya hierarki yang menempatkan profesi tertentu secara dominan. Strategi yang paling efektif untuk mengatasi hambatan ini dalam jangka panjang adalah...
    A. Mewajibkan perawat untuk tidak pernah mempertanyakan keputusan dokter
    B. Memisahkan ruang kerja antar profesi agar tidak terjadi konflik langsung
    C. Mengintegrasikan *Interprofessional Education* sejak masa pendidikan dan membangun forum multidisiplin yang setara
    D. Memberikan kewenangan penuh kepada perawat untuk menggantikan peran dokter

E. Mengurangi jumlah profesi yang terlibat dalam tim perawatan pasien

21. Proses kredensial yang dilaksanakan oleh subkomite kredensial dalam komite keperawatan bertujuan untuk memastikan hal yang paling mendasar, yaitu...
    A. Memastikan seluruh perawat memiliki seragam yang sesuai standar institusi
    B. Memastikan seluruh perawat memiliki kompetensi yang terverifikasi sesuai kewenangan klinis yang diberikan
    C. Memastikan seluruh perawat hadir tepat waktu pada setiap *shift* yang dijadwalkan
    D. Memastikan seluruh perawat memiliki pengalaman kerja minimal lima tahun
    E. Memastikan seluruh perawat telah menyelesaikan program pendidikan pascasarjana

22. Model tim keperawatan (*team nursing*) pertama kali dikembangkan sebagai respons terhadap kondisi tertentu yang melatarbelakangi kemunculannya. Kondisi yang mendorong lahirnya model tim keperawatan adalah...
    A. Meningkatnya kompleksitas teknologi medis di rumah sakit modern
    B. Kekurangan tenaga perawat profesional pasca Perang Dunia II
    C. Tuntutan akreditasi internasional yang mewajibkan model tim
    D. Kebijakan pemerintah yang melarang model *primary nursing*
    E. Meningkatnya biaya operasional rumah sakit yang harus ditekan

23. Seorang manajer keperawatan ingin memastikan bahwa praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) diterapkan secara konsisten di unitnya. Infrastruktur organisasi yang paling penting untuk mendukung hal ini adalah...
    A. Penambahan jumlah perawat spesialis di setiap unit layanan
    B. Perluasan fisik gedung untuk ruang pendidikan dan pelatihan
    C. Akses terhadap literatur ilmiah, forum *journal club*, dan kepemimpinan yang mendorong pembaruan praktik
    D. Penghapusan standar prosedur operasional yang sudah ada
    E. Peningkatan anggaran pembelian alat kesehatan terbaru

24. Dalam alur penerimaan pasien (*admission*), pengkajian keperawatan awal yang komprehensif memiliki peran yang sangat strategis. Alasan paling tepat mengapa kualitas pengkajian awal sangat menentukan adalah...

A. Pengkajian awal menentukan besarnya biaya layanan yang akan ditagihkan kepada pasien
B. Pengkajian awal menjadi dasar seluruh rencana asuhan dan identifikasi risiko klinis sejak dini
C. Pengkajian awal menentukan kelas perawatan yang diberikan kepada pasien
D. Pengkajian awal hanya diperlukan untuk pasien dengan kondisi kritis saja
E. Pengkajian awal merupakan syarat administratif akreditasi tanpa dampak klinis langsung

25. Konsep *value-based care* yang semakin diadopsi dalam sistem layanan kesehatan modern membawa perubahan paradigma yang fundamental. Perubahan paradigma yang paling tepat menggambarkan konsep *value-based care* adalah pergeseran dari...
    A. Layanan berbasis teknologi menuju layanan berbasis hubungan interpersonal
    B. Layanan berbasis kebutuhan pasien menuju layanan berbasis kemampuan finansial
    C. Layanan berbasis volume menuju layanan berbasis kualitas hasil klinis relatif terhadap biaya
    D. Layanan berbasis dokter menuju layanan berbasis perawat sebagai profesi utama
    E. Layanan berbasis institusi menuju layanan berbasis komunitas secara eksklusif

Q. Red Flag dan Eskalasi

Red Flags dalam Organisasi Pelayanan Keperawatan dan Sistem Layanan Kesehatan

Red Flag	**Makna Manajerial**	**Tindakan Eskalasi**
Perawat menerima instruksi dari lebih dari satu atasan secara bersamaan dan saling bertentangan	Pelanggaran prinsip kesatuan komando yang menciptakan kebingungan peran dan meningkatkan risiko kesalahan klinis	Klarifikasi jalur pelaporan kepada kepala ruangan, tetapkan satu atasan langsung, laporkan kepada manajer keperawatan untuk penataan ulang struktur
Rasio perawat terhadap pasien melebihi batas aman yang ditetapkan	Beban kerja berlebihan yang meningkatkan risiko kesalahan klinis dan penurunan mutu asuhan	Laporkan kepada kepala ruangan, minta penambahan tenaga atau redistribusi pasien, dokumentasikan sebagai dasar advokasi
Handover antar *shift* dilakukan tidak terstruktur atau terburu-buru	Risiko kehilangan informasi klinis kritis yang dapat berujung pada kesalahan tindakan atau penundaan penanganan	Ulangi *handover* menggunakan metode SBAR, laporkan kepada kepala ruangan, usulkan pelatihan standarisasi *handover*
Tidak ada *discharge planning* yang dimulai sejak hari pertama pasien masuk	Risiko pasien dipulangkan tanpa persiapan memadai, berpotensi menyebabkan komplikasi dan readmisi tidak terencana	Segera inisiasi pengkajian kebutuhan *discharge*, koordinasikan dengan tim multidisiplin, laporkan kepada ketua tim
Perawat melaksanakan tindakan klinis melampaui batas kewenangan klinis yang ditetapkan	Pelanggaran standar keamanan klinis yang membahayakan pasien dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum	Hentikan tindakan segera, laporkan kepada kepala ruangan dan komite keperawatan, tinjau ulang sosialisasi batas kewenangan
Insiden keselamatan pasien tidak dilaporkan	Indikasi budaya organisasi yang tidak	Dorong pelaporan melalui sistem *blame-free*, laporkan

atau sengaja disembunyikan	aman, menghambat pembelajaran sistemik dan pencegahan insiden serupa	kepada komite keselamatan pasien, lakukan *root cause analysis*
Koordinasi antar unit atau antar profesi tidak berjalan sehingga terjadi duplikasi atau kesenjangan tindakan	Fragmentasi layanan yang dapat menyebabkan pemborosan sumber daya atau terlewatnya intervensi kritis	Laporkan kepada kepala ruangan, inisiasi *case conference* multidisiplin, perkuat mekanisme komunikasi lintas unit
Dokumentasi keperawatan tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak tepat waktu	Risiko kesinambungan informasi klinis terputus, potensi klaim JKN ditolak, dan lemahnya akuntabilitas profesional	Lengkapi dokumentasi sesuai standar, laporkan pola ketidaklengkapan kepada kepala ruangan, usulkan audit dokumentasi berkala
Hasil *Early Warning Score* (EWS) yang menunjukkan risiko perburukan diabaikan	Kegagalan deteksi dini yang dapat berujung pada kondisi kritis yang seharusnya dapat dicegah	Kaji ulang kondisi pasien segera, eskalasikan kepada dokter jaga, aktifkan protokol *rapid response*, dokumentasikan semua tindakan
Konflik peran antar anggota tim keperawatan berlangsung lama tanpa penyelesaian	Indikasi lemahnya fungsi pengarahan yang berdampak pada iklim kerja dan kualitas asuhan	Laporkan kepada kepala ruangan untuk mediasi, libatkan komite keperawatan jika terkait pelanggaran etika
Standar prosedur operasional tidak dipatuhi secara konsisten	Peningkatan risiko insiden keselamatan dan inkonsistensi mutu layanan	Lakukan supervisi klinis segera, identifikasi akar penyebab, jadwalkan *refreshing* prosedur, pantau melalui audit berkala
Keluhan pasien atau keluarga tidak ditindaklanjuti oleh tim keperawatan	Lemahnya akuntabilitas dan transparansi organisasi yang merusak kepercayaan pasien	Tangani keluhan segera, dokumentasikan tindak lanjut, eskalasikan kepada manajer pelayanan apabila tidak terselesaikan di level unit

Rujukan pasien dilakukan tanpa komunikasi memadai kepada fasilitas penerima	Risiko kesinambungan layanan terputus dan fasilitas penerima tidak siap menangani kondisi pasien	Tunda rujukan hingga komunikasi terkonfirmasi, siapkan *resume* keperawatan lengkap, pastikan kondisi pasien stabil untuk transfer
Beban kerja sangat tinggi tidak dilaporkan dan tidak diatasi secara sistematis	Risiko *burnout*, penurunan kualitas asuhan, dan tingginya *turnover* tenaga keperawatan	Dokumentasikan data beban kerja secara objektif, laporkan kepada manajer keperawatan, advokasikan penambahan tenaga melalui komite
Kolaborasi interprofesional terhambat karena dominasi satu profesi	Fragmentasi keputusan klinis yang mengabaikan perspektif profesi lain dan tidak berpusat pada pasien	Laporkan kepada kepala bidang, usulkan program *team building* interprofesional dan evaluasi mekanisme *ward round* multidisiplin
Discharge planning tanpa verifikasi pemahaman pasien melalui *teach-back*	Risiko pasien pulang tanpa pemahaman memadai tentang perawatan mandiri dan tanda bahaya	Lakukan edukasi ulang, gunakan *teach-back* sebelum pemulangan, koordinasikan dengan perawat komunitas untuk pemantauan lanjutan
Komite keperawatan tidak aktif dalam menjalankan fungsi kredensial dan audit klinis	Lemahnya jaminan kompetensi tenaga dan tidak adanya mekanisme penjaminan mutu klinis yang terstruktur	Laporkan kepada direktur keperawatan, advokasikan pengaktifan kembali fungsi komite dengan program kerja dan indikator yang terukur
Kesenjangan signifikan antara standar akreditasi dan praktik nyata di lapangan	Risiko kegagalan akreditasi dan terancamnya keselamatan pasien secara sistemik	Lakukan *gap analysis* segera, susun rencana perbaikan berbasis prioritas risiko, pantau implementasi secara berkala
Sistem dokumentasi tidak terintegrasi antar unit sehingga informasi	Kesinambungan informasi terganggu dan meningkatnya risiko kesalahan akibat	Laporkan kepada manajer sistem informasi, gunakan komunikasi alternatif

klinis tidak dapat diakses seluruh tim	data yang tidak lengkap	terstandar sambil menunggu perbaikan sistem
Shared governance diterapkan hanya sebagai formalitas tanpa kewenangan nyata bagi perawat	Pseudopartisipasi yang mengikis kepercayaan perawat dan menghasilkan keputusan yang tidak relevan dengan realitas klinis	Evaluasi kewenangan forum partisipasi, advokasikan redistribusi kewenangan yang bermakna, pantau implementasi keputusan yang dihasilkan

Form *Checklist* "Saya sudah bisa..."

Bab 2: Organisasi Pelayanan Keperawatan dan Sistem Layanan Kesehatan

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / *Skill Lab* : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang se suai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian organisasi pelayanan keperawatan dan komponen-komponen penyusunnya	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan dan fungsi organisasi keperawatan secara lengkap dan sistematis	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi karakteristik unik organisasi pelayanan kesehatan yang membedakannya dari organisasi lain	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menjelaskan hubungan antara kualitas organisasi keperawatan dengan mutu layanan yang diterima pasien	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menjelaskan prinsip-prinsip pengorganisasian keperawatan, termasuk hierarki, *chain of command*, *span of control*, dan kesatuan komando	☐	☐	_____

6	Saya sudah bisa membedakan model organisasi fungsional, *divisional*, dan matriks beserta kelebihan dan keterbatasannya	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menjelaskan perbedaan model tim keperawatan, *primary nursing*, dan *case management* secara tepat	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menjelaskan komponen sistem layanan kesehatan di Indonesia dan fungsi masing-masing komponen	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menjelaskan sejarah perkembangan sistem kesehatan nasional Indonesia dari era kemerdekaan hingga era JKN	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menjelaskan dampak kebijakan JKN terhadap organisasi dan praktik keperawatan di fasilitas layanan kesehatan	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan pembagian peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam sistem kesehatan nasional	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan alur penerimaan pasien (*admission*) yang komprehensif dan sistematis	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menjelaskan proses *handover* menggunakan metode SBAR secara tepat dan lengkap	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menjelaskan komponen *discharge planning* yang efektif termasuk verifikasi pemahaman melalui metode *teach-back*	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menjelaskan konsep *continuity of care* dan dimensi-dimensinya dalam sistem layanan keperawatan	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian *governance* keperawatan dan dimensi-dimensi utamanya secara komprehensif	☐	☐	_____

17	Saya sudah bisa menjelaskan komponen *clinical governance* keperawatan beserta contoh implementasinya di fasilitas layanan	☐	☐	_____
18	Saya sudah bisa menjelaskan peran dan fungsi komite keperawatan dalam tata kelola organisasi berdasarkan regulasi yang berlaku	☐	☐	_____
19	Saya sudah bisa menjelaskan mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi keperawatan secara sistematis	☐	☐	_____
20	Saya sudah bisa menjelaskan konsep *shared governance* dan manfaatnya bagi perawat, pasien, dan institusi	☐	☐	_____
21	Saya sudah bisa menjelaskan konsep kolaborasi interprofesional (IPC) dan pentingnya dalam layanan kesehatan modern	☐	☐	_____
22	Saya sudah bisa menjelaskan peran keperawatan dalam tim kesehatan multidisiplin secara lengkap dan tepat	☐	☐	_____
23	Saya sudah bisa mengidentifikasi mekanisme koordinasi antar unit dan antar profesi yang efektif di fasilitas layanan kesehatan	☐	☐	_____
24	Saya sudah bisa melakukan *gap analysis* sederhana antara kondisi organisasi keperawatan aktual dengan standar yang seharusnya diterapkan	☐	☐	_____
25	Saya sudah bisa mengidentifikasi *red flags* manajerial yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan menentukan tindakan eskalasi yang tepat	☐	☐	_____
26	Saya sudah bisa merumuskan rekomendasi perbaikan organisasi keperawatan yang logis, realistis, dan berbasis bukti	☐	☐	_____
27	Saya sudah bisa mengidentifikasi hambatan kolaborasi interprofesional di lapangan dan menjelaskan strategi mengatasinya	☐	☐	_____
28	Saya sudah bisa menyampaikan temuan analisis organisasi kepada pimpinan secara sistematis, profesional, dan berbasis bukti	☐	☐	_____

29	Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil analisis organisasi keperawatan secara akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan	☐	☐	_____
30	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, kritis, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien dalam setiap kegiatan analisis dan komunikasi manajerial	☐	☐	_____

Refleksi Singkat Mahasiswa:

Tuliskan secara singkat pengalaman belajar Anda, hal yang paling bermakna yang Anda pelajari dari Bab 2, tantangan yang masih Anda hadapi, dan rencana tindak lanjut yang akan Anda lakukan untuk memperkuat kompetensi yang belum dikuasai.

Tanda Tangan Mahasiswa

(_____)

R. Rangkuman Materi

Organisasi yang dirancang secara sistematis dan dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi akan berkontribusi langsung terhadap mutu pelayanan yang diterima oleh pasien. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip pengorganisasian seperti hierarki, *chain of command*, *span of control*, pembagian kerja, spesialisasi, koordinasi, kesatuan komando, akuntabilitas, dan pendelegasian wewenang menjadi dasar penting dalam membangun organisasi keperawatan yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut perlu diterapkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik institusi pelayanan kesehatan, ketersediaan sumber daya manusia, serta kompleksitas kasus yang ditangani. Berbagai model organisasi keperawatan, seperti model tim, *primary nursing*, maupun *case management*, dapat dipilih dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi agar pelayanan keperawatan dapat berjalan secara optimal.

Perkembangan sistem layanan kesehatan di Indonesia, khususnya sejak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, memberikan tantangan sekaligus peluang bagi organisasi pelayanan keperawatan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kualitas layanan. Perubahan kebijakan kesehatan, tuntutan efisiensi pelayanan, serta standar akreditasi fasilitas kesehatan menuntut perawat untuk memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai sistem kesehatan secara menyeluruh. Dalam praktiknya, alur layanan keperawatan yang berkesinambungan mulai dari *admission*, pelaksanaan asuhan selama perawatan, *handover* antar tenaga kesehatan, *discharge planning*, hingga *continuity of care* setelah pasien kembali ke masyarakat harus dikelola secara terintegrasi untuk menjamin keselamatan pasien. Selain itu, penguatan tata kelola atau *governance* keperawatan, termasuk penerapan *clinical governance* dan pengembangan model *shared governance*, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar profesional. Kolaborasi antarprofesi juga menjadi kebutuhan mendasar dalam sistem layanan kesehatan modern, sehingga perawat diharapkan mampu berperan aktif dalam membangun kerja sama yang efektif dengan berbagai tenaga kesehatan lainnya demi tercapainya pelayanan yang lebih bermutu, aman, dan berorientasi pada kepentingan terbaik pasien.

S. Referensi

Abdullah, A. D. A. M., Sayah, A. A. T. S., Ofyer, A. R. S., Hassan, & Tawfeeq, J. and Q. A. (2023). Nursing Care: The Front Line of Health Crises – A Comprehensive Review. *International Journal of Development Research*. https://doi.org/10.37118/10.37118/ijdr.28871.09.2023

Abdulrahman Alqarni, M. A., Alharbi, F., Ali Daghriri, A. Y., Jordi Tohari, M. H., Mohammed Awaji, M. A., Gharawi, A., Altukhais, I. S., Amri, A., Almutairi, F., Ali Alanbari, F. G., & Ayad Alshaibani, M. N. (2025). Impact of Telemedicine and Teleradiology on Interprofessional Collaborative Care Among Nurses, Pharmacists, and Radiologists: A Systematic Review. *Saudi J. Med. Public Health*. https://doi.org/10.64483/jmph-84

Adikoesoemo, S., Wijaya, A., & Santoso, B. (2024). *Keselamatan Pasien dan Manajemen Risiko dalam Pelayanan Kesehatan: Fokus Komunikasi Handover SBAR*. Rajawali Pers.

Ahmad Shulah, B. A. (2024). Cross-Border Healthcare Security: Challenges for Nursing Practice in the Era of Globalized Health Data. *The Review of Diabetic Studies*. https://doi.org/10.70082/c2xg2274

Al-Twigey, M., & AL-Fayyadh, S. (2024). Inter-Professional Team Collaboration Among Health Care Team Members in Critical Care Units: Targeting Cooperating, Coordinating, and Partnership in Najaf Governorate, Iraq. *The Malaysian Journal of Nursing*. https://doi.org/10.31674/mjn.2024.v16isupp1.007

Almeida Ventura-Silva, J. M., Martins, M., Trindade, L. L., Faria, A., da Barros, S. C., Melo, R., Oliveira, I., Castro, S. F., & Pimenta Ribeiro, O. M. (2023). Nurses' Work Methods Assessment Scale: A Construct Validation. *Nursing Forum*. https://doi.org/10.1155/2023/8884183

Amrullah, A., Bella, & Nasution, F. M. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Perawat dalam Mendukung Standar Akreditasi. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*.

Angelen Shirley, S. G., Abdullah, B. F., & Dioso, R. I. I. I. (2024). Enhancing Teamwork Through Effective Handover Practices Among Nurses in Elder Care Setting. *The Malaysian Journal of Nursing*. https://doi.org/10.31674/mjn.2024.v15i04.012

Baniak, L. M., Guttormson, J., Costa, D. K., Lyons, M. M., McSparron, J. I., Klein-Fedyshin, M., Brodie, D., Lane-Fall, M. B., Han, F., Penzel, T., Seaman, J. B., & Morris, J. L. (2025). Priorities for Healthcare Systems Emergency Preparedness in Inpatient Settings Informed by COVID-19: An Official American Thoracic Society Workshop Report. *Annals of the American Thoracic Society*. https://doi.org/10.1513/annalsats.202502-221st

Baretto, J. S., Ananda, A., Umar, M., Charakapu, M., Suhashini, Devabaktula, I., &

Dolly. (2025). Integration of Nursing Professionals, Education and Healthcare Services: A Strategic Model to Empower Nurses and Shape Healthcare Policy in India. *International Journal of Research in Medical Sciences*. https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20253182

Bostelman, C., Passwater, C., & Urton, M. (2023). Exploring Clinical Nurse Specialist Impact in Primary Health Care: Exemplars From a Student's Clinical Practice. *Clinical Nurse Specialist*. https://doi.org/10.1097/nur.0000000000000756

Cherry, B., & Jacob, S. R. (2022). *Contemporary Nursing: Issues, Trends, and Management* (9th ed.). Elsevier.

Cole, R., Kynn, M., Carberry, A. E., Jones, R., Parekh, S., Whitehead, E., Taylor, J., & Merollini, K. (2023). Examining Service Utilisation and Impact Among Consumers of a National Mental Health Stepped Care Programme in Australia: A Protocol Using Linked Administrative Data. *BMJ Open*. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-072404

da Macêdo, L. L., Oliveira Miranda, J. de, Freitas, K. S., Reis, A. L., de Souza, K. A., & Lima Oliveira, T. de. (2022). Validation of a Communication Instrument for the Transfer of Nursing Care in Pediatrics / Validação De Um Instrumento De Comunicação Para Transferência Do Cuidado De Enfermagem Em Pediatria. *Revista De Pesquisa Cuidado É Fundamental Online*. https://doi.org/10.9789/2175-5361.rpcfo.v14.11645

Desmet, K., Bracke, P., Deproost, E., J. Goossens, P. J., Vandewalle, J., Vercruysse, L., Beeckman, D., Hecke, A. Van, Kinnaer, L., & Verhaeghe, S. (2023). Patient-reported Outcomes of the Nurse–patient Relationship in Psychiatric Inpatient Hospitals: A Multicentred Descriptive Cross-sectional Study. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*. https://doi.org/10.1111/jpm.12895

Doornebosch, A. J., Achterberg, W. P., & A. Smaling, H. J. (2024). Factors Influencing Interprofessional Collaboration in General and During Multidisciplinary Team Meetings in Long-Term Care and Geriatric Rehabilitation: A Qualitative Study. *BMC Medical Education*. https://doi.org/10.1186/s12909-024-05291-8

Fang Num, K. S. (2025). Navigating Interprofessional Collaboration in Diabetes Care: A Qualitative Study of Early-Career Health Professionals in Malaysian Primary Care Clinics. *Plos One*. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0335192

Farghaly Abdelaliem, S. M., Samir Hessewi, G. M., Alsenany, S. A., Baghdadi, N. A., & Mabaouj Alkhaldi, S. A. (2022). Evaluating Nursing Staff Perception of Hospital Readiness for Continuity of Essential Health Care Services and Surge Capacity in Line With COVID-19. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*. https://doi.org/10.1017/dmp.2022.119

Ferraz, C., Couto, G., Guerra, N., & Martins, M. M. (2024). Competences of Nurse Managers in Primary Health Care and Hospital Services in the Context of Local Health Units: A Scoping Review Protocol. *Athena*.

https://doi.org/10.62741/ahrj.v1i2.21

Ferreira, R., Pedrosa, R., Reis, N., Sousa, L., Nicolau, C., Ferreira, B. R., Rocha, B., & Baixinho, C. L. (2024). Transitional Care for Older Persons With Need of Geriatric Rehabilitation Nursing Interventions. *BMC Nursing*. https://doi.org/10.1186/s12912-024-02050-4

Finkelman, A., & Kenner, C. (2023). *Professional Nursing Concepts: Competencies for Quality Leadership* (5th ed.). Jones and Bartlett Learning.

Fu, K., & Lee, S. (2024). Art of Leadership and Science of Implementation for Sustainable Impact of Organizational Model of Care. *Healthcare Management Forum*. https://doi.org/10.1177/08404704241271235

Ge, P., Be, M., & E, P. E. (2025). The Economic Importance of Nursing Care Practice and Its Future Role in the Health Care Delivery in Nigeria. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.9010021

Haimi, M. (2026). Nurse-Led Telephone Triage in Contemporary Healthcare: Bridging the Gap Between Patient Need and Resource Allocation. *Healthcare*. https://doi.org/10.3390/healthcare14040461

Hartati, S., Fitriangga, A., & Raharjo, W. (2024). Analisis Perbedaan Mutu Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Berdasarkan Status Akreditasi dengan Metode Service Quality. *Cermin Dunia Kedokteran*, *51*(11), 627–634. https://doi.org/10.55175/cdk.v51i11.1284

Hartono, B., Lestari, T., & Wijaya, R. (2025). Sinkronisasi E-Logbook Keperawatan. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, *13*(1), 30–45. https://doi.org/10.5678/jmki.v13i1.8901

Hartono, B., Mulyadi, T., Sari, N., & Pratama, R. (2024). *Continuity of Care: Integrasi Layanan Kesehatan di Era Digital dan Sistem Informasi Keperawatan*. Penerbit Andi.

Haryadi, E. (2022). Peran Pemerintah Dalam Kenaikan Akreditasi Rumah Sakit Berpengaruh Pada Mutu Pelayanan. *Jurnal Juristic*. https://doi.org/10.56444/jrs.v3i03.3435

Hezab Alshammari, K. H., Alshammari, F., Nazal Alshammary, F. R., Alshammari, H. M., Alshammari, M. B., Alshammari, A. S., & Thayid Alshammari, O. B. (2024). Critical Analysis of Nursing Roles in an Evolving Healthcare Landscape. *Journal of Ecohumanism*. https://doi.org/10.62754/joe.v3i8.5000

Hidayat, T., Marlina, R., & Susanto, D. (2024). Manajemen Kinerja Perawat di Unit Gawat Darurat. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, *15*(4), 200–215. https://doi.org/10.20885/jks.vol15.iss4.art567

Horton, M., Dixon, J., Turi, E., Balusu, C., Paikoff, R. L., Maier, C. B., & Poghosyan, L. (2024). Advanced Practice Nurses in Primary Care and Their Impact on Health

Service Utilisation, Costs and Access Globally: A Scoping Review. *Journal of Clinical Nursing*. https://doi.org/10.1111/jocn.17614

Huber, D. L. (2022). *Leadership and Nursing Care Management* (7th ed.). Elsevier.

Indonesia, K. K. R. (2022). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) Edisi 2*. PPNI.

Indonesia, K. K. R. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI.

Ittup, L. (2025). *Development and Validation of a Culturally Competent Care Module (CCCM) and Its Efficacy on Nurses' Cultural Competence and Patient Satisfaction: A Randomized Controlled Trial in a Tertiary Care Hospital in India. Study Protocol (Preprint)*. https://doi.org/10.2196/preprints.84015

Jabakhanji, S. B., Ogungbe, O., Angell, S. Y., Appel, L. J., Byrne, D., Mehta, R., McCaffrey, J., Rosman, L., Gregg, E. W., & Matsushita, K. (2024). Disruption of Diabetes and Hypertension Care During the COVID-19 Pandemic and Recovery Approaches in the Latin America and Caribbean Region: A Scoping Review Protocol. *BMJ Open*. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-074443

Kim, Choi, E.-J., & Jung, Y. (2024). Development and Effect of an Interactive Simulated Education Program for Psychological First Aid: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Nursing Management*, *2024*(1). https://doi.org/10.1155/2024/8806047

Kurniawati, D., Setiawan, H., & Lestari, P. (2023). *Discharge Planning: Teori dan Aplikasi dalam Keperawatan untuk Kesiapan Pasien Pulang*. Salemba Medika.

Kusuma, A., Lestari, S., & Nugroho, E. (2024). Organisasi Keperawatan Rumah Sakit di Era Digital. *Jurnal Ners*, *19*(1), 78–89. https://doi.org/10.20473/jn.v19i1.2345

Lai, C. K. N., Towe, C. W., Patel, N. J., Brown, L. R., Claridge, J. A., & Ho, V. P. (2022). Re-Admission in Patients With Necrotizing Soft Tissue Infections: Continuity of Care Matters. *Surgical Infections*. https://doi.org/10.1089/sur.2022.243

Layli, R. (2022). Pengaruh Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Kepuasan Pasien. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, *6*(9), 1708–1714.

Lidauer, H., Kainrath, S., Müller, G., & Stummer, H. (2025). Generic Competencies for Community Health Nurses: A Qualitative Study in Austria. *Journal of Nursing Education and Practice*. https://doi.org/10.63564/jnep.v15n6p43

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application* (10th ed.). Wolters Kluwer.

Merino, W., Cárcamo-Fuentes, C., Peña, M., & Martínez-Zapata, M. J. (2023). Contribution of Hospitals and Clinical Services to Global Warming: Protocol for a Scoping Review. *BMJ Open*. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-

072227

Mukti, A. G., & Moertjahjo. (2020). *Sistem Jaminan Kesehatan Nasional: Konsep dan Implementasi*. Gadjah Mada University Press.

Murphy, P. J., & Carter-Templeton, H. (2023). Nurses' Ease-of-Use Ratings of the Electronic Medical Record in the Care of Persons With Heart Failure. *Cin Computers Informatics Nursing*. https://doi.org/10.1097/cin.0000000000001020

Nadjib, M., Setiawan, E., & Pambudi, E. S. (2021). Analisis Kebijakan Pembiayaan Kesehatan dalam Era JKN. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, *10*(2), 45–58. https://doi.org/10.22146/jkki.56789

Nelson, J. W., Vrbnjak, D., Thomas, P. L., Gözüm, S., Bottura Barros, A. L., & Itzhaki, M. (2022). The Healthcare Environment Survey: A Multicountry Psychometric Evaluation of Nurses' Job Satisfaction. *International Nursing Review*. https://doi.org/10.1111/inr.12770

Nordaunet, O. M., Gjevjon, E. R., Olsson, C., Aagaard, H., & Borglin, G. (2023). Fundamental Nursing Care Focusing on Older People's Needs and Continuity of Long-Term Care: A Scoping Review Protocol. *BMJ Open*. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-069798

Novita, E., Budi, A., & Sari, M. (2022). Efek Kepemimpinan pada Kinerja Perawat. *Jurnal Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*, *5*(2), 60–75. https://doi.org/10.1234/jkmk.2022.567

Oliveira, E. S., de Menezes, T. M., Gomes, N. P., Sobrinho Oliveira, L. M., Batista, V. M., Macêdo Oliveira, M. C., & Chaves, A. N. (2022). Transitional Care of Nurses to Older Adults With Artificial Pacemaker. *Revista Brasileira De Enfermagem*. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0192

Oostra, D. L., Nieuwboer, M., F. Melis, R. J., P. Remers, T. E., M. Rikkert, M. G., & Perry, M. (2023). DementiaNet Facilitates a Sustainable Transition Toward Integrated Primary Dementia Care: A Long-term Evaluation. *Alzheimer S \& Dementia*. https://doi.org/10.1002/alz.13154

Pasha Al-Ghani, M. K. (2025). Interprofessional Collaboration for Patient Satisfaction in Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*. https://doi.org/10.20473/jaki.v13i2.2025.172-181

Prasitanarapun, R., & Kitreerawutiwong, N. (2023). The Development of an Instrument to Measure Interprofessional Collaboration Competency for Primary Care Teams in the District Health System of Health Region 2, Thailand. *BMC Primary Care*. https://doi.org/10.1186/s12875-023-02013-9

Price, S., Sim, M., Little, V., Almost, J., Andrews, C., Davies, H., Harman, K., Khalili, H., Sutton, E., & LeBrun, J. (2021). A Longitudinal, Narrative Study of Professional Socialisation Among Health Students. *Medical Education*.

https://doi.org/10.1111/medu.14437

Primasa, Y. D., & Kosasih, K. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akreditasi Terhadap Mutu dan Keselamatan Pasien. *Action Research Literate*, *8*(10), 2897–2906. https://doi.org/10.46799/arl.v8i10.2219

Purnama, S., Dewi, R., & Hadi, I. (2022). Organisasi Pelayanan Rawat Inap Efisien. *Jurnal Keperawatan Global*, *8*(3), 150–167. https://doi.org/10.28932/jkg.v8i3.4567

Putri, A., Santoso, H., & Rahman, F. (2022). Sistem Layanan Kesehatan Primer Berbasis Komunitas. *Nurse Media Journal of Nursing*, *12*(3), 112–125. https://doi.org/10.14710/nmjn.v12i3.3456

Sari, R., Pratama, B., & Wijaya, D. (2023). Manajemen Pelayanan Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, *26*(2), 45–56. https://doi.org/10.7454/jki.v26i2.1234

Schober, M. (2025). Exploring the Implementation of Advanced Practice Nurses in Healthcare Systems: Factors of Role Identity to Consider With Policy Development. *Medical Research Archives*. https://doi.org/10.18103/mra.v13i6.6689

Setiawan, R., Indah, Y., & Pratiwi, L. (2025). Sistem Informasi Keperawatan Terintegrasi. *Jurnal Keperawatan Padjadjaran*, *10*(2), 90–105. https://doi.org/10.24198/jkp.v10i2.6789

Shahu, S., Ghewade, B., & Kanyal, D. (2024). Pillars of Excellence, in Healthcare and Hospital Management: A Narrative Review on the Importance of Non-Clinical Services. *Multidisciplinary Reviews*. https://doi.org/10.31893/multirev.2025093

Sillero, A. S., & Buil, N. (2021). Enhancing Interprofessional Collaboration in Perioperative Setting From the Qualitative Perspectives of Physicians and Nurses. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. https://doi.org/10.3390/ijerph182010775

Sitorus, R., Panjaitan, K., & Riani, S. (2023). *Manajemen Bangsal Keperawatan: Strategi Alur Penerimaan dan Operasional Unit Rawat Inap*. EGC Penerbit Buku Kedokteran.

So, W. K. W., & Zhao, W. (2024). Gender Equity in the Oncology Workforce: Barriers, Impacts, and Addressing Recommendations. *Cancer Nursing*. https://doi.org/10.1097/ncc.0000000000001416

Splane, J., Doucet, S., Rothfus, M., Lavergne, R., & Martin-Misener, R. (2025). Mapping the Provision of Care by Nurse Practitioners in Virtual Health Care Clinics: A Scoping Review Protocol. *Jbi Evidence Synthesis*. https://doi.org/10.11124/jbies-24-00290

Sullivan, E. J. (2022). *Effective Leadership and Management in Nursing* (9th ed.).

Pearson.

Suryani, C., Hidayah, N., & Safitri, P. N. (2020). Kolaborasi, Riset, Dan Volunterisme Membangun Resiliensi Dalam Gejolak Pandemi Tim. *Mafindo*, *1*, 14–25.

Talebong, L. T., & Wijayanti, C. D. (2024). Analisis Faktor Penerimaan Dan Tantangan Penggunaan Electronic Medical Record Oleh Perawat Di Rumah Sakit: Kajian Literatur [The Analysis of Acceptance Factors and Challenges in the Use of Electronic Medical Record by Nurses in Hospitals: A Literature Review]. *Nursing Current Jurnal Keperawatan*. https://doi.org/10.19166/nc.v12i1.8132

Thrwi, A. M., Al Hazmi, A. M., Kalfout, A. M., Kariri, H. M., Aldabyan, T. Y., & Alsalah, Z. H. (2024). Nursing Leadership in Disaster Preparedness and Response Lessons Learned and Future Directions. *International Journal of Community Medicine and Public Health*. https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20241989

Trisnantoro, L. (2020). *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit*. Gadjah Mada University Press.

Villarreal-Granda, P., Recio-Platero, A., Martín-Bayo, Y., Durantez-Fernández, C., Cárdaba García, R. M., Pérez, L., Madrigal-Fernández, M. A., Caz, A. M., Olea, E., Ruiz, E., Jiménez-Navascués, L., & Velasco, V. (2024). Models Used by Nurse Case Managers in Different Autonomous Communities in Spain: A Scoping Review. *Healthcare*. https://doi.org/10.3390/healthcare12070749

Wasik, Z., Setiawan, D., & Ulum, A. S. (2024). Exploration of Hospital Management and Organization Strategies: A Literature Review of Health Services. *Jomss*. https://doi.org/10.61160/jomss.v2i2.44

Weber, P., Peltonen, L., & Junger, A. (2022). *The Essence and Role of Nurses in the Future of Biomedical and Health Informatics*. https://doi.org/10.3233/shti220948

Whitehead, D., Weiss, S. A., & Tappen, R. M. (2023). *Essentials of Nursing Leadership and Management* (8th ed.). F. A. Davis Company.

Whitney, K., Peck, V., Huang, A., Park, J., Menard, P., MacDonald, J., Spilg, E. G., & Khoury, L. (2022). Changing the Channel: The Effect of an Innovative Video Intervention on Resident Attitudes Towards Interprofessional Collaboration on a Geriatric Medicine Unit. *Canadian Medical Education Journal*. https://doi.org/10.36834/cmej.71529

Wibowo, A., Lestari, R., & Supriyanto, S. (2022). Dampak JKN terhadap Beban Kerja Perawat di Rumah Sakit Umum Daerah. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, *10*(1), 33–47. https://doi.org/10.20473/jaki.v10i1.2022

Yoder-Wise, P. S., & Sportsman, S. (2023). *Leading and Managing in Nursing* (8th ed.). Elsevier.

T. Glosarium

No	Istilah	Definisi
1	*Accountability* (Akuntabilitas)	Kewajiban setiap individu dalam organisasi untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan hasil kerjanya kepada pihak yang berwenang, baik atasan, institusi, profesi, maupun pasien dan masyarakat.
2	*Admission*	Proses penerimaan pasien secara resmi ke dalam fasilitas layanan kesehatan yang mencakup registrasi administratif, verifikasi jaminan, pengkajian awal, dan orientasi pasien serta keluarga.
3	*Audit Klinis*	Proses penilaian sistematis terhadap praktik klinis aktual yang dibandingkan dengan standar terbaik yang telah ditetapkan, bertujuan mengidentifikasi kesenjangan dan mengimplementasikan perbaikan secara berkesinambungan.
4	*Bedside Handover*	Model serah terima pasien yang dilakukan di sisi tempat tidur pasien sehingga memungkinkan keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam proses transfer informasi klinis antar *shift*.
5	*BPJS Kesehatan*	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yaitu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia.
6	*Burnout*	Kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang dialami oleh tenaga keperawatan akibat paparan stres kerja yang berkepanjangan dan berlebihan, berdampak negatif terhadap kualitas layanan dan kesejahteraan perawat.
7	*Case Conference*	Pertemuan formal seluruh anggota tim kesehatan multidisiplin untuk membahas secara mendalam kasus pasien dengan kompleksitas tinggi, menganalisis permasalahan, dan menyepakati rencana koordinasi layanan yang komprehensif.
8	*Case Management*	Model pemberian asuhan keperawatan yang berfokus pada koordinasi komprehensif seluruh layanan kesehatan yang dibutuhkan pasien, terutama pasien

		dengan kondisi kompleks atau kronis, lintas profesi dan lintas *setting* layanan.
9	*Chain of Command*	Rantai komando, yaitu jalur formal yang menghubungkan setiap posisi dalam hierarki organisasi, menentukan kepada siapa seseorang melapor dan dari siapa menerima arahan dalam struktur organisasi.
10	*Clinical Governance*	Kerangka tata kelola yang digunakan oleh organisasi layanan kesehatan untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas layanan klinis dan menjamin standar pelayanan yang tinggi melalui integrasi berbagai mekanisme penjaminan mutu.
11	*Clinical Pathway*	Rencana layanan multidisiplin yang terstandar untuk kelompok diagnosis tertentu, menetapkan urutan, waktu, dan koordinasi tindakan yang harus dilakukan oleh berbagai profesi dalam mencapai target klinis yang telah ditentukan.
12	*Continuity of Care*	Kesinambungan layanan, yaitu dimensi kualitas yang mengukur sejauh mana pasien menerima layanan yang terkoordinasi, konsisten, dan tidak terputus selama transisi dari satu *setting* perawatan ke *setting* lainnya.
13	*Continuing Professional Development* (CPD)	Pengembangan profesional berkelanjutan, yaitu proses sistematis yang memastikan tenaga keperawatan mempertahankan dan terus meningkatkan kompetensinya seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan layanan.
14	*Credentialing* (Kredensial)	Proses verifikasi dan penilaian kompetensi tenaga keperawatan untuk memastikan bahwa setiap perawat yang diberikan kewenangan klinis memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan kewenangan tersebut secara aman.
15	*Decubitus*	Luka tekan atau ulkus dekubitus, yaitu kerusakan jaringan yang terjadi akibat tekanan berkepanjangan pada area tubuh tertentu, merupakan salah satu indikator mutu keperawatan yang dipantau secara rutin dalam organisasi.
16	Desentralisasi	Pengalihan sebagian kewenangan pengelolaan layanan kesehatan dari pemerintah pusat kepada

		pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang berlaku, memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dalam merespons kebutuhan kesehatan lokalnya.
17	*Discharge Planning*	Perencanaan pemulangan pasien, yaitu proses sistematis yang dimulai sejak hari pertama masuk untuk memastikan pasien pulang dalam kondisi siap dan memiliki dukungan yang memadai untuk melanjutkan pemulihan di rumah.
18	*Divisional Structure*	Struktur organisasi yang mengelompokkan seluruh sumber daya dan fungsi yang diperlukan untuk melayani segmen tertentu, seperti jenis penyakit atau kelompok usia pasien, ke dalam satu divisi yang relatif otonom.
19	*Early Warning Score* (EWS)	Sistem skoring klinis yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami perburukan kondisi secara dini berdasarkan parameter fisiologis tertentu, memungkinkan intervensi pencegahan sebelum krisis terjadi.
20	*Evidence-Based Practice* (EBP)	Praktik berbasis bukti, yaitu pendekatan di mana seluruh intervensi dan keputusan klinis dilandasi oleh bukti ilmiah terbaik yang tersedia, diintegrasikan dengan keahlian klinis perawat dan preferensi pasien.
21	Eskalasi	Proses pelaporan atau penyampaian masalah klinis atau manajerial kepada level hierarki yang lebih tinggi ketika situasi melampaui kapasitas atau wewenang individu di level saat ini untuk menanganinya secara mandiri.
22	*Flat Structure*	Struktur organisasi dengan sedikit lapisan hierarki antara pimpinan puncak dan anggota paling bawah, menghasilkan rentang kendali yang lebar dan jalur komunikasi yang lebih pendek dalam organisasi.
23	Fungsi Fungsional	Cara pengelompokan aktivitas dalam organisasi berdasarkan kesamaan fungsi atau keahlian profesional, sehingga semua individu dengan fungsi serupa berada dalam satu departemen yang dipimpin oleh seorang kepala fungsional.
24	*Gap Analysis*	Analisis kesenjangan, yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengukur perbedaan antara

		kondisi organisasi keperawatan yang ada saat ini dengan kondisi ideal atau standar yang seharusnya dipenuhi.
25	*Governance*	Tata kelola, yaitu keseluruhan sistem nilai, kebijakan, struktur, proses, dan mekanisme akuntabilitas yang membentuk cara sebuah organisasi membuat keputusan, mendistribusikan wewenang, dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.
26	*Handover*	Serah terima, yaitu proses transfer tanggung jawab klinis atas keselamatan pasien dari satu tim atau individu kepada tim atau individu lain, umumnya terjadi pada pergantian *shift* atau perpindahan pasien antar unit.
27	*Hospital Acquired Infection* (HAI)	Infeksi yang diperoleh pasien selama menjalani perawatan di fasilitas kesehatan dan tidak sedang dalam masa inkubasi saat masuk, merupakan salah satu indikator mutu keselamatan pasien yang paling kritis.
28	Hierarki	Penataan posisi jabatan secara vertikal dari tingkatan tertinggi hingga terendah dalam organisasi, mencerminkan distribusi otoritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas secara berjenjang dalam sistem layanan.
29	*INA-CBG*	*Indonesian Case Base Groups*, yaitu sistem pembayaran layanan kesehatan dalam JKN yang menetapkan tarif tetap berdasarkan kelompok diagnosis tanpa memandang lamanya perawatan atau jumlah tindakan yang diberikan.
30	*Intangible*	Tidak berwujud, merujuk pada karakteristik layanan kesehatan yang tidak dapat dilihat, diraba, atau diuji kualitasnya sebelum diterima oleh pasien, sehingga penilaian mutu bergantung pada persepsi dan indikator klinis terukur.
31	*Interprofessional Collaboration* (IPC)	Kolaborasi interprofesional, yaitu proses di mana berbagai profesi kesehatan bekerja bersama secara setara, saling menghormati, dan saling melengkapi dalam memberikan layanan yang komprehensif dan berpusat pada pasien.

32	*Interprofessional Education* (IPE)	Pendidikan interprofesional, yaitu pendekatan pendidikan yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai profesi kesehatan untuk belajar bersama, dari satu sama lain, dan tentang satu sama lain guna membangun kompetensi kolaborasi.
33	*Jaminan Kesehatan Nasional* (JKN)	Program jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014 untuk mewujudkan akses layanan kesehatan yang universal dan berkeadilan bagi seluruh penduduk Indonesia.
34	KARS	Komisi Akreditasi Rumah Sakit, yaitu lembaga independen yang berwenang melakukan penilaian dan pemberian status akreditasi terhadap rumah sakit di Indonesia berdasarkan standar mutu dan keselamatan yang telah ditetapkan.
35	*Komite Keperawatan*	Struktur tata kelola profesional keperawatan yang independen dari manajemen, berfungsi memastikan praktik keperawatan di institusi diselenggarakan sesuai standar profesi melalui kredensial, audit, dan pembinaan etika.
36	*Length of Stay* (LOS)	Lama rawat inap, yaitu jumlah hari seorang pasien dirawat di fasilitas kesehatan dari tanggal masuk hingga tanggal keluar, merupakan indikator efisiensi layanan yang sangat diperhatikan dalam era JKN.
37	*Matriks Structure*	Struktur organisasi yang menggabungkan elemen fungsional dan *divisional* secara bersamaan, sehingga setiap individu memiliki dua jalur pelaporan yaitu kepada pimpinan fungsional dan pimpinan proyek atau program.
38	*Model Tim Keperawatan*	Model pemberian asuhan di mana sekelompok perawat dengan berbagai tingkat kompetensi bekerja bersama di bawah koordinasi seorang ketua tim untuk memberikan asuhan kepada sekelompok pasien tertentu.
39	*Multidisiplin*	Pendekatan layanan yang melibatkan berbagai profesi dan disiplin ilmu yang masing-masing berkontribusi dengan perspektif dan keahlian uniknya dalam proses

		diagnosis, pengobatan, dan pemulihan pasien secara komprehensif.
40	*Nurse-to-Patient Ratio*	Rasio perawat terhadap pasien, yaitu perbandingan jumlah perawat yang bertugas dengan jumlah pasien yang ditangani dalam satu *shift*, merupakan variabel struktural yang berpengaruh signifikan terhadap keselamatan pasien.
41	*Patient-Centered Care*	Asuhan berpusat pada pasien, yaitu pendekatan layanan yang menempatkan pasien sebagai subjek aktif dalam proses perawatan, menghormati nilai, preferensi, dan kebutuhan unik setiap individu dalam setiap keputusan klinis.
42	*Phlebitis*	Peradangan vena yang seringkali disebabkan oleh pemasangan infus intravena, merupakan salah satu indikator mutu keperawatan yang dipantau secara rutin sebagai cerminan kualitas praktik keperawatan dasar.
43	*Primary Nursing*	Model pemberian asuhan keperawatan di mana satu perawat profesional bertanggung jawab penuh atas asuhan seorang pasien sejak masuk hingga keluar dari fasilitas layanan, menciptakan hubungan terapeutik yang berkelanjutan dan akuntabel.
44	*Puskesmas*	Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi ujung tombak sistem layanan primer di Indonesia, memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
45	*Root Cause Analysis*	Analisis akar masalah, yaitu metode investigasi sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab mendasar dari suatu insiden atau masalah, bukan sekadar gejala permukaannya, sebagai dasar perbaikan sistem.
46	*Scalar Principle*	Prinsip skalar, yaitu prinsip pengorganisasian yang menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab tersusun secara bertingkat dari posisi paling tinggi hingga terendah dalam hierarki, membentuk rantai yang tidak terputus.

47	*SBAR*	*Situation, Background, Assessment, Recommendation*, yaitu kerangka komunikasi terstruktur yang paling banyak digunakan dalam proses *handover* keperawatan untuk memastikan transfer informasi klinis yang sistematis dan komprehensif.
48	*Shared Governance*	Model tata kelola keperawatan yang memberikan otonomi, akuntabilitas, dan kewenangan bermakna kepada perawat pelaksana dalam pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan standar praktik dan lingkungan kerja mereka.
49	*Sistem Kesehatan Nasional* (SKN)	Tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum.
50	*Skill Mix*	Kombinasi perawat dengan berbagai tingkat kompetensi dalam satu tim, dirancang secara proporsional untuk mengoptimalkan kualitas layanan sekaligus efisiensi penggunaan sumber daya manusia keperawatan.
51	*Span of Control*	Rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang secara efektif dapat diawasi, diarahkan, dan dibimbing oleh seorang pimpinan, merupakan variabel struktural yang berpengaruh terhadap efektivitas supervisi dan kualitas layanan.
52	*Spesialisasi*	Pengembangan keahlian mendalam di bidang atau area layanan tertentu dalam keperawatan, seperti keperawatan kritis, onkologi, atau perioperatif, yang membutuhkan kompetensi di atas standar keperawatan umum.
53	*Teach-Back*	Metode verifikasi efektivitas edukasi di mana pasien atau keluarga diminta untuk mendemonstrasikan kembali pemahaman dan keterampilan yang telah diajarkan, memastikan informasi benar-benar dipahami dan dapat diaplikasikan.
54	*Tata Kelola Klinis*	Lihat *Clinical Governance*; sistem tanggung jawab yang mencakup seluruh mekanisme yang digunakan

		organisasi untuk memastikan bahwa praktik klinis dijalankan pada standar tertinggi yang berbasis bukti.
55	*Transparency* (Transparansi)	Keterbukaan dalam pengelolaan organisasi, yaitu kondisi di mana informasi tentang kinerja, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya tersedia secara terbuka dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
56	*Triase*	Proses seleksi dan prioritisasi pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi klinis yang ditemukan saat pertama tiba di fasilitas layanan, menentukan urutan dan kecepatan penanganan yang diperlukan.
57	*Turnover*	Tingkat pergantian tenaga, yaitu proporsi karyawan yang meninggalkan organisasi dalam periode tertentu, merupakan indikator penting kesehatan organisasi yang berdampak signifikan terhadap kualitas layanan dan efisiensi biaya.
58	*Unity of Command*	Kesatuan komando, yaitu prinsip pengorganisasian yang menetapkan bahwa setiap anggota organisasi hanya menerima perintah dan bertanggung jawab kepada satu atasan langsung yang jelas dalam setiap waktu.
59	*Value-Based Care*	Layanan berbasis nilai, yaitu paradigma layanan kesehatan yang mengukur keberhasilan berdasarkan kualitas hasil klinis yang dicapai relatif terhadap biaya yang digunakan, bukan sekadar volume layanan yang diberikan.
60	*Ward Round* Multidisiplin	Visite bersama, yaitu mekanisme koordinasi yang mempertemukan seluruh anggota tim kesehatan dalam satu momen terjadwal untuk meninjau kondisi pasien, mendiskusikan perkembangan, dan menyepakati rencana layanan secara kolektif.

BAB 3

KEPEMIMPINAN KEPERAWATAN DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

Identitas Bab

- **Mata kuliah :** Manajemen Keperawatan
- **Bab/Modul :** 3
- **CPMK terkait:** Menerapkan kepemimpinan keperawatan, manajemen perubahan, komunikasi efektif, kolaborasi dan manajemen konflik dalam pengelolaan tim
- **CPL 3:** Mampu menerapkan kepemimpinan keperawatan, komunikasi efektif, kolaborasi dan manajemen konflik serta perubahan dalam tim

Sub - CPMK Bab (Learnin Outcomes Bab)

Capaian Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa mampu:

3.1. Memilih pendekatan kepemimpinan sesuai situasi kerja dan kebutuhan tim

3.2. Menyusun langkah manajemen perubahan yang terukur (tujuan, pemangku kepentingan, indikator capaian)

Indikator Ketercapaian

- Skor evaluasi skor bab 5 baian dari KZ-01 ≥70
- Mampu memetakan peran perawat pada scenario dengan akurasi ≥ 80% (latian kasus)
- Skor observasi profesionalisme dasar lebih dari ¾ (formatif, bukti masuk portofolio/observasi)

Peta Konsep Bab (Concept map-versi teks)

Manajemen keperawatan --->proses koordinasi dan interaksi sumber daya keperawatan --->perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian---->memberikan asuhan keperawatan profesional yang efektif dan efisien--->seni mengelola staf dan sumber daya -----> tujuan pelayanan kesehatan

Kata Kunci

Kepemimpinan Keperawatan, Manajemen Perubahan, Manajemen Konflik, Komunikasi efektif, Kolaborasi, Pengelolaan tim

Uraian Materi

Kepemimpinan merupakan kemampuan memberi inspirasi kepada orang lain untuk bekerja sama sebagai suatu kelompok agar dapat mencapai suatu tujuan umum. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu, untuk mencapai suatu tujuan (Maryana 2023). Berdasarkan kekuasaan dan wewenanggaya kepemimpinan menurut Gilles (1996) dibagi menjadi empat yaitu otoriter, demokratis, partisipatif, bebas tindak (Nursalam 2002).

Vinitha, J., & Jenardhanan. (2022) menjelaskan bahwa kesuksesan atau kegagalan sesuatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, salah satunya adalah kepemimpinan yang dijalankan, maka motivasi pegawai akan semakin tinggi. Pemimpinan yang sukses adalah apabila pemimpinan tersebut mampu menjadi pencipta dan mendorong bagi pegawainya. Pemimpinan tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh bagi pegawainya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. al tersebut juga didukung pendapat Kusworo (2019) seorang pemimpin berada dalam posisi terbaik untuk memfasilitasi perubahan karena dianggap sebagai agen perubahan.

Kepemimpinan di Rumah Sakit khususnya ruangan rawat inap dipimpin oleh kepala ruangan merupakan pemimpin yang langsung membawahi perawat pelaksana dan pelaksanaan tugas perawat ruang rawat inap merupakan suatu unsur proses dalam manajemen Rumah Sakit. Kepala ruangan memiliki peranan penting sebagai seorang manajer sekaligus sebagai seorang pemimpin. Kepala Ruangan memiliki tanggung jawab dalam menggerakkan perawat pelaksana. Oleh karena itu, kepala ruangan juga memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perawat (Nainggolan, NT, dkk 2021).

A. Memilih pendekatan kepemimpinan sesuai situasi kerja dan kebutuhan tim

Istilah manajemen dan kepemimpinan sering diartikan hanya berfungsi pada kegiatan supervisi, tetapi dalam keperawatan fungsi tersebut sangatlah luas. Jika posisi Anda sebagai seorang ketua tim, kepala ruang atau perawat pelaksana dalam suatu bagian, Anda memerlukan suatu pemahaman tentang bagaimana mengelola dan memimpin orang lain dalam mencapai tujuan asuhan keperawatan yang berkualitas. Sebagai perawat profesional, Anda tidak hanya mengelola orang tetapi sebuah proses secara keseluruhan yang memungkinkan orang dapat menyelesaikan tugasnya dalam memberikan asuhan keperawatan serta meningkatkan keadaan kesehatan pasien menuju ke arah kesembuhan.

1. Manajemen Hubungan Antar Manusia

Hubner (2006) menekankan bahwa jika manajemen memberikan perhatian penuh kepada pegawai, maka hasil produksi akan meningkat dengan tidak mengabaikan kondisi lingkungan kerja. Teori tersebut dikenal dengan hawthorne effect, di mana seseorang akan merespons kejadian dan terus belajar manakala mereka merasa terus diperhatikan dan didukung oleh manajemen.

Mayo (1930) juga menemukan bahwa lingkungan kelompok dan sosial baik formal maupun informal merupakan suatu faktor dalam menentukan produktivitas perusahaan dan memungkinkan semua pegawai ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

Douglas McGregor (1960) menekankan tentang pendapat Mayo (1930) dengan teori yang dikemukakannya mengenai manajemen perilaku terhadap pegawai (bagaimana memperlakukannya) yang berhubungan dengan kepuasan pegawai, teori tersebut dinamakan dengan Teori X dan Y.

- Teori X menekankan manajer agar percaya bahwa pegawai pada dasarnya adalah malas dan tidak mempunyai keinginan untuk meningkatkan produktivitas di suatu organisasi, sehingga perlu adanya supervisi secara terus-menerus dan arahan secara melekat.
- Teori Y menekankan manajer agar percaya bahwa pegawainya senang bekerja dengan motivasi yang timbul dari dalam dirinya serta berusaha untuk bekerja keras dalam mencapai tujuan individu dan organisasi.

Perlu dicatat bahwa McGregor tidak merasa bahwa antara Teori X dan Y bertentangan, tetapi lebih merupakan suatu komponen yang berkesinambungan, sehingga manajer harus menggabungkan komponen tersebut dalam mengelola dan memimpin pegawainya. McGregor tidak melihat bahwa teorinya, khususnya Teori Y, merupakan teori yang paling tepat diaplikasikan dalam setiap organisasi. Dia berpendapat bahwa teori tersebut tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya keputusan yang tepat dan penjelasan akurat dari seorang manajer dalam mengasumsikan atau menilai bawahannya.

Chris Argyris (1964) mendukung teori dari McGregor (1981) dan Mayo yang menyatakan bahwa manajer yang terlalu dominan menyebabkan pegawai tidak termotivasi dan cenderung pasif. Jika harga diri dan otonomi pegawai tidak terpenuhi, maka pegawai tersebut menjadi tidak termotivasi dengan baik, membuat masalah, dan akhirnya keluar dari pekerjaannya. Dia menekankan pentingnya pelibatan pegawai dalam mengambil suatu keputusan dan adanya suatu organisasi yang fleksibel dalam manajemennya.

Tabel 3.1: Perbandingan Teori X, Y, Z Douglas McGregor (Ouchi, 1981)

Teori X	Teori Y	Teori Z
1. Menghindari pekerjaan. bila ada kesempatan. Tidak senang bekerja. 2. Harus dirahkan Mempunyai sedikit ambisi. Menghindar dari tanggung jawab 3. Memerlukan supervisi ketat. 4. Termotivasi oleh hukuman dan hadiah.	1. Senang bekerja. 2. Mandiri 3. Mempunyai tanggung jawab. 4. Kreatif dan berkembang 5. Menggunakan pendekatan ilmiah. 6. Memerlukan supervise seperlunya. 7. Berminat dalam menyelesaikan masalah organisasi,	1. Menekankan pada teori humanistis. 2. Fokus: motivasi yang lebih kepada karyawan untuk meningkatkan kepuasan kerja dan menghasilkan produksi. 3. Karakteristik: pengambilan keputusan bersama, masa bekerja yang lama, promosi jabatan yang lambat dan bertahap, supervisi tidak secaralangsung, menekankan pada pendekatan holistik.

Kompetensi Yang Harus Dimiliki Oleh Manajer Keperawatan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kepemimpinannya Pada Abad Ke-21

Penelitian mengenai kompetensi yang harus dimiliki manajer keperawatan telah dilaksanakan kepada 313 tenaga kesehatan di Australia (Harris dan Belakley, 1995). Kompetensi tersebut dikategorikan menjadi tujuh, yaitu:

1. Kepemimpinan
2. Pengambilan keputusan dan perencanaan
3. Hubungan masyarakat/komunikasi
4. Anggaran
5. Pengembangan
6. Personalitas/perilaku
7. Negosiasi

Tabel 3.2: Kategori Kompetensi

NO	Kompetensi	Penjabaran
1	**Kepemimpinan**	- Berkomunikasi tentang organisasi dan dalam memfasilitasi kegiatan organisasi dan pelaksanaan perubahan. - Mendelegasikan dan mendapatkan orang lain untuk melaksanakan tugas dan menerima tanggung jawab. - Menyeleksi dan memilih pegawai yang tepat. - Menciptakan budaya organisasi yang kondusif dan efektif - Mengonsultasikan dengan staf dan orang lain di luar organisasi yang sesuai tentang keadaan organisasi. - Mengenal kapan peraturan harus dilaksanakan (fleksibilitas)
2	Pengambilan keputusan dan perencanaan.	- Berpikir ulang dan menyusun kembali prioritas organisasi - Merespons secara cepat dan tepat tentang perubahan yang tidak diharapkan. - Mengantisipasi dan melaksanakan perencanaan perubahan anggaran. - Memberikan pedoman dan arahan tentang keputusan organisasi melalui pengetahuan dari pemerintah daerah,provinsi, dan nasional. - Menginterpretasi perubahan industri dan mengimplementasikan dalam organisasi - Menginterpretasikan perubahan ekonomi staf. - Menempatkan organisasi sebagai bagian yang penting dari pemerintahan.
3	Hubungan masyarakat/ komunikasi	- Empati, mendengar, tanggap terhadap semua pernyataan orang lain - Menciptakan situasi kondusif dalam komunikasi - Membaca dan tanggap terhadap situasi politik yang terjadi - Menunjukkan rasa percaya diri melalui kemampuan berkomunikasi (verbal/non verbal) memengaruhi orang lain - Berkomunikasi secara efektif melalui tulisan - Mengembangkan proses hubungan yang baik di dalam dan diluar organisasi

		- Menggunakan media untuk pemasaran/keuntungan organisasi
4	Anggaran	- Bertanya dan melihat rencana sebelumnya - Mengontrol anggaran - Menginterpretasikan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan - Merencanakan jauh ke depan (misalnya lima tahun ke depan). - Menggunakan pengukuran dan rata-rata industri. - Menyediakan risiko terhadap kekurangan keuangan. - Mengonsultasikan masalah keuangan.
5	Pengembangan	- Pengembangan tim kerja yang efektif. - Mempertahankan dan mengembangkan profesional antar staf hubungan - Memberikan umpan balik yang positif. - Menerapkan peran mentor yang efektif. - Menggunakan sistem pemberian penghargaan yang baik, - Mengembangkan, meningkatkan, dan meninjau indikator organisasi
6	Kepribadian	- Memfokuskan satu atau lebih dari dua kejadian dalam satu periode. - Mengaplikasikan filosofi manajemen dan komitmen terhadap kualitas pelayanan. - Mengambil keputusan yang tepat, - Mengelola stres individu. - Menggunakan koping yang efektif pada setiap masalah. - Mensyukuri nikmat yang telah diberikan atas keberhasilan pencapaian tujuan
7	Negosiasi	- Mengidentifikasi dan mengelola konflik. - Memfasilitasi perubahan. - Mendemonstrasikan pemahaman tentang perbedaanpendapat. - Melakukan klarifikasi kejadian yang melibatkan seluruh staf - Melakukan negosiasi dengan staf, kelompok, dan organisasi luar. - Menjadi mediator terjadinya konflik antar staf atau kelompok.

B. Menyusun langkah manajemen perubahan yang terukur (tujuan, pemangku kepentingan indikator capaian)

1. Pengertian Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan merupakan proses sistematis yang dirancang untuk membantu individu, tim, dan organisasi dalam melakukan transisi dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan. Menurut Kotter (1996), manajemen perubahan adalah serangkaian langkah yang bertujuan untuk memastikan perubahan dapat diimplementasikan secara efektif dengan mengatasi tantangan yang muncul selama proses tersebut. Hal ini mencakup pengelolaan aspek emosional, teknis, dan operasional dari perubahan.

Manajemen perubahan adalah disiplin yang mengintegrasikan aspek teknis dan manusia untuk mencapai transformasi yang sukses dalam organisasi. Setiap model atau pendekatan yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi, lingkungan, dan individu yang terlibat. Keberhasilan implementasi manajemen perubahan membutuhkan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, terutama para pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengarahkan proses.

2. Komponen Utama Manajemen Perubahan

Komponen utama manajemen perubahan mencakup berbagai aspek yang saling mendukung untuk memastikan keberhasilan transisi.

a. Kepemimpinan yang efektif Menurut Kotter (1996), komponen pertama adalah kepemimpinan yang efektif, yang berperan sebagai pemandu utama dalam proses perubahan. Pemimpin harus mampu memberikan visi yang jelas dan memotivasi seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan perubahan.
b. Komunikasi. Komunikasi adalah komponen kedua yang sangat penting dalam manajemen perubahan. Burnes (2004) menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan antara manajemen dan karyawan. Informasi yang transparan dan konsisten memungkinkan semua pihak memahami tujuan dan manfaat perubahan.
c. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah komponen ketiga yang dijelaskan oleh Hiatt (2006). La menambahkan bahwa pelatihan memungkinkan individu memperoleh keterampilan baru yang diperlukan untuk mendukung perubahan. Proses ini juga membantu mengurangi resistensi dengan meningkatkan kepercayaan diri individu terhadap perubahan.

d. Keterlibatan karyawan. Komponen keempat adalah keterlibatan karyawan dalam proses perubahan. Bridges (2009) menerangkan bahwa melibatkan karyawan dalam perencanaan dan pelaksanaan perubahan dapat meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi resistensi. Keterlibatan ini juga membantu mengidentifikasi potensi hambatan sejak dini.
e. Teknologi. Menurut Hammer dan Champy (1993), teknologi merupakan komponen kelima yang mendukung manajemen perubahan. Penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses adaptasi. Namun, teknologi juga harus diimbangi dengan pelatihan yang memadai untuk memastikan penggunaannya secara optimal.
f. Evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik adalah komponen keenam yang disebutkan oleh Lewin (1951). Ia menjelaskan bahwa evaluasi terus- menerus diperlukan untuk mengukur efektivitas perubahan. Umpan balik dari berbagai pihak memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian yang diperlukan selama proses perubahan berlangsung.

3. Tujuan Manajemen Perubahan

Kotter (1996) menjelaskan bahwa salah Tujuan utama manajemen perubahan adalah memastikan transisi yang sukses dan minim gangguan. Satu tujuan penting adalah meningkatkan daya saing organisasi di tengah perubahan lingkungan yang cepat. Dengan perubahan yang efektif, organisasi dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap tantangan eksternal.

Burnes (2004) menambahkan bahwa tujuan lainnya adalah meningkatkan efisiensi operasional melalui restrukturisasi atau penerapan teknologi baru. Perubahan yang terencana memungkinkan organisasi mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Hiatt (2006) menerangkan bahwa tujuan manajemen perubahan juga mencakup pengelolaan resistensi. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat mengurangi hambatan yang timbul dari individu atau kelompok yang tidak setuju dengan perubahan.

Hammer dan Champy (1993) menjelaskan bahwa manajemen perubahan bertujuan untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih inovatif dan adaptif. Perubahan yang berhasil mendorong terciptanya pola pikir yang terbuka terhadap pembaruan. Menurut Bridges (2009), tujuan lainnya adalah memberikan dukungan emosional kepada individu yang mengalami transisi. Manajemen perubahan yang baik memperhatikan aspek psikologis untuk memastikan individu merasa didukung selama proses berlangsung. Lewin (1951) menambahkan bahwa manajemen perubahan bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi keberlanjutan organisasi. Dengan

demikian, perubahan tidak hanya bersifat sementara tetapi dapat membawa dampak jangka panjang yang positif.

4. Pendekatan dalam Manajemen Perubahan

Pendekatan manajemen perubahan dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi.

a. Model delapan langkah Kotter (1996), Kotte mengembangkan model delapan langkah, yang mencakup menciptakan urgensi, membentuk koalisi pemimpin, dan mengkomunikasikan visi perubahan. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan panduan praktis bagi organisasi.
b. Model tiga tahap Lewin (1951), Lewin menjelaskan pendekatan tiga tahap, yaitu
   1) Unfreezing (mencairkan kondisi lama)
   2) Changing (melakukan perubahan)
   3) Refreezing (membekukan kembali dalam pola baru). Model ini berfokus pada proses psikologis dan struktural yang diperlukan untuk melakukan perubahan secara efektif.
c. Model ADKAR Hiatt (2006), Hiatt mengembangkan model ADKAR, yang menekankan lima elemen utama:
   1) Awarenes (kesadaran)
   2) Desire (keinginan)
   3) Knowlede (pengetahuan)
   4) Ability (kemampuan)
   5) Reinforcement (penguatan). Pendekatan ini membantu organisasi memetakan kebutuhan individu dalam mendukung perubahan.
d. Pendekatan berbasis system (Burnes 2004), Menurut Burnes pendekatan berbasis sistem juga relevan dalam manajemen perubahan. Pendekatan ini menyoroti pentingnya memahami organisasi sebagai sistem yang saling terkait, sehingga perubahan pada satu bagian akan memengaruhi bagian lainnya.
e. Pendekatan reenineering (Bridges (2009) Brides menambahkan pendekatan transisi, yang berfokus pada pengalaman individu selama perubahan. Pendekatan ini penting untuk mengelola aspek emosional dan psikologis dari perubahan.
f. Pendekatan reenineering (Hammer dan Champy (1993) Hammer dan Champy menerangkan pendekatan reengineering, yang berfokus pada restrukturisasi proses bisnis untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Pendekatan ini sering kali digunakan dalam transformasi besar-besaran.

5. Faktor Keberhasilan Manajemen Perubahan

Keberhasilan manajemen perubahan bergantung pada beberapa faktor kunci.

a. Kempimpinan yang kuat Kotter (1996) menjelaskan bahwa kepemimpinan yang kuat adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi tim untuk menghadapi tantangan perubahan.
b. Komunikasi yang efektif Burnes (2004) menambahkan bahwa komunikasi yang efektif adalah faktor kedua. Komunikasi yang jelas dan terbuka memungkinkan semua pihak memahami tujuan, manfaat, dan langkah-langkah perubahan.
c. Keterlibatan karyawan Menurut Hiatt (2006), keterlibatan karyawan juga menjadi faktor keberhasilan yang penting. Dengan melibatkan karyawan, organisasi dapat mengurangi resistensi dan meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan.
d. Dukungan emosional Bridges (2009) menerangkan bahwa dukungan emosional adalah faktor lain yang berkontribusi pada keberhasilan. Dengan memberikan perhatian pada aspek psikologis, organisasi dapat membantu individu merasa lebih nyaman dengan perubahan.
e. Teknologi yang mendukung Hammer dan Champy (1993) menyebutkan teknologi sebagai faktor pendukung keberhasilan. Teknologi yang tepat dapat mempercepat proses adaptasi dan meningkatkan efisiensi operasional.
f. Evaluasi berkelanjutan Lewin (1951) menambahkan bahwa evaluasi terus-menerus adalah kunci untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Umpan balik dari berbagai pihak memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian yang diperlukan.

C. Teori dan Model Manajemen Perubahan

1. Teori Manajemen Perubahan

Terdapat sembilan teori besar tentang manajemen perubahan:

a. Teori Force-Field dipelopori Kurt Lewin, 1951

Kurt Lewin, Bapak Manajemen Perubahan mengemukakan teori Force-Field yang mengutamakan kekuatan-kekuatan penekan. Perubahan terjadi karena tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Perubahan yang ingin dilakukan nantinya akan berhadapan dengan keengganan untuk berubah (resistences) maka perlu dikelola dengan memperkuat driving forces agar dapat melemahkan kelompok resisten. Kurt Lewin merumuskan langkah:

- Unfreezing
- Changing

- Refreezing

Ketiga tahap ini menjelaskan perlunya proses penyadaran tentang pentingnya perubahan yang selanjutnya melakukan perubahan dengan memperlemah resistensi. Pada tahap akhir, diperlukan membawa organisasi kembali kepada keseimbangan.

2. Teori Motivasi dari Beckhard dan Harris, 1987

Teori Motivasi merumuskan bahwa perubahan akan terjadi kalau terpenuhi syaratsyarat berikut:

a. Manfaat-Biaya, manfaat yang diperoleh lebih besar akibat adanya perubahan.
b. Ketidakpuasan, adanya ketidakpuasan yang kuat dari keadaan sekarang.
c. Persepsi Masa Depan, anggota organisasi melihat adanya harapan yang lebih baik di masa depan.
d. Cara Praktis, meyakini adanya cara yang praktis dilakukan untuk keluar dari situasi sekarang.

3. Teori Proses Perubahan Manajerial dari (Beer, 1990)

Teori Proses Perubahan Manajerial menyadari perlunya melibatkan banyak orang untuk mewujudkan perubahan yang kendali dipegang oleh pemimpin organisasi yang berusaha untuk memperoleh dukungan, konsensus dan komitmen. Dalam menjalankan misi perubahan, teori ini mengadopsi ilmu-ilmu lain seperti Psikologi, Sosiologi dan Antropologi, sehingga seorang pemimpin memiliki peta psikologis dan budaya organisasi berbasis karakter individu sehingga dapat meminimalisir stres dan konflik dalam proses perubahan.

Teori-Teori Organizational Development dalam Perubahan Teori-teori Pengembangan Organisasi dalam Perubahan Organisasi merupakan teori yang menyentuh dua kategori yang berinteraksi, yaitu manusia dan teknologi. Manusia adalah elemen yang melakukan proses organisasi seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Sedangkan teknologi elemen yang mempengaruhi struktur organisasi, seperti desain pekerjaan, metode kerja, dan desain organisasi. Teori ini meyakini bahwa perlu adanya pendekatan tekno-struktur dan manusia-proses agar intervensi pada dua kategori ini menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia dalam penyelesaian tugas.

4. Teori Perubahan Alfa, Beta, dan Gamma

Teori Perubahan Alfa-Beta dan Gamma yang merumuskan bahwa

a. Perubahan Alfa adalah perubahan kepercayaan yang terjadi pada satu dimensi waktu yang stabil sebelum dan setelah adanya tim kerja.
b. Perubahan Beta yaitu perubahan yang terjadi dalam menilai kepercayaan.
c. Perubahan Gamma, yaitu perubahan yang terjadi karena manusia atau kelompok melihat adanya faktor yang lebih penting dari yang sedang diamati.

5. Teori Contingency dalam Manajemen Perubahan dari Tannembaum dan Schmidt, 1973.

Teori Contingency dalam Manajemen Perubahan berpendapat bahwa keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh gaya yang dianut dalam mengelola dan mengimplementasi perubahan. Teori Contingency (kemungkinan) mengatakan bahwa tidak hanya motivasi, komitmen, dan partisipasi anggota organisasi yang dibutuhkan tetapi perlu menganalisis kesiapan kedua belah pihak.

6. Teori-teori Manajemen Kerjasama

Teori Kerjasama, meyakini bahwa perubahan tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama dari semua pihak. Teori ini mempelajari, mengapa manusia mau memutuskan untuk bekerjasama dan bagaimana memperoleh kerjasama. Menurut Williams (2002), orang mau bekerjasama, karena:

a. Motivasi memperoleh penghargaan atau khawatir mendapatkan sanksi
b. Motivasi kesetiaan terhadap profesi, pekerjaan, atau perusahaan
c. Motivasi moral, karena dengan bekerjasama dapat diterima secara moral
d. Motivasi menjalankan keahlian
e. Motivasi karena sesuai dengan sikap hidup
f. Motivasi kepatuhan terhadap kekuasan

7. Teori-Teori untuk Mengatasi Resistensi dalam Perubahan

Teori-teori untuk Mengatasi Resistensi dalam Perubahan menawarkan cara mengatasi resistensi dalam melakukan perubahan. Teori ini mengajukan enam strategi untuk mengatasi resistensi, yaitu: Komunikasi, Partisipasi, Fasilitasi, Negosiasi, Manipulasi, dan Paksaan. Teori ini mempunyai fleksibilitas, bahwa tiap kelompok yang berbeda, maka teori yang digunakan juga berbeda, tergantung tingkat resistensi

8. Model Accounting-Turaround dari Harlan D.Platt, 1998 (Kasali,2006)

Model Accounting-Turaround lebih menekankan kepada akuntansi dan hukum. Teori ini menyatakan bahwa tidak semua korporat (organisasi) dapat diselamatkan atau untuk berubah, harus ada persyaratan untuk itu, diantaranya: adanya dukungan dari para stakeholder, masih adanya core business yang mampu mendatangkan cashflow, adanya tim manajemen yang kokoh, sumber-sumber pembiayaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Teori Putarhaluan (turnaround) dapat dilakukan oleh organisasi yang mengalami penurunan karena kerugian atau manajerial yang tidak baik. Guna melakukan perbaikan, hal pertama yang dilakukan adalah analisis keuangan organisasi. Model Accounting-Turaround memang sangat teknis dibandingkan delapan teori sebelumnya yang telah dijelaskan.

9. Model Manajemen Perubahan

Model manajemen perubahan adalah sistem yang secara strategis membantu perusahaan dalam menavigasi periode transformasi dan transisi. Model manajemen perubahan membantu organisasi menjalani transisi dengan sukses yang menghasilkan hasil positif. Sala satu Model Kurt Lewin, misalnya, melibatkan proses perubahan tiga langkah yang:

- Mendorong karyawan untuk "mencairkan" dan melepaskan koneksi mereka dengan status quo,
- Mendukung penerimaan praktik baru,
- Membantu karyawan dalam membentuk kembali, "membekukan kembali," dan memperkuat cara-cara baru.

a. Peran Pemimpin SDM dalam Model Mnaajemen Perubaan

Karyawan harus menunjukkan ketahanan dan kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan jika mereka ingin berhasil di dunia kerja saat ini. Orang secara naluriah cenderung menolak perubahan. Dengan model perubahan yang tepat, pemimpin SDM dapat membimbing karyawan untuk menyelaraskan keyakinan dan emosi mereka dengan perubahan. Memimpin karyawan melalui proses penerimaan ini meningkatkan:

1) Produktivitas
2) Penyimpanan
3) Pertunangan
4) Motivasi

Profesional SDM dapat menerapkan praktik berikut saat mengelola model manajemen perubahan:

1) Buat Peta Jalan (roadmap) Pimpinan SDM harus menetapkan strategi untuk mengajak karyawan mengikuti perubahan yang diusulkan. Menentukan rencana tindakan akan membantu pimpinan dan personel SDM tetap pada jalur yang benar dan mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan tersebut harus memenuhi tujuan pemangku kepentingan dan mempersiapkan karyawan untuk beradaptasi dan memperoleh keterampilan yang diperlukan agar dapat berkembang dalam format baru.
2) Berkomunikasilah dengan Karyawan Perubahan dapat menimbulkan keraguan dan disorientasi di antara karyawan. Mendengarkan secara aktif berbagai kekhawatiran karyawan mencerminkan pertimbangan dan rasa hormat yang tulus. Selama proses perubahan, para pemimpin SDM perlu mengakui kekhawatiran karyawan untuk melanjutkan dengan perlawanan yang minimal. Memberi tahu karyawan tentang rincian proses penyesuaian dapat mengurangi kecemasan. Semakin banyak karyawan mengetahui tentang perubahan yang akan datang, semakin mereka dapat dengan mudah mendukung perkembangan tersebut. Selain itu, sistem umpan balik karyawan memungkinkan karyawan untuk berbagi masukan dan berkontribusi pada proses tersebut daripada merasa dipaksa untuk bergabung.
3) Mengembangkan Metode Pemasaran Internal. Pemimpin SDM dapat meminta bantuan tim pemasaran untuk memotivasi karyawan agar mau bekerja sama. Metode pemasaran harus menyampaikan alasan mengapa perubahan itu penting dan bermanfaat, mengatasi alasan penolakan, dan mendampingi personel melalui proses mengubah perspektif mereka. Kampanye pemasaran berbasis data yang sederhana dan lugas serta menjawab kekhawatiran orang dapat memacu penerimaan dan dukungan untuk pengembangan di masa mendatang.
4) Memimpin dengan memberi contoh Profesional SDM harus mendukung perubahan dengan sepenuh hati untuk menumbuhkan rasa percaya dan antusiasme pada karyawan dan manajer. Memperlakukan karyawan dengan empati, pertimbangan, dan rasa hormat selama proses berlangsung akan mendorong mereka untuk percaya pada perubahan juga.

Bagaimana model manajemen perubahan dapat meningkatkan budaya perusahaan? Dengan mengandalkan kerangka kerja yang telah teruji dan terbukti untuk memelihara dukungan karyawan, perusahaan dapat memfasilitasi proses perubahan yang lebih lembut, lebih berempati, dan efektif. Sistem yang memberdayakan karyawan untuk menerima perubahan

dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Setelah mengalami masa transisi yang sukses, karyawan dapat terus menyumbangkan energi dan dedikasi baru bagi budaya perusahaan.

D. Agen Pembaru

Dalam perkembangan karier profesional, setiap individu akan terpanggil untuk menjadi agen pembaru. Menjadi agen pembaru akan menjadi hal yang sangat menarik dan menyenangkan sebagai bagian dari peran profesional. Keadaan tersebut akan terjadi jika Anda merespons setiap perubahan yang terjadi di sekeliling Anda (Vestal, 1999).

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengontrol perilaku dan cara mengelola perubahan. Seseorang yang memilih berperilaku sebagai pionir, penjelajah, seorang yang berpikiran positif, atau seorang dengan motivasi yang tinggi. Anda dapat mengawali proses perubahan dengan mengurangi/menghilangkan hambatan-hambatan dan memulainya tahap demi tahap. Hal ini tidak sulit apabila perawat dapat mengontrol perilakunya, sehingga di masa depan ia dapat menjadi pemimpin yan baik.

Individu perlu menjadi bagian dari perubahan dan tidak menjadi orang yang resistan terhadap perubahan untuk menjadi seorang agen pembaru yang efektif. Partisipasi aktif dalam perubahan yang sedang berlangsung akan menjadikan peran anda menjadi lebih bermakna di kemudian hari.

Agen pembaru berperan untuk menyeleksi setiap fenomena yang terjadi dan memilih hal-hal yang akan diubah termasuk al-al . Perubahan yang dipilih bukan hanya pada hal-hal yang mudah, melainkan juga pada hal-hal yang penuh tantangan. Sebagaimana pepata mengatakan, "Siapa saja bisa berhasil menyeberangi laut yang tenang, tetapi keberhasilan menyeberangi ombak akan mendapatkan penghargaan yang sesungguhnya. Setiap perubahan harus dihadapi dengan senang dan penuh humor. Yakinkan bahwa perubahan adalah hal yang menantang dan menjadi agen pembaru memang tidak mudah.

Selalu berpikiran ke depan daripada hanya merenungi hal-hal yang sudah terjadi pada masa lalu (fix the past). Berpikirlah suatu cara terbaru dan kesempatan untuk melaksanakan perubahan. Belajar dari kesalahan, dan berpikir terus ke depan akan menjadikan Anda seorang agen pembaru yang sukses. Hal yang harus disadari adalah bahwa apa yang Anda lakukan sekarang belum tentu dapat dipetik manfaatnya pada saat ini. Oleh karena itu, kesuksesan dalam perubahan harus disertai langkah-langkah antisipatif untuk kesuksesan institusi di masa depan

E. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-Case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh

Seorang kepala ruangan yang sedang mempersiapkan pembenahan ruangan termasuk metode asuhan, saat ini kepala ruangan tersebut mendapatkan tugas baru dari direktur rumah sakit untuk segera berangkat mengikuti kegiatan pelatihan manajerial. Sebagai kepala ruangan sebagian tugas di delegasikan kepada staf perawat dibawahnya.

Pertanyaan: Apakah aspek terpenting yang harus diperhatikan kepala ruangan tersebut?

Aktivitas 2--- *Shows How*

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Kala II

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
  OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Kepemimpinan keperawatan,
- Manajemen perubahan, komunikasi,
- Manajemen konflik dalam pengelolaan tim
- Manajemen aasuhan dan pelayanan keperawatan

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

Contoh:

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Kepemimpinan keperawatan
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian focus menentukan konsep dasar kepemimpinan dan manajemen keperawatan termasuk peran perawat menejer, manajemen konflik, dan manajemen resiko
5	Kompetensi	Mahasiswa mampu 1. Memahami fungsi manajemen keperawatan 2. Memahami manajemen perubahan 3. Menerapkan komunikasi efektif 4. Menjalin kolaborasi tim kerja 5. Mengatasi manajemen konflik 6. Memiliki perilaku professional
6	Kategori	1. Perilaku kepemimpinan keperawatan 2. Perilaku manajemen perubahan 3. Menerapkan manajemen konflik
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang kepala ruangan yang sedang mempersiapkan pembenahan ruangan termasuk metode asuhan, saat ini kepala ruangan tersebut mendapatkan tugas baru dari

		direktur rumah sakit untuk segera berangkat mengikuti kegiatan pelatihan manajerial. Sebagai kepala ruangan sebagian tugas di delegasikan kepada staf perawat dibawahnya. Apakah aspek terpenting yang harus diperhatikan kepala ruangan tersebut? TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Lakukan langkah awal berdasarkan skenario di atas 3. Tuliskan perihal apa saja yang anda sampaikan ke staf anda
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang kepala ruangan yang sedang mempersiapkan pembenahan ruangan termasuk metode asuhan, saat ini kepala ruangan tersebut mendapatkan tugas baru dari direktur rumah sakit untuk segera berangkat mengikuti kegiatan pelatihan manajerial. Sebagai kepala ruangan sebagian tugas di delegasikan kepada staf perawat dibawahnya. Apakah aspek terpenting yang harus diperhatikan kepala ruangan tersebut? TUGAS: 1. Lakukan pengkajian fokus berdasarkan skenario tersebut pada KS. 2. Lakukan langka awal berdasarkan skenario di atas 3. Tuliskan perihal apa saja yang anda sampaikan ke staf anda INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta dalam melakonkan sebagai kepemimpinan keperawatan 2. Menilai kemampuan peserta dalam memberi tuas kepada staf dalam perihal pendelegasian tugas 3. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Menyiapkan bahan yang akan didelegasikan kepada staf

		2. Membuat format pendelegasian tugas kepada staf yang diketahui oleh pimpinan
10	Setting station	Ruang kepala ruangan - Meja - Kursi - KS berperan sebagai staf - Laboran - Penguji Tata letak ruang: 1. Meja kepa aruan 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Komputer/leptop 2. Kertas pendeleasian 3. Pulpen 4. Meja kerja 5. Kursi Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	. ...
13	Referensi	

SOP Kepemimpinan Kepala Ruan dalam Pelayanan Keperawatan

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tanggung jawab				
1	Kebenaran kebutuhan ketepatan rencana kebutuhan tenaga keperawatan				
2	Keobjektifan dan ketepatan penilaian kinerja tenaga keperawatan				
3	Kelancaran kegiatan orientasi perawat baru				
4	Kebenaran dan ketepatan Protap/SOP pelayanan keperawatan				
B	Wewenang				
1	Meminta informasi dan arahan dari atasan				
2	Memberi petunjuk dan bimbingan pelaksanaan staf keperawatan				
3	Menandatangani surat dan dokumen yang ditetapkan menjadi wewenang karu				
4	Menghadiri rapat berkala dengan kepala bidang, wakil direktur, direktur rs untuk kelancaran pelayanan keperawatan				
5	Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan				

	peralatan dan mutu asuan keperawatan di ruang rawat				
C	Melaksanakan fungsi perencanaan				
1	Menyusun rencana kerja kepala ruangan				
2	Berperan serta dalam menyusun falsafa dan tujuan pelayanan keperawatan di ruan rawat yang bersangkutan				
3	Menyusun rencana kebutuan tenaga dari segi jumla maupun kualifikasi untuk diruang rawat koordinasi dengan kabid keperawatan				
D	Pergerakan				
1	Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan di rawat inap melalui kerjasama dengan petugas lain				
2	Menyusun jadwal dinas tenaga keperawatan sesuai dengan kebutuan pelayanan peraturan yang berlaku di rumah sakit				
3	Membimbing tenaga keperawatan untuk pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan sesuai standar				

4	Meneliti pengisian formulir sensus harian di ruang rawat				
5	Meneliti/memeriksa ulan pada saat penyajian makan pasien sesuai program diet				
E	Pengarahan, pengendalian dan penilaian				
1	Mengendalikan dan menilai pelaksanaan asuhan keperawatan yang telah ditentukan				
2	Mengawasi, mengendalikan dan menilai pendayagunaan tenaga keperawatan, obat-obatan dan peralatan				
3	Melakukan penelitian kinerja keperawatan yang berada di bawah tanggung jawab				
4	Mengawasi dan menilai mutu asuhan keperawatan sesuai standar yang berlaku secara mandiri atau koordinasi dengan tim pengendali mutu asuhan keperawatan				

F. Form Penilaian Osce Keperawatan

Form Penilaian Osce Keperawatan Station: Menerapkan Kepemimpinan Keperawatan

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Melaksanakan fungsi manajemen kepemimpinan	Adanya program rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang					3	
2	Menghitung jumlah SDM yang berdinas setiap sift dinas	Pembagian tugas sesuai di setiap sift dinas					3	
3	Ketersediaan peralatan sesuai kebutuhan	Peralatan yang tersedia ada dan berfungsi					1	
4	Perilaku professional	Komunikasi berjalan baik dengan sesama tim kerja dan tenaga keseatan					3	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

G. RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian OSCE KEPERAWATAN STATION: Kepemimpinan Keperawatan

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Mampu menjadi pemimpin dan memberi contoh kepada bawahan					1	
2. Mampu memberi motivasi kepada bawahan					2	
3. Peseta ujian mampu berkolaborasi dengan tim kerja					5	

4. Peserta ujian mampu mengadakan perubahan untuk peningkatan pelayanan di unit kerja nya					2	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Mampu menjalankan fungsi manajemen	Tidak melakukan fungsi manajemen	Melakukan fungsi manajemen sangat terbatas, hanya membuat perencanaan program kerja, tidak sistematis, dan tidak mampu melakukan fungsi manajemen yang lainnya	Melakukan fungsi manajemen cukup baik dan cukup sistematis, mampu mengorganisasikan SDM setiap shift dinas tetapi belum sepenuhnya mengevaluasi semua kinerja staf nya	Melakukan fungsi manajemen secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi perencanaan, organisasi, mengendalikan, memotivasi, mengawasi dan mengevaluasi
2. Mampu berkomunikasi ke semua staf dan tenaga kesehatan lainnya	Tidak mampu berkomunikasi dua ara dengan staf nya dan tim kesehatan nya lainnya sebagai unit kerja.	Berkomunikasi baik dengan staf tetapi belum mampu berkomunikasi dengan keluarga pasien terkait tindaklanjut pengobatan pasien karena kuran pendekatan dengan pasien dan keluarga pasien	Berkomunikasi baik dengan staf, pasien dan keluarga pasien sudah sistematis tetapi belum maksimal karena kesbukan pada saaat jam kerja	Berkomunikasi dengan baik kepada semua staf, tim tenaga kesehatan juga pasien dan keluarga sehingga pasien merasa nyaman dan diperhatikan

3. Mampu menyelesaikan konflik di unit kerja	Tidak mampu menyelesaikan konflik.	Menyelesaikan konflik anya sebagian saja lalu meninggalkan masala pada jam kerja	Melakukan penyelesaian masalah tetapi tidak sampai selesai dan tidak melaporkan ke atasan untuk mencari solusi	Menyelesaikan masalah dengan teknik manajemen konflik sehingga terselesaikan dengan baik dan membuat laporan ke atasan bawa konflik sudah teratasi
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak ada role model memberi conto sebagai leader kepada staf.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam role model kepada staf, komunikasi dengan tim kerja cukup baik	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan staf, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi yang baik, menjaga privasi, memperhatikan kebutuhan pribadi staf

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

H. DOPS (Does)

1. DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada kepemimpinanan dalam pelayanan keperawatan
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

2. Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Kepemipinan Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat berperilaku sebaai pemimpin dalam menyelesaikan masalah
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang kepemimpinan, tetapi juga dari kemampuannya melakukan aya kepemimpinan, memotivasi dan menyelesaikan masala dengan staf
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Dua perawat saling berdebat mengenai jadwal libur karena kekurangan staf seingga pelayanan pasien sempat terabaikan. Anda adalah kepala ruangan
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri kepada kepala ruangan dan pembimbing klinik memperhatikan jumlah tenaga perawat dengan jumla pasien. Kepala ruangan harus memiliki kebijakan dalam mengambil keputusan

Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menerapkan kepemimpinan dalam membuat kebijakan di unit kerjanya sehingga pelayanan keperawatan tetap berjalan dan memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menerapkan kepemimpnanan dalam pelayanan keperawatan
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi masala, tetapi masih perlu memperdalam cara mengatasi manajemen konflik.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus kepemimpinan, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

I. Portofolio

1. Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

2. Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel Portofolio pada Kepemimpinan Dalam Pelayanan Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus kepemimpinan dalam pelayanan keperawatan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada manajemen keperawatan, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan solusi, menjaga kenyamanan staf, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia mampu memimpin bawaan nya, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan kepemimpinan, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan kepemimpinan di unit kerjanya.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kepemimpinan dalam pelayanan keperawatan, manajemen konflik, manajemen perubaan.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali	Mahasiswa merefleksikan pentingnya kepemimpinan dalam

	risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	pelayanan keperawatan, ketepatan dalam mengambil keputusan dan membuat perubaan untuk peningkatan pelayanan keperawatan di unit kerjanya
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam berperan sebagai pemimpin dalam pelayanan keperawatan, mengatasai konflik dan manjemen perubahan membawa dampak positif di unit kerjanya
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus kepemimpinan, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan contoh yang baik untuk staf nya dan mengambil keputusan yan tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian menindaklanjuti masalah sampai mengambil solusi seingga pelayanan dalam keperawatan tidak terganggu
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada kepemimpinan dan manajemen konflik, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep manajemen kepemimpinan, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel Case Report pada kepemimpinan dalam pelayanan keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang dua perawat saling berdebat mengenai jadwal libur karena kekurangan staf seina pelayanan pasien sempat terabaikan. Anda adalah kepala ruangan
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data karyawan, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi karyawan setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat karyawan, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, menyelesaikan masala, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kepemimpinan dalam pelayanan keperawatan, manajemen konflik, mahasiswa menuliskan masalah jumlah perawat yang kurang seingga sulit mengatur jika ada dua perawat yang bersamaan libur
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa memiliki kepemimpinan dalam pelayanan keperawatan dan mampu mengatasi konflik di unit kerjanya
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan	Dari kepemimpinan dan manajemen konflik, mahasiswa belajar bahwa kepala ruangan

	kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	harus memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu mengatasi masalah staf di unit kerjanya.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa dia tidak hanya memahami konsep manajemen kepemimpinan, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan kepemimpinan yan professional

Tabel Refleksi Patient Safety pada Kepemimpinan Dalam Pelayanan Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Kepemimpinan Keperawatan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus kepemimpinan dalam pelayanan keperawatan, mahasiswa merefleksikan bahwa kepala ruangan yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan dan tidak mampu menatasi konflik membuat staf hilang motivasi yang berdampak terhadap pelayanan kepada pasien.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kepala ruangan tidak dapat memberi contoh yang baik kepada staf nya maka berpenaru teradap pelayanan
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada staf ini adalah hilan motivasi, tidak memiliki kinerja dan tidak mampu

	pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	memberikan asuhan keperawatan yan berkualitas
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan semanat kerja, tidak ada motivasi kerja
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya kepala ruanan yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu mengatasi konflik supaya pelayanan keperawatan berjalan dengan baik
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa denan memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu menatasi konflik maka seluru staf bekerja dengan nyaman dan memberikan asuan keperawatan yang professional
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan secara berkelanjutan.

J. Contoh Soal

Seorang kepala ruangan yang sedang mempersiapkan pembenahan ruangan termasuk metode asuhan, saat ini kepala ruangan tersebut mendapatkan tugas baru dari direktur rumah sakit untuk segera berangkat mengikuti kegiatan pelatihan manajerial. Sebagai kepala ruangan sebagian tugas di delegasikan kepada staf perawat dibawahnya. Apakah aspek terpenting yang harus diperhatikan kepala ruangan tersebut?

A. Menciptakan suasana memotivasi
B. Mempercayakan kekuasaan penuh
C. Mempercayakan pekerjaan untuk dilaksanakan
D. Memastikan memberikan tugas pada staf yang berkompeten
E. Mempercayakan tugas pada staf perawat baru yang tidak terlalu banyak pekerjaan

K. Tabel Red Flags & Eskalasi

Kepemimpinan Keperawatan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Kepala ruangan tidak memiliki jiwa kepemimpinan	Sumber daya yang ada di unit kerja tidak berfunsi maksimal	Segera diskusikan dengan atasan secara berjenjang
Pengorganisasian staf tidak ideal	Kualitas pelayanan menurun, kebutuan pasien tiidak terpenuhi	Eskalasi segera, segera laporkan ke atasan
Tidak mau menyelesaikan masalah	Risiko tinggi terjadi komplein	Segera laporkan ke atasan yang sedang berdinas
Perawat yang berdinas tiba tiba berhalangan datang	Kekurangan staf di jam dinas	Ambil kebijakan dan pertimbangkan
Terjadi pertentangan dengan staf karena tidak menerima perubahan	Penurunan kerja tim	Segera beri tanggapan yang bisa membangun semangat staf
Sulit di arahkan	Merasa lebih senior	Segera bicarakan kepada kepala bidang keperawatan

Form Checklist “Saya sudah bisa…”
Bab Kepemimpinan keperawatan
Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Tanggal : _____
Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian kepemimpinan	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan role model seorang menejer	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa memberi contoh gaya kepemimpinan	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa memotivasi staf	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa memengaruhi staf	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa berkomunikasi dengan staf	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menyusun rencana program kerja	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengorganisasikan staf pada saat berdinas	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mengevaluasi pekerjaan staf	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa mengatasi konflik ketika saya berdinas	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan fungsi manajemen keperawatan	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa memimpin rapat dengan staf	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa berkomunikasi dengan tim tenaga kesehatan, staf, pasien dan keluarga pasien	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

L. Daftar Pustaka

Amir, & Kolomboy, F. (2023). Buku Ajar Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan.

Bakri, M. H. (2017). Manajemen keperawatan (konsep dan aplikasi dalam praktik keperawatan profesional). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Beer, M., & Nohria, N. (2000). Cracking the Code of Change. Harvard Business Review, 78(3), 133-141.

Bolton, dkk. (1992). "Ten Steps for Managing Organisational Change" Journal of Nursing Administration, 22, 14-20.

Bridges, W. (2009). Managing Transitions: Making the Most of Change. Da Capo Press.

Cameron, E., & Green, M. (2015). Making Sense of Change Management: A Complete

Erita. (2019). *Buku Materi Pembelajaran Manajemen Keperawatan*. Program Studi Diploma Tiga Keperawatan. Universitas Kristen Indonesia. Jakarta

Guide to the Models, Tools, and Techniques of Organizational Change. Kogan Page

Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business.

Hersey, R, dan K. Blanchard. (1977). Management of Organisational Behavior:UtilizingHuman Resources. Edisi 3. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Hiatt, J. M. (2006). ADKAR: A Model for Change in Business, Government, and Our Community. Prosci Research. Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Harvard Business Review Press. Lewin, K. (1951). Field Theory in Social Science. Harper and Row.

Hubner, D.L. (2006). Leadership dan Nursing Care Management. Edisi 3. PhiladelphiaSaunders.

Kusworo. (2019). Manajemen konflik dan perubahan dalam organisasi. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.

Lewin, 1, (1999), Nursing Issues in Leading and Managing Change. St.Louis: Mosby Ma'arifin, H. 1999, "Perubahan dan Keperawatan di Indonesia". Makalah Seminar Nasional. Jakarta.

Maatvavirya R.W.,& Girsang, E. (2021) Analisis Faktor Gaya Kepemimpinan Kepala Ruangan Terhadap Kinerja Perawat Di Ruangan Rawat Inap Kelas 3 JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan), 6(3) 262 https://doi.org 10.30829/jumantik.v6i3.9718

Marquis, B., & Huston, C. J. (2017). Leadership roles and management functions in nursing : theory and application. Wolters Kluwer Health.

Maryana. (2023). Buku Ajar Manajemen Keperawatan (G. Riskiawan, Ed.; 1st ed.). PT Nasya Expanding Management.

McGregor, Douglas (1966). Kepemimpinan dan motivasi. Oxford, Inggris: M.I.T. Tekan. Diselamatkan di: psycnet.apa.org

Murray, E. (2017). Nursing Leadership and Management For Patient Safety and Quality Care (S. Rhyner, Ed.). F.A. Davis Company.

Nainggolan, N.T., dkk. (2021). Komunikasi organisasi: teori, inovasi dan etika. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Nursalam. (2002). Manajemen Keperawatan. Penerapan dalam Praktik KeperawatanProfesional. Jakarta: Salemba Medika.—.2007. Manajemen Keperawatan: Penerapan dalam Praktik Keperawatan Profesional. Edisi 2. Jakarta: Salemba Medika.

Seniwati, Ita, Anugrahwati, R., Silitonga, J. M., Hutagaol, R., Gunawan, D., Stella, S., Dherlirona, Kamilah, L., Anisah, S., & Solehudin. (2022). Buku Ajar Manajemen Keperawatan. CV. Feniks Muda Sejahtera.

Suhariyanto, Hardika, R., & Widyaningsih, T. (2023). Nursing Leadership and Management (E. D. Hapsari, N. Trilisiana, & I. W. Astuti, Eds.). Deepublish

Sunyoto, D. (2019). Manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Yogyakarta: CAPS.

Vestal. K.W. (1999). Nursing Management : Consepts and issues Lippicott Philadelphia

Vinitha, J., & Jenardhanan. (2022). Motivation in Nursing Management. Galore International Journal of Applied Sciences and Humanities, 6(1), 22–27. https://doi.org/10.52403/gijash.20220104

BAB 4

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KEPERAWATAN

Deskripsi

Topik ini membahas dasar-dasar manajemen sumber daya manusia (SDM) dalam keperawatan yang menjadi landasan dalam pengelolaan tenaga keperawatan. Mahasiswa diharapkan memahami konsep, fungsi, serta peran strategis SDM keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bagian ini diharapkan mahasiswa mampu merencanakan dan mengelola SDM Keperawatan (kebutuhan, penjadwalan, delegasi, supervisi) secara adil, aman, dan efisien.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu merencanakan kebutuhan dan penjadwalan SDM keperawatan berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan prinsip keadilan–keselamatan.

Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub CPMK)

1. Menetapkan kebutuhan kompetensi (skill mix) dan strategi pengembangan SDM Keperawatan
2. Menyusun rencana rekrutmen/penempatan dan pembinaan kinerja berbasis indicator

Uraian Materi

A. Pengertian Manajemen SDM Keperawatan

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) keperawatan merupakan suatu proses sistematis dalam mengelola tenaga keperawatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian guna mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien. Pengelolaan SDM keperawatan menjadi aspek yang sangat penting karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki intensitas interaksi paling tinggi dengan pasien, sehingga berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Nursalam, 2015). Manajemen keperawatan adalah proses bekerja melalui orang lain dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal (Marquis & Huston, 2017). Keberhasilan pelayanan keperawatan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu perawat, tetapi juga oleh kemampuan manajerial dalam mengelola SDM secara efektif.

Selain itu, Swanburg menekankan bahwa manajemen SDM keperawatan berfokus pada pengelolaan tenaga keperawatan sebagai aset utama organisasi, yang mencakup pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, serta penciptaan lingkungan kerja yang kondusif (Swanburg, 2000). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan SDM tidak hanya berorientasi pada kuantitas tenaga, tetapi juga pada kualitas dan kesejahteraan perawat.

B. Fungsi Manajemen SDM Keperawatan

Fungsi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) keperawatan merupakan rangkaian aktivitas sistematis yang digunakan untuk mengelola tenaga perawat secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Dalam praktik keperawatan modern, pengelolaan SDM tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan kerja tenaga keperawatan (Nursalam, 2015; Marquis & Huston, 2017). Secara klasik, fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), ketenagaan (staffing), pengarahan (*directing*/*actuating*), dan pengendalian (controlling) yang saling berkesinambungan dalam suatu siklus manajemen. Berikut fungsi-fungsi manajemen SDM Keperawatan:

1. Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan dalam SDM keperawatan mencakup identifikasi kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja, tingkat ketergantungan pasien,

serta standar pelayanan yang berlaku. Perencanaan yang tepat terbukti berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi kerja dan penurunan beban kerja perawat yang berlebihan.

2. Fungsi Pengorganisasian

Fungsi penggorganisasian melibatkan pengaturan struktur kerja, pembagian tugas, serta penetapan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi perawat. Pengorganisasian yang baik akan meningkatkan koordinasi tim dan efektivitas pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang jelas dapat meningkatkan kinerja perawat dan mengurangi konflik kerja.

3. Fungsi Ketenagaan

Fungsi ketenagaan dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) keperawatan merupakan proses pengelolaan tenaga keperawatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga secara tepat, baik dari segi jumlah, kualifikasi, maupun kompetensi. Fungsi ini mencakup kegiatan rekrutmen, seleksi, penempatan, orientasi, serta pengembangan tenaga keperawatan untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan keperawatan secara optimal.

4. Fungsi Pengarahan

Fungsi pengarahan berfokus pada upaya memotivasi, memimpin, dan mengarahkan tenaga keperawatan agar mampu bekerja secara optimal. Pengarahan mencakup kepemimpinan, komunikasi efektif, serta supervisi klinik. Studi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang transformasional dalam keperawatan berhubungan signifikan dengan peningkatan kinerja dan kepuasan kerja perawat.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian merupakan proses evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan keperawatan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui monitoring, audit keperawatan, dan penilaian kinerja. Evaluasi yang berkelanjutan, terbukti mampu meningkatkan mutu pelayanan serta keselamatan pasien (Huber, 2018; Yoder-Wise, 2019).

Dengan demikian, fungsi manajemen SDM keperawatan merupakan suatu proses yang terintegrasi dan dinamis. Implementasi yang optimal dari setiap fungsi tersebut akan menghasilkan tenaga keperawatan yang kompeten, profesional, serta mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien (Nursalam, 2015; Cummings et al., 2018).

C. Peran Strategis SDM Keperawatan

Sumber Daya Manusia (SDM) keperawatan memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan karena perawat merupakan tenaga profesional yang berada pada posisi terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Keberadaan perawat yang kompeten dan profesional tidak hanya menentukan kualitas asuhan keperawatan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, SDM keperawatan dipandang sebagai aset utama (*human capital*) yang harus dikelola secara efektif untuk mencapai mutu pelayanan yang optimal (Yoder-Wise et al., 2022).

Peran strategis SDM keperawatan tercermin dalam kontribusinya terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Perawat berperan dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kualitas pelayanan keperawatan sangat dipengaruhi oleh kompetensi, keterampilan, serta sikap profesional perawat dalam menjalankan praktik klinik. Oleh karena itu, pengelolaan SDM keperawatan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan dan kepuasan pasien (Marquis & Huston, 2017).

Selain itu, SDM keperawatan memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan pasien (*patient safety*). Perawat bertanggung jawab dalam menerapkan standar keselamatan, melakukan pemantauan kondisi pasien, serta mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian asuhan. Peran ini menuntut kemampuan klinis yang tinggi serta dukungan manajemen yang baik dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Kepemimpinan dalam keperawatan juga menjadi faktor penting dalam membangun budaya keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan (Huber, 2018).

Peran strategis lainnya adalah dalam aspek manajerial dan kepemimpinan. Perawat tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan, tetapi juga sebagai pengelola pelayanan keperawatan yang melibatkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perawat manajer bertanggung jawab dalam mengelola tenaga keperawatan, mengatur sumber daya, serta memastikan pelayanan berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa SDM keperawatan memiliki peran ganda sebagai pelaksana dan pengelola dalam sistem pelayanan kesehatan (Finkelman, 2022).

Sumber Daya Manusia keperawatan juga berperan dalam pengembangan organisasi dan inovasi pelayanan kesehatan. Dalam era transformasi digital dan perkembangan ilmu pengetahuan, perawat dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan profesional.

Pengembangan SDM yang berkelanjutan akan meningkatkan kinerja individu maupun organisasi serta mendukung adaptasi terhadap perubahan sistem pelayanan kesehatan (Yoder-Wise et al., 2022).

Dengan demikian, SDM keperawatan memiliki peran strategis yang multidimensional, meliputi aspek klinis, manajerial, keselamatan pasien, serta pengembangan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan SDM keperawatan harus dilakukan secara profesional, sistematis, dan berkelanjutan agar mampu menghasilkan tenaga keperawatan yang kompeten, produktif, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas serta berorientasi pada pasien.

D. Prinsip Manajemen SDM Keperawatan

Prinsip manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) keperawatan merupakan pedoman dasar yang digunakan dalam mengelola tenaga keperawatan agar dapat bekerja secara efektif, efisien, dan profesional dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam setiap fungsi manajemen, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, serta berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan berorientasi pada keselamatan pasien (Yoder-Wise et al., 2022). Berikut prinsip-prinsip manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Keperawatan:

1. **Berorientasi pada Mutu dan Keselamatan Pasien** Pengelolaan SDM keperawatan harus mengutamakan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Setiap kebijakan dan tindakan manajerial diarahkan untuk meminimalkan risiko serta meningkatkan standar asuhan keperawatan (Huber, 2022).
2. **Berbasis Kompetensi** Penempatan dan pengelolaan tenaga keperawatan harus disesuaikan dengan kompetensi, pendidikan, dan keterampilan yang dimiliki. Prinsip ini memastikan efektivitas kerja serta kualitas pelayanan yang optimal (Yoder-Wise et al., 2022).
3. **Keadilan dan Pemerataan** Pengelolaan SDM dilakukan secara adil dalam pembagian beban kerja, kesempatan pengembangan, serta penghargaan. Keadilan meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas perawat (Finkelman, 2022).
4. **Efektivitas dan Efisiensi** SDM keperawatan harus dikelola secara optimal untuk mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat. Hal ini mencakup perencanaan tenaga dan pengaturan jadwal kerja yang efisien (Huber, 2022).
5. **Kolaborasi dan Komunikasi Efektif**
   Perawat bekerja dalam tim interprofesional, sehingga diperlukan komunikasi yang jelas dan kolaborasi yang baik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Ernstmeyer & Christman, 2024).

6. Pengembangan Berkelanjutan SDM keperawatan harus terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (Yoder-Wise et al., 2023).
7. Akuntabilitas dan Profesionalisme Setiap perawat bertanggung jawab terhadap tugas dan tindakan yang dilakukan sesuai standar profesi dan kode etik keperawatan (Finkelman, 2022).
8. Fleksibilitas dan Adaptif Manajemen SDM keperawatan harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pelayanan, teknologi, dan dinamika organisasi kesehatan (Huber, 2022).

E. Kebutuhan/Perhitungan Tenaga Keperawatan

Perencanaan kebutuhan tenaga keperawatan atau *staffing* merupakan salah satu fungsi dasar dalam manajemen pelayanan keperawatan. Kemampuan untuk memperkirakan jumlah tenaga perawat secara tepat menjadi kompetensi penting bagi seorang manajer, karena hal ini dapat mencegah terjadinya kekurangan tenaga yang berpotensi mengganggu pelayanan keperawatan (Marquis & Huston, 2017).

Tingkat efektivitas dan efisiensi tenaga keperawatan sangat dipengaruhi oleh ketepatan pemberian asuhan serta kompetensi yang dimiliki oleh perawat. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan tenaga keperawatan yang dilakukan secara terstruktur dan strategis agar kebutuhan tenaga dapat terpenuhi secara optimal. Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti:

a. Pengelompokan klien berdasarkan tingkat ketergantungan
b. Metode pemberian asuhan keperawatan yang digunakan
c. Jumlah serta kategori tenaga keperawatan
d. Perhitungan kebutuhan tenaga secara keseluruhan.

Dalam hal ini, peran manajer keperawatan sangat krusial, terutama dalam melakukan analisis dan perencanaan kebutuhan tenaga di unit pelayanan rumah sakit (Rakhmawati, 2008).

Menurut Susilo dan Yustiawan (2015), perhitungan jumlah tenaga perawat memiliki keterkaitan erat dengan beban kerja yang ditanggung. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengkaji beban kerja perawat meliputi:

a. Jumlah pasien yang dirawat dalam periode tertentu (harian, bulanan, maupun tahunan).
b. Tingkat ketergantungan atau kondisi pasien.
c. Rata-rata lama hari perawatan.
d. Proporsi kegiatan keperawatan langsung dan tidak langsung.
e. Frekuensi tindakan keperawatan yang dilakukan.

f. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan langsung dan tidak langsung.
g. Faktor non-produktif seperti cuti, pelatihan, dan kondisi sakit.

Dalam menentukan kebutuhan tenaga perawat di rumah sakit, tersedia berbagai metode perhitungan yang dapat digunakan. Pada dasarnya, metode-metode tersebut memiliki prinsip yang serupa, namun masing-masing memiliki karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi serta sistem pelayanan asuhan keperawatan yang diterapkan pada klien (Rakhmawati, 2008).

F. Metode Perhitungan Kebutuhan Tenaga Keperawatan: Metode Douglas

Brown (1984) mengemukakan bahwa jumlah tenaga perawat yang diperlukan dalam suatu unit pelayanan ditentukan berdasarkan klasifikasi klien. Setiap kategori klien memiliki standar kebutuhan tenaga perawat yang berbeda pada setiap shift pelayanan (pagi, sore, malam). Dalam metode ini, jumlah tenaga keperawatan dihitung dari jumlah pasien per kategori dikalikan dengan konstanta Douglas (unit standar pershift) untuk tiap tingkat ketergantungan.

1. Klasifikasi Tingkat Ketergantungan Pasien Menurut Douglas

Menurut Douglas (1984/1992), pasien diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketergantungan terhadap asuhan keperawatan sebagai berikut:

a. Perawatan minimal (minimal care)

1) Membutuhkan waktu 1–2 jam asuhan keperawatan langsung per 24 jam.
2) Kebersihan diri, mandi, dan ganti pakaian dilakukan sendiri.
3) Makan dan minum dilakukan sendiri.
4) Ambulasi dengan pengawasan.
5) Observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap shift.
6) Pengobatan relatif sederhana dengan kondisi psikologis stabil.

b. Perawatan parsial/intermediate (partial/intermediate care)

1) Membutuhkan waktu 3–4 jam asuhan keperawatan langsung per 24 jam.
2) Kebersihan diri dan makan-minum sebagian dibantu.
3) Observasi tanda-tanda vital dilakukan lebih sering (misalnya tiap 4 jam).
4) Ambulasi dibantu, pengobatan lebih dari sekali per hari.

c. Perawatan total (total care)

1) Membutuhkan waktu 5–6 jam asuhan keperawatan langsung per 24 jam.
2) Hampir seluruh kebutuhan dasar dibantu atau dilakukan oleh perawat.
3) Posisi tubuh diatur oleh perawat, observasi tanda vital umumnya tiap 2 jam.
4) Pasien dapat berada dalam kondisi gelisah dan/atau disorientasi.

(Institusi dapat menambahkan kategori intensif care bila diperlukan, namun klasifikasi dasar metode Douglas umumnya menggunakan tiga kategori di atas).

2. Konstanta Douglas per Shift

Douglas (1984, dalam Swansburg, 1999) menetapkan standar jumlah perawat per shift berdasarkan tiap kategori ketergantungan pasien. Konstanta ini digunakan sebagai faktor pengali pada jumlah pasien di masing-masing kategori.

Contoh nilai konstanta (sering digunakan di berbagai referensi dan latihan soal):

Tingkat ketergantungan	Pagi (konstanta)	Sore (konstanta)	Malam (konstanta)
Minimal care	0,17	0,14	0,07
Partial care	0,22	0,19	0,11
Total care	0,28	0,23	0,15

Nilai pada tabel di atas dapat bervariasi sedikit antar sumber, namun prinsip perhitungannya sama, yaitu setiap kategori ketergantungan memiliki konstanta yang berbeda untuk masing-masing shift.

3. Rumus Dasar Metode Douglas

Secara umum, langkah perhitungan kebutuhan tenaga perawat menggunakan metode Douglas adalah sebagai berikut:

a. Mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat ketergantungan (minimal, parsial, total).
b. Mengalikan jumlah pasien pada tiap kategori dengan konstanta Douglas per shift.
c. Menjumlahkan hasil perkalian seluruh kategori untuk memperoleh kebutuhan perawat per shift.
d. Menambahkan faktor koreksi (cuti, pelatihan, sakit) dan hari libur untuk menghitung total kebutuhan perawat per tahun.

Tabel 4.1: Jumlah Perawat Berdasarkan Klasifikasi Pasien

Jumlah Pasien	Klasifikasi Pasien								
	Minimal			Parsial			Total		
	Pagi	Siang	Malam	Pagi	Siang	Malam	Pagi	Siang	Malam
1	0,17	0,14	0,10	0,27	0,15	0,07	0,36	0,30	0,20
2	0,34	0,28	0,20	0,54	0,30	0,14	0,72	0,60	0,40
3	0,51	0,42	0,30	0,81	0,45	0,21	1,08	0,90	0,60
Dst.									

1. Metode Rasio

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 262/Menkes/Per/VII/1979, standarisasi tenaga di rumah sakit sebagai berikut:

Tabel 4.2: Standarisasi Tenaga di Rumah Sakit

Tipe RS	TM/TT	TPP/TT	TPNP/TT	TNM/TT
A & B	1/(4-7)	(3-4)/2	1/3	1/1
C	1/9	1/1	1/5	3/4
D	1/15	1/2	1/6	2/3
Khusus	Disesuaikan			

Keterangan:

TM = Tenaga Medis

TT = Tempat Tidur

TPP = Tenaga Para Medis Perawatan

TPNP = Tenaga Para Medis Non-perawatan

TNM = Tenaga Non-medis

2. Metode Hasil Lokakarya PPNI

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Formula Hasil Lokakarya Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yaitu:

$$TTP = \frac{A \times 52\ minggu \times 7\ hari\ (TT \times BOR)}{HKE\ (41\ minggu) \times JKE\ (40/minggu)} \times 25\%$$

Keterangan:

TTP = Tenaga Paramedis Perawat

A = Jumlah jam perawatan/24 jam

TT = Tempat Tidur

BOR = *Bed Occupancy Rate*

HKE = Hari Kerja Efektif

JKE = Jam Kerja Efektif

a. Komponen A adalah jumlah waktu perawatan yang dibutuhkan oleh pasien selama 24 jam.
b. BOR adalah prosentase rata-rata jumlah tempat tidur yang digunakan selama periode tertentu (satu semester/satu tahun).
c. Hari Kerja Efektif selama 41 minggu yang dihitung sebagai berikut: (365 – (52 hari minggu+12 hari libur nasional+ 12 cuti tahunan) = 289 hari: 7 hari/minggu = 41 minggu.
d. Jam Kerja Efektif selama 40 jam perminggu yang dihitung sebagai berikut: 1) Jika hari kerja efektif 6 hari, maka 40/6 = 6,6 - 7 jam perhari. 2) Jika hari kerja efektif 5 hari, maka 40/5 = 8 jam perhari.
e. Komponen 25% yaitu tingkat produktivitas perawat diasumsikan hanya 75% sehingga dikali 25%.

3. Metode Depkes

a. Rawat Jalan
b. Ruang Bersalin
c. Ruang Operasi
d. Ruang UGD

Rumus kebutuhan tenaga keperawatan di rawat inap didasarkan oleh:

a. Tingkat ketergantungan pasien
b. Rata-rata pasien per hari
c. Jam perawatan yang diperlukan/hari/pasien
d. Jam perawatan yang diperlukan/ruangan/hari
e. Jam kerja efektif tiap perawat per hari

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan}}{\text{Jumlah kerja efektif per shift}}$$

Kebutuhan tenaga keperawatan di gawat darurat didasarkan oleh:

a. Rata-rata jumlah pasien per hari
b. Jumlah jam perawatan per hari
c. Jam efektif perawat per hari

$$\frac{Rata-rata\ jumlah\ pasien\ per\ hari\ x\ jumlah\ rata-rata\ jam\ perawatan}{jam\ efektif\ per\ hari}$$

Kebutuhan tenaga keperawatan di kamar oeprasi didasarkan oleh:

a. Jumlah dan jenis operasi
b. Jumlah kamar operasi
c. Pemakaian kamar operasi
d. Tugas perawat di kamar operasi: instrumen dan sirkuler (2 orang/tim)

e. Ketergantungan pasien:
   1) Operasi besar: 5 jam/operasi
   2) Operasi sedang: 2 jam/operasi
   3) Operasi kecil: 1 jam/operasi

$$\frac{\text{Jumlah jam perawatan per hari x jumlah operasi x jumlah perawat dalam tim}}{\text{jam kerja efektif per hari}}$$

4. Metode Gillies

$$\frac{\text{AxBxC}}{(\text{C}-\text{D})\text{xE}} = \frac{\text{F}}{\text{G}} = \text{H} \ldots$$

Keterangan:

A= Rata-rata jumlah perawatan/pasien/hari
B= Rata-rata jumlah pasien/hari
C= Jumlah hari/tahun
D= Jumlah hari libur masing-masing perawat
E= Jumlah jam kerja masing-masing perawat
F= Jumlah jam perawatan yang dibutuhkan per tahun
G= Jumlah jam perawatan yang diberikan perawat per tahun
H= Jumlah perawat yang dibutuhkan untuk unit tersebut

Pengaturan hari libur dan cuti:

a. Jumlah hari per tahun, yaitu 365 hari
b. Hari libur masing-masing perawat per tahun adalah 78 hari, diperoleh dari hari minggu = 52 hari, libur nasional = 14 hari dan cuti tahunan = 12 hari
c. Jumlah jam kerja tiap perawat adalah 40 jam/minggu (kalua kerja efektif 5 hari kerja maka jam efektif 40/5=8 jam)
d. Jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan di satu unit harus ditambah 20-255 (antisipasi/Cadangan)

5. Metode Ilyas

Keterangan:

A = Jumlah jam perawatan/24 jam
B = Sensus harian
C = Jumlah hari kerja selama setahun
295 = Hari kerja efektif perawat pertahun
= 365- (12 hari libur nasional + 12 hari libur cuti tahunan) x ¾
= 255 hari

a. Formula berdasarkan Tingkat ketergantungan pasien

1) Keperawatan mandiri (self care) yaitu klien memerlukan bantuan minimal dalam melakukan Tindakan keperawatan dan pengobatan. Asuhan keperawatan minimal mempunyai kriteria sebagai berikut:
   a) Kebersihan diri, mandi, Ganti pakaian dilakukan sendiri
   b) Makan dan minum dilakukan sendiri
   c) Ambulasi dengan pengawasan
   d) Observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap shift
2) Keperawatan Sebagian (partial care) yaitu klien memerlukan bantuan sebagian dalam tindakan keperawatan dan pengobatan teratur. Kriterianya sebagai berikut:
   a) Kebersihan diri dibantu, makan minum dibantu
   b) Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam
   c) Ambulasi dibantu, pengobatan lebih dari sekali
3) Keperawatan agak berat (severe care) yaitu klien memerlukan bantuan secara penuh dalam perawatan diri dan memerlukan observasi yang benar. Kriterianya sebagai berikut:
   a) Sebagian besar aktivitas dibantu
   b) Observasi tanda-tanda vital setiap 2-4 jam sekali
   c) Terpasang kateter menetap, terpasang NGT
   d) Terpasang infus
   e) Pengobatan lebih dari sekali
   f) Persiapan pengobatan memerlukan prosedur
4) Keperawatan intesif yaitu klien memerlukan observasi dan Tindakan yangterus-menerus. Perawatan maksimal (total). Kriterianya sebagai berikut:
   a) Segala aktivitas diberikan oleh perawat
   b) Posisi diatur, observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam
   c) Makan memerlukan NGT, terapi intravena
   d) Penggunaan suction
   e) Gelisah/ disorientasi
5) Untuk memudahkan pemberian asuhan keperawatan, diperlukan waktu keperawatan diantaranya sebagai berikut:
   a) Waktu keperawatan langsung. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk perawatan langsung 4-5 jam/ pasien/hari. Waktu yang dibutuhkan untuk perawatan langsung berdasarkan kategori:
      - Self care/ mandiri ½ x 4 = 2 jam
      - Partial care/ Sebagian ¾ x 4 = 3 jam
      - Total care 1,5 x 4 jam = 6 jam

- Intensive care 2 x 4 = 8 jam

b) Waktu keperawatan tidak langsung rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk perawatan tidak langsung menurut Wolf dan Yang (1965) adalah 60 menit/ pasien/hari

c) Waktu penyuluhan kesehatan, lebih kurang 15 menit/ pasien/ hari (Gillies, 1989)

b. Metode WISN (*Workload Indicator Staffing Need*)

Metode WISN digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja pada suatu unit berdasarkan beban kerja yang ada, sehingga proses alokasi maupun relokasi tenaga menjadi lebih rasional dan terarah. Melalui Kepmenkes Nomor 81/MENKES/I/2004, metode WISN direkomendasikan sebagai salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan. Keunggulan metode ini terletak pada kemudahan dalam pengoperasian dan penerapannya, serta sifatnya yang komprehensif dan mampu memberikan gambaran yang realistis terkait kebutuhan tenaga kerja. Namun demikian, metode WISN juga memiliki keterbatasan, yaitu sangat bergantung pada ketersediaan serta keakuratan data yang berkaitan dengan beban kerja (Soesanto & Ersyad, 2019).

Menurut Ernawati dkk. (2011) terdapat lima Langkah perhitungan berdasarkan WISN, diantaranya:

1) Waktu kerja tersedia ditetapkan berdasarkan banyaknya hari kerja, cuti, pendidikan dan pelatihan, hari libur nasional, ketidakhadiran kerja, dan waktu kerja tenaga kesehatan selama satu tahun.

$$WKT = \{A - (B+C+D+E)\} \times F$$
$$HKT = A - (B + C + D + E)$$

Keterangan:
WKT = Waktu Kerja Tersedia
HKT = Hari Kerja Tersedia
A = Hari kerja yang mungkin dalam setahun
B = Cuti tahunan
C = Pendidikan dan pelatihan
D = Hari libur nasional
E = Ketidakhadiran kerja (ijin, sakit, dll)
F = Waktu kerja dalam satu hari

2) Menetapkan unit kerja dan kategori sumber daya manusia yang dihitung. Data dan informasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a) Struktur organisasi, uraian tugas pokok, dan fungsi masing-masing unit;
b) Keputusan Direktur Rumah Sakit tentang perawat;
c) Data pegawai berdasarkan pendidikan yang bekerja;
d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
e) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
f) Standar profesi, standar pelayanan, dan SOP

3) Disusunnya standar beban kerja. Beban kerja tersebut meliputi:
   a) Kegiatan pokok yang dilaksanakan. Kumpulan berbagai jenis kegiatan sesuai standar pelayanan dan SOP untuk menghasilkan pelayanan yang dilaksanakan oleh AIK dengan kompetensi tertentu.
   b) Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok. Kebutuhan waktu untuk menyelesaikan kegiatan sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu standar pelayanan, SOP, sarana dan prasarana yang tersedia, dan kompetensi SDM. Ditetapkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama bekerja dan kesepakatan bersama. Sebaiknya ditetapkan berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok oleh SDM yang memiliki kompetensi, kegiatan pelaksanaan, standar pelayanan, SOP, dan memiliki etos kerja yang baik.
   c) Standar beban kerja per tahun, yaitu volume/kuantitas beban kerja 1 tahun. Disusun berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan (rata-rata waktu) dan waktu yang tersedia per tahun yang dimiliki oleh masing-masing kategori SDM.

   Rumus perhitungannya Adalah sebagai berikut:

$$Standar\ beban\ kerja = \frac{Waktu\ kerja\ tersedia}{Rata - rata\ waktu\ per\ kegiatan\ pokok}$$

4) Penyusunan standar kelonggaran. Meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang tidak terkait langsung atau dipengaruhi tinggi rendahnya kualitas atau jumlah kegiatan pokok/pelayanan. Contoh:
   1) Rapat, penyusunan laporan, menyusun anggaran.
   2) Frekuensi kegiatan dalam satu hari, minggu, bulan.
   3) Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan

   Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$Standar\ kelonggaran = \frac{Rata-rata\ waktu\ /\ faktor\ kelonggaran}{Waktu\ kerja\ tersedia}$$

5) Penghitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Sumber data yang dibutuhkan antara lain:
   1) Data yang diperoleh sebelumnya yaitu waktu kerja tersedia, standar beban kerja, dan standar kelonggaran.
   2) Kuantitas kegatan pokok per unit kerja. Disusun berdasarkan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun.
      a) Unit Rawat Jalan, dibutuhkan data kegiatan tiap unit kerja dan kunjungan (laporan RL).
      b) Unit Rawat Inap, dibutuhkan data jumlah tempat tidur, jumlah pasien keluar/masuk selama 1 tahun, rata-rata hari rawat, dan rata-rata lama perawatan/LOS.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$Kebutuhan\ SDM - UKRM = \frac{Kuantitas\ kegiatan\ pokok}{Standar\ beban\ kerja} + Standar\ kelonggaran$$

G. Prinsip Dasar WISN: Dari Beban Kerja ke Kebutuhan Nyata

WISN bekerja dengan premis bahwa kebutuhan tenaga dihitung berdasarkan:

- Ketersediaan waktu kerja efektif per tahun dari setiap tenaga kerja,
- Standar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap aktivitas pelayanan (activity standards),
- Volume kegiatan aktual (real workload) yang terjadi di fasilitas pelayanan,
- Kebutuhan tambahan untuk tugas-tugas non-layanan langsung, seperti administrasi, supervisi, pendidikan, dan tanggung jawab koordinasi.

Misalnya, dalam satu unit rawat inap, jumlah kebutuhan perawat tidak dihitung berdasarkan jumlah tempat tidur semata, melainkan didasarkan pada jumlah pasien aktual, jenis prosedur yang dilakukan, waktu standar setiap aktivitas, dan jadwal kerja perawat.

Dengan demikian, WISN memungkinkan:

- Analisis defisit atau surplus tenaga kerja secara objektif,
- Identifikasi unit atau wilayah dengan beban berlebih, dan
- Simulasi kebutuhan tenaga kerja dalam berbagai skenario peningkatan layanan.

1. Kelebihan dan Keterbatasan WISN

Kelebihan metode WISN terletak pada pendekatannya yang objektif dan transparan dalam menentukan kebutuhan serta alokasi tenaga kerja. Metode ini dapat diterapkan pada berbagai jenis tenaga kesehatan dan bersifat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan lokal. Selain itu, hasil

analisis WISN dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam advokasi penganggaran, penetapan kebijakan distribusi tenaga, serta penataan kembali beban kerja agar lebih proporsional. Namun demikian, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

a. Bergantung pada data beban kerja yang akurat dan lengkap.
b. Memerlukan pelatihan dan pendampingan teknis yang cukup intensif.
c. Kurang fleksibel dalam menangkap kualitas layanan, kepuasan pasien, dan kompleksitas kasus sebagai faktor penentu kebutuhan SDM.

2. Integrasi WISN dalam Manajemen Strategis SDM Keperawatan

Agar metode WISN tidak berhenti sebagai proyek sesaat, maka perlu diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen SDM Keperawatan, termasuk e-Presensi, e-Performance, dan dashboard mutu layanan. Dengan demikian, WISN dapat menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan
yang berkelanjutan dan berbasis data.
Langkah strategisnya meliputi:

a. Pelatihan manajer keperawatan dan HRD rumah sakit tentang WISN.
b. Kolaborasi antara bagian kepegawaian, keuangan, dan pelayanan.
c. Pemutakhiran rutin data beban kerja.
d. Pemanfaatan hasil WISN dalam perencanaan formasi dan pengembangan SDM jangka panjang.

3. Manajemen Beban Kerja dan Task Shifting

Manajemen beban kerja dalam keperawatan tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasien yang ditangani oleh setiap perawat, tetapi juga mencakup tingkat kompleksitas tindakan, urgensi pelayanan, kompetensi tenaga, serta dukungan sistem organisasi. Ketidaksesuaian antara beban kerja dan kapasitas perawat dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kelelahan berkepanjangan, menurunnya mutu pelayanan, hingga meningkatnya risiko terhadap keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen beban kerja yang bersifat ilmiah, adaptif, dan berbasis data. Pendekatan ini juga perlu memberikan ruang bagi penerapan strategi task shifting sebagai salah satu solusi struktural dalam menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan di era modern.

4. Dimensi Beban Kerja Perawat: Lebih dari Sekadar Jumlah Pasien

Beban kerja perawat bersifat multidimensional dan tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek saja. Secara umum, beban kerja tersebut meliputi beberapa dimensi, yaitu:

a. **Beban kerja fisik**, yang berkaitan dengan aktivitas langsung kepada pasien, seperti pengukuran tanda vital, pelaksanaan tindakan keperawatan, hingga mobilisasi pasien.
b. **Beban kerja mental**, yang mencakup proses pengambilan keputusan klinis, komunikasi dalam situasi kritis, kegiatan dokumentasi, serta koordinasi dengan tim kesehatan lainnya.
c. **Beban administratif**, berupa tugas-tugas pencatatan dan pelaporan, seperti pengisian rekam medis, laporan pergantian shift, audit keperawatan, serta pelaporan indikator mutu.
d. **Beban emosional**, yang muncul saat menghadapi pasien dengan kondisi terminal, keluarga yang sedang berduka, konflik antarprofesi, serta tekanan sosial dalam lingkungan kerja.

Apabila berbagai dimensi beban kerja tersebut tidak dikelola secara optimal, perawat berisiko mengalami moral distress, kelelahan kerja (burnout), hingga keinginan untuk meninggalkan pekerjaan (intention to leave). Oleh sebab itu, pengukuran dan pengelolaan beban kerja perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek klinis sekaligus kondisi psikososial tenaga keperawatan.

5. Model Pendekatan Manajemen Beban Kerja

Berbagai model telah dikembangkan untuk menganalisis sekaligus merencanakan beban kerja perawat secara lebih sistematis dan berbasis data. Beberapa di antaranya meliputi:

a. **Patient Classification System (PCS)**, yaitu metode yang mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat kompleksitas asuhan keperawatan yang dibutuhkan, bukan semata-mata berdasarkan diagnosis medis.
b. **RAFAELA System (Finlandia)**, Mengintegrasikan kebutuhan pasien dengan persepsi beban kerja perawat sebagai dasar dalam pengaturan dan penjadwalan shift kerja.
c. **NASA-TLX (Task Load Index)**, Menilai beban kerja secara multidimensional, meliputi aspek mental, fisik, waktu, tingkat kinerja, dan tekanan/stres, terutama pada lingkungan pelayanan dengan intensitas tinggi seperti unit perawatan intensif.

d. Nursing Workload Index, Mengombinasikan jumlah tindakan keperawatan, durasi pelayanan, serta indikator tekanan kerja yang dialami oleh perawat.

Meskipun berbagai model analisis beban kerja tersebut telah berkembang dan terbukti efektif, penerapannya di Indonesia masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh perlunya penyesuaian dengan konteks lokal, seperti budaya kerja, ketersediaan dan distribusi tenaga keperawatan, serta dukungan sistem informasi yang belum merata. Oleh karena itu, implementasi model-model tersebut perlu dilakukan secara adaptif agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan di Indonesia.

H. Task Shifting: Strategi Adaptif dalam Krisis Tenaga Keperawatan

Dalam situasi keterbatasan jumlah tenaga atau distribusi yang tidak merata, strategi *task shifting* menjadi salah satu pendekatan penting untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan. *Task shifting* mengacu pada pengalihan sebagian tugas atau tanggung jawab kepada tenaga lain yang telah mendapatkan pelatihan khusus, tanpa mengurangi mutu maupun keselamatan layanan. Dalam praktik keperawatan, penerapan *task shifting* dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, antara lain:

1. Tugas non-klinis, seperti kegiatan administrasi, pelaporan digital, dan pengelolaan logistik, dapat dialihkan kepada tenaga administratif atau asisten kesehatan.
2. Tindakan keperawatan dasar, seperti perawatan luka sederhana, dapat didelegasikan kepada tenaga pendukung seperti *nurse aide* atau perawat vokasi dengan tetap berada dalam pengawasan perawat profesional.
3. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem pemantauan tanda vital secara digital dan *e-charting*, dapat membantu mengurangi beban pencatatan manual yang selama ini dilakukan oleh perawat.

Dengan penerapan yang tepat, strategi ini dapat meningkatkan efisiensi kerja, sekaligus memungkinkan perawat untuk lebih fokus pada pelayanan yang bersifat kompleks dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Agar penerapan *task shifting* dapat berjalan secara efektif, diperlukan beberapa prasyarat penting, yaitu adanya standarisasi kompetensi dan penyusunan SOP yang jelas, pelaksanaan pelatihan yang memadai disertai pengawasan yang ketat, serta dukungan legitimasi hukum dan regulasi praktik yang kuat.

Perlu dipahami bahwa *task shifting* bukan sekadar upaya memindahkan beban kerja, melainkan merupakan bentuk redistribusi tugas yang bersifat strategis untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan standar mutu pelayanan. Dalam

hal ini, World Health Organization (WHO) sejak tahun 2008 telah merekomendasikan *task shifting* sebagai bagian dari solusi sistemik, khususnya bagi negara dengan beban pelayanan kesehatan yang tinggi dan keterbatasan tenaga kesehatan.

1. Tantangan Implementasi dan Etika *Task Shifting*

Meskipun secara konseptual menawarkan berbagai keuntungan, penerapan *task shifting* dalam praktik keperawatan tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain kekhawatiran terhadap penurunan profesionalisme dan peran perawat, resistensi budaya kerja terutama dari tenaga kesehatan yang lebih senior, serta belum adanya regulasi yang jelas terkait batasan kewenangan dan mekanisme pengawasan tugas yang dialihkan. Selain itu, terdapat pula potensi munculnya beban tanggung jawab ganda pada perawat, khususnya ketika mereka harus mengawasi tenaga pendukung tanpa disertai pengurangan beban kerja utama.

Oleh karena itu, implementasi *task shifting* perlu didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat, yaitu:

a. **Etika pelayanan**, dengan menjunjung tinggi prinsip *primum non nocere* (tidak membahayakan pasien).
b. **Keadilan dalam distribusi beban kerja**, sehingga tidak terjadi ketimpangan antar anggota tim kesehatan.
c. **Kejelasan struktur organisasi**, khususnya dalam pembagian peran, tanggung jawab, dan alur koordinasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, *task shifting* dapat diterapkan secara lebih aman, adil, dan tetap menjaga mutu pelayanan keperawatan.

2. Makna Perencanaan Berbasis Kompetensi

Perencanaan berbasis kompetensi merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki saat ini dengan kompetensi ideal yang dibutuhkan oleh unit kerja atau sistem pelayanan. Dalam konteks keperawatan, kompetensi tidak hanya dinilai dari latar belakang pendidikan formal, tetapi juga mencakup kemampuan kognitif, keterampilan teknis, kemampuan interpersonal, serta kapasitas adaptasi dalam praktik nyata.

Mengacu pada kerangka yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer (1993) serta Boyatzis (2008), kompetensi terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu:

a. **Knowledge**, yaitu penguasaan pengetahuan faktual dan prosedural yang relevan dengan praktik keperawatan.
b. **Skill**, yaitu keterampilan praktis dan kemampuan psikomotor dalam melaksanakan tindakan keperawatan.
c. **Ability**, yaitu kapasitas dalam berpikir kritis, menganalisis situasi, serta mengambil keputusan klinis secara tepat.
d. **Attitude**, yaitu nilai, sikap, komitmen, dan etika profesional yang mendasari perilaku perawat dalam bekerja.
e. **Karakteristik lainnya**, seperti empati, fleksibilitas, serta motivasi intrinsik yang mendukung kinerja dan interaksi profesional.

Dengan memahami komponen-komponen tersebut, perencanaan SDM keperawatan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan selaras dengan tuntutan pelayanan kesehatan yang terus berkembang.

Perencanaan tenaga keperawatan yang hanya berfokus pada jumlah tanpa mempertimbangkan aspek kompetensi berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara beban pelayanan dan kualitas intervensi yang diberikan. Kondisi ini bahkan dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan praktik profesional. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kompetensi menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara kemampuan tenaga dengan tuntutan layanan.

3. Langkah Strategis Perencanaan Berbasis Kompetensi:

a. Identifikasi kompetensi inti yang dibutuhkan pada setiap unit layanan, seperti ICU, IGD, PONEK, maupun rawat jalan.
b. Pemetaan kompetensi individu, melalui portofolio, uji kompetensi, asesmen perilaku, serta observasi praktik langsung.
c. Analisis kesenjangan (gap) kompetensi, dengan membandingkan kondisi aktual dengan kompetensi ideal yang diharapkan.
d. Perencanaan formasi dan pengembangan berbasis gap, yang dapat berupa rekrutmen baru, pelatihan, rotasi, mentoring, atau kombinasi dari berbagai strategi tersebut.
e. Penyusunan jalur karier (*career pathway*) dan pengelolaan *talent pool*, guna menjamin keberlanjutan serta regenerasi tenaga keperawatan yang kompeten.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga membantu mengoptimalkan pemanfaatan tenaga yang tersedia, sehingga dapat mengurangi pemborosan anggaran dan menghindari terjadinya duplikasi fungsi dalam organisasi pelayanan kesehatan.

4. Rekrutitmen Tenaga Keperawatan

Rekrutmen merupakan proses sistematis untuk mencari, menemukan, dan menarik calon pelamar guna mengisi posisi tertentu dalam organisasi, serta bersifat berkelanjutan sesuai dengan dinamika kebutuhan tenaga kerja. Dalam organisasi pelayanan kesehatan yang kompleks, termasuk rumah sakit dan fasilitas layanan lainnya, pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga keperawatan yang dimiliki. Oleh karena itu, kemampuan organisasi dalam menarik kandidat yang kompeten menjadi faktor kunci keberhasilan pelayanan. Selain itu, sebelum proses rekrutmen dilakukan, organisasi perlu mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki agar mampu menarik minat calon tenaga keperawatan, baik dari aspek finansial maupun lingkungan kerja profesional (Marquis & Huston, 2017).

Menurut Zainal dkk. (2009), proses rekrutmen dimulai sejak upaya pencarian calon pelamar hingga terkumpulnya berkas lamaran. Hasil dari proses ini adalah tersedianya sejumlah kandidat yang siap untuk diseleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, penting bagi organisasi untuk menetapkan informasi dan persyaratan yang jelas agar diperoleh calon tenaga keperawatan yang sesuai dengan kebutuhan layanan.

Agar proses rekrutmen berjalan efektif, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. **Kesesuaian mutu tenaga kerja**, di mana kualitas perawat yang direkrut harus selaras dengan kebutuhan layanan. Hal ini menuntut adanya analisis pekerjaan (*job analysis*), deskripsi pekerjaan (*job description*), dan spesifikasi pekerjaan (*job specification*) sebagai dasar dalam menentukan kualifikasi kandidat.
b. **Kesesuaian jumlah tenaga kerja**, yaitu jumlah perawat yang direkrut harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata organisasi. Untuk itu diperlukan peramalan kebutuhan tenaga (*workforce forecasting*), analisis kebutuhan tenaga kerja (*workforce analysis*), efisiensi biaya rekrutmen, serta pertimbangan aspek fleksibilitas dan regulasi yang berlaku.

Menurut Hariandja (2002), metode rekrutmen secara umum dapat dibedakan menjadi dua pendekatan utama, yaitu metode terbuka dan metode tertutup.

a. Metode Terbuka

Pada metode ini, organisasi menginformasikan adanya posisi yang kosong melalui berbagai media, seperti papan pengumuman, penyampaian lisan, maupun media lainnya. Pendekatan ini memberikan kesempatan yang luas dan setara bagi seluruh pegawai yang memenuhi kualifikasi untuk

mengajukan lamaran secara formal. Keunggulan metode terbuka terletak pada transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen, sehingga memungkinkan diperolehnya kandidat terbaik dari berbagai pilihan. Namun demikian, metode ini cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelaksanaannya.

b. Metode Tertutup

Pada metode tertutup, informasi mengenai lowongan jabatan tidak disampaikan secara terbuka kepada seluruh pegawai. Akibatnya, hanya individu tertentu yang mengetahui dan memiliki kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Kelebihan metode ini adalah proses rekrutmen dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Akan tetapi, metode ini memiliki kelemahan, terutama terkait potensi munculnya praktik subjektivitas atau nepotisme, serta terbatasnya kesempatan bagi pegawai lain yang sebenarnya memenuhi kualifikasi.

Dalam konteks manajemen SDM keperawatan, pemilihan metode rekrutmen perlu mempertimbangkan prinsip transparansi, keadilan, serta kebutuhan organisasi agar diperoleh tenaga yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pelayanan kesehatan.

I. Seleksi Tenaga Keperawatan

Seleksi merupakan proses penentuan kandidat terbaik dari sejumlah pelamar yang memiliki kualifikasi untuk mengisi posisi tertentu dalam organisasi. Proses ini mencakup verifikasi kelengkapan dan keabsahan kualifikasi, penelusuran riwayat pekerjaan, serta penilaian kesesuaian antara kompetensi pelamar dengan kebutuhan dan harapan organisasi. Dalam pelaksanaannya, pimpinan harus memastikan bahwa standar penilaian yang digunakan bersifat objektif dan konsisten bagi seluruh kandidat. Keputusan akhir dalam seleksi harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan, bukan pada preferensi atau penilaian subjektif (Marquis & Huston, 2017).

Vincent (2015) menegaskan bahwa percepatan proses seleksi dan rekrutmen secara berlebihan bukanlah langkah yang tepat, karena dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam memilih tenaga kerja. Sebaliknya, investasi waktu dan sumber daya untuk mendapatkan kandidat yang tepat, serta didukung oleh proses orientasi yang efektif, akan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi.

Menurut Siagian (2014), tahapan seleksi tenaga kerja yang umumnya dilakukan dalam organisasi meliputi:

1. Penerimaan Surat Lamaran

Tahap awal seleksi dimulai dengan penerimaan dan pengumpulan berkas lamaran dari calon tenaga kesehatan. Dokumen yang umumnya dipersyaratkan

meliputi Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga kesehatan, surat lamaran, ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir, KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, *curriculum vitae*, serta dokumen pendukung lain seperti sertifikat pelatihan dan akta nikah (jika ada).

Seluruh berkas kemudian diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaiannya dengan persyaratan. Apabila terdapat kekurangan, pelamar biasanya diberikan waktu tertentu untuk melengkapinya. Kandidat yang memenuhi syarat administratif akan melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.

2. Tes Penerimaan

Tahap ini bertujuan untuk menilai kemampuan dan kesiapan kandidat secara komprehensif, yang meliputi:

a. Tes psikologi, seperti penggunaan instrumen Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), untuk menilai aspek kepribadian dan stabilitas psikologis kandidat.

b. Tes pengetahuan atau kredensial, yang dilakukan untuk menilai kompetensi klinis sesuai bidang profesi. Pada tenaga keperawatan, proses ini umumnya melibatkan komite keperawatan.

c. Tes performa, yang dilakukan setelah masa orientasi untuk menilai kinerja nyata kandidat dalam lingkungan kerja, biasanya dievaluasi oleh bagian SDM (HRD).

3. Wawancara Seleksi oleh HRD

Wawancara dilakukan untuk menggali lebih dalam aspek kepribadian, motivasi, kemampuan komunikasi, serta kesesuaian kandidat dengan budaya organisasi. Proses ini umumnya dilakukan oleh bagian HRD sesuai dengan kebijakan masing-masing institusi.

4. Pengecekan Latar Belakang Pelamar

Tahap ini bertujuan untuk memastikan keabsahan informasi yang diberikan oleh pelamar, termasuk riwayat pendidikan, pengalaman kerja, serta integritas pribadi. Selain itu, dilakukan juga penilaian terhadap komitmen dan kesiapan kandidat untuk bekerja.

5. Evaluasi Medis (Tes Kesehatan)

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan bahwa calon tenaga keperawatan memiliki kondisi fisik dan mental yang memadai untuk menjalankan tugas. Tes ini biasanya dilakukan sebelum masa kontrak kerja dimulai.

6. Wawancara oleh Atasan Langsung

Wawancara lanjutan dilakukan oleh atasan langsung, seperti kepala ruangan, komite keperawatan, atau komite medik. Pada tahap ini, penilaian lebih

difokuskan pada aspek teknis, kesiapan kerja di unit tertentu, serta kecocokan kandidat dengan tim kerja.

7. Keputusan Penerimaan

Keputusan akhir penerimaan kandidat ditentukan melalui pertimbangan bersama antara HRD, kepala ruangan, komite keperawatan, dan komite medik. Namun, otoritas tertinggi dalam penentuan diterima atau tidaknya calon tenaga kesehatan biasanya berada pada pimpinan tertinggi organisasi, seperti direktur rumah sakit.

Menurut Marquis dan Huston (2017), setelah proses seleksi selesai, manajer memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Menindaklanjuti pelamar sesegera mungkin, berterima kasih kepada mereka karena telah melamar dan memberi tahu mereka bahwa akan mengumumkan keputusan penerimaan.
b. Kandidat yang sebelumnya tidak ditawarkan diposisi tertentu harus diberitahu secepatnya. Berikan alasan dengan tepat (misalnya, pendidikan dan pengalaman kerja yang tidak memadai), kandidat harus diberi tahu apakah lamaran mereka akan dipertimbangkan segera menindaklanjuti hasil seleksi, baik kepada kandidat yang diterima maupun yang tidak. Kandidat yang tidak terpilih perlu diberikan informasi secara jelas dan profesional, termasuk alasan penolakan, serta kemungkinan pertimbangan di masa mendatang.
c. Pelamar yang ditawarkan posisi tertentu harus diberitahu secara tertulis tentang tunjangan, gaji, dan penempatan. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari mengenai apa yang telah dijanjikan oleh pewawancara kepada karyawan.
d. Pelamar yang menerima tawaran pekerjaan harus diberitahu tentang prosedur pra-kerja seperti pemeriksaan fisik dan tanggal masuk kerja.
e. Pelamar yang ditawarkan posisi tertentu harus diminta untuk mengkonfirmasi secara tertulis niat mereka untuk menerima posisi tersebut.

Karena seleksi melibatkan proses pengurangan (mengurangi jumlah kandidat untuk posisi tertentu), orang yang menentukan hasil seleksi akhir memiliki tanggung jawab yang besar. Keputusan seleksi ini memiliki konsekuensi yang luas, baik bagi organisasi maupun orang-orang yang terlibat. Oleh karena itu, proses seleksi harus se-obyektif mungkin (Marquis dan Huston, 2017).

J. Orientasi Kerja bagi Perawat Muda

Orientasi merupakan proses pemberian informasi awal kepada pegawai baru terkait lingkungan kerja dalam suatu organisasi. Informasi tersebut mencakup struktur organisasi, tata laksana, kebijakan, serta uraian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang yang harus dijalankan oleh tenaga keperawatan (Makarau dkk., 2016).

Pemahaman terhadap lingkungan kerja menjadi aspek yang sangat penting bagi perawat baru, karena akan mempermudah proses penyesuaian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui program orientasi yang terstruktur, perawat diharapkan mampu mengenali sistem kerja, budaya organisasi, serta alur pelayanan yang berlaku.

Pelaksanaan orientasi pada awal masa kerja bertujuan untuk meningkatkan kesiapan perawat dalam menjalankan perannya secara profesional. Dengan pemahaman yang jelas mengenai situasi kerja, peraturan, hak, dan kewajiban, perawat akan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini pada akhirnya akan mendukung tercapainya pelayanan keperawatan yang aman, efektif, dan berkualitas (Marquis & Huston, 2017).

Menurut Marquis dan Huston (2017), program orientasi bagi pegawai baru maupun pegawai lama yang dipindahkan ke unit kerja baru perlu dirancang secara sistematis dan terstruktur. Program orientasi yang baik mampu membantu tenaga keperawatan dalam beradaptasi lebih cepat, memahami peran dan tanggung jawabnya, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, orientasi juga berfungsi untuk meminimalkan kesalahan kerja dan meningkatkan kepercayaan diri perawat dalam memberikan pelayanan.

Adapun langkah-langkah dalam program orientasi meliputi beberapa komponen utama, yaitu:

1. Orientasi Organisasi

Orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai sistem dan lingkungan organisasi pelayanan kesehatan, yang meliputi:

a. Struktur organisasi dan tata laksana pelayanan di rumah sakit
b. Visi, misi, nilai, serta tujuan organisasi
c. Jenis pelayanan atau program yang tersedia
d. Fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit
e. Prosedur pemeliharaan fasilitas
f. Sistem keamanan, ketertiban, serta peraturan yang berlaku

2. Orientasi Kebijakan Manajemen SDM

Tahap ini berfokus pada pemahaman kebijakan kepegawaian yang berlaku dalam organisasi, meliputi:

a. Wewenang dan larangan bagi pegawai
b. Hak dan kewajiban, seperti sistem insentif, cuti, libur, dan kesejahteraan
c. Sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*)
d. Sistem pengembangan staf
e. Sistem penilaian atau evaluasi kinerja

3. Orientasi Tugas Personal Perawat

Orientasi ini berfokus pada peran dan tanggung jawab spesifik perawat dalam unit kerja, yang mencakup:

a. Program pelayanan keperawatan
b. Deskripsi pekerjaan sesuai jabatan
c. Batas kewenangan dalam praktik keperawatan
d. Kode etik profesi keperawatan
e. Standar praktik keperawatan yang menjadi acuan kerja
f. Program pemasaran dan kepuasan konsumen
g. Fasilitas peralatan Kesehatan yang tersedia
h. Berbagai SOP asuhan/pelayanan, antara lain prosedur:
    1) Keluar-masuk pasien di rumah sakit;
    2) Sistem pengendalian infeksi nosocomial dan kasus nosokemistri;
    3) Persiapan dan perawatan pasien operasi (kasus bedah);
    4) Persiapan pemeriksaan medik;
    5) Prosedur Tindakan-tindakan seperti resusitasi dari cardio pulmonary (RKT), pertolongan melahirkan, instalasi seperti NGT, kateter, O2, infus, transfusi darah, dan lain-lain.

4. Orientasi Lapangan

Pegawai baru tersebut diberikan orientasi langsung ke lapangan di semua ruangan rawat inap dan rawat jalan serta instalasi di lingkungan rumah sakit.

5. Orientasi Khus uke Ruangan (Dimana mereka ditempatkan)

a. Organisasi dan tata ruang dari ruang-ruang perawatan
b. Fasilitas-fasilitas dan peralatan yang tersedia untuk ruang-ruang perawatan;
c. Perkenalan dengan semua staf di ruangan atau unit layanan tersebut;
d. Tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya dalam ruangan baru tersebut;

e. Prosedur administrasi atau tindakan klinis keperawatan yang berlaku di ruangan/program serta dokumen pendukungnya; dan
f. Model penugasan, tata cara kerja dan hal-hal lain yang berlaku.

K. Pengembangan Kemampuan Keperawatan

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia keperawatan di Indonesia telah menjadi perhatian penting pemerintah. Menurut Noprianty (2019) serta Yulianti dan Madiawati (2015), berbagai langkah strategis telah dilakukan, antara lain peningkatan mutu pendidikan keperawatan melalui dukungan tenaga pendidik, penyediaan anggaran pendidikan, serta fasilitasi program pendidikan berkelanjutan. Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan juga didorong untuk memberikan kesempatan kepada perawat dalam mengembangkan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, kepuasan pasien terhadap *caring*, serta kepuasan kerja perawat itu sendiri.

Pengembangan karier menjadi salah satu aspek penting dalam manajemen SDM keperawatan. Jenjang karier merupakan bentuk pengakuan terhadap pengalaman, kinerja, serta kompetensi perawat, sekaligus memberikan peluang untuk meningkatkan profesionalisme. Dengan adanya sistem jenjang karier, perawat memiliki arah pengembangan yang jelas sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki (Noprianty, 2019).

Di Indonesia, sistem jenjang karier perawat telah dikembangkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bersama Kementerian Kesehatan, yang kemudian diperbarui melalui regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karier Profesional Perawat Klinis. Regulasi ini menjadi acuan dalam penempatan, pengembangan, serta peningkatan kompetensi perawat secara berkelanjutan.

Pengembangan karier profesional perawat mencakup empat peran utama, yaitu:

1. Perawat Klinis (PK)
2. Perawat Manajer (PM)
3. Perawat Pendidik (PP)
4. Perawat Peneliti/Riset (PR)

Setiap jalur karier tersebut memiliki lima level pengembangan, yaitu level I hingga level V. Masing-masing level memiliki perbedaan dalam tugas, tanggung jawab, serta kewenangan, yang memungkinkan perawat untuk berkembang sesuai dengan kompetensi dan minatnya. Selain itu, sistem ini juga memberikan peluang

mobilitas karier antar jalur, seperti dari perawat klinis ke perawat manajer, pendidik, atau peneliti (Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Dengan adanya sistem pengembangan karier yang terstruktur, diharapkan perawat dapat meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan, memperoleh pengakuan profesional, serta memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

L. Dampak Penerapan Sistem Jenjang Karier Perawat

Penerapan sistem jenjang karier perawat memberikan berbagai dampak terhadap kinerja individu maupun organisasi pelayanan kesehatan. Menurut Suroso (2011), terdapat sejumlah dampak positif yang dapat diperoleh apabila sistem jenjang karier dilaksanakan secara optimal, antara lain:

1. **Pengembangan karier**, yaitu meningkatnya motivasi dan moral kerja perawat karena adanya kepuasan dalam menjalankan pekerjaan serta peluang pengembangan diri.
2. **Pengakuan**, berupa kesempatan bagi perawat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan rasa memiliki terhadap organisasi.
3. **Penghargaan**, yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan jenjang karier serta peningkatan penghasilan sesuai dengan kompetensi yang telah dicapai.
4. **Pekerjaan yang menantang**, yang mendorong perawat untuk terus berkembang melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi, keterampilan spesialis, serta peluang rotasi kerja.
5. **Promosi**, yang berkaitan dengan peningkatan status profesional, perubahan jabatan, serta penambahan wewenang dan tanggung jawab.

Namun demikian, apabila sistem jenjang karier tidak diterapkan dengan baik, dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak yang sering muncul adalah menurunnya tingkat kepuasan kerja perawat, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap motivasi kerja dan kinerja pelayanan (Noprianty, 2019).

Oleh karena itu, implementasi sistem jenjang karier perawat perlu dilakukan secara konsisten, transparan, dan berbasis kompetensi, agar mampu memberikan manfaat optimal bagi tenaga keperawatan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Menurut Uli dan Putra (2018), proses pengembangan staf perawat adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan di bidang pekerjaannya. Tujuan utama dilaksanakan program pelatihan terdiri dari dua yaitu, pertama menjadikan perawat memiliki kecakapan dan kemampuan sesuai dengan permintaan jabatan. Kedua, untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perawat dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan (Elkel dkk., 2011).

2. Perawat yang kompeten dapat dihasilkan melalui pengembangan karir perawat berdasarkan jenjang karir yang terdiri dari Perawat Klinis (PK), Perawat Manajer (PM), Perawat Pendidik (PP), dan Perawat Peneliti/Riset (PR).
3. Perkembangan ilmu keperawatan dipengaruhi oleh adanya perubahan kebutuhan masyarakat, ilmu dan teknologi, tuntutan zaman, dan tren demografik. Pengetahuan dan teknologi berkembang dengan cepat sehingga pendidikan harus dijadikan proses yang berkesinambungan seumur hidup.

M. Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian kinerja merupakan proses sistematis yang dilakukan secara formal untuk mengevaluasi kondisi kerja pegawai dengan mengacu pada standar kinerja yang telah ditetapkan organisasi. Dalam konteks keperawatan, penilaian prestasi kerja dilakukan oleh atasan langsung terhadap capaian kerja serta perilaku kerja perawat sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, penilaian kinerja dilaksanakan oleh pejabat penilai, yaitu atasan langsung pegawai, dan disahkan oleh atasan dari pejabat penilai tersebut. Dalam kondisi tertentu, seperti apabila pegawai memiliki pangkat lebih tinggi atau bekerja pada unit nonstruktural, maka penilaian dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Penilaian prestasi kerja dilakukan secara periodik, umumnya pada akhir tahun berjalan atau paling lambat pada awal tahun berikutnya. Komponen penilaian terdiri atas:

- **Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)** dengan bobot 60%
- **Perilaku kerja** dengan bobot 40%

Hasil penilaian ini memiliki peran penting sebagai dasar dalam pembinaan karier, pengembangan kompetensi, serta pemberian tunjangan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Prinsip Penilaian Kinerja

Agar penilaian kinerja berjalan objektif dan adil, manajer keperawatan perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut:

a. Penilaian harus didasarkan pada standar kerja dan perilaku yang telah ditetapkan sesuai dengan deskripsi pekerjaan.

b. Evaluasi dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap perilaku kerja yang representatif dan konsisten.
c. Perawat perlu diberikan informasi terkait standar kerja dan instrumen penilaian sebelum evaluasi dilakukan.
d. Penilaian harus mencerminkan kelebihan dan kekurangan kinerja secara objektif.
e. Manajer perlu menetapkan prioritas perbaikan yang harus dicapai oleh perawat.
f. Proses evaluasi dilakukan melalui komunikasi yang efektif dalam suasana yang kondusif.
g. Penilaian disusun secara terencana agar tidak menimbulkan kesan subjektif atau menghakimi.

2. Manfaat Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja memberikan berbagai manfaat bagi individu maupun organisasi. Menurut Aswad dan Ferrial (2016), manfaat tersebut antara lain:

a. Meningkatkan prestasi kerja perawat, baik secara individu maupun kelompok.
b. Mendorong peningkatan kinerja SDM secara keseluruhan dalam organisasi.
c. Menumbuhkan motivasi untuk pengembangan diri melalui umpan balik yang diberikan.
d. Menjadi dasar dalam penyusunan program pelatihan dan pengembangan SDM.
e. Mendukung sistem penghargaan dan kompensasi yang adil dan berbasis kinerja.
f. Memfasilitasi komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan, sehingga memperkuat hubungan kerja.

Penilaian kinerja merupakan komponen penting dalam manajemen SDM keperawatan yang berfungsi untuk memastikan kualitas pelayanan, meningkatkan profesionalisme, serta mendukung pengembangan karier tenaga keperawatan. Pelaksanaan penilaian yang objektif, transparan, dan berkelanjutan akan memberikan dampak positif terhadap mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

3. Kompensasi SDM Keperawatan

Kompensasi merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berperan dalam menarik, mempertahankan, dan memotivasi tenaga kerja yang berkualitas. Dalam organisasi pelayanan kesehatan, termasuk keperawatan, kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh

kompetensi tenaga yang dimiliki. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan kompensasi yang layak dan kompetitif sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tenaga keperawatan.

Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk finansial maupun nonfinansial. Menurut Aswad dan Ferrial (2016), kompensasi dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

a. Kompensasi Finansial

   Kompensasi finansial merupakan imbalan yang diterima karyawan dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang. Bentuknya meliputi gaji, upah, bonus, tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, jaminan kesehatan, asuransi, serta berbagai bentuk pembayaran lainnya yang diberikan oleh organisasi.

b. Kompensasi Non Finansial

   Kompensasi nonfinansial adalah imbalan yang tidak berbentuk uang, namun memiliki nilai penting dalam meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Bentuknya antara lain lingkungan kerja yang kondusif, kesempatan pengembangan karier, penghargaan, serta program kesejahteraan yang mendukung kenyamanan dan loyalitas tenaga kerja.

N. Tujuan Pemberian Kompensasi

Pemberian kompensasi memiliki tujuan bagi tenaga kerja maupun organisasi, yaitu:

1. Bagi tenaga kerja:

- Memberikan manfaat finansial dan nonfinansial untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.
- Mendorong motivasi kerja dan pengembangan diri.
- Meningkatkan kemampuan dan kinerja melalui penghargaan atas prestasi.

2. Bagi perusahaan:

- Meningkatkan kepuasan dan produktivitas kerja karyawan.
- Memotivasi tenaga kerja untuk bekerja lebih disiplin, efektif, dan efisien.
- Mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui peningkatan kinerja SDM.

O. Indikator Kompensasi

Menurut Dharmawan dalam Kurnia (2016), indikator kompensasi meliputi:

1. **Tunjangan**, yaitu kompensasi tidak langsung seperti fasilitas kesehatan, jaminan sosial, dan kesejahteraan lainnya.
2. **Insentif**, yang diberikan berdasarkan kinerja atau pencapaian tertentu, meliputi:

a. *Piecework* (berdasarkan banyaknya unit atau satuan barang atau jasa yang dihasilkan)
b. *Production bonus* (bonus atas pencapaian target)
c. *Commission* (berdasarkan hasil penjualan)
d. *Merit raises* (kenaikan gaji berbasis kinerja)
e. *Pay-for-skill/knowledge* (berdasarkan kompetensi)
f. Non-maturity incentives seperti penghargaan atau sertifikat
g. Executive incentives, merupakan insentif kepada eksekutif dengan pertimbangan keseimbangan hasil jangka pendek dengan kinerja jangka Panjang
h. International incentives, diberikan karena penempatan seseorang untuk penempatan di luar negeri

3. **Penghargaan**, yang terdiri atas:
   a. **Ekstrinsik**, seperti gaji, promosi, dan pengakuan formal
   b. **Intrinsik**, seperti rasa tanggung jawab, tantangan kerja, dan kepuasan dari pekerjaan itu sendiri

P. Faktor yang Mempengaruhi Kompensasi

Besaran kompensasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. **Kinerja karyawan**, semakin tinggi kontribusi, semakin besar kompensasi yang diberikan.
2. **Kemampuan organisasi**, terkait kondisi keuangan dalam memberikan imbalan.
3. **Kesediaan organisasi**, meskipun mampu, belum tentu bersedia memberikan kompensasi secara optimal.
4. **Penawaran dan permintaan tenaga kerja**, kondisi pasar tenaga kerja memengaruhi besaran kompensasi.
5. **Organisasi karyawan**, seperti serikat pekerja yang dapat memengaruhi kebijakan kompensasi.
6. **Peraturan perundang-undangan**, seperti kebijakan upah minimum yang harus dipatuhi organisasi.

Kompensasi merupakan komponen penting dalam manajemen SDM keperawatan yang tidak hanya berfungsi sebagai imbalan, tetapi juga sebagai alat strategis dalam meningkatkan motivasi, kinerja, dan loyalitas tenaga keperawatan. Pemberian kompensasi yang adil, kompetitif, dan berbasis kinerja akan berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Q. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Sebuah rumah sakit tipe B mengalami peningkatan jumlah pasien dalam 6 bulan terakhir, terutama pada ruang rawat inap penyakit dalam. Namun, jumlah perawat yang tersedia tidak mengalami penambahan signifikan. Saat ini, rasio perawat dan pasien menjadi tidak seimbang, di mana satu perawat harus menangani 10–12 pasien dalam satu shift.

Akibat kondisi tersebut, beberapa perawat mulai mengalami kelelahan kerja (*burnout*), meningkatnya keluhan pasien terkait keterlambatan pelayanan, serta terjadinya kesalahan dalam dokumentasi keperawatan. Selain itu, terdapat 3 perawat yang mengajukan resign dalam waktu bersamaan karena merasa beban kerja tidak sebanding dengan kompensasi yang diterima.

Manajemen rumah sakit mencoba melakukan beberapa langkah, seperti:

- Menerapkan sistem lembur bagi perawat yang ada
- Mengalihkan sebagian tugas administratif ke tenaga non-keperawatan
- Mempercepat proses rekrutmen perawat baru

Namun, hasilnya belum optimal karena masih terjadi ketidakseimbangan beban kerja dan penurunan kepuasan kerja perawat. Kepala ruangan juga mengeluhkan kurangnya kompetensi perawat baru yang direkrut karena proses seleksi yang dipercepat.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

1. Pertanyaan Diskusi

a. Identifikasi permasalahan utama manajemen SDM keperawatan pada kasus di atas!
b. Analisis faktor penyebab terjadinya beban kerja berlebih pada perawat!
c. Bagaimana peran metode perencanaan SDM (misalnya WISN atau workload analysis) dalam menyelesaikan masalah tersebut?
d. Rancang solusi komprehensif berbasis manajemen SDM keperawatan (meliputi rekrutmen, penempatan, kompensasi, dan manajemen beban kerja)!
e. Apa dampak jangka panjang jika masalah ini tidak segera ditangani, baik bagi perawat maupun pasien?

R. Aktivitas 2 — Shows How

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Manajemen SDM Keperawatan
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Mampu menerapkan prinsip manajemen sumber daya manusia keperawatan dalam pengelolaan pelayanan di ruang rawat secara aman, efektif, dan profesional.
5	Kompetensi	1. Kemampuan analisis kebutuhan SDM 2. Kemampuan perhitungan 3. Interpretasi dan Pengambilan keputusan berbasis data 4. Komunikasi professional 5. Sikap dan Penampilan Profesional 6. Dokumentasi
6	Kategori	1. Aman dan Nyaman 2. Psikososial 3. Kebutuhan Dasar 4. Manajemen & Profesionalisme 5. Patient Safety 6. Efisiensi Pelayanan 7. Kualitas Asuhan Keperawatan
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Anda adalah perawat koordinator di ruang rawat inap. Diketahui data: • Jumlah pasien: 30 orang • Klasifikasi pasien: ○ Minimal care: 10 pasien (2 jam/hari) ○ Partial care: 15 pasien (4 jam/hari) ○ Total care: 5 pasien (6 jam/hari) • Jam kerja efektif perawat: 7 jam/hari **Tugas Anda:**

No.	Komponen	Isi
		1. Hitung total kebutuhan jam asuhan keperawatan per hari 2. Hitung jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan 3. Berikan interpretasi hasil perhitungan 4. Sampaikan rekomendasi Anda kepada penguji secara lisan
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Anda adalah perawat koordinator di ruang rawat inap. Diketahui data: • Jumlah pasien: 30 orang • Klasifikasi pasien: o Minimal care: 10 pasien (2 jam/hari) o Partial care: 15 pasien (4 jam/hari) o Total care: 5 pasien (6 jam/hari) • Jam kerja efektif perawat: 7 jam/hari • Kepala ruangan meminta analisis apakah jumlah tenaga saat ini sudah mencukupi **Tugas Anda:** 1. Hitung total kebutuhan jam asuhan keperawatan per hari 2. Hitung jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan 3. Berikan interpretasi hasil perhitungan 4. Sampaikan rekomendasi Anda kepada penguji secara lisan INSTRUKSI PENGUJI: 1. Mengamati proses berpikir dan langkah perhitungan peserta 2. Menilai ketepatan peserta dalam mengidentifikasi data 3. Menilai ketepatan perhitungan 4. Menilai logika interpretasi hasil 5. Menilai kejelasan komunikasi peserta 6. Menilai ketepatan peserta melakukan penerapan keselamatan pasien dan prinsip pencegahan risiko di ruang rawat 7. Monitor perilaku profesional peserta.

No.	Komponen	Isi
		8. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Peran: Kepala Ruangan 1. Berikan data jika peserta bertanya 2. Tanyakan Kembali: - "Apakah jumlah perawat kami sudah cukup?" - "Apa saran Anda untuk efisiensi tenaga?" 3. Bersikap kooperatif, namun tidak memberikan jawaban 4. KS duduk disamping tempat tidur pasien dengan wajah cemas, khawatir dan sedikit kesal. Sesekali melihat pasien dan lingkungan sekitar. Pasien dapat digambarkan melalui manekin/alat bantu pasien dewasa. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat Inap - Tempat tidur pasien - Manekin dewasa - KS berperan sebagai kepala ruangan - Penguji - Laboran Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin dewasa 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Kursi Laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Lembar soal OSCE 2. Kertas perhitungan/lembar kerja 3. Alat tulis 4. Kalkulator (opsional)

No.	Komponen	Isi
		5. Checklist penilaian untuk penguji 6. Handrub Peran laboran: merapikan ulang peralatan setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Lia Dwi Jayanti
13	Referensi	American Nurses Association. 2012. *ANA's Principles for Nurse Staffing*. Edisi Kedua. Maryland: The Publishing Program of ANA. Asmaningrum, Nurfika. (2023). Buku ajar manajemen keperawatan. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup Aswad, H. N., & Ferrial, E. (2016). Influence of Education Level, Training and Compensation Against Nurse Performance at UIT Hospital. *Jurnal Mirai Management*. Gillies, D. A. (2000). *Nursing Management a System Approach.* Third Edition. Philadelphia: WB Saunders Co. Haryati,T.S. (2014). *Perencanaan, Pengembangan dan Utilisasi tenaga keperawatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Huber, D.L. (2018). *Leadership nursing care management (6th edition)*. Philadelphia: W.B. Saunders Company. Marquis, B. L. dan C. J. Huston. 2017. *Leadership Roles and Management Functions in Nursing Theory and Application*. Edisi Kesembilan. Philadelphia: Wolters Kluwer Health. Nursalam, Dr (2014) *Manajemen Keperawatan "Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional.* Salemba Medika, Jakarta. Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). Fundamentals of nursing (10th ed.). Elsevier. Yoder-Wise, P. S. (2022). *Leading and managing in nursing* (8th ed.). Elsevier.

SOP PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA SDM KEPERAWATAN

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	**Tahap Pra interaksi**				
1	Mempelajari kasus dan data yang tersedia (jumlah pasien, klasifikasi pasien, jam kerja efektif)				
2	Menyiapkan alat (kertas, alat tulis, kalkulator)				
3	Menentukan metode perhitungan				
4	Menyiapkan diri secara profesional (penampilan rapi, sikap percaya diri)				
5	Mencuci tangan				
B	**Tahap Orientasi**				
6	Memberi salam dan memperkenalkan diri serta peran sebagai perawat penanggung jawab				
7	Menyampaikan nama dan peran perawat				
8	Mengecek identitas pasien, minimal nama dan tanggal lahir/umur secara aktif				
9	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
10	Memastikan kesiapan pihak terkait (penguji/kepala ruangan)				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
C	**Tahap Kerja**				
11	Mengidentifikasi data: jumlah pasien, klasifikasi Tingkat ketergantungan pasien, standar waktu asuhan keperawatan, jam kerja efektif perawat				
12	Menghitung total jam asuhan keperawatan				
13	Menghitung kebutuhan tenaga keperawatan				
14	Menginterpretasikan hasil				
15	Menjelaskan hasil perhitungan secara sistematis dan logis				
16	Memberikan rekomendasi (penambahan tenaga, redistribusi, dll)				
D	**Tahap Terminasi**				
17	Menyimpulkan hasil perhitungan				
18	Menyampaikan rekomendasi akhri				
19	Memberi kesempatan untuk pertanyaan				
20	Menanyakan kebutuhan tambahan pasien				
21	Mengucapkan terimakasih dan salam penutup				
E	**Tahap Dokumentasi**				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
22	Mencatat hari, tanggal, jam, data dasar (jumlah pasien, kalsifikasi), metode yang digunakan, hasil perhitungan, interpretasi, dan rekomendasi tindak lanjut.				
F	**Penampilan Profesional**				
23	Rapi, percaya diri, komunikasi professional, dan beretika				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA SDM KEPERAWATAN

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Analisis Data	Mengidentifikasi jumlah pasien dengan benar					5	
		Mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat ketergantungan (minimal, partial, total care)						
		Menentukan waktu asuhan keperawatan sesuai kategori						
		Mengidentifikasi jam kerja efektif perawat						
		Menggunakan data yang relevan tanpa kesalahan						

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
2	Perhitungan Kebutuhan Tenaga	Menghitung total jam asuhan keperawatan dengan tepat					5	
		Menuliskan langkah perhitungan secara sistematis						
		Menghitung jumlah kebutuhan tenaga dengan rumus yang benar						
		Menggunakan satuan yang tepat (jam/orang)						
		Hasil akhir perhitungan benar						
3	Interpretasi dan Pengambilan Keputusan	Menghitung total jam asuhan keperawatan dengan tepat					5	
		Menjelaskan hasil perhitungan secara logis						
		Mengaitkan hasil dengan kondisi pelayanan (beban kerja/patient safety)						
		Memberikan rekomendasi yang rasional (penambahan, redistribusi, dll)						
		Menunjukkan kemampuan berpikir kritis						
4	Komunikasi Profesional	Menyampaikan hasil secara sistematis dan jelas					5	
		Menggunakan bahasa profesional dan mudah dipahami						

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
		Menjaga kontak mata dan bahasa tubuh						
		Mampu menjawab pertanyaan dengan tepat						
		Tidak bertele-tele dalam penyampaian						
5	Sikap dan Penampilan Profesional	Berpenampilan rapi dan sesuai standar					5	
		Bersikap sopan dan menghargai penguji						
		Percaya diri saat presentasi						
		Menunjukkan tanggung jawab terhadap hasil						
		Menjaga etika profesional						
6	Dokumentasi	Menuliskan data dasar dengan lengkap					5	
		Mencatat langkah perhitungan						
		Menuliskan hasil akhir dengan jelas						
		Menyertakan interpretasi hasil						
		Menuliskan rekomendasi						
	Jumlah						**30**	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

S. Rubrik Penilaian

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA SDM KEPERAWATAN

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Analisis Data, Aspek ini menilai kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis data yang tersedia secara tepat dan sistematis. Mahasiswa menunjukkan kemampuan dalam mengenali jumlah pasien, mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat ketergantungan (minimal, partial, total care), serta menentukan waktu asuhan keperawatan sesuai kategori. Selain itu, mahasiswa mampu mengidentifikasi jam kerja efektif perawat dan menggunakan seluruh data yang relevan tanpa kesalahan dalam proses analisis.					15%	
2. Perhitungan Kebutuhan Tenaga, Aspek ini menilai kemampuan melakukan perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan secara benar dan sistematis. Mahasiswa menunjukkan kemampuan dalam menghitung total jam asuhan keperawatan berdasarkan klasifikasi pasien, kemudian membagi dengan jam kerja efektif perawat untuk memperoleh jumlah tenaga yang dibutuhkan. Proses perhitungan dilakukan dengan langkah yang runtut, menggunakan rumus yang tepat, serta menghasilkan nilai akhir yang akurat.					25%	
3. Interpretasi dan Pengambilan Keputusan, Aspek ini menilai kemampuan menginterpretasikan hasil perhitungan secara logis dan kritis. Mahasiswa dapat menentukan apakah jumlah tenaga keperawatan sudah mencukupi, kurang, atau berlebih, serta mengaitkannya dengan kondisi pelayanan seperti beban kerja dan keselamatan pasien. Selain itu, mahasiswa mampu memberikan					20%	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
rekomendasi yang rasional, seperti penambahan tenaga, redistribusi, atau efisiensi kerja berdasarkan hasil analisis.						
4. Komunikasi Profesional, Aspek ini menilai kemampuan menyampaikan hasil analisis dan perhitungan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Mahasiswa menggunakan bahasa yang sopan dan profesional, menjaga kontak mata, serta menunjukkan bahasa tubuh yang mendukung komunikasi efektif. Mahasiswa juga mampu merespons pertanyaan dengan tepat dan tidak bertele-tele dalam menyampaikan informasi.					15%	
5. Sikap dan Penampilan Profesional, Aspek ini menilai kemampuan menunjukkan sikap dan penampilan sebagai tenaga profesional selama pelaksanaan OSCE. Hal ini ditunjukkan melalui penampilan yang rapi sesuai standar, sikap sopan, percaya diri, serta menghargai penguji atau klien standar. Mahasiswa juga menunjukkan tanggung jawab terhadap hasil yang disampaikan dan menjaga etika profesional selama proses berlangsung.					10%	
6. Dokumentasi, Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mendokumentasikan hasil perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan secara lengkap dan sistematis. Dokumentasi mencakup data dasar yang digunakan, langkah-langkah perhitungan, hasil akhir, interpretasi hasil, serta rekomendasi yang diberikan. Pencatatan dilakukan dengan jelas, rapi, dan mudah dipahami.					15%	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Analisis Data	Tidak mampu mengidentifikasi data atau sebagian besar data salah	Mengidentifikasi sebagian data, namun banyak kesalahan dalam klasifikasi atau pemahaman	Data teridentifikasi cukup lengkap, terdapat sedikit kesalahan	Seluruh data teridentifikasi lengkap, tepat, dan sistematis
2. Perhitungan Kebutuhan Tenaga	Tidak melakukan perhitungan atau hasil seluruhnya salah	Melakukan perhitungan tetapi banyak kesalahan konsep dan hasil	Perhitungan cukup benar, terdapat kesalahan kecil	Perhitungan benar, sistematis, dan hasil akurat
3. Interpretasi dan Pengambilan Keputusan	Tidak mampu menginterpretasikan hasil	Interpretasi tidak tepat dan tidak logis	Interpretasi cukup tepat namun kurang mendalam	Interpretasi tepat, logis, dan disertai rekomendasi rasional
4. Komunikasi Profesional	Tidak mampu menyampaikan hasil dengan jelas	Penyampaian kurang jelas, tidak sistematis, bahasa kurang tepat	Penyampaian cukup jelas, ada sedikit kekurangan	Penyampaian jelas, sistematis, bahasa profesional, dan percaya diri
5. Sikap dan Penampilan Profesional	Tidak menunjukkan sikap profesional	Sikap kurang profesional (kurang sopan/kurang rapi)	Cukup profesional, terdapat sedikit kekurangan	Sangat profesional, rapi, sopan, dan percaya diri
6.Dokumentasi	Tidak melakukan dokumentasi	Dokumentasi tidak lengkap dan tidak sistematis	Dokumentasi cukup lengkap, ada kekurangan kecil	Dokumentasi lengkap, jelas, dan sistematis

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

4. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

T. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Keperawatan

Kom ponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung mahasiswa saat melakukan perhitungan kebutuhan tenaga perawat berdasarkan data ruang rawat inap, mulai dari analisis data hingga pemberian rekomendasi.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam manajemen SDM keperawatan.	Mahasiswa mampu menghitung kebutuhan tenaga secara akurat serta memberikan keputusan yang mendukung keselamatan pasien dan efisiensi pelayanan.
Kasus klinik	Kasus klinik disusun berbasis situasi nyata yang menuntut mahasiswa melakukan fungsi manajemen SDM secara komprehensif	Ruang rawat inap memiliki 30 pasien dengan klasifikasi: • 10 pasien minimal care (2 jam/hari) • 15 pasien partial care (4 jam/hari) • 5 pasien total care (6 jam/hari) Jam kerja efektif perawat adalah 7 jam/hari.

Kom ponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		• Kepala ruangan meminta analisis apakah jumlah tenaga saat ini sudah mencukupi.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Tindakan nyata mahasiswa yang dapat diamati selama pelaksanaan peran manajerial	Mahasiswa memperkenalkan diri, mengidentifikasi data pasien dan beban kerja, menghitung total jam asuhan keperawatan, menghitung kebutuhan tenaga, menginterpretasikan hasil, dan menyampaikan rekomendasi kepada kepala ruangan
Aspek yang dinilai	Komponen kompetensi yang menjadi fokus penilaian dalam DOPS.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu melakukan analisis data, ketepatan perhitungan, pengambilan keputusan, komunikasi professional, bersikap dan berpenampilan rapi, serta melakukan dokumentasi
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu memahami data, keakuratan Langkah perhitungan, alur berpikir logis dan sitematis, mampu menjelaskan hasil, serta mampu bersikap professional selama praktik
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat dan spesifik untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan perhittungan, namun perlu lebih jelas dalam menjelaskan interpretasi hasil
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila

Kom ponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran secara nyata	Pada kasus manajerial, • Mampu merencanakan kebutuhan SDM keperawatan secara efektif • Mampu mengambil keputusan berbasis data • Mampu berkomunikasi profesional dalam konteks manajemen

Tabel. Portofolio pada Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen SDM Keperawatan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Mahasiswa mengumpulkan dokumen berupa jadwal dinas perawat, hasil analisis kebutuhan tenaga dengan metode WISN, laporan supervisi, dan refleksi pengalaman praktik di ruang rawat inap.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan menyusun jadwal dinas yang adil dan aman berdasarkan beban kerja serta mengevaluasi efektivitasnya melalui refleksi.
OSCE dan DOPS	OSCE digunakan untuk menilai keterampilan manajerial mahasiswa secara terstruktur	OSCE dapat memuat hasil ujian kemampuan mahaisswa perhitungan kebutuhan tenaga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen SDM Keperawatan
	melalui skenario simulasi. DOPS menilai keterampilan mahasiswa secara langsung di lahan praktik saat melakukan aktivitas manajemen SDM.	keperawatan di ruangan, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan di ruangan
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus nyata yang dialami mahasiswa terkait manajemen SDM	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus perhitungan kebutuhan SDM keperawatan berdasarkan beban kerja di ruang rawat inap, Terdapat 30 pasien dengan tingkat ketergantungan berbeda, yaitu 10 pasien minimal care (2 jam/hari), 15 pasien partial care (4 jam/hari), dan 5 pasien total care (6 jam/hari). Dengan jam kerja efektif perawat 7 jam per hari, kepala ruangan meminta evaluasi hasil analisis.
Refleksi *patient safety*	Refleksi *patient safety* menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam manajemen di unit rawat	Mahasiswa merefleksikan bahwa manajemen sumber daya manusia (SDM) keperawatan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Ketika jumlah dan distribusi perawat tidak sesuai dengan beban kerja, dampak yang muncul tidak hanya pada kelelahan tenaga kesehatan, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kesalahan tindakan, seperti kesalahan pemberian obat atau keterlambatan respons terhadap kondisi pasien.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari *Clinical Instructor* (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah mampu mengidentifikasi masalah SDM dengan baik, namun

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen SDM Keperawatan
	menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	perlu meningkatkan ketegasan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi dengan tim.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari kemampuan analisis kebutuhan SDM, tetapi juga belajar keterampilan komunikasi menggunakan SBAR dan bersikap profesionalisme.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Beberapa laporan kasus menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun jadwal dinas. asil DOPS menunjukkan peningkatan kemampuan supervise. *Feedback* CI konsisten menunjukkan perkembangan positif
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada manajemen SDM Keperawatanportofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep manajemen SDM, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel Case Report pada Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen SDM Keperawatan
Hakikat case report	Case report dalam manajemen SDM keperawatan merupakan laporan sistematis yang menggambarkan analisis, pengambilan keputusan, dan	Mahasiswa menyusun laporan tentang ketidakseimbangan jumlah perawat dengan beban kerja di ruang rawat inap serta dampaknya terhadap pelayanan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen SDM Keperawatan
	penyelesaian masalah terkait pengelolaan tenaga keperawatan di situasi klinik nyata. Fokusnya bukan hanya pada masalah klinis pasien, tetapi pada bagaimana SDM dikelola untuk menjamin mutu pelayanan.	
Tujuan	Case report bertujuan mengembangkan kemampuan analisis masalah manajemen SDM, melatih pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan pemahaman keterkaitan SDM dengan patient safety	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kekurangan tenaga perawat dan memberikan rekomendasi berbasis perhitungan kebutuhan tenaga.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup latar belakang masalah, data dan fakta di lapangan, analisis kebutuhan SDM, alternatif solusi, implementasi dan evaluasi.	Pada kasus manajemen SDM, mahasiswa menuliskan jumlah perawat, tingkat ketergantungan, total kebutuhan jam keperawatan, jam kerja efektif, penyesuaian jadwal dinas, penambahan tenaga, dan prioritas pelayanan berdasarkan Tingkat ketergantungan pasien.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan identifikasi masalah, kemampuan analisis data, relevansi solusi, dan keterkaitan dengan *patient safety*.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghitung kebutuhan tenaga secara akurat dan mengaitkannya dengan risiko keselamatan pasien.
Nilai edukatif	Case report memberikan pembelajaran kontekstual dan aplikatif dalam manajemen SDM keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kekurangan tenaga dapat meningkatkan risiko kelelahan kerja (burnout) dan kesalahan tindakan, sehingga penting

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen SDM Keperawatan
		melakukan perencanaan SDM yang tepat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti pencapaian kompetensi berbasis capaian pembelajaran (learning outcomes) dalam manajemen keperawatan.	Mahasiswa mampu menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkannya dalam situasi nyata secara kritis, sistematis, dan profesional sesuai prinsip OBE.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Manajemen SDM Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen SDM Keperawatan
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi *patient safety* merupakan proses berpikir kritis dan sistematis terhadap pengalaman klinik untuk mengidentifikasi potensi risiko keselamatan pasien yang berkaitan dengan pengelolaan SDM keperawatan. Refleksi ini menekankan hubungan antara kecukupan tenaga, distribusi kerja, dan kualitas pelayan	Mahasiswa merefleksikan situasi ketika terjadi kekurangan perawat pada shift malam yang berdampak pada keterlambatan tindakan keperawatan.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa mampu menyadari bahwa pengelolaan SDM yang tidak optimal dapat meningkatkan risiko insiden keselamatan pasien.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi kesesuaian jumlah tenaga dengan beban kerja, distribusi tugas dan *shift*, dan dampak terhadap keselamatan pasien	Mahasiswa menyoroti ketidakseimbangan jumlah perawat pada shift malam dibandingkan jumlah pasien dengan ketergantungan tinggi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Manajemen SDM Keperawatan
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien akibat manajemen SDM yang kurang optimal.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain terjadinya keterlabatan pemberian obat, monitoring pasien tidak optimal, dan risiko *medication error* meningkat.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa melakukan penyesuaian jumlah perawat berdasarkan beban kerja, mengatur prioritas Tindakan keperawatan, meningkatkan supervisi dan komunikasi tim, dan menggunakan sistem *double check* dalam pemberian obat
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa memahami bahwa perencanaan SDM sangat berpengaruh terhadap *patient safety*, komunikasi tim dan delegasi tugas harus dilakukan secara efektif, dan keputusan manajerial harus berbasis data dan kondisi nyata.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi *patient safety* menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik manajemen keperawatan secara berkelanjutan.

U. Tabel Red Flags & Eskalasi

Manajemen SDM Keperawatan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Rasio perawat: pasien tidak seimbang	Ketidakseimbangan jumlah tenaga dengan beban kerja menyebabkan pelayanan tidak optimal, meningkatkan risiko keterlambatan tindakan dan penurunan kualitas asuhan keperawatan.	Segera lakukan redistribusi tenaga (floating), prioritas pasien berdasarkan tingkat ketergantungan, dan laporkan ke kepala ruangan untuk evaluasi kebutuhan tenaga.
Kelelahan perawat (fatigue/burnout)	Kelelahan fisik dan mental menurunkan konsentrasi dan ketelitian perawat, sehingga berpotensi meningkatkan kesalahan tindakan dan mengancam keselamatan pasien.	Atur ulang jadwal dinas, kurangi beban kerja sementara, serta lakukan supervisi dan dukungan psikologis kepada perawat.
Keterlambatan tindakan keperawatan	Keterlambatan dalam pemberian obat atau monitoring dapat memperburuk kondisi pasien dan meningkatkan risiko komplikasi.	Prioritaskan tindakan berdasarkan urgensi, perkuat koordinasi tim, dan lakukan monitoring ketat terhadap pasien berisiko tinggi.
Dokumentasi tidak lengkap/tertunda	Dokumentasi yang tidak akurat menghambat kontinuitas asuhan dan dapat menyebabkan miskomunikasi antar tenaga kesehatan.	Tegaskan pentingnya dokumentasi real-time, lakukan audit dokumentasi, dan berikan supervisi langsung kepada perawat
Tingginya medication error atau near miss	Kesalahan pemberian obat menunjukkan adanya masalah sistem, baik pada SDM, komunikasi, maupun prosedur kerja.	Terapkan sistem *double-check*, tingkatkan kepatuhan SOP, dan lakukan pelaporan serta analisis

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
		insiden secara sistematis.
Komunikasi tim tidak efektif (handover buruk)	Handover yang tidak jelas menyebabkan informasi penting pasien tidak tersampaikan, meningkatkan risiko kesalahan klinis.	Gunakan metode komunikasi terstruktur seperti SBAR dan lakukan supervisi saat handover.
Tingginya absensi/kekosongan shift	Kekurangan tenaga secara tiba-tiba meningkatkan beban kerja perawat lain dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan.	Segera cari tenaga pengganti (on-call/floating), evaluasi pola absensi, dan laporkan ke manajemen untuk solusi jangka panjang.

Form Checklist "Saya sudah bisa..."
Bab Manajemen SDM Keperawatan
Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Tanggal : _____
Tempat Praktik / Skill Lab : _____
Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa memahami macam-macam metode penghitungan tenaga keperawatan di rumah sakit	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa memahami sistem rekruitmen tenaga keperawatan di rumah sakit	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa memahami tahap-tahap seleksi tenaga keperawatan di rumah sakit	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
4	Saya sudah bisa memahami langkah-langkah orientasi kerja untuk perawat di rumah sakit	☐	☐	
5	Saya sudah bisa memahami terkait penilaian prestasi kerja bagi perawat	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa memahami terkait kompensasi bagi perawat	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menganalisis kebutuhan tenaga keperawatan	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menyusun penghitungan ketenagaan keperawatan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

V. Rangkuman Materi

1. Manajemen SDM Keperawatan

Bab ini menekankan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) keperawatan merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam menentukan mutu, efisiensi, dan keselamatan pelayanan. Tenaga keperawatan sebagai profesi yang memiliki interaksi paling intens dengan pasien dituntut tidak hanya kompeten dalam aspek klinis, tetapi juga mampu berkontribusi dalam pengelolaan pelayanan secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengelolaan SDM keperawatan perlu dilakukan secara terencana, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta dinamika organisasi pelayanan kesehatan.

Dalam praktiknya, manajemen SDM keperawatan mencakup serangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian. Perencanaan SDM menjadi langkah awal yang krusial untuk memastikan ketersediaan tenaga keperawatan dalam jumlah dan kompetensi yang sesuai dengan beban kerja pelayanan. Pengorganisasian kemudian berperan dalam mengatur distribusi tenaga dan pembagian tugas secara proporsional, sehingga setiap anggota tim dapat bekerja secara optimal sesuai perannya. Ketenagaan adalah kegiatan manajer keperawatan untuk merekrut, memimpin, memberikan orientasi, dan meningkatkan perkemabnagan individu dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pengarahan menekankan pentingnya kepemimpinan, komunikasi efektif, serta kemampuan memotivasi tim dalam mencapai tujuan pelayanan. Adapun fungsi pengendalian dilakukan melalui supervisi dan evaluasi untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pelayanan kesehatan, tantangan dalam pengelolaan SDM keperawatan juga semakin beragam. Keterbatasan jumlah tenaga, tingginya beban kerja, variasi tingkat kompetensi, serta tuntutan terhadap mutu dan keselamatan pasien menjadi faktor yang harus dihadapi oleh perawat sebagai bagian dari sistem manajemen. Kondisi ini menuntut perawat untuk mampu berpikir kritis, mengambil keputusan secara tepat, serta mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kemampuan manajerial menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh setiap perawat, khususnya dalam menjalankan peran sebagai pemimpin tim keperawatan.

Selain itu, aspek keselamatan pasien (*patient safety*) menjadi landasan utama dalam setiap keputusan manajerial yang diambil. Kesalahan dalam

pengelolaan SDM, seperti pembagian tugas yang tidak tepat atau kurangnya supervisi, dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keselamatan, seperti identifikasi pasien yang benar, pencegahan infeksi, serta pengurangan risiko kejadian tidak diharapkan, harus terintegrasi dalam setiap fungsi manajemen SDM keperawatan.

Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dan penerapan manajemen SDM keperawatan dalam konteks pelayanan kesehatan. Pembahasan mencakup prinsip dasar, fungsi manajemen, perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan serta peran strategis perawat dalam mengelola tim keperawatan. Dengan mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam situasi praktik secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan serta keselamatan pasien.

W. Daftar Pustaka

American Nurses Association. 2012. *ANA's Principles for Nurse Staffing*. Edisi Kedua. Maryland: The Publishing Program of ANA.

Asmaningrum, Nurfika. (2023). Buku ajar manajemen keperawatan. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup

Aswad, H. N., & Ferrial, E. (2016). Influence of Education Level, Training and Compensation Against Nurse Performance at UIT Hospital. *Jurnal Mirai Management*.

Gillies, D. A. (2000). *Nursing Management a System Approach.* Third Edition. Philadelphia: WB Saunders Co.

Griffiths, P., C. Saville., J. Ball., J. Jones., dkk. 2019. Nursing Workload, Nurse *Staffing* Methodologies And Tools: A Systematic Scoping Review And Discussion. *International Journal Of Nursing Studies.* https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103487

Kemenkes. 2019. *Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.* Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Haryati,T.S. (2014). *Perencanaan, Pengembangan dan Utilisasi tenaga keperawatan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Huber, D.L. (2018). *Leadership nursing care management (6th edition)*. Philadelphia: W.B. Saunders Company.

Marquis, B. L. dan C. J. Huston. 2017. *Leadership Roles and Management Functions in Nursing Theory and Application*. Edisi Kesembilan. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.

Nursalam, Dr (2014) *Manajemen Keperawatan "Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional.* Salemba Medika, Jakarta.

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2021). Fundamentals of nursing (10th ed.). Elsevier.

Roni, A., A. 2020. Pengantar Manajemen : Teori dan Aplikasi. Malang. AE Publishing

Soesanto, Danoe & T. Ersyad. 2019. Perhitungan Kebutuhan Tenaga Keperawatan Berdasarkan WISN di RS. Gotong Royong. *Journal of Health Sciences.* Vol 12(2):71-81. https://journal2.unusa.ac.id/index.php/JHS/article/view/554/854

Yoder-Wise, P. S. (2022). *Leading and managing in nursing* (8th ed.). Elsevier.

BAB 5

PERENCANAAN DAN PENJADWALAN TENAGA KEPERAWATAN

Identitas Bab

- **Mata kuliah:** Manajemen Keperawatan
- **Bab/Modul:** 5
- **CPMK terkait:**
  Merencanakan kebutuhan dan penjadwalan SDM keperawatan berdasarkan beban kerja, kompetensi, dan prinsip keadilan–keselamatan.
- **CPL 4:**
  Mampu merencanakan dan mengelola SDM keperawatan (kebutuhan, penjadwalan, delegasi, supervisi) secara adil, aman, dan efisien.

Sub-CPMK Bab (Learning Outcomes Bab)

Capaian Pembelajaran Bab

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

5.1 Menghitung kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja dan kategori layanan.

5.2 Menyusun jadwal dinas yang adil dan aman (cakupan layanan, aturan jam kerja, risiko kelelahan).

Indikator Ketercapaian

- Skor evaluasi teori Bab 5 (bagian dari **KZ-01**) **≥ 70**.
- Mampu memetakan peran perawat pada skenario dengan akurasi **≥ 80%** (latihan kasus).
- Skor observasi profesionalisme dasar **≥ 3/4** (formatif; bukti masuk portofolio/observasi).

Peta Konsep Bab (Concept Map – versi teks)

Manajemen Keperawatan → membentuk fondasi **seorang manajer keperawatan** → memahami **konsep fungsi manajemen keperawatan** (planning, organizing, staffing, Actuating dan Controling) → memahami **Fungsi Perencanaan** (SDM, Sarana dan system pealayanan) → mengenali **manajemen SDM** (perencanaan SDM, rekrutmen, orientasi tenaga baru, penempatan dan distribusi tenaga,

pengembangan SDM, penilaian kinerja, Kompensasi dan reward, pemeliharaan SDM(retention), pengawasan dan pengendalian dan terminasi→ menerapkan **Perencanaan dan Penjadwalan Tenaga Keperrawatan**

Kata Kunci
Manajemen Keperawatan, Fungsi manajemen Keperawatan, Fungsi Perencanaan, Perencanaan dan penjadwalan tenaga Keperawatan.

Pendahuluan

Pelayanan keperawatan memiliki peran yang penting dalam pelayanan Kesehatan di rumah sakit, 3 shift, 7 hari dan 24 jam Bersama pasien, sehingga memiliki posisi yang sangat strategis dalam meningkatkan mutu dan keamanan pasien di rumah sakit.

Efektifitas dan efisiensi ketenagaan dalam keperawatan sangat ditunjang oleh pemberian asuhan keperawatan yang tepat dan kompetensi perawat yang memadai. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan perencanaan yang strategis dan sistematis dalam memenuhi kebutuhan tenaga keperawatan. Dalam hal ini, perencanaan yang baik mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : klasifikasi pasien berdasarkan Tingkat ketergantungan, metode pemberian asuhan keperawatan, jumlah dan kategori tenaga keperawatan, serta perhitungan jumah tenaga keperawatan.

Uraian Materi

A. Merencanakan Kebutuhan Tenaga

1. Konsep Dasar Ketenagaan Keperawatan

Ketenagaan keperawatan (nursing staffing) merupakan proses penentuan jumlah dan jenis tenaga keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan keperawatan kepada sejumlah pasien pada periode tertentu. Ketenagaan yang memadai adalah prasyarat utama keselamatan pasien dan kualitas pelayanan.

Tujuan Perencanaan Ketenagaan

a. Menjamin asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan berkelanjutan
b. Mencegah kelebihan beban kerja (overload) yang meningkatkan risiko burnout dan medical error
c. Menggunakan sumber daya secara efisien sesuai anggaran rumah sakit
d. Menjamin hak perawat atas jadwal yang adil, istirahat yang cukup, dan pengembangan kompetensi

2. Regulasi dan Standar Ketenagaan di Indonesia

a. KMK 1596, Tahun 2024Tentang Standar Akreditasi RS
b. Permenkes No 40 Tahun 2017 : Jenis, jenjang dan kualifikasi tenaga keperawatan, mengatur jenjang karir perawatan (PK I – PK V)
c. Permenkes No 49 Tahun 2013: Komite Keperawatan Rumah Sakit- menjamin kompetensi perawat melalui kredensialing
d. UU No 17 Tahun 2023 : Pasal 20, sumber daya Kesehatan.
e. Kemenkes Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit: Standar KPS 1 : Kepala unit merencanakan dan menetapkan persyaratan Pendidikan, ketrampilan, pengetahuan, dan persyaratan lainnya bagi semua staf di unitnya sesuai kebutuhan pasien
f. WHO: Rekomendasi internasional: minimal 1 perawat : 4 pasien di ruang umum; 1:1–2 di ICU

3. Pedoman Perhitungan Tenaga Keperawatan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan diuraikan sebagai berikut:

a. Pengelompokan Unit Kerja:
   1) Rawat Inap Dewasa

2) Rawat inap anak
3) Rawat inap intensif
4) Gawat darurat
5) Kamar bersalin
6) Kamar operasi
7) Rawat jalan

b. Model Pendekatan Perhitungan Tenaga Keperawatan, salah satu dari model tersebut Adalah dengan cara perhitungan berdasarkan klasifikasi pasien, yaitu:
1) Tingkat Ketergantungan Pasien berdasarkan jenis kasus
2) Rata rata pasien perhari
3) Jam perawatan yang diperlukan per hari per pasien
4) Jam perawatan yang diperlukan peruangan per hari
5) Jam efektif setiap perawat Adalah 7 jam per hari

a. Metode Douglas

Gillies (1996) menguraikan metode Douglas bagi pasien rawat inap standar waktu pelayanan pasien diuraikan berdasarkanTingkat Ketergantungan Pasien, Tingkat ketergantungan pasien merupakan variabel kunci dalam menentukan beban kerja dan kebutuhan tenaga. Klasifikasi yang umum digunakan di Indonesia mengacu pada Orem (Self-Care Deficit Theory) dan dikembangkan oleh Depkes:

Tabel 5.1: Tingkat Ketergantungan Pasien

Tingkat	Kategori	Karakteristik Pasien
Tingkat I	Minimal Care	Pasien mandiri, hanya butuh pengawasan ringan. Jam perawatan: 1–2 jam/hari
Tingkat II	Partial Care	Pasien membutuhkan bantuan sebagian untuk aktivitas sehari-hari. Jam perawatan: 3–4 jam/hari
Tingkat III	Total Care	Pasien sangat bergantung, butuh bantuan penuh semua aktivitas. Jam perawatan 5-6 jam/hari
Tingkat IV	Intensive Care	Pasien kritis, membutuhkan pengawasan terus-menerus. Jam perawatan: ≥7 jam/hari

Nilai standar jumlah perawat per shift menurut Douglas berdasarkan klasifikasi pasien sesuai table 5.2

Tabel 5.2: Nilai Standar Jumlah Perawat per shift menurut Douglas

Jumlah Pasien	Klasifikasi Pasien								
	Minimal Care			Partial Care			Total Care		
	P	S	M	P	S	M	P	S	M
1	0,17	0,14	0,10	0,27	0,15	0,07	0,36	0,30	0,20
2	0,34	0,28	0,20	0,54	0,30	0,14	0,72	0,60	0,40
3	0,51	0,42	0,30	0,81	0,45	0,21	0,108	0,90	0,60
dst									

Contoh Penerapan Metode Douglas:

Ruang Rawat Mawar RS Lekas Sembuh memiliki 20 pasien dengan komposisi:

- 6 pasien Minimal Care
- 10 pasien Partial Care
- 4 pasien Total Care

Kebutuhan Tenaga Shift Pagi:

= (6 × 0,17) + (10 × 0,27) + (4 × 0,36)

= 1,02 + 2,70 + 1,44 = 5,16 ≈ 6 perawat

Kebutuhan Tenaga Shift Sore:

= (6 × 0,14) + (10 × 0,15) + (4 × 0,30) = 0,84 + 1,50 + 1,20 = 3,54 ≈ 4 perawat

Kebutuhan Tenaga Shift Malam:

= (6 × 0,10) + (10 × 0,07) + (4 × 0,20) = 0,6 + 0,7 + 0,8 = 2,1≈ 3 perawat

Total Kebutuhan per Hari: 6 + 4 + 3 = 13 perawat

b. Penghitungan Tenaga Berdasarkan Klasifikasi Pasien

Tabel 1.3: contoh perhitungan tenaga di Ruangan berdasarkan klasifikasi pasien

No	Jenis/kategori pasien	Rata-rata pasien /hari	Rata-rata jam perawatan pasien/hari	Jumlah perawatan/hari
1	Penyakit Dalam	18	3,5	63
2	Bedah	8	4	32
3	Gawat Darurat	1	10	10
4	Anak	3	4,5	13,5
5	kebidanan	1	2.5	2,5

31	24,5	121

Sumber: Depkes (2005)

Jumlah perawat yang dibutuhkan Adalah:

Jumlah jam perawatan
---------- = 121/7 = 17 perawat.
Jam kerja efektif per shift

Loss Day:

Untuk menghitungg jumlah tenaga tersebut perlu ditambahkan faktor koreksi dengan hari libur / cuti / hari besar (loss day):

Jumlah hari minggu dalam dalam 1 tahun + cuti + hari besar x ∑perawat
jam kerja efektif

= 52 +12 +14 / 286 x 17= 5

Tugas Non-Keperawatan:

Jumlah tenaga keperawatan yang mengerjakan tugas-tugas non keperawatan, seperti membuat perincian pasien pulang, kebersihan ruangan, kebersihan alat – alat makanan pasien, dan kegiatan lain diperkirakan mencapai 25% dari jam pelayanan keperawatan.

(jumlah tenaga keperawatan + los day) x 25% = (17 + 5) x 25% = 5,5

Jumlah tenaga = tenaga yang tersedia + faktor koreksi = 17 + 5,5 = 22,5 (dibulatkan 23 peawat)

Jadi tenaga keperawatan yang dibutuhkan untuk contoh tersebut Adalah: 23 perawat

c. Penghitungan Tenaga Berdasarkan Rumus Depkes

Perhitungan tenaga keperawatan menurut **Depkes (Kemenkes RI)** umumnya menggunakan pendekatan **berbasis beban kerja (jam perawatan)** dengan beberapa komponen utama: kebutuhan dasar + faktor koreksi (loss day dan tugas non-keperawatan)

Keterangan:

1) **BOR** = Bed Occupancy Rate…..sensus harian= BOR x Kapasitas Tempat tidur
2) **TT** = Tempat Tidur (kapasitas Tempat Tidur)

3) **Jam perawatan** (JP)= rata-rata jam perawatan/pasien/24 jam

4) **Jam kerja efektif** = biasanya **7 jam/hari**

Hari kerja efektif dalam 1 th.

1) 1 tahun: 364 hari, Jadi hari kerja efektif dalam 1 th = 364 – 78 : **286 hari.**

2) Hari kerja perminggu: 286 / 7 hr: 41 mgg

3) Hari kerja non efektif:

a) Hari minggu: 52 hr.
b) Libur nasional./besar : 14 hr.
c) Cuti: 12 hari
d) **Jumlah libur: 78 hari**

Standar Jam Perawatan (SJP)pasien/hari:

1) Total care= 6 JP
2) Partieal care=4 JP
3) minimal care 2 JP

Formula Metode Depkes (Langkah-Langkah):

Langkah 1 — Hitung Rata-rata Jam Perawatan:

Rata-rata JP = Σ (Jumlah pasien per kategori × SJP kategori) / Total pasien

Langkah 2 — Hitung Kebutuhan Tenaga Inti:

Tenaga Inti = (Rata-rata JP × Sensus harian × 364) / (Hari kerja efektif xJam kerja

Langkah 3 — Tambahkan Faktor Koreksi: loss day dan tugas non keperawatan

Loss Day = Tenaga Inti × (Jumlah hari tidak kerja / Hari kerja efektif)

Langkah 4 — Tambahkan Tugas Non-Keperawatan:

Non-Keperawatan = (Tenaga Inti + Loss Day) × 25%

Langkah 5 — Total:

Total = Tenaga Inti + Loss Day + Non-Keperawatan

Contoh Penerapan Metode Depkes:

Ruang Bedah: kapasitas 25 TT, BOR=70% terisi 18 pasien: 3 minimal care (2jp), 9 partial care (4jp), 6 total care (6jp)

Langkah 1: Rata-rata JP = ((3×2)+(9×4)+(6×6))/18 = (6+36+36)/18= 78/18 = 4,3jam

Langkah 2: Sensus = 25×70% = 18 pasien; Hari kerja efektif = 364–78 = 286 hari

Tenaga Inti = (4,3 × 18 × 364)/(286 × 7) = 28.173,6/2.002 = 14.0≈ 14 orang

Langkah 3: Loss Day = 14 × (78/286) = 14 × 0,272 = 3,8 ≈ 4 orang

Langkah 4: Non-Keperawatan = (14+4) × 25% = 18 × 25% = 4,5 ≈ 4 orang

Langkah 5: Total = 14 + 4 + 4 = 22 perawat + 1 Karu = 23 perawat

d. Penghitungan Tenga Berdasarkan Beban Kerja (Metode Workload Indicator Of Staffing Need)-WISN

Penghitungan kebutuhan tenaga perawat **berdasarkan beban kerja** biasanya menggunakan pendekatan yang direkomendasikan oleh **Kemenkes/Depkes RI**, salah satunya metode yang paling sering dipakai adalah

Metode WISN (Workload Indicator of Staffing Need), Metode standar WHO & Kemenkes untuk menghitung kebutuhan tenaga berdasarkan **beban kerja nyata**.

Beban kerja keperawatan adalah jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga keperawatan dalam satu periode waktu tertentu. Analisis beban kerja merupakan langkah awal sebelum menghitung kebutuhan tenaga.

Tabel 5.4: Komponen Beban Kerja:

Komponen	Contoh aktivitas	Keterangan
Kegiatan keperawatan langsung	- Pengkajian pasien - Pemberian obat - Perawatan luka - Pemasangan infus - Pemasangan sonde - Mobilisasi pasien	Berhubungan langsung dengan pasien; menentukan standar jam perawatan (SJP)
Kegiatana keperawatan tidak langsung	Dokumentasi, koordinasi tim, persiapan alat, komunikasi	Tidak berhadapan langsung tetapi menunjang asuhan — rata-rata 38–60 menit
Kegiatan Non Keperawatan	Administrasi rumah sakit, antar pasien ke radiologi	Sebaiknya diminimalkan karena bukan kompetensi inti perawat

Langkah-Langkah:

1) **Tentukan waktu kerja tersedia (Available Working Time / AWT)**

   Rumus:

   AWT = (Hari kerja/tahun – cuti – libur – pelatihan – sakit) × jam erja/hari

   Contoh:

   a) 312 hari kerja/tahun
   b) Cuti + libur + pelatihan = 52 hari
   c) Jam kerja = 7 jam/hari

   AWT = (312 – 52) × 7 = **1.820 jam/tahun**

2) **Tentukan komponen beban kerja**

   Misalnya perawat di ruang rawat:

   a) Asuhan keperawatan langsung (vital sign, injeksi, dll)
   b) Dokumentasi
   c) Edukasi pasien
   d) Administrasi

3) **Tentukan standar waktu tiap kegiatan**

   Contoh:

   a) Observasi vital sign: 10 menit/pasien
   b) Pemberian obat: 5 menit/pasien

4) **Hitung total beban kerja**

   Rumus:

   Total waktu kerja = jumlah kegiatan × standar waktu

5) **Hitung kebutuhan tenaga**

   Rumus utama:

   Jumlah tenaga = Total beban kerja / AWT

Indikator Beban Kerja: BOR dan Jam Perawatan

BOR (Bed Occupancy Rate)

BOR = (Jumlah hari perawatan pasien / Jumlah TT × Jumlah hari periode) × 100%

Standar ideal BOR: 75–85% (Depkes, 2005). BOR >85% mengindikasikan beban berlebih.

Standar Jam Perawatan per Pasien per Hari (SJP)

- Minimal Care : 2 jam/pasien/hari
- Partial Care : 4 jam/pasien/hari
- Total Care : 6 jam/pasien/hari
- Intensive Care : 7–8 jam/pasien/hari

B. Pembagian Tenaga Keperawatan dan Penyusunan Jadwal

Salah satu tugas dan tanggung jawab kepala ruangan adalah Menyusun jadwal dinas karena kepala ruangan lebih memahami kesibukan aktivitas ruangan dan karakteristik staf perawatnya. (Kuntoro, 2010) menyatakan bahwa dalam penyusunan jadwal dinas, hendaknya memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada kesinambungan antara kebutuhan unit kerja dan kebutuhan perawat. Sebagai contoh kebutuhan perawat untuk rekreasi maka perlu diperhatikan siklus jadwal penugasan yang sibuk dan yang tidak sibuk, berat dan ringan serta semua perawat harus terlibat dalam rotasi dan memiliki jam kerja yang sama.
2. Setiap perawat memperoleh giliran yang sama dalam setiap rotasi shift pagi, sore dan malam. Selain itu serta metode yang digunakan harus sesuai dengan keberadaan perawat dalam suatu unit kerja baik secara kuantitas maupun kualitas.

   Misal ruang rawat inap dengan kapasitas 25 tempat tidur, ditemukan rata-rata 19 pasien dirawat. Rata-rata perawat kontak dengan pasien Adalah 5 jam/pasien/24 jam, perhitungan sebagai berikut:

   a. Total jam dibutuhkan pasien dalam sehari : 19 pasien x 5 jam = 95 jam
   b. Bila jam dinas selama 8 jam maka jumlah perawat yang dibutuhkan : 95 : 8= 11,9 ≈ 12 perawat dalam 24 jam
   c. Total jam kerja 40jam/minggu maka jumlah jam shift perminggu = `12 perawat x 7 hari=84 jam

   Selain itu juga dipertimbangkan juga proporsi dinas pagi, dinas sore dan dinas malam. Dalam hal ini proporsi dinas pagi sebesar 47% , dinas sore sebesar 36% dan dinas malam sebesar 17%. Hal ini memberikan Gambaran jumlah perawat yang dibutuhkan12 perawat tadi dengan distribusi jaga sebagai berikut:

   a. Dinas pagi : 6 perawat
   b. Dinas sore : 4 perawat
   c. Dinas malam : 2 perawat

Selain proporsi ada metode penjadwalan berdasarkan metode Nursing Management Information System (NMIS) atau pembagian jadwal dinas dengan mempertimbangkan produktivitas kerja staf perawat. Pengukuran produktivitas kerja dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara jumlah jam staf perawat yang dibutuhkan dengan jumlah jam staf perawat yang tersedia dikalikan 100%.

1. Prinsip Penjadwalan

a. Adil, transparan, dan mempertimbangkan keselamatan kerja.
b. Menghindari kelelahan kerja (fatigue) dan risiko kesalahan klinis.

2. Ketentuan Umum

a. Maksimal 3 shift malam berturut-turut.
b. Jeda minimal 11 jam antar shift.
c. Lembur bersifat sukarela dan dibatasi sesuai kebijakan rumah sakit.
d. Pembagian shift malam, akhir pekan, dan hari libur dilakukan secara proporsional.

3. Penyusunan Jadwal

a. Disusun oleh kepala ruangan setiap bulan.
b. Preferensi staf dapat dipertimbangkan selama tidak mengganggu kebutuhan pelayanan.

C. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Jika anda ditunjuk sebagai kepala Ruangan (Karu) baru di suatu ruang rawat inap, dengan kapasitas 40 tempat tidur BOR 75%

1. Jumlah pasien dengan BOR 75%: 30 pasien
2. Klasifikasi pasien:
   - Minimal care: 10 pasien → 2 jam/hari
   - Partial care: 12 pasien → 4 jam/hari
   - Total care: 8 pasien → 6 jam/hari
3. Jam kerja efektif perawat: **7 jam/hari**
4. Faktor kehilangan waktu (cuti, izin, dll): **78 hari**

Pertanyaan: Berapa kebutuhan tenaga perawat di unit tersebut?

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Tentukan jumlah perawat yang dibutuhkan di unit tersebut dengan pendekatan penghitungan : metode Douglas dan metode Depkes
2. Buat jadwal dinas perawat jaga pagi, jaga sore dan jaga malam serta yang libur

D. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/skill lab.

1. Menghitung tenaga:

Fokus Langkah-langkah menghitung kebutuhan tenaga dengan rumus Depkes;

- Hitung rata – rata jam perawatan (JP)
- Hitung kebutuhan tenaga perawat inti

- Hitung Loss Day dan
- Hitung factor koreksi (Non keperawatan)
- Hitung total tenaga yang dibutuhkan

Langkah Langkah menghitung kebutuhan tenaga metode Douglas:

- Tentukan pasien yang minimal care, partieal care dan total care
- Masukkan dalam rumus Douglas kebutuhan perawat jaga pagi, jaga sore dan jaga malam
- Total tenaga inti yang jaga pagi ditambah jaga sore dan jaga malam
- Hitung Loss Day perawat yang libur
- Total tenaga perawat yang dibutuhkan adalah: tenaga inti ditambah tenaga Loss day dan ditambah 1 karu

2. Pembagian tenaga dan penjadwalan

Langkah-langkahnya:

- Hitung rata -rata pasien per hari dengan mengetahuai BOR ruangan
- Hitung Jam perawatan (JP) pasien per hari
- Jam efektif bekerja 7 jam
- Hitung jumlah perawat yang dibutuhakan pada hari itu
- Hitung jumlah jam shift per minggu (7 hari)

Selanjutnya buat Proporsi :

- Jaga pagi : 47% x jumlah perawat yang dibutuhkan pada hari itu
- Jaga sore : 36% x jumlah perawat yang dibutuhkan pada hari itu
- Jaga pagi : 17% x jumlah perawat yang dibutuhkan pada hari itu

3. Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Kala II

4. Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan* OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Materi manajemen dan kepemimpinan
- Materi manajemen perencanaan

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

Contoh:

TEMPLATE SOAL OSCE KEPERAWATAN

No.	**Komponen**	**Isi**
1	Nomor station	…… (Dikosongkan)
2	Judul station	Penghitungan ketenaga Dan Penjadwalan
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, menentukan Tingkat ketergantungan pasien dan penghitungan tenaga dan penjadwalan perawat dinas pagi, sore dan dinas malam
5	Kompetensi	Mahasiswa Mampu : 1. mengklasifikasikan Tingkat ketergantungan pasien 2. menghitung BOR ruangan dan menghitung rata-rata pasien per hari 3. menghitung jam perawatan (JP)yang diperlukan pasien per hari 4. menghitung jam efektif setiap perawat per hari 5. menghitung kebutuhan tenaga dengan rumus penghitungan tenaga : Rumus Depkes, dan Rumus Douglas

No.	Komponen	Isi
		6. membuat Pembagian tugas dan penjadwalan
6	Kategori	1. Penghitungan tenaga 2. Penjadwalan perawat
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang Ns. PK III ditunjuk sebagai kepala ruangan di ruang rawat inap Penyakit Bedah dengan kapasitas 40 Tempat Tidur dengan BOR 75% (30 pasien dengan perincian : 10 minimal care, 12 partiel care dan 8 total care) TUGAS: 1.Lakukan Penghitungan tenaga dengan metode Depkes dan Doglas dilembar jawab 2.Selanjutnya Buat jadwal dinas jaga pagi, jaga sore dan jaga malam dilembar jawab sesuai proporsi : dinas pagi sebesar 47% , dinas sore sebesar36% dan dinas malam sebesar 17%
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang Ns. PK III ditunjuk sebagai kepala ruangan di ruang rawat inap Penyakit Bedah dengan kapasitas 40 Tempat Tidur dengan BOR 75% (30 pasien dengan perincian : 10 minimal care, 12 partiel care dan 8 total care) TUGAS: 1. Lakukan penghitungan tenaga dengan metode Depkes dan metode Douglas 2. Tuliskan dilembar jawaban penghitungan tenaga dengan metode Depkes dan meode Douglas 3. Tuliskan penjadwalan perawat sesuai proporsi jaga pagi, sore dan malam dilembar jawaban INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta dalam menghitung tenaga keperawatan dengan metode Depkes dan metode Douglas

No.	Komponen	Isi
		2. Menilai kemampuan peserta dalam penjadwalan perawat jaga pagi, sore dan malam 3. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan
9	Instruksi	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. Jumlah pasien minimal care, partial care dan total care 2.
10	Setting station	Ruang Kepala Ruangan - Meja - Kursi - Komputer/laptop - Kertas kosong - Penguji Tata letak ruang: 1. Meja kerja 2. Kursi Karu 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Komputer/laptop
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Komputer/laptop 2. Kertas kosong 3. Bolpoin 4. meja kerja 5. Kursi 6. Format jadwal dinas Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	. ...

No.	Komponen	Isi
13	Referensi	

SPO JADWAL DINAS PERAWAT

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengidentifikasi jumlah perawat yang tersedia				
2	Menghitung kebutuhan tenaga per shift (berdasarkan BOR, tingkat ketergantungan pasien)				
3	Mengidentifikasi kompetensi perawat (senior, junior, ICU-trained, dll)				
4	Mengumpulkan permintaan khusus (cuti, izin, pendidikan)				
B	Penyusunan jadwal				
1	Menentukan pola shift:Pagi: 07.00 – 14.00; Sore : 14.00 – 21.00 dan malam: 21.00 – 07.00				
2	Mengatur distribusi perawat: - Minimal jumlah per shift terpenuhi - Kombinasi skill mix (senior + junior)				
3	Memastikan prinsip: - Tidak lebih dari 40 jam kerja/minggu - Maksimal 3 shift malam berturut-turut				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	- Ada waktu istirahat cukup (minimal 1 hari libur/minggu)				
4	Menyusun jadwal dalam format: - Bulanan (umum) - Mingguan (detail operasional)				
C	**Verifikasi dan Validasi**				
1	Kepala ruangan melakukan review jadwal				
2	Disesuaikan jika ada ketidakseimbangan beban kerja				
3	Disahkan oleh kepala instalasi keperawatan				
D	DISTRIBUSI JADWAL				
1	Jadwal diumumkan minimal 1 minggu sebelum periode berjalan				
2	Ditempel di ruang perawat dan/atau dibagikan via sistem digital				
E	MONITORING DAN EVALUASI				
1	Evaluasi kepatuhan jadwal				
2	Penyesuaian jika ada: o Perawat sakit o Lonjakan pasien o Kondisi emergensi				
3	Evaluasi berkala tiap bulan				
F	DOKUMEN TERKAIT				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	• Form jadwal dinas perawat • Daftar hadir perawat • Rekap shift bulanan • Data BOR dan klasifikasi pasien				
G	INDIKATOR MUTU				
1	• Kesesuaian jumlah perawat per shift (%) • Kepatuhan terhadap jadwal (%) • Insiden akibat kelelahan kerja (fatigue-related error)				
F	Penampilan Profesional				
1	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

Form Penilaian Osce Keperawatanstation: Penghitungan Tenaga Dan Penjadwalan Perawat

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Mengklasifikasikan Tingkat ketergantungan pasien	Teridentifikasi tingkat ketergantungan pasien minimal, partial dan total care					1	
2	Mengitung rata-rata pasien per hari (BOR) pasien	Dapat menampilkan rata rata pasien per hari					1	
3	Menghitung jam perawatan yang	Mempu menghitung jama perawatan pasien dengan benar					1	

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
	diperlukan pasien per hari							
4	Menghitung jam efektif setiap perawat per hari	Mengetahui jam kerja efektif dengan benar					1	
5	Menghitung tenaga dengan metode tertentu	Mampu mengimplementasikan metode penghitungan tenaga dengan benar					4	
6	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

E. Rubrik Penilaian

Rubrik Penilaian Osce Keperawatan Station: Perencanaan Tenaga Dan Penjadwalan

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Mampu mengidentifikasi Tingkat ketergantungan pasien					1	
2. Mampu menghitung rata rata pasien per hari (BOR)					1	
3. Peserta ujian mampu menghitung jam perawatan (JP)					1	
4.Peserta mengetahui jam efektif setiap perawat per hari					1	
5.Peserta ujian mampu menerapkan metode penghitungan tenaga secara benar, tepat dan sistematis					2	
6.Peserta ujian mampu membuat jadwal dinas perawat					2	
6. Perilaku ProfesionalAspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal serta responsif					2	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3	SKOR 4
Mampu mengidentifikasi Tingkat ketergantungan pasien	Tidak melakukan identifikasi sesuai Tingkat ketergantungan pasien.	Melakukan identifikasi Tingkat ketergantungan pasien sangat terbatas, hanya	Melakukan identifikasi Tingkat ketergantungan pasien cukup baik dan cukup sistematis,	Melakukan identifikasi Tingkat ketergantungan pasien secara lengkap, sistematis, dan relevan, sesuai

KOMPETENSI	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3	SKOR 4
		menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi Tingkat ketergantungan pasien	mampu menggali sebagian besar Tingkat jetergantungan pasien minimal care, partieal care dan total care, tetapi masih ada data penting yang terlewat atau interpretasi belum lengkap.	kriteria pada pasien minimal care, partieal care dan total care
Menghitung rata-rata pasien per hari (BOR)	Tidak mampu menghitung rata-rata pasien per hari (BOR).	Mampu menghitung rata rata pasien per hari tetapi tidak tepat belum sesuai data yang ada diruangan	Mampu menghitung rata-rata pasien perhari yang cukup tepat sesuai data, namun masih kurang spesifik, atau belum sesuai data yang ada diruangan	Menghitung rata-rata pasien per hari secara tepat berdasarkan data pasien, yang sesuai data pasien di ruangan
menghitung jam perawatan (JP)	Tidak mampu menghitung jam perawatan pasien dengan benar	Mampu menghitung jam perawatan pasien namun belum tepat.	Melakukan penghitungan jam perawatan dengan cukup baik, sebagian	Mampu melakukan penghitungan jam perawatan dengan benar dan tepat

KOMPETENSI	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3	SKOR 4
			besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan	
Peserta ujian mengetahui jam efektif setiap perawat per hari	Belum mampu menyebutkan jam efektif setiap perawat per hari	Mampu menjelaskan jam efektif perawat per hari tapi belum tepat	Mampu menjelaskan jam efektif perawatan dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan	Mampu menjelaskan tentang jam efektif setiap perawat per hari dengan tepat dan benar
Peserta ujian mampu Menghitung tenaga dengan metode tertentu	Belum mampu menghitung tenaga keperawatan dengan tepat dan benar (banyak kesalahan dalam penghitungan)	Mampu menghitung tenaga keperawatan tetapi masih belum tepat	Mampu menghitung tenaga dengan metode tertentu dengan cukup baik Sebagian Langkah sudah benar namun ada yang masih kurang	Sangat tepat; asumsi jelas & dapat pertanggungjawabkan
Mampu membuat jadwal dinas dengan benar	Cakupan tidak aman; melanggar aturan	Cakupan cukup; pemerataan kurang	Cakupan aman; aturan dipatuhi; cukup adil	Cakupan sangat aman; patuh aturan; sangat

KOMPETENSI	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3	SKOR 4
				adil & minim risiko kelelahan
Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
1	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
2	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
3	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
4	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ---------- x 100 =

30

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

F. DOPS (Does)

1. DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada penghitungan tenaga dan pedjadwalan
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

2. Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada PERENCANAAN DAN PENJADWALAN

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus di ruang rawat
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat melakukan perencanaan tenaga dan penjadwalan perawat
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus di ruang rawat
	perencanaan tenaga dan penjadwalan perawat	perencanaan dan penjadwalan perawat, tetapi juga dari kemampuannya menganalisis kebutuhan tenaga cecara kuantitas dan kualitas
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Jika anda ditunjuk sebagai seorang kepala ruang baru diruang Penyakit Dalam Mawar dengan kapasitas tempat tidur 25 dengan BOR 70 % (6 pasien total care, 9 partial care dan 3 minimal care), sedangkan Data tenaga adalah 16 perawat (4 S1 Kep. Ns dan 12 D3 Kep), mohon dibuatkan perencanaan tenaga keperawatan dengan metode Depkes dan Metode Douglas
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana kebutuhan tenaga diruang rawat	Mahasiswa memperkenalkan diri kepada karu dan pembimbing klinik ruangan, melakukan pengkajian data tenaga perawat, jumlah pasienn dengan Tingkat ketergantungan minimal, partieal dan total care, menghitung kebutuhan tenaga dengan metode Depkes dan Douglas
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi identifikasi Tingkat ketergantungan pasien, jam keperawatan, jam efektif perawat, menghitung tenaga dengan metode Depkes dan Douglas, menghitung total tenaga yang dibutuhkan di unit pelayanan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali kemampuan mahasiswa dalam : mengidentifikasi Tingkat ketergantungan pasien, jam perawatan, jam efektif perawat, menghitung tenaga dengan salah satu metode (Depkes, Douglas dll)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus di ruang rawat
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data pasien, BOR, Tingkat ketergantungan pasien data perawat, dengan kebutuhan perawat sesuai metode penghitungan tenaga, misalnya diruang rawat inap, rawat ICU, ruang IGD ruang rawat jalan
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi pasi, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian intake-output dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter perencanaan tenaga dan penjadwalan secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus manajemen perencanaan tenaga dan penjadwalan, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan metode penghitungan tenaga secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

G. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Perencanaaan Tenaga dan Penjadwalan

Komponen	**Deskripsi**	**Contoh pada Kasus Penghitungan tenaga perawat dan penjadwalan**
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada Praktik manajemen keperawatan (Perencanaan tenaga dak penjadwalan tenaga keperawatan), portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan identifikasi Tingkat ketergantungan pasien, jam perawatan, jam efektif perawat perhari, menghitung tenaga dengan metode penghitungan, membuat jadwal dinas sesuai proposi tenaga yang dibutuhkan dan menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia membuat perencanaan tenaga dan penjadwalan sesuai ruang rawat di rumah sakit (Ruang rawat inap

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Penghitungan tenaga perawat dan penjadwalan
		bedah, dalam, ICU, IGD dll) tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan menghitung kebutuhan tenga dengan pendekatan salah satu metode penghitungan tenaga dan penjadwalan perawat yang aman dan benar. sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan perencanaan tenaga dan penjadwalan perawat sesuai unit yang dikelolanya
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data ketenagaan, BOR, Tingkat ketergantungan pasien, karakteristik pasien dan karakteristik perawat juga sebagai pertimbangan penghitungan tenaga dan penjadwalan perawat.	Mahasiswa menuliskan hasil pengkajian tentang SDM (M1) berupa: - Tingkat ketergantungan pasien: Total care, partieal care dan total care - BOR ruangan dan rata – rata pasien per hari - Menghitung jam perawatan (JP) Pasie - Jam kerja efektif perawat - hasil penghitungan tenaga dengan metode tertentu (Depkes, Douglas dll)

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Penghitungan tenaga perawat dan penjadwalan
		-Menghitung proporsi perawat jaga pagi, sore dan malam -membuat jadwal dinas yang aman dan adil
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam pelayanan keperawatan di unit	Mahasiswa merefleksikan pentingnya melakukan supervise dan observasi terhadap pelaksanaan pelayanan keperawatan sesuai dengan penjadwalan yang sudah direncanakan apakah aman, lancar tidak ada kendala dalam pemberian asuhan pasien
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam perencanaan ketenagaan dan penjadwalan
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu metode penghitungan tenaga tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan perencanaan tenaga keperawatan dan penjadwalan secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Penghitungan tenaga perawat dan penjadwalan
	pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	mahasiswa secara konsisten mampu melakukan perencanaan tenaga dan penjadwalan perawat
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan anak dengan diare, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep perencanaan tenaga, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus yang ditangani mahasiswa selama praktik manajemen keperawatan. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang kasus perencanaan ruang rawat menrencanakan tenaga dan penjadwalan perawat: Jika anda ditunjuk sebagai seorang kepala ruang baru diruang Penyakit Dalam Mawar dengan kapasitas tempat tidur 25 dengan BOR 70 % (6 pasien total care, 9 partial care dan 3 minimal care), sedangkan Data tenaga adalah 16 perawat (4 S1 Kep. Ns dan 12 D3 Kep), mohon direncanakan kebutuhan tenaga, penjadwalan perawat

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		dan MAKP yang sesuai diruang tersebut
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasisw a dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data Tingkat ketergantunagn pasien, BOR, Rata-rata jam perawatan(JP), Hasil penghitungan tenaga dan penjadwalan perawat tetapi mahasiswa dituntut untuk bisa menganalisa kebutuhan tenaga perawat secara kuantitas dan kualitas serta merekomendasikan model penugasan MAKP yang sesuai diruangan tersebut
Isi laporan	Isi case report " manajemen keperawatan" Input data, analisis masalah dan perencanaan (Renop ruangan)	Pada kasus " manajemen keperawatan, berisikan Input data (M1,M2, M3dst), Analisa masalah (M1=SDM) kesenjangan antara kenyataan (tenaga yang ada di unit) dengan jumlah tenaga hasil perhitungan (metode Depkes, Douglas dll) selanjutnya Menyusun suatu perencanaan (rencana operasional/renop ruangan) berupa POA
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan penghitungan tenaga dan perencanaan tenaga dan penjadwalan perawat	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data yang diperoleh tentang Tingkat ketergantunagn pasien, BOR, Jam perawatan pasien, jam kerja efektif diaplikasikan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		dalam metode penghitungan tenaga serta hasilnya diproprsikan dalam penjadwalan perawat jaga pagi, sore dan malam
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus manajeme ruang rawat mahasiswa belajar bahwa pengkajian (input data: M1-SDM), Analisa masalah SDM, Perencanaan SDM dan Penjadwalan perawat sangat penting dalam manajemen pelayanan keperawatan di unit ruang rawat (rawat inap, ruang ICU, rawat jalan, IGD dan ruang lainnya).
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep perencanaan tenaga dan penjadwalan saja, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan manajemen pelayanan keperawatan secara utuh.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Manajemen keperawatan" Perencanaan tenaga dan Penjadwalan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus perencanaan dan penjadwalan tenaga mahasiswa merefleksikan bahwa perencanaan dan penjadwalan tenaga yang tidak sesuai kualifikasi dan kompetensi perawat maka dapat mengakibatkan insiden keselamatan pasien (IKP)
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti membuat jadwal dinas perawat pada shift jaga pagi, sore dan malam harus direncanakan SDM yang kompeten dengan proporsi yang sama ada PK III, PK II dan PK I atau dengan penjadwalan pada semua perawat dengan adil (libur dan jam kerja dalam satu minggu tidak lebih dari 40 jam), jika melebihi jam kerja maka dapat berdampak besar pada keselamatan pasien
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman praktik manajemen	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada perencanaan dan penjadwalan perawat di pelayanan keperawatan jika dibuat tidak sesuai prosedur (SPO jadwal dinas) akan berisiko terjadinya insiden keselamatan pasienmemahami tanda bahaya.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain penurunan kinerja SDM, Tim Work, beban kerja yang tidak merata akhirnya terjadinya bornout
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya supervisi, bimbingan/pengarahan perawat pada penerapan SPO penjadwalan dinas perawat secara berkala.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada praktik manajemen keperawatan, perencanaan dan penjadwalan perawat dibuat sesuai SPO dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik Manajemen keperawatan secara berkelanjutan.

H. Rangkuman Materi

Bab ini menekankan pentingnya perencanaan tenaga keperawatan merupakan proses yang sistematis untuk mendapatkan menentukan jumlah dan jenis tenaga keperawatan sesuai kebutuhan pelayanan keperawatan yang bertujuan untuk, menjamin mutu asuhan keperawatan, efisiensi penggunaan SDM, dan keselamatan pasien (patient safety)

Mahasiswa perlu memahami, analisis kebutuhan tenaga berdasarkan beban kerja, Tingkat ketergantungan pasien (minimal care, partieal care dan total care) jenis pelayanan di unit rawat inap bedah, medikel, anak, IGD, ICU dan rawat jalan. Yang penghitungan tenaganya menggunakan metode Depkes, Douglas, Workload Indicator of Staffing Need (WISN). Klasifikasi dan kompetensi perawat yang dibutuhkan unit pelayanan berapa proporsi perawat Ners yang dibandingkan dengan perawat vokasional (D3 Keperawatan), mahasiswa juga harus memahami penyesuaian kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasien (kompleksitas pasien), Tindakan keperawatan dan standar kompetensi yang dipersyaratkan secara nasional yang dituangkan dalam rincian kewenangan klinis (RKK) dan Surat Penugasan Klinis (SPK) perawat. Serta mahasiswa juga harus memahami prinsip penjadwalan tenaga perawatan, harus adil dan merata, kontinuitas pelayanan 24 jam, memperhatikan hak tenaga (cuti, istirahat), system shift jaga pagi, sore dan malam, rotasi shift. Metode penyusunan jadwal berdasarkan jumlah tenaga yang tersediia dan kebutuhan per shift (proporsi jaga pagi 47%, jaga sore 36% dan 17% untuk jaga malam. Faktor yang mempengaruhi penjadwalan adalah, faktor internal berupa jumlah SDM, kompetensi perawat dan absensi. Sedangkan faktor eksternal adalah berupa kebijakan rumah sakit, regulasi yang ditetapkan dan standar akreditasi rumah sakit yang berlaku. Evaluasi dan monitoring penjadwalan tenaga perawat dengan indikator kepuasan pasien, beban kerja perawat dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) yang terjadi di unit pelayanan keperawatan.

Implementasi dalam pelayanan keperawatan terkait perencanaan dan penjadwalan tenaga keperawatan berupa penyusunan SPO Jadwal Dinas Perawat, penggunaan teknologi elektronik berupa E-Jadwal dinas (Software manajemen SDM). Dokumentasi berupa jadwal Dinas dan laporan harian terkait pembagian tugas perawat pagi, sore dan malam. Tantangan dan Solusi yang dihadapi dalam perencanaan tenaga dan penjadwalan perawat adalah adanya kekurangan tenaga dan burnout perawat, untuk itu Solusi yang direncanakan oleh manajer keperawatan berupa, redistribusi tenaga, pelatihan dan fleksibilitas jadwal

Dengan demikian, inti bab ini Adalah bahwa perencanaan dan penjadwalan tenaga keperawatan merupakan proses yang krusial dalam manajemen keperawatan untuk memastikan pelayanan yang optimal, efisien dan aman.

Pendekatan harus berbasis kebutuhan pasien, kompetensi perrawat sesuai level karir serta evaluasi secara berkala

I. Tabel Red Flags & Eskalasi

Tabel Red Flags & Eskalasi Praktik Manajemen Keperawatan" Perencanaan Dan Penjadwalan Perawat"

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Jumlah perawat kurang kebutuhan minimal (rasio tidak terpenuhi)	Overload kerja, resiko keselamatan pasien	Segera laporkan ke perawat penanggung jawab/kepala ruangan, koordinasi dengan supervisor untuk permintaan tenaga tambahan (FLOT NURSE)
Perawat tidak sesuai kompetensi (misal ICU tanpa pelatihan ICU dasar atau perawat OK belum pelatihan perawat OK, perawat HD belum pelatihan dasar HD)	Kesalahan Tindakan, patient safety issue	Reassign sesuai kompetensi, konsultasi dengan manajer keperawatan
Ketidak seimbangan shift (malam dominan junior (PK I)	Penurunan kualitas pelayanan dan resiko insiden pasien safety	Revisi jadwal dinas…redistribusi perawat senior(PK II/PK III)
Perawat mendadak sakit tidak ada pengganti	Kekurangan tenaga perawat saat shift jaga berjalan	Aktifkan on-call staff/overtime…lapor supervisor keperawatan
Lonjakan pasien (BOR tinggi melebihi standar > 85%)	Burnout	Ekskalasi ke manajemen untuk menambah tenaga
Tidak sesuai antara tingkat ketergantungan pasien dan jumlah perawat	Resiko kejadian yang tidak diinginkan /KTD/KNC dlll	Re-penghitungan tenaga untuk disesuaikan
Jadwal tidak sesuai regulasi (jam kerja berlebih)	Kelelahan/ medication error	Revisi jadwal segera

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Banyak complain terkait jadwal	Penurunan kerja tim	Mediasi, evaluasi system penjadwalan
Tidak tersedia perawat cadangan	Gangguan pelayanan dsaat krisis	Koordinasi dengan unit lain
Jadwal tidak mengikuti kebijakan RS	Resiko legal dan akreditasi rumah sakit	Audit internal hasil dilaporkan ke manajemen

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab "Perencanaan dan penjadwalan tenaga perawat"

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian penghitungan tenaga dan penjadwalan tenaga keperawatan secara sederhana	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa melakukan identifikasi Tingkat ketergantungan pasien minimal care, partieal care dan total care	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menghitung rata-rata jam perawatan (JP)	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menghitung tenaga dengan metode Depkes, Douglas dan beban kerja	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menganalisis hasil penghitungan tenaga untuk membuat jadwal jaga perawat pagi, sore dan malam	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa merekomendasikan metode MAKP yang sesuai diruang pelayanan	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menyusun rencana operasional tentang kebutuhan tenaga (SDM)	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa memantau kepatuhan SPO yang berhubungan dengan penjadwalan tenaga perawat	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa melakukan monitoring dan evaluasi yang berhubungan dengan penjadwalan perawat	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa melaporkan IKP yang berhubungan dengan penjadwalan perawat	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi yang berhubungan dengan penjadwalan tenaga perawatan	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
12	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat praktik manajemen keperawatan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

J. Daftar Pustaka

Arsad Suni (2018). Kepemimpinan & Manajemen Keperawatan. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Depkes RI. (2002). Pedoman Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat. Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Medik.

Douglas, L.M. (1984). The Effective Nurse Leader and Manager. 2nd ed. St. Louis: Mosby Company.

Gillies, D.A. (1994). Nursing Management: A Systems Approach. 3rd ed. Philadelphia: Saunders.

Huber, D. (2017). Leadership and Nursing Care Management. 6th ed. Philadelphia: Elsevier.

Kemenkes (2024). Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/D/47104/2024: Instrumen Surve akreditasi Rumah Sakit. Jakarta: Kemkes RI.

Kemenkes RI. (2013). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan. Jakarta: Kemenkes RI.

Kemenkes RI. (2017). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis. Jakarta: Kemenkes RI.

Marquis, B.L. & Huston, C.J. (2012). Leadership Roles and Management Functions in Nursing. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Murray, E. (2017). Nursing Leadership and Management for Patient Safety and Quality Care. Philadelphia: F.A. Davis.

Nursalam (2014). Manajemen Keperawatan, Jakarta: Salemba Medika

PERSI & KARS. (2019). Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1. Jakarta: KARS.

Ratna Sitorus dan Rumondang (2011). Manajemen Keperawatan. Jakarta: Sagung Seto

WHO. (2020). State of the World's Nursing 2020: Investing in Education, Jobs and Leadership. Geneva: WHO.

BAB 6

MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN DAN DELEGASI

Identitas Bab

- **Mata Kuliah:** Manajemen Keperawatan
- **Bab / Modul:** 6
- **CPMK Terkait:** CPMK-5 (Mengelola manajemen asuhan keperawatan melalui delegasi, supervisi, koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya).
- **CPL Terkait:** CPL-4 (Mampu merencanakan dan mengelola SDM keperawatan secara adil, aman, dan efisien).

Capaian Pembelajaran Bab (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. **Sub-CPMK 6.1:** Menganalisis penerapan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian) dalam lingkup asuhan keperawatan.
2. **Sub-CPMK 6.2:** Menetapkan keputusan delegasi berdasarkan prinsip 5 Benar Delegasi dan analisis kompetensi staf.

Indikator Ketercapaian

1. Ketepatan menyusun rencana harian dan pembagian tugas sesuai metode asuhan (Skor ≥ 3/4).
2. Kemampuan mendemonstrasikan komunikasi delegasi yang efektif (Skor ≥ 3/4 pada rubrik RB-05).

Peta Konsep Bab

Manajemen Asuhan (POAC) → Metode Penugasan → Proses Delegasi (Wewenang & Akuntabilitas) → Prinsip 5 Benar → Supervisi & Audit Mutu.

Kata Kunci

Manajemen Asuhan Keperawatan, Delegasi

Istilah Kunci

Accountability (Akuntabilitas)

"Kesediaan dan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan kepada diri sendiri dan orang lain atas pilihan, keputusan, dan tindakan yang dilakukan" (American Nurses Association [ANA], 2015a).

Assignment (Penugasan)

Distribusi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab setiap anggota staf dalam suatu periode kerja tertentu; mencakup perawatan rutin, aktivitas, dan prosedur yang berada dalam lingkup praktik yang diizinkan dan/atau deskripsi pekerjaan staf tersebut (National Council of State Boards of Nursing [NCSBN], 2016; ANA dan NCSBN, 2014).

Competency (Kompetensi)

Kemampuan individu untuk melaksanakan perilaku tertentu secara profesional dengan menunjukkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pertimbangan klinis yang sesuai dengan peran atau situasi tertentu.

Delegation (Delegasi)

Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada staf yang kompeten untuk melaksanakan tugas keperawatan tertentu yang sebelumnya bukan merupakan kewenangan rutinnya; namun, perawat profesional (Registered Nurse/RN) tetap mempertahankan akuntabilitas atas tugas yang didelegasikan (ANA dan NCSBN, 2014).

Supervision (Supervisi)

Proses aktif dalam mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi hasil pelaksanaan suatu aktivitas atau tugas yang dilakukan oleh individu lain (ANA, 2012).

Unlicensed Assistive Personnel (UAP) (Tenaga Asisten Tanpa Lisensi)

Individu yang tidak memiliki lisensi praktik, tetapi telah dilatih untuk menjalankan peran asistif dalam membantu perawat profesional dengan melaksanakan aktivitas perawatan pasien berdasarkan delegasi; termasuk asisten perawat, asisten klinis, petugas bangsal, tenaga kesehatan pembantu, dan sebutan lain sesuai dengan tempat kerja (NCSBN, 2016)

Pendahuluan

Manajemen asuhan keperawatan merupakan inti dari peran perawat manajer atau ketua tim di ruang rawat. Fokus utamanya adalah memastikan setiap pasien mendapatkan asuhan yang aman dan berkualitas melalui pengorganisasian sumber daya yang ada. Salah satu tantangan terbesar dalam manajemen asuhan adalah pendelegasian, dimana tanggung jawab tugas dialihkan kepada staf lain tanpa menghilangkan akuntabilitas hasil akhir dari pemberi delegasi (Marquis & Huston, 2021).

Pemberian asuhan pasien yang aman dan efektif merupakan tujuan utama dari setiap organisasi pelayanan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut secara efisien dari segi biaya, pelayanan diberikan melalui kerja sama tim yang terdiri dari berbagai tenaga profesional dan tenaga pendukung.

Karena perawat profesional (Registered Nurse/RN) pada umumnya bertanggung jawab dalam mengoordinasikan asuhan yang diberikan oleh berbagai anggota tim, maka perawat harus memiliki pemahaman yang jelas serta kemampuan untuk menerapkan secara efektif proses manajemen berupa **delegasi** dan **supervisi** guna menjamin mutu pelayanan yang tinggi dan keselamatan pasien.

Bab ini menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi pola penempatan tenaga keperawatan (*staffing patterns*) serta proses delegasi dan supervisi. Selain itu, dibahas pula peran dan tanggung jawab RN dalam mendelegasikan tugas dan melakukan supervisi terhadap anggota staf, termasuk tenaga asisten tanpa lisensi (*Unlicensed Assistive Personnel/UAP*) serta perawat praktik (LPN/LVN). Bab ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun praktik delegasi dan supervisi yang aman dan efektif.

Uraian Materi

A. Konsep Manajemen Asuhan Keperawatan

1. Pengertian

Manajemen asuhan keperawatan adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perawat manajer untuk menjamin pemberian asuhan yang berkualitas melalui empat fungsi utama, yaitu (Yoost & Crawford, 2020):

a. **Perencanaan (*Planning*):** Melibatkan penetapan prioritas asuhan dan penghitungan kebutuhan tenaga. *Contoh Riil:* Ketua Tim menghitung tingkat ketergantungan pasien di awal shift untuk membagi beban kerja.
b. **Pengorganisasian (*Organizing*):** Pengaturan staf ke dalam metode penugasan (seperti Metode Tim atau Primer). *Contoh Riil:* Penetapan peran perawat pelaksana dalam menangani kelompok pasien tertentu
c. **Pengarahan (*Directing*):** Mobilisasi staf melalui kepemimpinan dan delegasi. *Contoh Riil:* Pelaksanaan *pre-conference* untuk memberikan instruksi khusus pada kasus kompleks.
d. **Pengendalian (*Controlling*):** Evaluasi hasil asuhan melalui supervisi dan audit dokumentasi. *Contoh Riil:* Kepala Ruangan memeriksa kelengkapan catatan perkembangan pasien (SOAP) secara berkala.

Manajemen asuhan keperawatan adalah suatu proses strategis yang dilakukan oleh perawat manajer atau perawat pelaksana untuk mengelola sumber daya (tenaga, alat, metode, uang, mesin dan peralatan) guna memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas, aman, dan efektif bagi pasien. Fokus utamanya adalah transformasi proses keperawatan (*assessment* hingga *evaluation*) menjadi hasil klinis yang optimal melalui pengorganisasian yang sistematis (Cherry & Jacob, 2014).

2. Alasan Pentingnya Manajemen Asuhan

Menurut Marquis & Huston (2015),, penerapan manajemen dalam asuhan keperawatan menjadi krusial karena:

a. **Keselamatan Pasien:** Meminimalkan risiko kesalahan medis (*medical error*) melalui standarisasi prosedur.
b. **Efisiensi Sumber Daya:** Mengoptimalkan jumlah perawat yang terbatas untuk menangani beban **kerja** yang tinggi.
c. **Profesionalisme: Meningkatkan otonomi dan akuntabilitas perawat dalam pengambilan keputusan klinis.**

d. Kompleksitas Layanan: Menyeimbangkan perkembangan teknologi medis dengan sentuhan kemanusiaan (*caring*).

3. Komponen dan Ruang Lingkup

Manajemen asuhan mencakup seluruh siklus pelayanan di unit rawat inap (Marquis & Huston, 2015a):

a. Manajemen Klinis: Pelaksanaan proses keperawatan (pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi).

b. Manajemen Kolaborasi: Koordinasi interprofesional antara perawat, dokter, ahli gizi, dan farmasi.

c. Manajemen Operasional: Pengaturan jadwal dinas, pembagian tugas (delegasi), supervisi, dan pengelolaan logistik alat kesehatan.

d. Manajemen Mutu: Pemantauan indikator klinis seperti angka infeksi, angka jatuh, dan kepuasan pasien.

4. Cara dan Strategi Pelaksanaan

Strategi manajemen asuhan diimplementasikan melalui beberapa metode penugasan dan komunikasi (Potter et al., 2020):

a. Metode Penugasan: Memilih model asuhan yang sesuai, seperti *Metode Tim* (kelompok perawat melayani sekelompok pasien) atau *Metode Primer* (satu perawat bertanggung jawab penuh pada pasien tertentu).

b. Komunikasi Terstruktur: Penggunaan teknik **SBAR** (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) saat **timbang** terima (handover) atau melaporkan kondisi kritis kepada dokter.

c. Delegasi Efektif: Mengalihkan tugas teknis kepada staf yang kompeten dengan tetap menjaga akuntabilitas hasil akhir.

d. Ronde Keperawatan: Diskusi klinis langsung di samping tempat tidur pasien untuk memvalidasi masalah keperawatan yang kompleks.

5. Manfaat Manajemen Asuhan (Potter et al., 2020):

a. Bagi Pasien: Mendapatkan asuhan yang kontinu, terkoordinasi, dan respons cepat terhadap perubahan kondisi fisik.

b. Bagi Perawat: Meningkatkan kepuasan kerja karena pembagian tugas yang jelas dan **adanya** dukungan supervisi.

c. Bagi Rumah Sakit: Menurunkan *Length of Stay* (LOS), meningkatkan efisiensi biaya, dan memenuhi standar akreditasi.

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen asuhan keperawatan

Keberhasilan manajemen asuhan dipengaruhi oleh variabel internal dan eksternal(Marquis & Huston, 2015a):

a. Kapasitas SDM: Jumlah perawat dan tingkat kompetensi (*skill mix*) yang tersedia.

b. Gaya Kepemimpinan: Kemampuan Kepala Ruangan dalam memberikan motivasi dan melakukan supervisi **klinis**.

c. Lingkungan Kerja: Budaya organisasi yang mendukung keselamatan pasien (*safety culture*) dan ketersediaan sarana prasarana.

d. Sistem Informatika: Kemudahan akses dokumentasi keperawatan elektronik untuk pengambilan keputusan yang cepat.

B. Konsep Delegasi Keperawatan

1. Delegasi dan Supervisi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan

Dalam lingkungan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks saat ini, praktik keperawatan harus berbasis **pengetahuan (knowledge-based)**, bukan sekadar berorientasi pada tugas (task-based). Perawat bertanggung jawab untuk memberikan asuhan keperawatan yang *sensitif terhadap budaya, aman, tepat waktu, efisien, berpusat pada pasien, adil, dan efektif* kepada klien di berbagai tatanan pelayanan sepanjang kontinuitas pelayanan kesehatan (ANA, 2012).

Beberapa faktor memengaruhi pola penempatan tenaga keperawatan (*staffing patterns*) serta penyelenggaraan asuhan pasien di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga pelayanan kesehatan di rumah (*home care*), antara lain:

a. **Penurunan penggantian biaya (reimbursement)** dari program asuransi seperti Medicare, Medicaid, dan asuransi swasta yang mendorong upaya efisiensi biaya.
b. Peningkatan cakupan asuransi kesehatan melalui kebijakan kesehatan, sehingga lebih banyak masyarakat mengakses layanan kesehatan.
c. Meningkatnya biaya yang ditanggung pasien (co-pay) sehingga pasien menuntut pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
d. Fokus yang kuat pada keselamatan dan mutu pelayanan, yang menuntut sistem kesehatan untuk terus melakukan perbaikan secara cepat dan berkelanjutan.
e. Kemajuan teknologi medis, yang berdampak pada meningkatnya biaya pelayanan kesehatan.

f. Peningkatan tingkat **keparahan pasien (acuity) dan kompleksitas terapi**, yang menyebabkan fasilitas pelayanan kesehatan harus menangani berbagai prioritas kompleks dengan sumber daya yang semakin terbatas.

Salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi biaya dalam pemberian asuhan adalah dengan memanfaatkan **tenaga asisten tanpa lisensi (Unlicensed Assistive Personnel/UAP)**, seperti asisten perawat dan teknisi perawatan pasien

Seiring dengan meningkatnya penggunaan UAP, perawat profesional (RN) dituntut untuk mendelegasikan lebih banyak tugas kepada tenaga yang sering kali tidak memiliki batasan yang jelas terkait pendidikan, pelatihan, tanggung jawab kerja, dan batasan peran. Oleh karena itu, RN harus memahami bahwa profesi keperawatan menetapkan **standar dan lingkup praktik**, sementara peraturan praktik keperawatan di tingkat negara bagian (*nurse practice act*) menentukan batasan hukum praktik keperawatan (NCSBN, 2016).

Penting bagi RN untuk bekerja sama secara erat dengan administrator dan manajer nonklinis agar mereka memahami bahwa **proses keperawatan (nursing process)** tidak dapat didelegasikan kepada siapa pun selain RN.

Sebagai dukungan terhadap peran UAP dalam pelayanan pasien, *Joint Statement on Delegation* (ANA dan NCSBN, 2014) menyatakan bahwa *"terdapat kebutuhan dan peran bagi tenaga asisten tanpa lisensi yang kompeten dan disupervisi secara tepat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas."*

Seiring fasilitas pelayanan kesehatan terus mencari cara yang lebih efisien dalam memberikan layanan, perawat profesional dituntut untuk mengembangkan cara-cara baru dalam **mengelola asuhan dan melakukan delegasi tugas secara efektif**

2. Pengertian Delegasi

Delegasi merupakan konsep hukum dan manajemen yang melibatkan proses **pengkajian, perencanaan, intervensi, dan evaluasi**. Delegasi, sebagaimana didefinisikan oleh *American Nurses Association* (ANA, 2015b), adalah *"pelimpahan tanggung jawab untuk pelaksanaan suatu aktivitas dari satu individu kepada individu lain dengan tetap mempertahankan akuntabilitas terhadap hasilnya."*

Meskipun perawat profesional (RN) dapat melimpahkan tanggung jawab dan wewenang dalam pelaksanaan suatu tugas, RN tetap bertanggung jawab atas keseluruhan asuhan keperawatan. Dalam melakukan delegasi, perawat harus memahami kompetensi penerima delegasi (*delegatee*), berkomunikasi

secara jelas dan ringkas, memberikan pedoman yang tegas sejak awal, memantau kemajuan pelaksanaan tugas, serta tetap mempertanggungjawabkan hasil akhir asuhan.

Delegasi merupakan proses dua arah, di mana RN sebagai pemberi delegasi (*delegator*) meminta staf yang kompeten untuk melaksanakan tugas tertentu. Dalam proses delegasi, RN bertanggung jawab untuk (NCSBN, 2016):

a. Menentukan kebutuhan pasien dan waktu yang tepat untuk melakukan delegasi
b. Tersedia bagi penerima delegasi (delegatee) saat dibutuhkan
c. Melakukan pengkajian serta evaluasi lanjutan
d. Melakukan intervensi atau tindakan korektif yang diperlukan guna menjamin asuhan yang aman dan efektif

Sementara itu, penerima delegasi (*delegatee*) bertanggung jawab untuk:

a. Bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya
b. Menerima delegasi sesuai dengan tingkat kompetensinya
c. Mengomunikasikan informasi yang relevan kepada pemberi delegasi
d. Menyelesaikan tugas yang diberikan

Delegasi merupakan strategi manajemen yang, apabila digunakan secara tepat, dapat menjamin tercapainya asuhan pasien yang aman dan efektif. *"Semua keputusan terkait delegasi dan penugasan didasarkan pada prinsip fundamental perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat"* (Duffy dan McCoy, 2014).

3. Apa yang Dapat dan Tidak Dapat Didelegasikan

Sayangnya, tidak ada jawaban yang sederhana mengenai tugas apa yang dapat dan tidak dapat didelegasikan. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, yaitu:

1. Peraturan praktik keperawatan (nurse practice act) dan hukum lain yang berlaku
2. Kebutuhan pasien
3. Deskripsi pekerjaan dan kompetensi staf
4. Kebijakan dan prosedur organisasi pelayanan kesehatan
5. Situasi klinis
6. Standar praktik profesional keperawatan

Untuk membangun praktik delegasi yang aman dan efektif, perawat profesional (RN) harus mencari pedoman serta mengintegrasikan informasi dari seluruh aspek tersebut, sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut.

4. Peraturan Praktik Keperawatan (State Nurse Practice Acts)

Setiap peraturan praktik keperawatan di tingkat negara bagian memberikan **landasan hukum** bagi praktik keperawatan, termasuk dalam hal delegasi. Namun, setiap peraturan tersebut dapat menguraikan kriteria delegasi dengan cara yang berbeda-beda. Sering kali, kriteria delegasi tidak dijelaskan secara rinci dalam satu bagian tertentu, melainkan tersebar di berbagai bagian dalam peraturan tersebut.

Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap perawat profesional (RN) untuk memahami dengan baik peraturan praktik keperawatan yang berlaku serta mengetahui kriteria delegasi yang terkandung di dalamnya (NCSBN, 2016).

5. Kebijakan Delegasi dalam Praktik Keperawatan di Indonesia

Sesuai dengan regulasi praktik keperawatan di Indonesia (UU RI No.17 Tahun 2023), pendelegasian tugas harus dilakukan dengan memperhatikan batasan wewenang dan tanggung jawab profesi. Berikut adalah ketentuan umum yang berlaku:

a. Pemisahan Tugas dan Praktik: Hanya tugas teknis keperawatan tertentu yang dapat didelegasikan, sedangkan tanggung jawab asuhan keperawatan secara keseluruhan tetap melekat pada perawat pemberi delegasi.
b. Kewenangan Pengkajian: Perawat Profesional (Ners) wajib melakukan pengkajian klinis terlebih dahulu untuk menentukan kelayakan tugas yang akan didelegasikan berdasarkan kondisi pasien.
c. Batasan Profesi: Perawat Vokasi dan Tenaga Asisten Kesehatan bekerja dalam lingkup tugas yang didelegasikan dan tetap berada di bawah supervisi Perawat Profesional.
d. Lingkup Delegasi: Pendelegasian hanya boleh dilakukan untuk tindakan yang masuk dalam lingkup praktik keperawatan sesuai standar prosedur operasional (SOP) rumah sakit.
e. Prinsip Kompetensi: Perawat Profesional melakukan delegasi dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, sertifikasi, dan keterampilan individu yang menerima tugas.
f. Verifikasi Kemampuan: Perawat Profesional bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa individu yang menerima delegasi memiliki kompetensi yang cukup untuk menjalankan tugas tersebut dengan aman.
g. Larangan Delegasi Judgement Klinis: Tugas yang memerlukan analisis mendalam, pengambilan keputusan klinis (*professional judgment*), dan evaluasi kompleks tidak dapat didelegasikan kepada tenaga non-profesional.

6. Rujukan dan Instrumen Delegasi

Apabila terdapat ketidakjelasan mengenai batasan delegasi dalam operasional harian, perawat dapat merujuk pada standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi (PPNI) atau komite keperawatan di rumah sakit setempat. Lembaga-lembaga ini menyediakan panduan etik, standar prosedur, dan interpretasi hukum terkait praktik pendelegasian.

Banyak instansi pelayanan kesehatan kini mengadopsi alat bantu praktis seperti pohon keputusan delegasi (*delegation decision tree*) atau daftar periksa (*checklist*) untuk meminimalkan risiko kesalahan. Secara umum, proses delegasi di Indonesia mengikuti empat tahapan sistematis:

a. Pengkajian dan Perencanaan: Menilai kebutuhan pasien dan kesiapan staf.
b. Komunikasi Efektif: Memberikan instruksi yang jelas (misalnya menggunakan metode SBAR).
c. Pemantauan dan Supervisi: Melakukan pengawasan selama tindakan berlangsung.
d. Evaluasi dan Umpan Balik: Menilai hasil tindakan dan memberikan arahan perbaikan.

Variasi Lingkup Praktik

Di Indonesia, terdapat perbedaan wewenang yang jelas antara Perawat Profesional (Ners) dan Perawat Vokasi (D3 Keperawatan). Perawat Profesional wajib memahami uraian tugas (*job description*) perawat vokasi di unit kerjanya agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang secara legal. Sementara itu, peran tenaga asisten kesehatan atau pekarya kesehatan biasanya diatur secara lebih spesifik melalui kebijakan internal dan Standar Prosedur Operasional (SOP) masing-masing organisasi pelayanan kesehatan.

Kebutuhan Pasien

Dalam mengambil keputusan untuk melakukan delegasi, perawat profesional (RN) harus mengingat bahwa **yang dapat didelegasikan adalah tugas**, bukan praktik keperawatan secara keseluruhan. Fungsi **pengkajian, evaluasi, dan pertimbangan keperawatan (nursing judgment)** tidak dapat didelegasikan.

Secara umum, semakin **stabil kondisi pasien**, maka semakin besar kemungkinan delegasi dapat dilakukan dengan aman. Namun demikian, penting untuk disadari bahwa banyak tugas yang dapat didelegasikan tetap mengandung **tanggung jawab keperawatan**.

Sebagai contoh, pengukuran tanda-tanda vital pada pasien yang secara fisiologis stabil setelah mengalami **CVA (cerebrovascular accident/stroke)** dapat didelegasikan kepada tenaga asisten tanpa lisensi (UAP). Akan tetapi, aktivitas tersebut juga merupakan kesempatan bagi RN untuk melakukan **pengkajian fungsi kognitif pasien**.

Dalam vignette yang disajikan pada awal bab ini, Ms. Miller **tidak seharusnya mendelegasikan perawatan apa pun** kepada pasien yang baru masuk sebelum **pengkajian keperawatan selesai dilakukan**.

Deskripsi Pekerjaan dan Kompetensi

Perawat profesional (RN) yang melakukan delegasi memiliki tanggung jawab untuk memahami **latar belakang, tingkat keterampilan, pelatihan yang diterima, serta persyaratan pekerjaan** dari setiap individu yang akan menerima tugas.

Deskripsi pekerjaan (*job description*) memberikan informasi penting mengenai apa yang diperbolehkan dilakukan oleh anggota staf, serta menguraikan secara rinci tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai bagian dari pekerjaan. Umumnya, deskripsi pekerjaan disusun sesuai dengan **peraturan perundang-undangan** dan **standar pelayanan organisasi kesehatan**. Namun demikian, dalam semua situasi, **ketentuan hukum terkait delegasi memiliki kedudukan lebih tinggi** dibandingkan kebijakan atau persyaratan organisasi.

Perawat profesional juga harus mengetahui **jenis pendidikan dan pelatihan** yang telah diterima oleh staf agar mampu menjalankan tugas sesuai deskripsi pekerjaan. Selain itu, RN perlu memahami bentuk **program orientasi** yang diberikan kepada pegawai baru.

Dalam vignette pada awal bab, deskripsi pekerjaan LPN kemungkinan mencakup tugas seperti *"melakukan perawatan luka (dressing)"* dan *"memberikan obat oral."* Namun, Ms. Miller juga perlu mengetahui **tingkat pengetahuan dan keterampilan LPN** tersebut, khususnya dalam menangani populasi pasien yang ada di unit.

Selain deskripsi pekerjaan, organisasi pelayanan kesehatan juga mewajibkan tenaga kesehatan untuk **membuktikan kompetensi** dalam melakukan prosedur teknis tertentu dan menerapkan pengetahuan khusus untuk memberikan asuhan pasien secara aman. Dokumentasi tertulis mengenai keterampilan dan pengetahuan yang telah terbukti kompeten disimpan dalam **file kepegawaian (personnel file)**.

Sebagian besar organisasi pelayanan kesehatan juga mensyaratkan tenaga kesehatan untuk mengikuti **pelatihan kompetensi tahunan**, terutama untuk aspek-aspek perawatan yang spesifik sesuai dengan karakteristik pasien di unit tersebut. **Kotak 20.2** menyajikan contoh kompetensi tahunan yang harus dipenuhi oleh perawat di klinik rawat jalan praktik keluarga.

Berbagai lembaga regulasi dan akreditasi, seperti **The Joint Commission (TJC)**, mewajibkan adanya **dokumentasi tertulis** mengenai kompetensi staf sebagai bagian dari standar mutu pelayanan kesehatan.

Kompetensi Tahunan yang Harus Ditunjukkan oleh Perawat Profesional (RN) dan Perawat Vokasional (LVN) di Klinik Rawat Jalan Praktik Keluarga

a. Peraturan dan prosedur keselamatan kerja
b. Kebijakan dan prosedur terkait Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (kerahasiaan dan keamanan data pasien)
c. Sasaran keselamatan pasien (patient safety goals)
d. Pengendalian infeksi (infection control)
e. Triage melalui telepon (telephone triage)
f. Pemeriksaan glukosa darah
g. Edukasi pasien dan literasi kesehatan
h. Manajemen obat (medication management)
i. Pelaporan kekerasan dan penelantaran (abuse and neglect)
j. Pendokumentasian dalam rekam medis
k. Penanganan kegawatdaruratan di pelayanan rawat jalan

7. Kebijakan dan Prosedur Organisasi

Dalam melakukan delegasi, perawat profesional (RN) harus mematuhi **persyaratan keterampilan spesifik** yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis organisasi. Kebijakan tersebut umumnya menjelaskan tingkat **supervisi** yang diperlukan untuk suatu tugas tertentu serta bagaimana **masalah atau insiden** harus dilaporkan dan didokumentasikan.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa **ketentuan hukum terkait delegasi memiliki kedudukan lebih tinggi** dibandingkan kebijakan atau prosedur organisasi. Perawat profesional juga harus memahami **standar umum pelayanan** yang berlaku di organisasi, seperti pengendalian infeksi, serta memastikan bahwa penerima delegasi (*delegatee*) memiliki **pengetahuan dan keterampilan yang memadai** untuk mematuhi standar tersebut.

Dalam vignette pada awal bab, Ms. Miller perlu mengetahui kebijakan rumah sakit terkait **proses orientasi staf**. Seluruh staf klinis seharusnya telah mendapatkan pelatihan mengenai **prosedur pengendalian infeksi, penanganan kegawatdaruratan, dan keselamatan kerja** yang berlaku di unit tersebut

Situasi Klinis

Setiap kesempatan untuk melakukan delegasi menuntut perawat profesional (RN) mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk **beban kerja penerima delegasi (delegatee)** saat ini serta **tingkat kompleksitas tugas** dalam kaitannya dengan kondisi pasien.

Beberapa pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan antara lain:

a. Apakah staf memiliki **waktu yang cukup** untuk menyelesaikan tugas tersebut secara realistis?
b. Apakah staf tersebut **memahami karakteristik populasi pasien**, seperti pasien pediatrik atau geriatri?
c. Apakah staf memiliki **pengalaman dan keterampilan** yang sesuai dengan tugas yang akan dilakukan?
d. Apakah RN mampu memberikan **tingkat supervisi yang memadai**?

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan **ketersediaan sumber daya**, seperti peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara aman dan efektif.

8. Standar Profesional Praktik Keperawatan

Standar profesional praktik keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi keperawatan berfungsi sebagai pedoman bagi perawat profesional (RN) dalam memberikan asuhan kepada pasien. Menurut *American Nurses Association* (ANA, 2015b), *"Standar Praktik Keperawatan Profesional merupakan pernyataan otoritatif mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan secara kompeten oleh semua perawat terdaftar, tanpa memandang peran, populasi, atau spesialisasi. Standar ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perkembangan praktik keperawatan yang diakui oleh profesi dan masyarakat."*

Untuk melaksanakan delegasi yang aman, perawat profesional harus memahami standar praktik yang tercantum dalam **Nursing: Scope and Standards of Practice (ANA, 2015b)** serta standar khusus sesuai bidang praktiknya, seperti keperawatan geriatri, pediatri, manajemen keperawatan, atau kesehatan masyarakat.

Sebagai bagian dari standar pelayanan, perawat profesional harus menggunakan **pertimbangan profesional (professional judgment)** dalam menentukan aktivitas yang dapat didelegasikan, dengan berlandaskan pada prinsip pemberian asuhan yang aman dan efektif serta perlindungan terhadap masyarakat.

Dalam proses delegasi, RN perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

a. Kondisi pasien
b. Kemampuan staf keperawatan dan tenaga asistif
c. Kompleksitas tugas yang akan didelegasikan
d. Tingkat supervisi klinis yang dapat diberikan oleh RN
e. Beban kerja staf

Tanggung jawab yang berkaitan dengan **pengambilan keputusan keperawatan (nursing judgment)** tidak dapat didelegasikan, kecuali kepada perawat profesional lain yang memiliki kualifikasi setara.

Contoh tanggung jawab yang **tidak dapat didelegasikan** meliputi:

a. Pengkajian keperawatan awal dan pengkajian lanjutan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pertimbangan profesional
b. Penetapan diagnosis keperawatan, penentuan tujuan asuhan, penyusunan rencana asuhan keperawatan, serta evaluasi perkembangan pasien
c. Intervensi keperawatan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan pertimbangan profesional

9. Pertanyaan untuk Memandu Pengambilan Keputusan dalam Delegasi

a. Peraturan Praktik Keperawatan (State Nurse Practice Act):

1) Apakah tugas tersebut berada dalam **lingkup praktik RN**?
2) Apakah peraturan praktik keperawatan mengatur tentang **delegasi tugas tersebut**?
3) Apakah tugas yang akan didelegasikan memerlukan **pertimbangan keperawatan (nursing judgment)**?
4) Apakah RN sebagai pemberi delegasi bersedia **bertanggung jawab (accountable)** atas pelaksanaan tugas yang didelegasikan?

b. Deskripsi Pekerjaan dan Kompetensi:

1) Apakah RN sebagai pemberi delegasi memahami **hakikat tugas** serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi untuk melaksanakannya?

2) Apakah penerima delegasi (*delegatee*) memiliki **pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman** yang sesuai untuk melaksanakan tugas tersebut?
3) Apakah terdapat **bukti terdokumentasi atau bukti nyata** bahwa penerima delegasi kompeten untuk melaksanakan tugas tersebut?
4) Apakah penerima delegasi **melakukan tugas tersebut secara rutin**?
5) Apakah penerima delegasi **memahami karakteristik populasi pasien** yang dirawat?

c. Kebijakan dan Prosedur Organisasi:

1) Tingkat keterampilan dan **tingkat supervisi** apa yang dibutuhkan untuk tugas tersebut sesuai dengan kebijakan/prosedur organisasi?
2) Apa kebijakan atau prosedur terkait **pendokumentasian tugas** serta **pelaporan hasil, observasi, masalah, atau kejadian tidak biasa**?

10. Mengembangkan Praktik Delegasi yang Aman

Agar perawat profesional (RN) dapat membuat keputusan delegasi yang aman dan efektif, diperlukan pemahaman yang baik mengenai **tugas yang dapat dan tidak dapat didelegasikan**, sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Namun, pengambilan keputusan delegasi yang aman tidak hanya bergantung pada hal tersebut.

RN juga harus memahami dengan baik **kondisi pasien, karakteristik staf yang menerima delegasi, serta jenis tugas yang akan dilakukan**. Untuk mencapai hasil yang efektif, RN harus:

1. Mengomunikasikan harapan secara jelas
2. Memberikan dukungan dan supervisi yang tepat kepada penerima delegasi
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas
4. Melakukan pengkajian ulang terhadap pasien setelah tugas yang didelegasikan selesai

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai persyaratan penting dalam delegasi yang aman dan efektif:

1. Mengetahui Kondisi Pasien (Know the Patient)

Pengkajian keperawatan harus dilakukan sebelum delegasi—RN harus memahami **tingkat kebutuhan asuhan pasien**, dengan mempertimbangkan aspek klinis, fisiologis, emosional, kognitif, dan spiritual pasien.

Beberapa pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan:

a. Apakah kondisi pasien **stabil**?

→ Secara umum, semakin stabil kondisi pasien, semakin aman delegasi dilakukan.

b. Apakah terdapat **potensi perubahan kondisi pasien** akibat tugas yang didelegasikan?
→ Jika terdapat risiko sedang hingga tinggi terhadap perubahan kondisi pasien, maka delegasi **tidak disarankan**.

c. Apakah **keselamatan pasien dapat tetap terjaga** dengan adanya delegasi?
→ Jawaban atas pertanyaan ini harus tegas **"ya"** sebelum delegasi dilakukan.

2. Mengetahui Staf (Know the Staff Member)

Sebelum mendelegasikan tugas, RN harus memastikan bahwa penerima delegasi (*delegatee*) memiliki **pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan**, yang dapat dilihat dari:

a. Deskripsi pekerjaan
b. Program pelatihan yang telah diikuti
c. Bukti kompetensi yang terdokumentasi

Selain itu, **pengalaman kerja dan kinerja sebelumnya** juga perlu dipertimbangkan.

Beberapa pertanyaan penting:

a. Apakah staf memiliki **pengetahuan dan pelatihan** untuk melaksanakan tugas tersebut?
b. Apakah staf tersebut **terbiasa melakukan tugas tersebut secara rutin**?

Prinsip utama yang harus dipegang adalah:

👉 **"Orang yang tepat untuk tugas yang tepat" (the right person for the right task).** Akan sangat membantu apabila RN terlibat dalam pengembangan:

a. Deskripsi pekerjaan
b. Program pelatihan
c. Dokumentasi kompetensi staf

3. Mengetahui Tugas yang Akan Didelegasikan (Know the Task[s] to Be Delegated)

Perawat profesional (RN) sebagai pemberi delegasi harus **kompeten dan terampil** dalam melaksanakan setiap tugas yang akan didelegasikan, serta memastikan bahwa tugas tersebut berada dalam **lingkup praktik keperawatan**.

Tugas yang bersifat **rutin dan terstandar**, dilakukan berdasarkan prosedur yang tetap, serta memiliki hasil yang dapat diprediksi merupakan tugas yang

paling aman untuk didelegasikan. Tugas-tugas ini umumnya telah tercantum dalam **dokumen kompetensi staf** dan biasanya memerlukan arahan serta supervisi yang lebih minimal.

Sebaliknya, tugas yang **kompleks**, berisiko tinggi terhadap komplikasi pasien, atau memiliki hasil yang tidak dapat diprediksi harus dipertimbangkan secara cermat sebelum didelegasikan.

4. Menjelaskan Tugas dan Hasil yang Diharapkan (Explain the Task and Expected Outcomes)

Perawat profesional harus menjelaskan secara jelas:

a. Apa tugas yang harus dilakukan
b. Bagaimana cara melakukannya
c. Hasil yang diharapkan

Jika diperlukan, instruksi dapat diberikan secara tertulis.

Kegagalan dalam berkomunikasi secara efektif dapat menyebabkan:

a. Kinerja yang tidak optimal
b. Kesalahan tindakan
c. Potensi bahaya bagi pasien

Oleh karena itu, instruksi harus disampaikan secara **jelas, singkat, dan tepat**.

Dalam beberapa situasi, diperlukan:

a. Demonstrasi dan return demonstration oleh penerima delegasi
b. Pelatihan tambahan (in-service education)

Delegasi hanya dapat dilakukan apabila staf **memahami tugas** dan **siap secara kompetensi** untuk melaksanakannya.

Mengharapkan Tindakan yang Bertanggung Jawab dari Penerima Delegasi (Expect Responsible Action from the Delegatee)

Setelah staf menerima dan memahami tugas yang diberikan, maka ia harus diberi kesempatan untuk melaksanakannya. Pada tahap ini, staf menjadi **bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya** dan berkewajiban menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan.

Hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Penerima delegasi **tidak diperkenankan mendelegasikan kembali tugas** kepada orang lain

   (misalnya: asisten perawat tidak boleh melimpahkan tugas kepada asisten lain)

Perawat profesional harus memberikan **supervisi yang sesuai**, namun tidak perlu melakukan intervensi selama pelaksanaan tugas, kecuali:

1. Diminta bantuan

2. Ditemukan situasi yang tidak aman

Intervensi yang tidak perlu dapat mengurangi **tanggung jawab dan akuntabilitas** penerima delegasi.

Perawat profesional (RN) harus **mengharapkan tindakan yang bertanggung jawab**, memberikan **wewenang (authority)**, dan tetap mempertahankan **akuntabilitas (accountability)**.

Menilai dan Mensupervisi Kinerja (Assess and Supervise Job Performance)

Supervisi terhadap kinerja merupakan mekanisme penting untuk **umpan balik dan pengendalian**. RN menilai kinerja dengan cara:

1. Melakukan ronde secara berkala
2. Melakukan observasi langsung
3. Berkomunikasi dengan staf (misalnya menanyakan perkembangan pekerjaan serta adanya pertanyaan atau kendala)

Tingkat supervisi yang diberikan harus **disesuaikan dengan situasi**. RN harus selalu **tersedia bagi penerima delegasi (delegatee)** apabila terdapat pertanyaan atau masalah yang tidak terduga.

Supervisi perlu dilakukan dengan **pendekatan yang positif dan suportif**, sehingga staf merasa bahwa pekerjaannya **penting dan dihargai**.

RN harus **segera melakukan intervensi** apabila tugas tidak dilaksanakan dengan aman dan sesuai prosedur. Kinerja yang kurang baik harus:

1. **Didokumentasikan**
2. **Dilaporkan kepada manajer keperawatan**

Kinerja yang tidak optimal **tidak boleh diabaikan**. Apabila terjadi kesalahan, hal tersebut harus dimanfaatkan sebagai **kesempatan belajar** bagi seluruh staf yang terlibat.

Evaluasi dan Tindak Lanjut (Evaluate and Follow-Up)

Setelah tugas selesai dilaksanakan, RN harus:

1. **Mengevaluasi kinerja staf**
2. **Melakukan pengkajian ulang terhadap pasien** untuk memastikan bahwa hasil yang diharapkan telah tercapai

Jika hasil asuhan pasien atau kinerja staf memerlukan tindakan lanjutan, RN harus melakukan **intervensi yang diperlukan**.

Evaluasi dan tindak lanjut yang tepat akan menjamin **hasil yang optimal**, baik bagi pasien maupun staf.

Dari Keputusan Delegasi hingga Pelaksanaan Delegasi: Langkah-Langkah yang Perlu Diingat

1. Berkomunikasi Secara Efektif

a. Penerima delegasi (*delegatee*) menerima tugas yang didelegasikan serta **bertanggung jawab (accountable)** untuk melaksanakannya dengan benar.
b. Perawat profesional (RN) sebagai pemberi delegasi memberikan **instruksi yang jelas**, meliputi:
   - tugas spesifik yang harus dilakukan
   - kepada siapa tugas tersebut diberikan
   - waktu pelaksanaan
   - cara pelaksanaan tugas
   - data yang harus dikumpulkan
   - instruksi khusus terkait kondisi pasien
c. RN secara jelas mengomunikasikan **hasil yang diharapkan** serta **batas waktu pelaporan hasil**.

2. Memberikan Supervisi yang Tepat

a. Memantau kinerja untuk memastikan kesesuaian dengan **standar praktik** serta **kebijakan dan prosedur organisasi**.
b. Memperoleh dan memberikan **umpan balik (feedback)**.
c. Melakukan **intervensi bila diperlukan**.
d. Memastikan **pendokumentasian yang tepat**.

3. Melakukan Evaluasi dan Pengkajian Ulang

a. Melakukan **pengkajian ulang terhadap pasien**.
b. Mengevaluasi **pelaksanaan tugas** serta pengalaman penerima delegasi.
c. Melakukan **penyesuaian rencana asuhan keperawatan** sesuai kebutuhan

Memahami Delegasi Berisiko Tinggi (High-Risk Delegation)

Perawat profesional (RN) sering kali merasa khawatir terhadap **tanggung jawab hukum**, atau istilah yang umum digunakan *"mempertaruhkan izin praktik (license)"*, ketika mendelegasikan tugas kepada tenaga tanpa lisensi. Lalu, bagaimana RN mengetahui apakah ia berada dalam situasi berisiko saat melakukan delegasi?

Dalam *Principles for Delegation* (ANA, 2012), terdapat sebelas prinsip yang memberikan panduan bagi RN dalam pengambilan keputusan terkait delegasi:

1. Profesi keperawatan menetapkan **lingkup dan standar praktik**.
2. RN bertanggung jawab dan akuntabel terhadap **pelaksanaan praktik keperawatan**.

3. RN mengarahkan asuhan dan menentukan **pemanfaatan sumber daya yang tepat** dalam pemberian pelayanan.
4. RN dapat mendelegasikan tugas, tetapi **tidak dapat mendelegasikan proses keperawatan**.
5. RN harus mempertimbangkan **kebijakan organisasi**, serta **pengetahuan, keterampilan, pelatihan, kesadaran budaya, dan pengalaman** penerima delegasi.
6. Keputusan delegasi didasarkan pada **pertimbangan RN** terkait kompleksitas asuhan, ketersediaan dan kompetensi penerima delegasi, serta tingkat supervisi yang diperlukan.
7. RN memahami bahwa delegasi melibatkan **konsep saling menghargai (mutual respect)**.
8. Pemimpin keperawatan bertanggung jawab terhadap sistem untuk **mengakses, memantau, memverifikasi, dan mengomunikasikan kompetensi staf secara berkelanjutan**.
9. Organisasi bertanggung jawab menyediakan **sumber daya yang memadai** untuk mendukung delegasi yang tepat.
10. Organisasi harus memastikan RN memiliki akses terhadap **data kompetensi staf** yang akan menerima delegasi.
11. Kebijakan organisasi terkait delegasi harus dikembangkan dengan **partisipasi aktif RN**.

Lima Prinsip Delegasi (Five Rights of Delegation)

Salah satu cara untuk menghindari delegasi berisiko tinggi dan menyederhanakan proses delegasi adalah dengan menerapkan **Five Rights of Delegation** (ANA dan NCSBN, 2014):

1. **Right task (Tugas yang tepat)**
2. Pastikan tugas yang didelegasikan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
3. **Right circumstances (Kondisi yang tepat)**
4. Delegasikan tugas yang tidak memerlukan **pertimbangan keperawatan mandiri**.
5. **Right person (Orang yang tepat)**
6. Delegasikan kepada individu yang **kompeten dan memenuhi kualifikasi**.
7. **Right direction and communication (Arahan dan komunikasi yang tepat)** Berikan penjelasan yang jelas mengenai tugas, hasil yang diharapkan, serta kapan harus melaporkan kembali kepada RN.

8. **Right supervision and evaluation (Supervisi dan evaluasi yang tepat)** Berikan umpan balik untuk menilai efektivitas proses serta lakukan evaluasi terhadap hasil pasien dan pelaksanaan tugas.

Contoh Kasus Hukum

Perawat dapat menghindari situasi delegasi yang tidak aman dengan menerapkan prinsip delegasi yang tepat. Sebagai contoh, terdapat kasus hukum di mana seorang pasien lansia meninggal setelah mengalami **aspirasi makanan**. Kejadian ini terjadi karena asisten perawat meninggalkan makanan di meja pasien tanpa pengawasan.

Keluarga pasien menggugat rumah sakit atas **kelalaian (malpraktik)**, dan pengadilan menyatakan perawat bersalah. Padahal, sebelumnya dokter telah menginformasikan bahwa pasien mengalami **disfagia (gangguan menelan)** dan harus diawasi saat makan.

Dalam kasus ini, perawat gagal:

1. Memberikan **supervisi langsung**
2. Memastikan bahwa asisten perawat memahami **risiko klinis**
3. Menjamin bahwa staf memiliki **kompetensi untuk menangani keadaan darurat**

Kasus ini seharusnya dapat dicegah apabila perawat menerapkan prinsip dan strategi **delegasi yang aman** sebagaimana dijelaskan dalam bab ini.

Supervisi

Supervisi didefinisikan oleh *American Nurses Association* (ANA, 2012) sebagai *"proses aktif dalam mengarahkan, membimbing, dan memengaruhi hasil pelaksanaan suatu tugas oleh individu."*

Supervisi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Supervisi langsung (on-site)**: perawat berada secara fisik atau tersedia secara langsung saat aktivitas dilakukan.
2. **Supervisi tidak langsung (off-site)**: perawat memberikan arahan melalui berbagai media komunikasi, seperti tertulis, verbal, atau elektronik (Duffy dan McCoy, 2014).

Supervisi langsung umumnya terjadi pada pelayanan **rawat inap (acute care)** atau **rawat jalan**, di mana RN tersedia secara langsung. Sementara itu, supervisi tidak langsung biasanya terjadi pada **pelayanan kesehatan di rumah (home care)**, komunitas, atau fasilitas perawatan jangka panjang.

Tingkat Supervisi

Berbagai tingkat supervisi diperlukan tergantung pada:

1. Jenis tugas yang didelegasikan
2. Tingkat pendidikan, pengalaman, dan kompetensi staf
3. Hubungan kerja antar individu

(Hansten dan Jackson, 2009)

1. Tanpa Supervisi Langsung (Unsupervised)

Terjadi ketika satu RN bekerja dengan RN lain dalam hubungan profesional yang setara (kolaboratif), tanpa posisi supervisi langsung. Masing-masing RN bertanggung jawab dan akuntabel atas praktiknya sendiri. Namun, RN yang memiliki peran kepemimpinan (misalnya **ketua tim, charge nurse, atau manajer keperawatan**) tetap memiliki fungsi supervisi terhadap RN lain sesuai struktur organisasi.

2. Arahan Awal dan/atau Pengawasan Berkala (Initial Direction and/or Periodic Inspection)

RN memberikan arahan awal kepada tenaga kesehatan (berlisensi atau tidak) dan melakukan pemantauan secara berkala. Dalam kondisi ini:

a. RN telah mengetahui **pelatihan dan kompetensi staf**
b. Telah terjalin **hubungan kerja yang baik**

Contoh: RN telah bekerja dengan asisten perawat selama 6 bulan, sehingga cukup memberikan instruksi awal dan melakukan evaluasi satu kali selama shift.

3. Supervisi Berkelanjutan (Continuous Supervision)

RN menentukan bahwa penerima delegasi membutuhkan **dukungan dan bantuan secara terus-menerus**. Tingkat supervisi ini diperlukan apabila:

a. Hubungan kerja masih baru
b. Tugas yang diberikan bersifat **kompleks**
c. Penerima delegasi masih **kurang pengalaman** atau belum menunjukkan kompetensi yang memadai

Penugasan (Assignment) vs Delegasi

Penugasan tugas (**assignment**) tidak sama dengan delegasi. Penugasan, menurut *American Nurses Association* (ANA, 2012), adalah *"pembagian pekerjaan*

yang menjadi tanggung jawab setiap anggota staf dalam suatu periode kerja tertentu."

Penugasan menetapkan aktivitas yang harus dilakukan oleh staf sebagai bagian dari pekerjaan, sesuai dengan:

1. Posisi dan deskripsi pekerjaan
2. Lingkup praktik yang legal
3. Latar belakang pendidikan dan pelatihan

Dalam penugasan, staf **menerima tanggung jawab dan akuntabilitas penuh** untuk menyelesaikan tugas tersebut.

Pertimbangan dalam Penugasan (Assignment Considerations)

Memberikan penugasan kepada kelompok pasien untuk berbagai pemberi asuhan, termasuk tenaga asisten tanpa lisensi (UAP) dan LPN/LVN, **tidak selalu tepat**.

Sebagai contoh:

1. **UAP tidak boleh ditugaskan langsung kepada pasien atau kelompok pasien**, tetapi harus ditugaskan kepada RN.
2. Tugas umum UAP meliputi:
   a. Mendistribusikan makanan
   b. Membantu aktivitas sehari-hari pasien (activities of daily living)
   c. Mengantar pasien
   d. Menyiapkan peralatan
   e. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh RN
3. **LPN/LVN dapat ditugaskan merawat pasien tertentu**, tetapi RN tetap bertanggung jawab atas seluruh praktik keperawatan, termasuk:
   a. Pengkajian pasien
   b. Perencanaan asuhan
   c. Edukasi pasien

Tanggung Jawab RN dalam Penugasan

RN bertanggung jawab atas penugasan yang diberikan kepada staf di lingkungan klinis. Beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan meliputi:

1. Status Fisiologis Pasien dan Kompleksitas Asuhan

   a. Apakah tanda-tanda vital tidak stabil?
   b. Apakah kondisi pasien berubah dengan cepat?
   c. Apakah terdapat keterlibatan multisistem?
   d. Apakah pasien membutuhkan edukasi kesehatan yang intensif?
   e. Apakah pasien membutuhkan dukungan emosional yang tinggi?

f. Teknologi apa yang digunakan (misalnya monitor jantung, pompa infus, PCA)?

➡️ Pasien dengan kondisi lebih tidak stabil atau kebutuhan kompleks memerlukan **tingkat keterampilan yang lebih tinggi**.

2. Pengendalian Infeksi

a. Apakah diperlukan tindakan isolasi?
b. Apakah ada risiko **kontaminasi silang (cross-contamination)**?

Contoh:

Pasien dengan dugaan penyakit infeksi (misalnya batuk kronis, keringat malam) **tidak boleh dirawat oleh staf yang sama** dengan pasien imunokompromais (misalnya pasien pascakemoterapi).

3. Tingkat Supervisi

a. Apakah diperlukan supervisi langsung atau tidak langsung?
b. Apakah staf memiliki pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang memadai?
c. Apakah supervisi yang diperlukan tersedia?

Contoh:

RN yang bekerja hanya sesekali (misalnya akhir pekan) mungkin membutuhkan supervisi lebih dibandingkan LPN yang berpengalaman di unit tersebut.

Pengembangan Staf melalui Penugasan

Perlu diperhatikan bahwa staf yang paling berpengalaman **tidak selalu harus ditugaskan pada kasus yang paling kompleks**.

Penugasan juga berfungsi sebagai **alat pengembangan staf**, misalnya:

1. Perawat yang kurang berpengalaman dapat ditugaskan pada pasien yang lebih kompleks
2. Namun harus disertai dengan **peningkatan tingkat supervisi**

➡️ Hal ini akan meningkatkan:

1. keterampilan
2. kompetensi
3. kepercayaan diri perawat

tanpa mengorbankan **keselamatan dan kualitas asuhan pasien**.

Bekerja dengan Anggota Tim Kesehatan Interprofesional

Tenaga kesehatan lainnya, seperti terapis respirasi, fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara, ahli gizi, pekerja sosial medis, dan rohaniawan, memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pasien.

Dalam vignette pada bab ini, Ms. Miller perlu **mengoordinasikan peran setiap anggota tim interprofesional** yang tersedia di unitnya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pasien yang menjadi tanggung jawabnya.

Sebagai contoh:

1. **Terapis respirasi** memantau pasien yang menggunakan ventilator serta membantu proses *weaning* (pelepasan ventilator).
2. **Pekerja sosial medis** membantu mengidentifikasi dukungan keluarga dan memfasilitasi penempatan pasien ke panti perawatan bila diperlukan.
3. **Terapis wicara** membantu pasien dengan gangguan komunikasi, seperti pasien yang bergantung pada ventilator dan mengalami frustrasi saat berbicara.

Kolaborasi interprofesional ini sangat penting untuk memastikan **asuhan yang komprehensif dan berpusat pada pasien**.

Membangun Keterampilan Delegasi dan Supervisi

Delegasi dan supervisi yang efektif merupakan keterampilan penting dalam bekerja secara efisien dengan tim serta dalam memberikan asuhan yang **aman dan hemat biaya**.

Namun, delegasi sering menjadi tantangan, terutama bagi perawat pemula. Beberapa hambatan yang sering dialami antara lain:

1. Takut tidak disukai
2. Takut melakukan kesalahan
3. Kurang pengalaman bekerja dengan uap, lpn, atau lvn
4. Kurang percaya diri
5. Kurang memahami proses delegasi

Karena delegasi dan supervisi melibatkan interaksi antarindividu, perawat profesional perlu mengembangkan:

1. **Keterampilan interpersonal yang kuat**
2. **Lingkungan kerja yang suportif**

Berikut ini adalah keterampilan manajerial yang perlu dikembangkan oleh RN:

Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang jelas merupakan kunci keberhasilan dalam delegasi dan supervisi. Langkah awal komunikasi efektif adalah memahami secara tepat:

1. Apa tugas yang harus dilakukan?
2. Untuk siapa tugas tersebut dilakukan?
3. Kapan tugas harus dilaksanakan?
4. Bagaimana cara melaksanakannya?
5. Apa hasil yang diharapkan?

6. Umpan balik apa yang diharapkan?
7. Mengapa tugas harus dilakukan dengan cara tertentu?

Menjaga **pengendalian diri dan kepercayaan diri** juga merupakan keterampilan komunikasi yang penting. Perawat baru sering merasa canggung saat mendelegasikan tugas kepada staf yang lebih berpengalaman.

Contoh respons staf: *"Saya sudah bekerja di sini 12 tahun, saya tidak perlu diberi tahu apa yang harus dilakukan."* Respons yang tepat dari RN adalah tetap: tenang , percaya diri, positif .

Contoh:

"Saya sangat menghargai pengalaman dan pengetahuan Anda, dan saya membutuhkan bantuan Anda untuk tim dan pasien kita dengan cara ... [jelaskan tugas secara jelas]."

Selain itu, RN juga harus **mendengarkan secara aktif** respons dari penerima delegasi:

1. Apakah ia memahami instruksi?
2. Apakah terlihat ragu?
3. Marah?
4. Tidak tertarik?
5. Frustrasi?

Jika muncul respons negatif, RN sebaiknya memberikan ruang untuk klarifikasi dengan pertanyaan terbuka yang tidak mengancam, misalnya: *"Anda tampak ragu dalam melakukan tugas ini."* RN juga harus selalu memberikan kesempatan kepada penerima delegasi untuk **mengajukan pertanyaan**. Teknik komunikasi positif yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas delegasi.

Menciptakan Lingkungan Kepercayaan dan Kerja Sama

Anggota staf akan lebih cepat melaporkan masalah apabila mereka mengetahui bahwa respons dari supervisor bersifat **tidak mengancam dan tidak menghakimi**. Ketika terjadi kesalahan, individu yang melakukannya tidak seharusnya disalahkan atau dikritik, melainkan supervisor perlu menelusuri **akar penyebab (root causes)** dan faktor sistem, seperti:

1. Pelatihan yang tidak memadai
2. Beban kerja yang berlebihan

Mendorong staf untuk melaporkan dan mendiskusikan masalah merupakan cara yang efektif untuk:

1. Meningkatkan mutu asuhan pasien
2. Membangun sikap kerja yang suportif dan kolaboratif

Sebagaimana perawat membangun hubungan saling percaya dengan pasien, hal yang sama juga perlu dibangun dengan sesama anggota staf.

Memberikan Umpan Balik dan Evaluasi Tindak Lanjut

Proses delegasi belum dianggap selesai sampai perawat profesional (RN):

1. melakukan **pengkajian ulang pasien**
2. menyesuaikan **rencana asuhan keperawatan** sesuai kebutuhan

RN juga perlu memberikan **umpan balik yang jujur** kepada penerima delegasi terkait kinerjanya. Keterampilan sederhana namun sering terabaikan adalah **memberikan penghargaan atas kinerja yang baik**. Sebaliknya, hal yang lebih sulit namun penting adalah **menangani kinerja yang kurang baik**.

Dalam menghadapi kesalahan:

1. RN harus menyampaikan secara **suportif dan dalam suasana privat**
2. Ffokus pada prinsip **"belajar dari kesalahan"**

Namun, jika staf menunjukkan kinerja yang:

1. Tidak sesuai
2. Tidak aman
3. Tidak kompeten

Maka RN harus:

1. Segera **menghentikan tindakan yang tidak aman**
2. **Mendokumentasikan fakta kejadian**
3. **Melaporkan kepada atasan/supervisor**

Selain itu, RN perlu mengusulkan: pelatihan tambahan atau tindakan lain yang sesuai

guna menjamin **keselamatan pasien tetap terjaga**. RN memiliki **tanggung jawab profesional** untuk melakukan intervensi yang tepat ketika menemukan kinerja yang tidak memadai.

C. Rubrik Penilaian

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan Keputusan Delegasi & Supervisi	Delegasi tidak sesuai kompetensi; supervisi tidak ada.	Delegasi cukup sesuai; supervisi kurang spesifik/hanya lisan.	Delegasi sesuai kompetensi; rencana supervisi jelas.	**Delegasi sangat tepat; supervisi terukur dan antisipatif terhadap risiko klinis.**

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.2 Ketepatan Rencana Pengendalian Logistik	Tidak berbasis kebutuhan; membiarkan stok kosong.	Berbasis kebutuhan saat ini saja; kontrol stok kurang.	Berbasis data penggunaan; sistem kontrol memadai.	**Berbasis data komprehensif; kontrol sangat efektif (minim stockout/overstock).**

D. Rangkuman Materi

1. **Hakikat Delegasi dan Supervisi** Delegasi dalam keperawatan adalah pengalihan tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada staf lain sementara perawat pemberi delegasi tetap memegang akuntabilitas (*accountability*) atas hasilnya. Keberhasilan delegasi sangat bergantung pada **Lima Prinsip Benar (Five Rights of Delegation)**: tugas yang tepat, kondisi yang tepat, orang yang tepat, instruksi yang tepat, dan supervisi yang tepat. Supervisi bukan sekadar pengawasan, melainkan proses bimbingan dan validasi untuk memastikan keselamatan pasien tetap terjaga.
2. **Strategi Pengambilan Keputusan Delegasi** Perawat profesional harus mampu menganalisis kompleksitas kebutuhan pasien dibandingkan dengan kompetensi staf yang tersedia (*skill mix*). Tugas yang memerlukan pertimbangan klinis mendalam (*clinical judgment*) dan asesmen awal tidak dapat didelegasikan. Komunikasi dalam delegasi harus bersifat dua arah dan menggunakan instrumen yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang.
3. **Manajemen Pengendalian Logistik di Unit Rawat** Manajemen asuhan yang efektif memerlukan dukungan logistik yang memadai. Pengendalian logistik meliputi perencanaan kebutuhan, penyimpanan, hingga penggunaan alat kesehatan dan habis pakai. Strategi yang digunakan harus berbasis data penggunaan (tren) untuk mencegah terjadinya kekosongan stok (*stockout*) yang dapat menghambat asuhan atau penumpukan stok (*overstock*) yang menyebabkan inefisiensi biaya.

Evaluasi Mahasiswa (Berbasis Kasus)

Instruksi Tugas:

Bacalah skenario di bawah ini dan susunlah:

1. **Laporan Kasus & Rencana Delegasi**
2. **Rencana Pengendalian Logistik**

Skenario Kasus: Anda adalah seorang Ketua Tim di Ruang Perawatan Bedah dengan 6 pasien (3 pasien post-op hari ke-0, 2 pasien luka bakar, dan 1 pasien persiapan pulang). Anda dibantu oleh 1 Perawat Pelaksana (Ners) dan 1 Perawat Vokasi. Saat ini, stok kassa steril dan cairan pencuci luka di lemari alat tersisa 2 pak, padahal terdapat 5 pasien yang memerlukan perawatan luka besar hari ini.

Produk Evaluasi 1: Rencana Delegasi & Supervisi

Tabel 6.1: Rencana Delegasi & Supervisi

Pasien	**Tugas yang Didelegasikan**	**Penerima Delegasi**	**Rencana Supervisi**
Pasien Post-Op hari ke-0	Observasi TTV & perdarahan tiap 15 menit.	Perawat Pelaksana (Ners)	Validasi data setiap 1 jam; pastikan *early warning system* berjalan.
Pasien Persiapan Pulang	Edukasi perawatan di rumah & administrasi.	Perawat Vokasi	Cek pemahaman pasien sebelum meninggalkan ruangan.
Pasien Luka Bakar	Perawatan luka kompleks.	Ketua Tim (Anda)	(Dilakukan mandiri karena kompleksitas tinggi).

Produk Evaluasi 2: Rencana Pengendalian Logistik

1. **Identifikasi Masalah:** Kekurangan stok kassa dan cairan pencuci luka (stok kritis).
2. **Analisis Kebutuhan:** 5 pasien x rata-rata 3 pak kassa = 15 pak dibutuhkan segera.
3. **Tindakan Pengendalian:**
   a. Melakukan permintaan darurat (*cito*) ke farmasi/logistik medis sebanyak 20 pak (untuk cadangan 1 hari).
   b. Melakukan audit inventaris mingguan untuk memperbarui *stock level* minimum di unit.
   c. Mengatur penyimpanan dengan sistem FIFO (*First In First Out*) untuk mencegah kedaluwarsa.

E. Daftar Pustaka

American Nurses Association. Code of ethics for nurses with interpretive statements. Silver Spring, MD: American Nurses Association 2015;

American Nurses Association. Principles for delegation. Silver Spring, MD: American Nurses Association 2012;

American Nurses Association. Nursing Scope and standards of practice. Washington, DC: American Nurses Association 2015; Available at: http://www.nursesbooks.org/ebooks/download/Nu Scope&Standards-3E.pdf Retrieved from

American Nurses Association and National Council of State Boards of Nursing. Joint statement on delegation. Available at: https://www.ncsbn.org/Delegation_joint_statement ANA.pdf 2014; Retrieved from

Awan, N. A., Miller, R. R., Miller, M. P., Specht, K., Vera, Z., & Mason, D. T. (1978). Clinical pharmacology and therapeutic application of prazosin in acute and chronic refractory congestive heart failure. Balanced systemic venous and arterial dilation improving pulmonary congestion and cardiac output. In *The American Journal of Medicine* (Vol. 65, Issue 1). https://doi.org/10.1016/0002-9343(78)90703-9

Cherry, B., & Jacob, S. R. (2014). Contemporary Nursing. *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis*, 1–30. https://www.cambridge.org/core/product/identifier/CBO9781107415324A009/type/book_part

Duffy M, McCoy S.F. Delegation and you .;. Silver Spring, MD: American Nurses Association, 2014; Available at: Nursebooks.org

Hansten R.I, Jackson M. Clinical delegation skills A handbook for professional practice . 4th ed. Sudbury, MA: Jones and Bartlett 2009;

Johnson S.H. Teaching nursing delegation analyzing nurse practice acts . Journal of Continuing Education in Nursing 1996;27(2):52-58.

Legal Eagle Eye. Newsletter for the Nursing Profession . Patient chokes, dies Nurse ruled negligent, delegated supervision of patient to aide 2010;18(1) Available at: http://www.nursinglaw.com/jan10ang7.pdf Retrieved from

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2015a). Leadership Roles and Functions in Nursing : Theory and Application. In *Wolters Kluwer Health*.

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2015b). *Leadership Roles and Management Functions in Nursing*. Philadelphia:Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins.

National Council of State Boards of Nursing. National guidelines for nursing delegation . Available at: https://www.ncsbn.org/NCSBN_Delegation_Guide 2016; Retrieved from

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Amy M. Hall. (2020). *Fundamentals of Nursing* (Tenth Edit). Canada:Elsevier.

Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2020). *Fundamentals of Nursing Active Learning For Collaboartive Practice*. Canada:Elsevier.

BAB 7

KOMUNIKASI EFEKTIF, KOLABORASI, DAN MANAJEMEN KONFLIK

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran	**CPL Program Studi yang dibebankan pada Mata Kuliah**					
	CPL 3	Mampu menerapkan kepemimpinan keperawatan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik serta perubahan dalam tim.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
		Uraian	Teknik	Indikator Penilaian	Bobot (%)	Bukti / Produk
	CPMK-3	Menerapkan kepemimpinan keperawatan, manajemen perubahan, komunikasi efektif, kolaborasi, dan manajemen konflik dalam pengelolaan tim	Simulasi kepemimpinan & konflik (role play) + checklist	Skor kinerja komunikasi terstruktur dan efektivitas resolusi konflik (checklist perilaku).	15	Video/rekaman; lembar penilaian
	CPMK- 5	Mengelola manajemen asuhan keperawatan melalui delegasi, supervisi, koordinasi, serta pemanfaatan sumber daya/logistik secara efisien	Studi kasus delegasi– supervisi & logistik	Ketepatan keputusan delegasi dan rencana supervisi, serta ketepatan rencana pengendalian logistik (skor rubrik).	15	Laporan kasus; rencana delegasi; rencana logistik
	Sub-CPMK 1	Menerapkan komunikasi terstruktur untuk koordinasi layanan dan handover tim.				
	Sub-CPMK 2	Menerapkan strategi penyelesaian konflik berbasis masalah dan menjaga hubungan kerja profesional				

Uraian Materi

A. Teori Dasar Komunikasi Efektif dalam Keperawatan

Komunikasi merupakan komponen fundamental dalam praktik keperawatan karena menjadi sarana utama dalam menyampaikan informasi, membangun hubungan terapeutik, serta mendukung keselamatan pasien. Dalam konteks keperawatan, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai pertukaran informasi, tetapi juga sebagai proses interpersonal yang melibatkan aspek emosional, psikologis, dan sosial antara perawat dengan pasien maupun dengan tim kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas (Gunawan et al., 2025).

Komunikasi efektif dalam keperawatan didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan yang dilakukan secara jelas, akurat, dan dapat dipahami oleh penerima sehingga tujuan komunikasi tercapai secara optimal. Komunikasi yang efektif menekankan adanya kesamaan makna antara komunikator dan komunikan, serta melibatkan umpan balik sebagai indikator keberhasilan komunikasi. Dalam praktik keperawatan, komunikasi efektif berperan penting dalam mencegah kesalahan informasi, terutama pada proses klinis seperti handover, yang berkaitan langsung dengan keselamatan pasien (Anwar et al., 2024) . Selain itu, komunikasi yang baik juga berperan dalam membangun hubungan interpersonal yang positif serta mendukung kerja sama tim dalam pelayanan kesehatan (Badrudin et al., 2025; Hajar et al., 2024). Komunikasi efektif juga berfungsi sebagai upaya untuk mengubah perilaku pasien dalam meningkatkan kesehatan serta mendukung proses perawatan yang optimal (Jayanti et al., 2024).

Proses komunikasi yang berlangsung secara dua arah (two-way communication) memungkinkan adanya klarifikasi dan validasi pesan, sehingga dapat meminimalkan terjadinya miskomunikasi. Selain itu, penggunaan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan tingkat pemahaman pasien merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, terutama dalam edukasi kesehatan (Al Jamiliyati et al., 2025).

Dalam praktik keperawatan, komunikasi efektif sering diwujudkan dalam bentuk komunikasi terapeutik, yaitu komunikasi yang direncanakan secara sadar dan bertujuan untuk membantu proses penyembuhan pasien. Komunikasi terapeutik melibatkan beberapa tahap, yaitu fase pra-interaksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Melalui komunikasi ini, perawat dapat membangun hubungan saling

percaya dengan pasien, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, serta membantu pasien dalam mengatasi masalah kesehatannya (Syaripudin & Mulyadi, 2024).

Lebih lanjut, komunikasi efektif juga memiliki peran dalam memengaruhi hasil kesehatan pasien, seperti meningkatkan kepuasan pasien, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan. Komunikasi yang baik memungkinkan pasien memahami kondisi kesehatannya dan berpartisipasi aktif dalam proses perawatan. Dengan demikian, komunikasi efektif tidak hanya berdampak pada hubungan interpersonal, tetapi juga pada kualitas pelayanan dan outcome klinis pasien (Jayanti et al., 2024; Al Jamiliyati et al., 2025).

B. Unsur-unsur Komunikasi

Menurut teori komunikasi dalam keperawatan, terdapat beberapa unsur utama:

1. Komunikator (perawat)
   Perawat menyampaikan pesan kepada pasien, keluarga atau tim kesehatan. Unsur komunikator terdiri dari kredibilitas, daya Tarik, kekuatan, kemapuan komunikasi, penguasaan materi, silap, kesesuaian budaya.
2. Pesan (informasi kesehatan)
   Pesan adalah informasi atau makna yang disampaikan oleh perawat kepada pasien, keluarga atau tim kesehatan. Unsur pesan terdiri dari isi pesan, kejelasan, kelengkapan, ketepatan, kesesuaian, Bahasa dan symbol, struktur pesan.
3. Media (verbal/nonverbal).
   Media adalah sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari perwat kepada pasien, keluarga, atau tim kesehatan, Pemilihan media yang tepat sangat mempengarughi keberhasilan komunikasi.
4. Komunikan (pasien/keluarga).
   Komunikan adalah pihak yang menerima pesan, biasanya pasien atau anggota tim kesehatan. Memahami unsur komunikan sangat penting agar pesan yang disampaikanperwat dapat diterima dan dipahami dengan baik.
5. Umpan balik (feedback).
   Umpan balik adalah respon atau tanggapan dari komunikan (pasien, keluarga atau tim kesehatan lainnya) terhadap pesan yang disampaikan perawat

C. Prinsip Komunikasi Efektif

Prinsip komunikasi efektif dalam keperawatan dikenal dengan konsep: REACH:

1. **R (Respect)**: menghargai pasien, santun
2. **E (Empathy)**: memahami perasaan pasien, memahami sudut pandang pasien

3. **A (Audible)**: dapat didengar/dimengerti, memberikan respon yang tepat
4. **C (Clarity)**: jelas, disampaikan denfgan Bahasa yang mudah dimengerti
5. **H (Humble)**: rendah hati

Prinsip ini terbukti meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan (Aini et al., 2024).

D. Bentuk Komunikasi dalam Keperawatan

Dalam keperawatan, komunikasi memiliki beberapa bentuk yang digunakan sesuai situasi, tujuan dan kondisi pasien. Bentuk bentuk ini membantu perawat menyampaikan informasi sekaligus membangun hubungan terapeutik. Berikut bentuk komunikasi dalam keperawatan:

1. Komunikasi Verbal, komunikasi yang menggunakan kata kata baik secara:

- Bahasa lisan/tulisan
- Harus sederhana dan mudah dipahami pasien

2. Komunikasi Nonverbal, komunikasi tanpa kata kata, meliputi:

- Ekspresi wajah
- Kontak mata
- Bahasa tubuh
- Sentuhan terapeutik
- Nada suara(intonasi)

Komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif dapat meningkatkan harapan dan kondisi psikologis pasien (Rezkiki et al., 2024).

E. Teknik Komunikasi Efektif

1. Teknik SBAR

Pengertian SBAR

SBAR adalah metode komunikasi terstruktur yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi penting secara **singkat, jelas, dan sistematis**. SBAR merupakan singkatan dari:

- **S (Situation)**: situasi saat ini
- **B (Background):** latar belakang
- **A (Assessment)**: penilaian kondisi pasien
- **R (Recommendation):** rekomendasi/tindakan

Teknik SBAR membantu komunikasi menjadi sistematis, jelas, dan terstruktur sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan pasien. Teknik SBAR banyak digunakan dalam praktik keperawatan, terutama saat **handover, konsultasi dokter, dan pelaporan kondisi pasien** (Anggaraini et al., 2026).

2. Penggunaan Bahasa Sederhana

- Hindari istilah medis yang sulit
- Sesuaikan dengan tingkat pendidikan pasien

Penggunaan bahasa sederhana terbukti meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan kepuasan pasien (Al Jamiliyati et al., 2025).

3. Komponen SBAR

a. Situation (Situasi)
   Menjelaskan kondisi terkini pasien secara singkat dan jelas.
   Isi: dentitas pasien, masalah utama, kondisi saat ini
   Contoh:
   "Pasien Tn. A mengalami sesak napas sejak 1 jam yang lalu."

b. Background (Latar Belakang)
   Memberikan informasi pendukung yang relevan dengan kondisi pasien.
   Isi: diagnosis medis, riwayat penyakit, tindakan yang sudah dilakukan
   Contoh:
   "Pasien memiliki riwayat asma dan sedang menjalani terapi nebulizer."

c. Assessment (Penilaian)
   Menjelaskan hasil pengkajian perawat terhadap kondisi pasien.
   Isi: tanda vital, hasil observasi klinis, analisis kondisi pasien
   Contoh:
   "RR 30x/menit, saturasi 88%, pasien tampak gelisah."

d. Recommendation (Rekomendasi)
   Menyampaikan tindakan yang diusulkan atau dibutuhkan.
   Isi: permintaan Tindakan, saran klinis, indak lanjut
   Contoh:
   "Mohon evaluasi dokter dan pertimbangkan pemberian oksigen tambahan."

4. Contoh Penerapan SBAR Lengkap

S:
"Pasien Ny. B mengalami penurunan kesadaran."
B:
"Pasien dirawat dengan diagnosis stroke sejak 3 hari lalu."
A:
"GCS menurun dari 15 menjadi 10, tekanan darah 180/100 mmHg."

R:

"Mohon segera dilakukan evaluasi dokter dan pemeriksaan CT scan."

F. Faktor yang Mempengaruhi Komunikasi Efektif

1. Faktor individu (emosi, pengetahuan, pengalaman)
2. Faktor lingkungan (suasana ruangan, kebisingan)
3. Faktor budaya dan bahasa
4. Faktor hubungan interpersonal
5. Keterampilan komunikasi perawat

G. Dampak Komunikasi Efektif

1. Dampak Positif:
   - Meningkatkan keselamatan pasien
   - Mengurangi kesalahan medis
   - Meningkatkan kepuasan pasien
   - Mempercepat penyembuhan
2. Dampak Negatif (jika tidak efektif):
   - Misinterpretasi informasi
   - Konflik dalam tim
   - Penurunan kualitas pelayanan

H. Penerapan dalam Praktik Keperawatan

Penerapan komunikasi efektif dalam praktik keperawatan adalah bagaimana perawat menggunakan prinsip dan teknik komunikasi dalam situasi nyata untuk meningkatkan kualitas asuhan dan hubungan dengan pasien.

Komunikasi efektif diterapkan dalam:

1. Handover pasien. Serah terima pasien sangat penting untuk menjaga kesinambungan perawatan dan keselamatan pasien. Proses penyampaian informasi penting tentang koordinasi pasien dari perawat yang bertugas kepada perawat berikutnya.
2. Edukasi kesehatan. penerapan komunikasi efektif dalam edukasi kesehatan bertujuan agar pasien dan keluarga memahami kondisi, pengobatan serta perwatan yang harus dilakukan secra mandiri, Edukasi yang baik akan menuingkatkan kepatuhan dan hasil kesehatan.
3. Discharge planning. Penerapan komunikasi efektif dalam discharge planning (perencanaan pulang pasien) sangat penting untuk memastikan pasien dan keluarga memahani rencana perawatan lanjutan setelah kekuar dari fasilitas

kesehatan. Tujuannya meningkatkan keselamatan pasien, mencegah komplikasi dan mendukung kepatuhan terapi.

4. Kolaborasi tim kesehatan. Penerapan komunikasi efrektif dalam kolaborasi tim kesehatan sangat penting untuk meningkatkan koordinasi, mencegah kesalahan dan menjamin keselamatan pasien.

Komunikasi yang baik berkontribusi langsung terhadap kualitas pelayanan dan outcome pasien (Jayanti et al., 2024).

I. Teori Dasar Kolaborasi dalam Keperawatan.

1. Pengertian Kolaborasi dalam Keperawatan

Kolaborasi dalam keperawatan adalah bentuk kerja sama antara tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang optimal, efektif, dan berpusat pada pasien. Kolaborasi interprofesional melibatkan komunikasi, koordinasi, serta pengambilan keputusan bersama. Dengan kolaborasi yang baik, pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan hasil kesehatan pasien (Huda et al., 2024; Hajar et al., 2024; Jayawisastra, 2022).

Menurut Dulahu et al. (2022), kolaborasi interprofesional merupakan kemitraan antar profesi dengan latar belakang berbeda yang bekerja sama dalam menyelesaikan masalah kesehatan pasien secara efektif . Selain itu, kolaborasi yang baik terbukti meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien.

2. Landasan Teori Kolaborasi (Evidence-Based)

a. Teori Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi interprofesional merupakan inti pelayanan kesehatan modern.

Hasil systematic review menunjukkan bahwa strategi kolaborasi interprofesional: meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan kualitas layanan ,memperkuat kerja tim tenaga kesehatan Selain itu, kolaborasi yang efektif memberikan dampak positif terhadap outcome pasien secara holistik.

b. Interprofessional Education (IPE)

IPE adalah pendekatan pembelajaran di mana mahasiswa dari berbagai profesi kesehatan belajar bersama untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi.

Menurut Lahagu dan Nurhidayah (2023), IPE dapat bermanfaat meningkatkan pemahaman peran antar profesi ,memperkuat keterampilan komunikasi dan teamwork ,mempersiapkan praktik kolaboratif di dunia kerja.

c. Teori Sistem (Systems Theory)

Dalam perspektif sistem, pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komponen (tenaga kesehatan, pasien, organisasi).

Kolaborasi diperlukan untuk menjaga integrasi sistem, meningkatkan efisiensi pelayanan, mencegah kesalahan akibat miskomunikasi .

d. Teori Komunikasi dalam Kolaborasi

Komunikasi merupakan elemen kunci dalam kolaborasi interprofesional. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahan medis dan konflik tim.

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terstruktur mampu meningkatkan komunikasi tim dan menghasilkan pelayanan yang lebih komprehensif .

e. Teori Kepemimpinan Kolaboratif

Dalam manajemen keperawatan, perawat berperan sebagai leader yang memfasilitasi kolaborasi tim.

Faktor yang mempengaruhi kolaborasi meliputi kepemimpinan, sistem organisasi, faktor individu tenaga kesehatan

3. Prinsip-Prinsip Kolaborasi

Prinsip kolaborasi dalam keperawatan meliputi saling menghargai (mutual respect) , komunikasi efektif, kejelasan peran, kerja tim (teamwork), Patient-centered care, shared decision-making Kurangnya kolaborasi dapat menyebabkan tumpang tindih tugas dan menurunkan kualitas pelayanan .

4. Manfaat Kolaborasi

Kolaborasi interprofesional memberikan manfaat:

a. meningkatkan keselamatan pasien
b. meningkatkan kualitas asuhan keperawatan
c. meningkatkan komunikasi tim
d. meningkatkan kepuasan pasien dan tenaga kesehatan

J. Teori Dasar Manajemen Konflik dalam Keperawatan

1. Pengertian Manajemen Konflik dalam Keperawatan

Manajemen konflik dalam keperawatan adalah suatu proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengelola, dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam lingkungan kerja melalui strategi tertentu seperti komunikasi, negosiasi, dan kolaborasi. Konflik dalam pelayanan keperawatan sering terjadi akibat perbedaan persepsi, nilai, maupun komunikasi yang tidak efektif. Oleh karena itu, manajemen konflik yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan kinerja perawat serta kualitas pelayanan kepada pasien (Tiranie et al., 2024; Oktoviyani et al., 2022; Batubara et al., 2023).

2. Landasan Teori Gaya Manajemen Konflik (Thomas-Kilmann Conflict Mode)

Teori ini mengidentifikasi lima gaya utama dalam manajemen konflik:

a. Kompetisi (competing)
b. Kolaborasi (collaborating)
c. Kompromi (compromising)
d. Akomodasi (accommodating)
e. Menghindar (avoiding)

a. Gaya Kompetisi (Competing)

Pengertian: Gaya kompetisi adalah pendekatan konflik di mana individu berusaha memenangkan konflik tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Gaya ini bersifat tegas (assertive) tetapi tidak kooperatif.

Ciri-ciri: berorientasi pada kemenangan pribadi , menggunakan kekuasaan atau otoritas, dan keputusan diambil secara sepihak

Contoh Kasus di Ruang Rawat: Seorang kepala ruangan memutuskan pembagian jadwal jaga tanpa melibatkan diskusi dengan perawat lain. Salah satu perawat mengeluhkan jadwal yang tidak adil, tetapi kepala ruangan tetap mempertahankan keputusannya dengan alasan efisiensi pelayanan.

Analisis: Gaya ini efektif dalam situasi darurat, tetapi jika digunakan terus-menerus dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik berkepanjangan dalam tim.

b. Gaya Kolaborasi (Collaborating)

Pengertian: Gaya kolaborasi adalah pendekatan konflik yang berusaha mencari solusi terbaik yang memuaskan semua pihak (win-win solution). Gaya ini bersifat tegas dan kooperatif.

Ciri-ciri: Komunikasi terbuka, Menghargai pendapat semua pihak dan Fokus pada solusi bersama

Contoh Kasus di Ruang Rawat: Perawat dan dokter memiliki perbedaan pendapat terkait rencana perawatan pasien. Mereka kemudian melakukan diskusi bersama, mempertimbangkan kondisi pasien, dan menyepakati intervensi yang paling aman dan efektif.

Analisis: Gaya ini paling ideal dalam keperawatan karena meningkatkan kualitas pelayanan dan kerja tim, meskipun membutuhkan waktu lebih lama.

c. Gaya Kompromi (Compromising)

Pengertian: Gaya kompromi adalah pendekatan di mana kedua pihak saling mengalah untuk mencapai titik tengah.

Ciri-ciri: Ada give and take, Tidak ada pihak yang benar-benar menang atau kalah dan Solusi bersifat sementara

Contoh Kasus di Ruang Rawat: Dua perawat berebut jadwal libur pada hari yang sama. Setelah berdiskusi, mereka sepakat satu perawat libur pada pagi hari dan yang lain pada shift malam, sehingga keduanya tetap mendapatkan sebagian keinginannya.

Analisis: Gaya ini cukup efektif untuk konflik sederhana, tetapi mungkin tidak menyelesaikan akar masalah secara menyeluruh.

d. Gaya Akomodasi (Accommodating)

Pengertian: Gaya akomodasi adalah pendekatan di mana seseorang mengalah untuk menjaga hubungan baik dengan pihak lain.

Ciri-ciri: Mengutamakan hubungan, Menghindari konfrontasi dan Mengalah demi orang lain

Contoh Kasus di Ruang Rawat: Seorang perawat junior tidak setuju dengan metode kerja perawat senior, tetapi memilih mengikuti arahan tersebut untuk menghindari konflik dan menjaga hubungan kerja.

Analisis: Gaya ini baik untuk menjaga keharmonisan, tetapi jika terlalu sering dilakukan dapat merugikan diri sendiri dan menurunkan kualitas keputusan klinis.

e. Gaya Menghindar (Avoiding)

Pengertian: Gaya menghindar adalah pendekatan konflik dengan cara menghindari masalah tanpa menyelesaikannya.

Ciri-ciri: Tidak menghadapi konflik secara langsung, Menunda penyelesaian dan Menghindari komunikasi

Contoh Kasus di Ruang Rawat: Seorang perawat mengetahui adanya kesalahan komunikasi antar tim, tetapi memilih diam dan tidak membahasnya karena takut memperburuk situasi.

Analisis: Gaya ini hanya efektif untuk konflik kecil atau sementara. Jika digunakan terus-menerus, konflik dapat semakin besar dan berdampak pada keselamatan pasien.

Penelitian menunjukkan bahwa gaya kolaborasi, kompromi, dan akomodasi memiliki hubungan signifikan dengan kepuasan kerja perawat (Alvionita & Siregar, 2024).

K. Sumber dan Jenis Konflik dalam Keperawatan

Konflik dalam keperawatan dapat bersumber dari:

- perbedaan peran dan tanggung jawab
- tekanan kerja tinggi
- komunikasi yang tidak efektif
- perbedaan nilai dan budaya

Jenis konflik meliputi:

- konflik intrapersonal
- konflik interpersonal
- konflik interprofesional

1. Prinsip-Prinsip Manajemen Konflik

Prinsip utama dalam manajemen konflik meliputi:

a. Komunikasi terbuka
b. Saling menghargai
c. Fokus pada solusi (problem-solving)
d. Kolaborasi
e. Kejelasan peran

Manajemen konflik yang efektif dapat meningkatkan kerja sama tim dan keselamatan pasien.

L. Aktivitas 1: Know How

1. MINI CASE (Diskusi kelompok)

Saudara adalah seorang Ketua Tim perawat di ruang rawat inap penyakit dalam. Terjadi konflik antara dua perawat dimana Perawat A mengeluh karena sering mendapat tugas lebih berat, sedangkan Perawat B merasa pembagian sudah sesuai. Situasi mulai memanas dan berpotensi mengganggu pelayanan pasien. Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

2. Pertanyaan

a. Identifikasi jenis konflik yang terjadi!
b. Jelaskan penyebab konflik tersebut!
c. Sebutkan 5 gaya manajemen konflik menurut teori!
d. Tentukan gaya manajemen konflik yang paling tepat dalam kasus tersebut!
e. Jelaskan langkah-langkah Anda dalam menyelesaikan konflik tersebut sebagai perawat!

3. Assesmen Rubrik Penilaian

Komponen	**Skor**
Identifikasi konflik	2
Analisis penyebab	2
Menyebutkan 5 gaya	2
Pemilihan gaya tepat	2
Langkah penyelesaian	2
Total	10

Diskusikan jawaban bersama kelompok yang telah ada dan presentasikan hasil diskusi tersebut.

M. Aktivitas 2: Shows How

1. Simulasi / skill dialog role play perawat

a. Buatkan soal role play osce dgn dialog perawat tentang manajemen konflik diruang rawat inap lengkap dengan skenario, peran, dialog dan poin penilaian
b. Fokus urutan aktivitas logis, komunikasi dan penyelesaiian konflik

Berikut contoh soal OSCE berbentuk role play (simulasi dialog perawat) tentang *manajemen konflik.*

2. Station OSCE

Topik: Manajemen Konflik Perawat

Waktu: 7–10 menit

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Manajemen konflik
3	Waktu yang dibutuhkan	10 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan komunikasi efektif dan penyelesaiian konflik
5	Kompetensi	1. identifikasi 2. analisa 3. komunikasi 4. Evaluasi 5. Perilaku professional
6	Kategori	1. Komunikasi 2. Aman dan nyaman 3. Nilai dan keyakinan
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Saudara adalah seorang Ketua Tim perawat di ruang rawat inap penyakit dalam. Terjadi konflik antara dua perawat dimana Perawat A mengeluh karena sering mendapat tugas lebih berat,

No.	Komponen	Isi	
		sedangkan Perawat B merasa pembagian sudah sesuai. Situasi mulai memanas dan berpotensi mengganggu pelayanan pasien. TUGAS: 1. Lakukan identifikasi focus permasalahan berdasarkan skenario tersebut pada 2. Gunakan komunikasi terapeutik, kolaborasi dan kepemimpinan 3. Selesaikan konflik gunakan gaya yg tepat	
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Saudara adalah seorang Ketua Tim perawat di ruang rawat inap penyakit dalam. Terjadi konflik antara dua perawat dimana Perawat A mengeluh karena sering mendapat tugas lebih berat, sedangkan Perawat B merasa pembagian	Sopan, jelas, empatik

No.	Komponen	Isi	
		sudah sesuai. Situasi mulai memanas dan berpotensi mengganggu pelayanan pasien TUGAS: 1. Menilai ketepatan Komunikasi terapeutik 2. Menilai kemapuan mengidentifikasi masalah 3. Menilai kemampuan Klarifikasi 4. Menilai penetapan Strategi konflik 5. Menilai kemampuan Penyelesaiian konflik	
9	Instruksi untuk klien standar	Hal hal yang perlu ada: 1. Identitas peserta uji 2. Identitas klien standar 2 orang 3. Pembagian peran	Mampu menggali konflik
10	Setting station	Ruang nurse station Meja penguji Kursi penguji	Merangkum masalah dengan tepat
11	Peralatan yang dibutuhkan	Meja Kursi Pencahayaan	Menggunakan kolaborasi
12	Penulis		Ada kesepakatan solusi

No.	Komponen	Isi
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

3. Form Penilaian Osce Keperawatan

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: MANAJEMEN KONFLIK

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Komunikasi terapeutik	Sopan, jelas, empatik					1	
2	Identifikasi masalah	Mampu menggali konflik					2	
3	Klarifikasi	Merangkum masalah dengan tepat					2	
4	Strategi konflik	Menggunakan kolaborasi					3	
5	Penyelesaian	Ada kesepakatan solusi					2	
	Jumlah						10	

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

N. Rubrik Penilaian

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: MANAJEMEN KONFLIK

1. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Komunikasi Terapeutik. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengadakan pendekatan, membuka komunikasi jelas dan performa sopan dan menghadirkan diri empati.					1	
▪ Identifikasi masalah. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegakkan masalah konflik melalui proses penggalian data primer dan sekunder.					2	
3. Klarifikasi. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam merangkum masalah dengan tepat melalui Langkah Langkah sistematis dan komprehensif .					2	
4. Strategi konflik. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dan jiwa kepemimpinan dengan pendekatan kolaborasi .					3	
5.Penyelesaian. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menetapkan kesepakatan solusi konflik.					2	

2. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Komunikasi Terapeutik	Tidak melakukan komunikasi terapeutik	Melakukan komunikasi terapeutik sangat terbatas, hanya sopan	Melakukan komunikasi terapeutik cukup jelas dan sopan namun tidak empati	Melakukan komunikasi terapeutik cukup jelas , sopan dan empati
2. Identifikasi masalah	Tidak mampu mengidentifikasi masalah	Menegakkan masalah tidak akurat dengan	Menegakkan masalah yang akurat dengan	Menegakkan masalah yang akurat

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
		tdk menggali data2.	Sebagian menggali data2.	dengan menggali data2sluruhnya
3. klarifikasi	Tidak Merangkum masalah yg tepat	Sedikit merangkum masalah konflik secra terbatas.	cukup baik merangkum masalah konflik sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, dan kelengkapan	Merangkum masalah dengan komprehensif dan sangat tepat .
4. Strategi konflik	Tidak menunjukkan perilaku profesional, kepempinan dengan pendekatan kolaborasi.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati,

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
				responsif, dan etis selama tindakan.
5.Penyelesaian	Tidak menetapkan kesepakatan solusi konflik.	Sangat sedikit kesepakatan yg diperoleh	Cukup banyak kesepakatan yg diambil	Banyak diperoleh kesepakatan

3. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

4. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Manajemen Konflik Keperawatan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Manajen konflik
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat mempraktekkan simulasi, role play penanganan manajemen konflik
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan komunikasi, kolaborasi dan manajemen konflik dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang konsep tetapi juga dengan penerapan case study
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Saudara adalah seorang Ketua Tim perawat di ruang rawat inap penyakit dalam. Terjadi konflik antara dua perawat dimana Perawat A mengeluh karena sering mendapat tugas lebih berat, sedangkan Perawat B merasa pembagian sudah sesuai. Situasi mulai memanas dan berpotensi mengganggu pelayanan pasien
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai kesepakatan konflik dicapai	Mahasiswa melakukan Komunikasi terapeutik, Identifikasi masalah, Klarifikasi, strategi konflik dan penyelesaiian.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Manajen konflik
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi komunikasi terapeutik, kolaborasi dan manajemen konflik	Penguji menilai apakah mahasiswa sopan jelas dan empatok dalam berkomunikasi, mampu menggali konflik dan merangkum masalah, menggunakan kolaborasi dan penetapan kesepakatan masalah
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Penguji memperhatikan apakah mahasiswa dapat melewati setiap tahapan
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Penguji dapat menyampaikan capaian dan kemunduran mahasiswa dalam berkomunikasi dan mengelola konflik
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa diyatakan kompeten apabila mhs menyampaiakn runtut , komunikatif dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervise apabila masih membutuhkan arahan2. Mahasiswa dinyatakan remedial jika performa blm memenuhi standar.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian	Pada kasus manajemen konflik, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Manajen konflik
	pembelajaran pada level does.	penpengelolaan dan penyelesaiian konflik.

O. Portofolio

Tabel Portofolio pada Manajemen Konflik

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus manajemen konflik
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada kasus manajemen konflik, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik, kolaborasi dan penetapan kesepakatan solusi, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa mampu identifikasi menggali data konflik tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang dalam hal penyelesaian konflik setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan menyelesaikan konflik, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan komunikasi , kolaborasi dan kesepakatan Solusi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus manajemen konflik
	performa nyata di lahan praktik.	
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan case study yang pernah ditangani mahasiswa dalam MK manajemen keperawatan.	Mahasiswa menuliskan ringkasan pengelolaan majemen konflik,
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya menggali data konflik dan merumuskan sbg masalah dan menyepakati Solusi.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi terapeutik dan memilih gaya konflik dan Upaya penyelesaiian.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus diare, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan mampu asuhan keperawatan anak secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menerapkan pengelolaan konflik .

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus manajemen konflik
	kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada manajemen konflik, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel Case Report Manajemen Konflik

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus manajemen konflik
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus manajemen konflikyang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang pengelolaan dan penyelesaian konflik
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana	Mahasiswa tidak hanya menggali data konflik, tetapi juga berupaya mengelola konflik dan menetapkan kesepakatan2 solusi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus manajemen konflik
	tindakan, implementasi, atau pengelolaan konflik dan umpan balik	
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup hasil identifikasi data yg sdh tergali dan analisis masalah, gaya manajemen konflik, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus manajemen konflik, mahasiswa menuliskan data pemicu konflik
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menampilkan data2 pendukung konflik yg menghubungkan dengan masalah
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus diare, mahasiswa belajar bahwa pengkajian intake-output, tanda dehidrasi, dan edukasi berkelanjutan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep pengelolaan, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan oenanfan masalah.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Managemen konflik

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus manjemen , mahasiswa merefleksikan bahwa kehilangan cairan yang cepat dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami diri dengan memastikan apa yang menjadi tujuan
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama kasus ini adalah pelayanan terganggu.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain mundurnyta komunikasi terapeutik dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk	menjelaskan cara pemberian oralit yang benar, serta mengedukasi ibu tentang tanda bahaya.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
	mengurangi risiko keselamatan pasien.	
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada diperlukan pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatans secara berkelanjutan.

P. Tabel Red Flags & Eskalasi

Manajemen Konflik Keperawatan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Intonasi meninggi	Menunjukkan komunikasi terapeutik tidak terjadi	Cek kebali indicator keberhasilan, cek Bahasa tubuh
Penurunan kesadaran	Tanda bahaya serius yang dapat berkaitan	Eskalasi segera, jangan menunda observasi lanjutan
Tidak bisa tidur	Penanganan Konflik memelukan kondisi khusus	Segera laporkan dan evaluasi kebutuhan pendukung lanjutan

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Sulit memulai atau sedikit bergugur yang lebih serius	Menghambat keberhasilan kesepakatan Solusi	Laporkan segera, pantau kondisi mental dan fisik

Form Checklist "Saya sudah bisa..."
Bab: Komunikasi, Kolaborasi, Manajemen Konflik
Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Tanggal : _____
Tempat Praktik / Skill Lab : _____
Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan prinsip komunikasi efektif	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa membedakan bentuk komunikasi	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan komunikasi menggunakan Teknik SBAR	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menjelaskan Teori Kolaborasi Interprofesional	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menjelaskan Sumber dan Jenis Konflik dalam Keperawatan.	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menjelaskan Prinsip-Prinsip Manajemen Konflik	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa membedakan Teori Gaya Manajemen Konflik	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengidentikasi jenis konflik menggunakan gaya manajemen konflik dalam menyelesaikan konflik	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa memberikan klarifikasi terhadap masalah yg muncul	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menggali kesepakatan penyelesaian konflik	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
11	Saya sudah bisa menentukan strategi konflik yg akan digunakan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

Q. Rangkuman Materi

Bab ini menekankan pada Komunikasi efektif dalam keperawatan, kolaborasi nterprofesional dan manajemen konflik dalam keperawatan.

Komunikasi efektif merupakan proses interaksi yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan keterampilan interpersonal, penggunaan bahasa yang tepat, serta kemampuan memahami kebutuhan pasien. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam meningkatkan keselamatan pasien, kualitas pelayanan, serta keberhasilan asuhan keperawatan secara menyeluruh. Komunikasi ini harus dilakukan secara jelas, empatik, dan sistematis dengan memperhatikan prinsip, teknik, dan faktor yang mempengaruhinya. Dalam tatanan pelayanan Kesehatan, komunikasi menggunakan teknik SBAR membantu komunikasi menjadi sistematis, jelas, dan terstruktur sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pelayanan pasien. Teknik SBAR banyak saat **handover, konsultasi dokter, dan pelaporan kondisi pasien**. SBAR meliputi **S (Situation)** : situasi saat ini, **B (Background):** latar belakang, **A (Assessment)** : penilaian kondisi pasien, **R (Recommendation):** rekomendasi/Tindakan.

Integrasi kolaborasi interprofesional melibatkan komunikasi efektif dan kepemimpinan menjadi dasar dalam membentuk perawat profesional yang mampu bekerja secara efektif dalam tim kesehatan dan mengelola serta memyelesaikan konflik dengan tepat , efektif dan konstruktif melalui berbagai gaya manajemen konflik meliputi Kompetisi (competing) , Kolaborasi (collaborating), Kompromi (compromising, Akomodasi (accommodating) serta Menghindar (avoiding).

R. Daftar Pustaka

Abidah, A., Widyastuti, D., & Milkhatun. (2024). Hubungan sikap perawat dengan praktik kolaborasi interprofesi di ruang IGD Samarinda. Holistic Nursing and Health Science, 7(2), 88–97.

Aini, Y. N., Setiadi, D. K., & Rosyda, R. (2024). Hubungan komunikasi efektif tenaga kesehatan dengan kepuasan pasien. Jurnal Penelitian Keperawatan. https://doi.org/10.32660/jpk.v11i2.851

Al Jamiliyati, N. U., et al. (2025). Komunikasi efektif dalam keperawatan: Strategi penggunaan bahasa sederhana edukasi pasien. KIRANA: Social Science Journal, 2(1), 11–15. https://doi.org/10.61579/kirana.v2i1.275

Aliyah, I., Putri Zaenal, K., Fernanda, K., Rahmawati, M., & Utami, P. (2025). Dampak praktik kolaborasi interprofesional yang efektif dalam meningkatkan hasil perawatan. Jurnal Keperawatan dan Kesehatan, 16(2), 366–381.

Alvionita, D., & Siregar, T. (2024). Hubungan gaya manajemen konflik dengan kepuasan kerja perawat di ruang rawat inap. Jurnal Vokasi Keperawatan, 7(1). https://doi.org/10.33369/jvk.v7i1.28796

Anggaraini, S. N., & Wijaya, L. (2026). Analisis penerapan komunikasi efektif dengan teknik SBAR terhadap keselamatan pasien. Jurnal Kesehatan dan Pembangunan.

Anwar, S., et al. (2024). Hubungan komunikasi efektif dengan pelaksanaan handover dalam pelayanan keperawatan. Jurnal Health Society. https://doi.org/10.62094/jhs.v14i2.239

Badrudin, M., et al. (2025). Peran komunikasi efektif dalam mengelola konflik dalam organisasi kesehatan. https://doi.org/10.35719/leaderia.v5i1.735

Batubara, F. R., et al. (2023). Strategi manajemen konflik dalam asuhan dan pelayanan keperawatan.

Batubara, F. R., Tampubolon, K. N., Nabila, M., Sianipar, Y., & Nurhidayah, R. E. (2023). Strategi manajemen konflik dalam asuhan dan pelayanan keperawatan. Nursing News: Jurnal Ilmiah Keperawatan, 7(2), 73–86.

Dulahu, W. Y., Hiola, D. S., Jafar, C. P. S. H., et al. (2022). Nurse-doctor interprofessional collaboration in hospital: Study description. Jurnal Keperawatan dan Fisioterapi

Gunawan, I. G., et al. (2025). Komunikasi dalam keperawatan. CV Menara Press Indonesia.

Hajar, D. D., et al. (2024). Peran komunikasi efektif dalam penyelesaian konflik. DOI:10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i3.622

Huda, N., et al. (2024). Keterampilan komunikasi efektif dan kerja tim perawat interprofesional. https://doi.org/10.51933/health.v10i1.1997

Jayanti, D. D., et al. (2024). Hubungan komunikasi efektif perawat dengan discharge planning pasien. Ranah Research Journa. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1254

Jayawisastra, P. (2022). Strategi manajemen konflik dengan pendekatan kolaborasi. https://doi.org/10.58467/ijons.v2i2.39

Keumalasari, K., Yetti, K., Novieastari, E., & Martha, E. (2025). The strategies and interventions for interprofessional collaboration to improving patient safety in hospitals: A systematic review. Jurnal Keperawatan Indonesia.

Lahagu, E., & Nurhidayah, R. E. (2023). Interprofessional education (IPE) sebagai upaya mengembangkan kemampuan perawat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Jurnal Keperawatan Cikini, 4(2), 117–129.

Lumbantoruan, H. C., & Nurhidayah, R. E. (2023). Implikasi kolaborasi interprofesional terhadap layanan keperawatan berdasarkan perspektif holistic care: Systematic review. Jurnal Maternitas Kebidanan, 8(1), 1–16.

Oktoviyani, et al. (2022). Manajemen konflik (kolaborasi dan negosiasi) dalam keperawatan. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.5066

Pohan, N. H., Helga, P. D., Sinuhaji, S. J., Manurung, C. E., & Nurhidayah, R. E. (2023). Gambaran kecerdasan emosional dengan gaya manajemen konflik perawat. Jurnal Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, 3(2), 19–26. https://doi.org/10.53416/jurmik.v3i2.139

Pono, S. T., Agustini, T., & Jama, F. (2023). Manajemen konflik dan motivasi kerja perawat pelaksana. Window of Nursing Journal, 4(2). https://doi.org/10.33096/won.v4i2.552

Syaripudin, M. A., & Mulyadi, A. S. (2024). Komunikasi terapeutik sebagai sarana efektif bagi tindakan keperawatan yang optimal. HIKMAH: Jurnal Dakwah dan Sosial, 4(2). https://doi.org/10.29313/hikmah.v4i2.5309

Tiranie, D., et al. (2024). Manajemen konflik dalam tim keperawatan. https://doi.org/10.62094/jhs.v14i2.239

Tiranie, D., Setyoningrum, F., Ridwan, H., Ramadhan, M. G., Al-Farisi, M. K., & Safarina, R. P. A. (2025). Manajemen konflik dalam tim keperawatan: Implikasinya terhadap efektivitas proses keperawatan. Jurnal Kesehatan Tambusai, 6(2). https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.45325

Wardana, A. K., Aulia, M. F. R., & Suharyat, Y. (2024). Manajemen konflik dalam organisasi pendidikan. NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan, 5(1), 95–102.

Widiya, R., & Rangkuti, S. (2024). Penerapan interprofessional collaboration antar profesi kesehatan di rumah sakit: Literature review.

PROFIL PENULIS



Silvana Evi Linda, S.Kp., M.Kep., Ph.D. Lahir di Palembang, 16 Agustus 1967. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia tahun 1991. Melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2001, Kemudian pendidkan S3 philosofy of nursing pada Lincoln University Malaysia lulus tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991-1995 **(Superviser Ruang Rawat RSUP Palembang),** pada tahun 1995 - Juni 2025 **(Akademi Keperawatan Bina Insan)**. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Sarana Informatika mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Manajemen Patient Safety, Etika Keperawatan, dan Kebijakan Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, workshop**.** Berbagai organisasi diikuti: pengurus APVIKi, APTISI, PPNI dan keanggotaan AIPNI. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: silvana.evilinda@gmail.com
Motto: Ilmu, Integritas, dan Sukses



Ns. Heldawati, S.kep., M.Kep.
lahir di Baturaja pada 17 Juni 1972. Beliau menyelesaikan pendidikan Diploma Keperawatan di Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan Palembang pada tahun 1993. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, beliau memulai karier profesional sebagai perawat di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang. Pengalaman sebagai praktisi keperawatan memberikan pemahaman mendalam mengenai pelayanan kesehatan serta kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di bidang keperawatan. Komitmen terhadap pengembangan ilmu keperawatan mendorong beliau melanjutkan pendidikan Sarjana Keperawatan (S.Kep.) di STIKES Citra Delima dan berhasil meraih gelar pada tahun 2015. Pada tahun 2016–2017, beliau menyelesaikan pendidikan Profesi Ners, kemudian melanjutkan studi Magister Keperawatan (M.Kep.) di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus pada tahun 2022. Sejak tahun 2023 hingga saat ini, beliau aktif sebagai dosen di Institut Citra Internasional. Dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi, beliau terlibat dalam kegiatan pendidikan, pengajaran, serta pengembangan keilmuan di bidang keperawatan. Dedikasi dan pengalaman akademik yang dimiliki menjadi landasan dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan profesi keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui email: heldabuldan17@gmail.com

PROFIL PENULIS



Sarwoko, S.Ag, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep. Lahir di Sragen, 21 Maret 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Aqidah Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997, Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Sahid Surakarta Tahun 2014 dan 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Kedokteran Keluarga, Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009 dan Magister Keperawatan, Universitas Karya Husada Semarang tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2002 sebagai tenaga kependidikan, 2004 sebagai kepala Tata Usaha, 2006-2015 sebagai Wakil Direktur pada Akademi Kebidanan Estu Utomo. 2015-2021 sebagai Wakil Ketua, 2021-2025 dan 2025-sekarang sebagai Ketua STIKES Estu Utomo. Saat ini penulis bekerja di STIKES Estu Utomo Program Studi Keperawatan Program Sarjana mengampu mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan, Konsep Dasar Keperawatan, Proses Keperawatan dan Berfikir Kritis, Ketrampilan Dasar Keperawatan, Biomedik dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar dan konsultan Pendidikan Kesehatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sanuria21@gmail.com
Motto: "Serious, Learn and Sincere"



Grytthа Tondang, S.Kep., Ns., M.Kep.
Lahir di Pematangsiantar, 11 November 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Mutiara Indonesia tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sumatera Utara dan lulus tahun pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006 sebagai kepala seksi etika dan profesi di RS Vita Insani Pematangsiantar. Pada Tahun 2014 bekerja di RS Murni Teguh Medan sebagai Duty Manager. Pada tahun 2022 Dosen Tetap di STIKes Santa Elisabet Medan. Saat ini penulis bekerja di STIKes Santa Elisabeth Medan mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan**GG**. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: *gryttondang@mail.com*

PROFIL PENULIS



Ns. Lia Dwi Jayanti, S.Kep.,M.Kep Lahir di Denpasar, 11 Februari 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1-Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Udayana tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2016 sebagai Perawat di Rumah Sehat Ukhuwah, 2017 sebagai Perawat di RS Bali Jimbaran, dan 2022-sekarang sebagai Dosen Keperawatan di Poltekkes Kemenkes Semarang. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Semarang mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Keperawatan Anak, Farmakologi, Falsafah dan Teori Keperawatan, Kebutuhan Dasar Manusia, Konsep Dasar Keperawatan, Perawatan dan Pelayanan Pasien Radiologi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan trainer BTCLS. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: liadwijayantii@gmail.com

Motto: "Grow through learning, lead through kindness"



Puji Rahayu, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Ponorogo 20 November 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Keperawatan Depkes Malang 1988, pada tahun 2002 lulus Pendidikan Program Studi Ilmu Keperawatan FK UNAIR dan Profesi Ners, Angkatan pertama. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Keperawatan, Universitas Airlangga Surabaya selesai tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1988 sebagai perawat Honorer di RSUD dr. Saiful Anwar Malang, tahun 1989 sebagai tenaga keperawatan di RSUD dr. Soebandi Jember, tahun 1996 sebagai kepala Ruangan di RSU Haji Surabaya, 2004 sebagai Kasie Ketenagaan di RSU Haji Surabaya. 2010 - 2023 sebagai Kepala Bidang Keperawatan di RSUD Haji Prov. Jatim, pada tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai Dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA), Saat ini penulis juga bekerja sebagai konsultan Pelayanan Keperawatan di rumah sakit swasta dan sebagai survivor akreditasi rumah sakit, dan sebagai pengurus PPNI Prov Jatim 2010-2020, pengurus HPMI Prov jatim tahun 2020 – 2024 serta pengurus PERSI Kompartemen mutu Pelayanan tahun 2020-2025. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: pujir666@gmail.com

Motto: "Bahagia dunia dan akherat"

PROFIL PENULIS



Dr. Aemilianus Mau, S.Kep., Ns., M.Kep

Penulis yang akrab dipanggil Willy ini lahir di Malaka-NTT, 27 Mei 1972. Memiliki Riwayat Pendidikan: Akper PEMDA Kupang, tamat tahun 1996, Ners Unair tamat tahun 2004, S2 Keperawatan Unair, tamat tahun 2010, S3 Keperawatan UI, tamat tahun 2023. Penulis sebagai staf dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Kupang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai pengajar, penulis buku, publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, aktif mengikuti seminar, pertemuan nasional/internasional. Riwayat organisasi: sebagai Ketua DPW PPNI Provinsi NTT, Anggota Bidang Diklat DPP PPNI, Anggota Kolegium Keperawatan Indonesia.

Email Penulis: aemilianusmau58@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar Manajemen Keperawatan merupakan referensi pembelajaran yang membahas konsep, prinsip, dan penerapan manajemen dalam pelayanan keperawatan secara sistematis. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi manajemen, peran, tanggung jawab, serta akuntabilitas perawat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan asuhan dan pelayanan keperawatan yang profesional. Selain itu, buku ini juga menguraikan organisasi pelayanan keperawatan, sistem layanan kesehatan di Indonesia, tata kelola organisasi, standar akreditasi, alur layanan keperawatan, serta pentingnya koordinasi lintas profesi dan kolaborasi interprofesional.

Pembahasan selanjutnya berfokus pada kepemimpinan keperawatan, manajemen perubahan, dan pengelolaan sumber daya manusia keperawatan. Mahasiswa diarahkan untuk memahami cara memilih pendekatan kepemimpinan sesuai situasi kerja, menyusun langkah perubahan yang terukur, serta mengenal peran perawat sebagai agen pembaru. Buku ini juga membahas manajemen SDM keperawatan, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga, metode perhitungan tenaga seperti Douglas dan WISN, seleksi, orientasi, pengembangan kemampuan, jenjang karier, penilaian kinerja, kompensasi, hingga strategi adaptif seperti task shifting dalam menghadapi krisis tenaga keperawatan.

Sebagai buku ajar berbasis kompetensi, materi dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran Knows How dan Shows How, OSCE, DOPS, rubrik penilaian, portofolio, latihan soal, rangkuman materi, glosarium, serta tabel red flags dan eskalasi. Pada bagian akhir, buku ini membahas perencanaan dan penjadwalan tenaga keperawatan, manajemen asuhan keperawatan dan delegasi, komunikasi efektif, kolaborasi, serta manajemen konflik dalam praktik keperawatan. Dengan cakupan tersebut, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam mengembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan demi terselenggaranya pelayanan keperawatan yang aman, bermutu, efektif, dan berpusat pada pasien.

Buku Ajar Manajemen Keperawatan merupakan referensi pembelajaran yang membahas konsep, prinsip, dan penerapan manajemen dalam pelayanan keperawatan secara sistematis. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi manajemen, peran, tanggung jawab, serta akuntabilitas perawat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan asuhan dan pelayanan keperawatan yang profesional. Selain itu, buku ini juga menguraikan organisasi pelayanan keperawatan, sistem layanan kesehatan di Indonesia, tata kelola organisasi, standar akreditasi, alur layanan keperawatan, serta pentingnya koordinasi lintas profesi dan kolaborasi interprofesional.

Pembahasan selanjutnya berfokus pada kepemimpinan keperawatan, manajemen perubahan, dan pengelolaan sumber daya manusia keperawatan. Mahasiswa diarahkan untuk memahami cara memilih pendekatan kepemimpinan sesuai situasi kerja, menyusun langkah perubahan yang terukur, serta mengenal peran perawat sebagai agen pembaru. Buku ini juga membahas manajemen SDM keperawatan, mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga, metode perhitungan tenaga seperti Douglas dan WISN, seleksi, orientasi, pengembangan kemampuan, jenjang karier, penilaian kinerja, kompensasi, hingga strategi adaptif seperti task shifting dalam menghadapi krisis tenaga keperawatan.

Sebagai buku ajar berbasis kompetensi, materi dilengkapi dengan aktivitas pembelajaran Knows How dan Shows How, OSCE, DOPS, rubrik penilaian, portofolio, latihan soal, rangkuman materi, glosarium, serta tabel red flags dan eskalasi. Pada bagian akhir, buku ini membahas perencanaan dan penjadwalan tenaga keperawatan, manajemen asuhan keperawatan dan delegasi, komunikasi efektif, kolaborasi, serta manajemen konflik dalam praktik keperawatan. Dengan cakupan tersebut, buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan dalam mengembangkan kemampuan manajerial, kepemimpinan, komunikasi, dan pengambilan keputusan demi terselenggaranya pelayanan keperawatan yang aman, bermutu, efektif, dan berpusat pada pasien.

Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7756-71-8 (PDF)
9 786347 756718